# 中医经典等级测试指南

ZHONGYI JINGDIAN DENGJI CESHI ZHINAN

梁繁荣 主编

科学出版社

# 中医经典等级测试指南

主　编　梁繁荣
主　审　张　琦　杨　宇
　　张新渝　刘　杨

科学出版社
北　京

## 内 容 简 介

《中医经典等级测试指南》是一本中医学经典条文的导读书，摘取《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》及温病学相关经典著作的经典条文816条，均分为三级，每一条文适量配以“提要”“词解”等内容。该读本是成都中医药大学学生参加“中医经典理论等级测试”的考试指南，也可作为全国中医院校“大学生中医经典等级考试”的经典条文指南，青年学生学习中医经典理论的课余研习读本，社会人员学习中医学的泛读本。

**图书在版编目(CIP)数据**

中医经典等级测试指南 / 梁繁荣主编. —北京：科学出版社，2016.11
ISBN 978-7-03-050362-6

Ⅰ. ①中… Ⅱ. ①梁… Ⅲ. ①中医师—资格考试—自学参考资料 Ⅳ. ①R2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第251022号

责任编辑：闵 捷
责任印制：谭宏宇 / 封面设计：殷 靓

科学出版社 出版
北京东黄城根北街16号
邮政编码：100717
http://www.sciencep.com
南京展望文化发展有限公司排版
上海叶大印务发展有限公司印刷
科学出版社发行 各地新华书店经销
*
2017年1月第 一 版 开本：B5(720×1000)
2017年1月第一次印刷 印张：20
字数：368 000
**定价：40.00元**
（如有印装质量问题，我社负责调换）

# 编辑委员会


**主　编**

梁繁荣

**副主编**

成词松　王浩中　刘　锋　鲁法庭　郭尹玲　叶　莹

**主　审**

张　琦　杨　宇　张新渝　刘　杨

**编　委**（按姓氏笔画排序）

王　飞　王宝家　冯全生　刘　军　刘秀华　江　泳
汤朝晖　余成浩　陈云慧　周仕轶　周　宜　郑秀丽
袁世清　徐姗姗　高永翔　唐朋利　蒋　翠

# 前　言

Foreword

中医药高等院校的根本任务是培养高素质中医药人才，肩负“传承中医理论，弘扬中医文化”的使命。成都中医药大学自1956年建校以来，恪守“秉承传统、崇尚创新、突出特色、强化优势、服务社会”的办学思路，遵循中医药教育规律和中医药人才成才规律，强化中医药专业学生的中国传统文化底蕴，加强中医药经典课程教学，重视培养学生正确的中医药理论思维，坚持办好传统特色鲜明的现代中医药高等教育。六十年来，学校历次修订教学计划，《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《温病学》等一直是中医类专业的必修课程，通过课堂教育引导青年学生系统学习中医学，传承和发展中医学。

当今时代，习诵中医经典还有必要吗？答案是肯定的。国家主席习近平同志指出：“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。”中医学具有独特的整体观念和辨证论治特点，倡导未病养生，重视个体化医疗，蕴含着中华民族的文化基因，植根于历代医家的反复临床实践。中医经典理论不会因为时间推移而过时，相反，中医经典的魅力就在于言近旨远，包罗万象，它提出问题和解决问题的方法非常经典，学习中医学的思维方法，不仅能够产生跨越时空的广泛认同感，而且能够推而广之，指导临床实践，取得确切疗效。

“读经典、悟经典、用经典”是学习中医学的三重境界，更是中医人才成长的必由之路。要学好中医学，首先必须熟读经典，在此基础上深入领悟经典理论内涵，并在临床反复实践。非诵读无以领悟，非领悟无以应用，非应用无以融通。有鉴于此，我们撷拾中医理论的重要经典条文，汇编成《中医经典等级测试指南》，本指南既是我校学生参加“中医经典理论等级测试”的考试指南，也可作为青年

学生学习中医经典理论的课余研习读本，还适用于社会人员学习中医学的泛读。

中医学历史悠久，源远流长，名医辈出，典籍丰富，诸家之说，理法多源。中医经典名篇、名句甚多，本指南不求面面俱到，仅采集了《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》以及温病学相关经典著作的重点条文。在条文数量方面，根据习诵中医经典“博而不杂，约而不漏”的思路，共收录经典条文816条，列分三级，一级条文需要背诵并掌握其内涵和拓展应用，二级条文需要背诵并熟悉其内涵，三级条文需要熟读并了解其内涵。为便于诵记和理解，条文多在300字以内，并适量配以“提要”“词解”“句解”“拓展”“方药”。

本书在建校六十周年校庆之际付梓出版，期待更多人员学习中医学，传承中医学，弘扬中医学。

编　者

2016年9月

# 目 录

Contents

壹 《黄帝内经》经典条文 / 1
一级条文(50 条) / 3
二级条文(70 条) / 26
三级条文(90 条) / 51

贰 《伤寒论》经典条文 / 87
一级条文(90 条) / 89
二级条文(116 条) / 123
三级条文(90 条) / 162

叁 《金匮要略》经典条文 / 195
一级条文(95 条) / 197
二级条文(50 条) / 229
三级条文(65 条) / 243

肆 温病学经典条文 / 259
一级条文(40 条) / 261
二级条文(30 条) / 281
三级条文(30 条) / 292

成都中医药大学中医经典知识等级考试实施方案(试行) / 305

成都中医药大学中医经典知识等级测试试题范例 / 308

# 壹　《黄帝内经》经典条文

# 一级条文(50条)

1 上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。(《素问·上古天真论》)

【提要】

通过古今对比,阐发了养生的重要意义与不同效果,并提出五种养生法则:"法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳"。

【词解】

① 法:顺应。

② 耗:《针灸甲乙经》作"好",与前"欲"字义合,即嗜好之意。

③ 不时御神:不善于驾驭、使用精神,即妄耗神气。时,善也;御,用也。

2 肾者主水,受五藏六府之精而藏之,故五藏盛,乃能写。(《素问·上古天真论》)

【提要】

通过阐述肾藏精与五脏六腑的关系,体现了后天滋养先天的思想。

【词解】

① 肾者主水:此指肾主藏精的功能。

② 写:通"泻"。

【句解】

肾具有水的闭藏特性,不仅藏先天之精,也藏五脏六腑气化产生的后天之精。五脏六腑精气充盛,才能向肾输送而藏之;肾中精气充盛,才可以向外泄精而具备生殖机能。可见,肾精与五脏六腑之精是相互补充的。

3 因于寒,欲如运枢,起居如惊,神气乃浮。因于暑,汗,烦则喘喝,静则多言,体若燔炭,汗出而散。因于湿,首如裹,湿热不攘,大筋绝短,小筋弛长,绝短为拘,弛长为痿。因于气,为肿。四维相代,阳气乃

竭。(《素问·生气通天论》)

【提要】

论述了阳失卫外,而致时令外邪乘虚侵入的疾病。由于四时邪气不同,所致疾病亦不相同。

【词解】

① 运枢:转动的门轴。比喻人体阳气的卫外作用,有如户枢那样主司肌表腠理的开阖。

② 起居如惊:生活作息没有正常的规律。

③ 神气乃浮:阳气开合失序而浮散损伤。

④ 四维相代:寒、暑、湿、气(风)四种邪气更替伤人。

【句解】

大筋绬短,小筋弛长:互文句。大筋、小筋或者收缩变短,或者松弛变长。绬,收缩。弛,松弛,弛缓。

4 凡阴阳之要,阳密乃固。两者不和,若春无秋,若冬无夏。因而和之,是谓圣度。故阳强不能密,阴气乃绝。阴平阳秘,精神乃治,阴阳离决,精气乃绝。(《素问·生气通天论》)

【提要】

论述阴精与阳气的关系,强调了阳气的作用。

【词解】

① 阳密乃固:阳气致密于外,阴精才能固守于内。

② 阴平阳秘:互文句,即阴阳平秘,阴阳平和协调之意。秘,通"密",致密。

【句解】

"凡阴阳之要,阳密乃固"强调了阳气在阴阳关系中所起的主导作用。在生理情况下,阳气致密于外,阴气才能固守于内,从而保持阴阳的协调。若"阳强不能密",则"阴气乃绝",阴阳的协调关系就会遭到破坏。

5 阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。(《素问·阴阳应象大论》)

【提要】

论述了阴阳是万事万物发生与运动变化的源泉和规律。

【词解】

① 神明之府:阴阳是产生自然界万物运动变化内在动力的场所。府,居舍、藏物的场所。

② 本：阴阳。

**【句解】**

阴阳者，天地之道也：阴阳是自然界的法则和规律。天地，泛指自然界。道，法则、规律。

6 故清阳为天，浊阴为地；地气上为云，天气下为雨；雨出地气，云出天气。故清阳出上窍，浊阴出下窍；清阳发腠理，浊阴走五藏；清阳实四支，浊阴归六府。（《素问·阴阳应象大论》）

**【提要】**

以阴阳升降运动说明人体的生理病理现象，并提出清阳浊阴升降出入的生理观。

**【句解】**

① 地气上为云，天气下为雨；雨出地气，云出天气：地气受阳热的蒸腾上升为云，天气受阴寒而凝聚下降为雨，而云变为上天之气，雨成为大地之气。可见天气的云来源于地气的水，地气的水产生于天气的云。通过云雨互变的自然现象，说明阴阳互根互用、相互转化、阴升阳降、阴阳交感、化生万物的道理。

② 清阳出上窍，浊阴出下窍：水谷之精气上奉于头面五官，饮食化生后之糟粕经下窍二阴排出体外。

③ 清阳发腠理，浊阴走五藏：卫气敷布于皮肤肌肉，精血津液归藏于五脏。

④ 清阳实四支，浊阴归六府：水谷精气充养于四肢及躯体，水谷及其糟粕传化在六腑。

7 壮火之气衰，少火之气壮。壮火食气，气食少火。壮火散气，少火生气。（《素问·阴阳应象大论》）

**【提要】**

论壮火、少火的概念及其对人体的影响。

**【句解】**

① 壮火之气衰，少火之气壮：药食气味纯阳者易化壮火，令正气虚衰，药物饮食气味温和者易化为少火，令正气盛壮。壮火，指药物饮食气味纯阳的作用。少火，指药物饮食气味温和的作用。气，指正气。之，作使、令解。后世对壮火、少火的含义，有进一步的发挥，认为壮火即病理之火，少火为生理之火。

② 壮火食气，气食少火：药物饮食的纯阳作用耗散人体的元气，人体的元气赖药物饮食的温和作用，药物饮食的温和作用补养人体的元气。前“食”字，是销蚀的意思，后“食”字，音义同“饲”。

8 气味辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论药物饮食五味的阴阳属性。

【词解】

涌泄：泛指呕吐泄泻。

9 阴胜则阳病，阳胜则阴病。阳胜则热，阴胜则寒。重寒则热，重热则寒。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论阴阳偏盛的病理表现。

【句解】

① 阴胜则阳病，阳胜则阴病：过用酸苦涌泄药，则机体阳气损伤；过用辛甘发散药，则机体阴精耗损。阴胜，即酸苦涌泻太过；阳胜，即辛甘发散太过。后世对此又有新的发挥，认为阴邪偏胜，则伤阳气；反之阳邪偏胜，则伤阴气，以此成为中医学病机总纲。

② 阳胜则热，阴胜则寒：本指用辛甘药太过则产生热病，用酸苦药太过则产生寒病。后世又发挥为阳邪胜致热病，阴邪胜致寒病。

③ 重寒则热，重热则寒：本指重复（或反复）应用寒性药则生热性病；反复（过用）热性药则生寒性病。后世对此亦有新解：反复感受寒邪会成热证，反复感受热邪会生寒证。重，一作“极”解。张介宾注：“此即上文寒极生热，热极生寒之义。盖阴阳之气，水极则似火，火极则似水，阳盛则格阴，阴盛则格阳，故有真寒假热，真热假寒之辨，而此错认，则死生反掌”。“极”则变，为事物本质之变，格阴格阳之证，其外寒、外热均属假象，两者不能混为一谈。

10 风胜则动，热胜则肿，燥胜则干，寒胜则浮，湿胜则濡泻。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论六淫的致病特点。

【句解】

① 热胜则肿：火热内郁，营气壅滞肉理，聚为痈疡红肿。

② 寒胜则浮：寒为阴邪，易伤阳气，阳气不行，聚水成为浮肿。浮，浮肿。

③ 湿胜则濡泻：脾为湿困，不能运化水谷，故泄泻稀溏。濡泻，又称湿泻，由湿邪伤脾所致。

11 天地者，万物之上下也；阴阳者，血气之男女也；左右者，阴阳之道路也；水火者，阴阳之征兆也；阴阳者，万物之能始也。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论述阴阳之间的相互关系。

【词解】

能始：元始，本始。能，古代文献中“胎”之借字。

【句解】

① 阴阳者，血气之男女也：张志聪注：“阴阳之道，其在人则为男为女，在体则为气为血”。之，与也，和也。

② 左右者，阴阳之道路也：古代浑天说认为天体运转是自东向西旋转，称右旋。日月星辰不断地自左向右旋转，才有昼夜、四时变迁。

12 阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论述阴阳的互根互用关系。

【句解】

阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也：阴气居于内，为阳气的主持；阳气居于外，为阴气的役使。守，镇守于内。使，役使于外。言阴阳内外相合互用，不可相离。

13 故善用针者，从阴引阳，从阳引阴，以右治左，以左治右，以我知彼，以表知里，以观过与不及之理，见微得过，用之不殆。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

运用阴阳理论指导针灸治疗。

【词解】

殆：危也。

【句解】

从阴引阳，从阳引阴：人之阴阳气血内外上下交相贯通，故针刺阳分或阴分，能够调节经脉的虚实盛衰。

14 善诊者，察色按脉，先别阴阳；审清浊，而知部分；视喘息，听

音声，而知所苦；观权衡规矩，而知病所主；按尺寸，观浮沉滑涩，而知病所生。以治无过，以诊则不失矣。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

运用阴阳理论指导疾病诊断。

【词解】

① 清浊：面部色泽的清与浊。清，面色明润光泽；浊，面色晦暗滞浊。

② 苦：病之苦痛。

③ 权衡规矩：泛言四时常脉。权为秤锤，衡为秤杆，规为作圆之器，矩为作方之器。此喻脉象。

15 心者，君主之官也，神明出焉。肺者，相傅之官，治节出焉。肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。膻中者，臣使之官，喜乐出焉。脾胃者，仓廪之官，五味出焉。大肠者，传道之官，变化出焉。小肠者，受盛之官，化物出焉。肾者，作强之官，伎巧出焉。三焦者，决渎之官，水道出焉。膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。（《素问·灵兰秘典论》）

【提要】

论脏腑的主要生理功能。

【词解】

① 治节：治理调节。比喻肺佐心以调气血、行营卫、治理诸脏的功能。

② 将军之官：肝属风木，性动而急，如将军之勇。

③ 作强：指精力充沛，强于所用，偏指体力。

④ 伎巧：人的智巧能力。

⑤ 决渎：疏通水道的意思。决，通也；渎，水道。

⑥ 州都：水液汇聚的地方。

⑦ 气化：肾气对膀胱所藏津液的蒸化和升清降浊功能。

16 心者，生之本，神之变也，其华在面，其充在血脉，为阳中之太阳，通于夏气。（《素问·六节藏象论》）

【提要】

心的概念及生理特点。

【句解】

阳中之太阳，通于夏气：心属火，位居膈上，宣达阳气，故为阳中之太阳，与夏热之气相应。

17 肺者，气之本，魄之处也，其华在毛，其充在皮，为阳中之太阴，通于秋气。（《素问·六节藏象论》）

【提要】

肺的概念及生理特点。

18 肾者，主蛰，封藏之本，精之处也，其华在发，其充在骨，为阴中之少阴，通于冬气。（《素问·六节藏象论》）

【提要】

肾的概念及生理特点。

【句解】

主蛰，封藏之本：此以冬眠伏藏之虫，比喻肾主藏精，宜闭藏而不妄泄的功能，故称“封藏之本”。

19 肝者，罢极之本，魂之居也，其华在爪，其充在筋，以生血气，其味酸，其色苍，此为阳中之少阳，通于春气。（《素问·六节藏象论》）

【提要】

肝的概念及生理特点。

【词解】

罢极之本：肝主筋，筋脉运动强健有力，有赖于肝血和肝气的濡养，故称肝为罢极之本。罢，音义同“疲”；极，《说文解字》曰：“燕人谓劳曰极”。罢极，即劳困的意思。

20 脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者，仓廪之本，营之居也，名曰器，能化糟粕，转味而入出者也，其华在唇四白，其充在肌，其味甘，其色黄，此至阴之类，通于土气。（《素问·六节藏象论》）

【提要】

脾胃的概念及生理特点。

【词解】

① 名曰器：六腑能运行糟粕，转五味而养五脏，出糟粕而通前后二阴，故六腑为水谷精气糟粕升降出入之器。器，中空的器皿。

② 其味甘，其色黄：林亿云：“详此六字当去”。与上下文例不合，文义不接，可从。

③ 至阴：脾属土，土为阴，主运水湿，故为至阴。至，极也。亦谓脾居中焦，在阳位至阴位之间；脾主长夏，四季由阳至阴，故称至阴。至，到也。可合参。

21 凡十一脏，取决于胆也。（《素问·六节藏象论》）

【提要】

论述胆在五脏六腑中的重要性。

【拓展】

李东垣注："胆者少阳春升之气，春气升则万化安。故胆气春升，则余脏从之，所以十一脏皆取决于胆"。张介宾注："足少阳为半表半里之经，亦曰中正之官，又曰奇恒之腑，所以能通达阴阳，而十一脏皆取决乎于此也"。又有"十一"乃"土"字之误，可参。

22 帝曰：其有不从毫毛而生，五藏阳以竭也。津液充郭，其魄独居，孤精于内，气耗于外，形不可与衣相保，此四极急而动中，是气拒于内，而形施于外，治之奈何？岐伯曰：平治于权衡，去宛陈莝，微动四极，温衣，缪刺其处，以复其形。开鬼门，洁净府，精以时服，五阳已布，疏涤五藏。故精自生，形自盛，骨肉相保，巨气乃平。（《素问·汤液醪醴论》）

【提要】

论述因"五藏阳已竭"而致水肿的病机、治法。

【词解】

① 去宛陈莝：祛除郁积于体内的陈腐水液。莝，本义为斩草、锄草，引申为铲除。宛，通"郁"，郁积、郁结。陈，陈腐。亦有另解：除去久郁的恶血。

② 巨气：正气。

【句解】

① 津液充郭，其魄独居：水液充满胸腹、肌肤，患者阳气郁遏，水液独盛体内。郭，同"廓"。津液，指水液。魄，属阴，此属阴的水液。居，留也。

② 孤精于内，气耗于外：水液独盛于体内，阳气耗散于体外。精，此指属阴的水液，与本句"魄"同义。

③ 四极急而动中：四肢极度浮肿，脏气变动而喘悸。急，肿急，形容极度浮肿。中，内脏，此处主要指心肺。

④ 气拒于内而形施于外：水气格拒于内而形体变异于外，形容身体水肿之甚。拒，格拒。施，音义同"易"，改变。

⑤ 开鬼门，洁净府：即发汗、利小便的治疗方法。

【拓展】

本节指出内伤水肿是由"五藏阳以竭"而产生，即阳气被遏，不能气化和布散水液，以致水液积聚，泛溢肌肤（即"津液充郭"），发为水肿。

本节提出内伤水肿治疗基本原则是“平治于权衡”和“去宛陈莝”。“平治于权衡”旨在协调阴阳，以针对导致水液积聚的内在病机，属于治本。“去宛陈莝”旨在排除陈积的水液，以针对水液积聚，即水肿的直接成因，属于治标。这样就能标本兼顾，自然可使“五阳已布”，水去肿消。

具体的治法，则外用“缪刺”，内用“开鬼门”“洁净府”的方法。所谓“缪刺”以及“温衣”“微动四极”，都意在疏通阳气，恢复气化，属于“平治于权衡”的体现。而“开鬼门”“洁净府”，则意在祛水消肿，属于“去宛陈莝”的体现。后世对此多有发挥，如张仲景在《金匮要略》中指出：“腰以下肿，当利小便；腰以上肿，当发汗乃愈”。皆在视水聚之处，就近外除。实与《素问·阴阳应象大论》所谓“其高者，因而越之；其下者，引而竭之”，即因势利导的原则一脉相承。临床上，根据寒热虚实辨证论治，如属风热犯肺、以头面先肿或甚之阳水者，用越婢汤宣肺清热、疏散水湿；属脾、肾阳虚，以腰以下先肿或甚之阴水者，用真武汤、实脾饮之类温补脾、肾、利水消肿等，都是在此指导下的具体运用。此外，“温衣”以保暖顾护阳气，“微动四极”以助行阳气，亦可视为护理上的要求，对后世水肿病的护理，产生了重要的影响。

23 诊法常以平旦，阴气未动，阳气未散，饮食未进，经脉未盛，络脉调匀，气血未乱，故乃可诊有过之脉。（《素问·脉要精微论》）

**【提要】**

诊病的时间以平旦为宜，并论述其原理。

**【词解】**

平旦：太阳刚升出地平线之时，即清晨、早晨。

**【句解】**

阴气未动，阳气未散：文互相备的修辞。言平旦之时，人刚刚醒寤，体内阴阳之气未因进食和劳作而被扰动、耗散。

24 夫精明五色者，气之华也，赤欲如白裹朱，不欲如赭；白欲如鹅羽，不欲如盐；青欲如苍璧之泽，不欲如蓝；黄欲如罗裹雄黄，不欲如黄土；黑欲如重漆色，不欲如地苍。五色精微象见矣，其寿不久也。（《素问·脉要精微论》）

**【提要】**

论述五色望诊。

**【词解】**

① 白裹朱：面色白里透红，隐然红润而不暴露。“白”通“帛”，即白色的丝织

物。朱，朱砂。

② 赭：代赭石，其色赤而晦暗不泽。

③ 苍璧：青色的玉石，碧绿明润有光泽。

④ 蓝：蓝草，干后变暗蓝色，可加工成靛青，作染料。

⑤ 罗裹雄黄：喻指为黄中透红之色。罗，丝织物的一种。

⑥ 重漆色：漆器反复上漆，黑而明亮。重，反复。

⑦ 地苍：青黑色的土地，黑而枯槁。张介宾注："地之苍黑，枯暗如尘"。

**【句解】**

① 精明五色者，气之华也：两目神气和面部五色，为五脏精气表露于外的征象。姚止庵注："精明以目言，五色以面言。言目之光彩精明，面之五色各正，乃元气充足，故精华发见于外也"。

② 五色精微象见矣，其寿不久也：五脏之真脏色外露，败象显现，预后不良。见，同"现"。

**【拓展】**

《黄帝内经》通过以具体实物的颜色为参照物，形象地阐明了望面部五色"欲"与"不欲"的要领，及其在疾病预后转归中的重要意义。"欲"之色为善色，多润泽光亮、隐然含蓄，表明气血尚充，脏腑精气内守尚未大衰，预后良好；"不欲"之色为恶色，多晦暗枯槁、彰然外露，表明气血衰败，脏腑精气衰极失守外脱，预后不良。临床上不少慢性消耗性疾病或内脏器质性病变，在疾病晚期由于脏腑精气衰败，往往表现晦滞枯槁的肤色，为难治或不治之征；至于五色突然彰然外露，俗称"回光返照"，更是危在旦夕。

25 万物之外，六合之内，天地之变，阴阳之应，彼春之暖，为夏之暑，彼秋之忿，为冬之怒，四变之动，脉与之上下，以春应中规，夏应中矩，秋应中衡，冬应中权。（《素问·脉要精微论》）

**【提要】**

论脉象与四时相应的机制及意义。

**【词解】**

中：符合。

**【句解】**

四变之动，脉与之上下：春夏秋冬四季气候的变动，脉象也随之发生相应变化。上下，指脉象的波动。

26 平人之常气禀于胃，胃者平人之常气也，人无胃气曰逆，逆者

死。(《素问·平人气象论》)

【提要】

论平人脉象。

【句解】

胃者,平人之常气:胃气是健康人的正常脉气。

27 食气入胃,散精于肝,淫气于筋。食气入胃,浊气归心,淫精于脉。脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛。毛脉合精,行气于府,府精神明,留于四藏,气归于权衡。权衡以平,气口成寸,以决死生。(《素问·经脉别论》)

【提要】

论述谷食入胃后其精气输布运行的过程。

【词解】

① 食气:饮食。

② 浊气:谷食之气中的浓稠部分。

③ 四藏:具体指哪四脏,前人争论不一。综观全文之义,以泛指所有的脏腑为是。

【句解】

① 毛脉合精:肺主气,心主血脉。毛脉合精,即气血相合。

② 府精神明,留于四脏:经气正常运行而不紊乱,流行输布于肝、心、脾、肾四脏。

③ 气归于权衡:精气化作血气入于血脉,精气的敷布要保持平衡的生理状态。衡,平衡。

④ 权衡以平:脏腑之气平衡协调,则十二经脉之气亦趋于平定。

⑤ 气口成寸,以决死生:肺朝百脉,脏腑之气皆显见于气口,故气口可诊脏腑之气血盛衰及病变。气口,指手太阴肺经在手腕部所过之处,因其长 1.9 寸,故曰"气口成寸"。

28 饮入于胃,遊溢精气,上输于脾。脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。水精四布,五经并行,合于四时五藏阴阳,揆度以为常也。(《素问·经脉别论》)

【提要】

论水饮入胃之后,其精气输布运行的过程。

【句解】

① 遊溢精气：精气满溢。遊，通“游”，浮游。遊溢，浮游盈溢之意。精气，由水谷化生之精气。

② 合于四时五藏阴阳：水谷精气在人体的输布、运行与四时五脏的阴阳变化相适应。合，应合。

③ 揆度以为常：诊察人体时，要以上述原则作为常规大法。揆度，测度也。

29 黄帝问曰：太阴阳明为表里，脾胃脉也，生病而异者何也？岐伯对曰：阴阳异位，更虚更实，更逆更从，或从内，或从外，所从不同，故病异名也。（《素问·太阴阳明论》）

【提要】

太阴和阳明（阴经和阳经），因其阴阳属性、循行部位、四时虚实逆从等的不同，所以其疾病的虚实变化、发病部位、证候、名称等都各自有别。

【句解】

① 阴阳异位：指足太阴脾经与足阳明胃经循行的部位不同。

② 更虚更实：太阴阳明与四时的虚实顺逆关系不同。春夏为阳，阳明之气与之相应，故春夏之季，阳明实而太阴虚；秋冬为阴，太阴之气与之相应，故秋冬之季，太阴实而阳明虚。

③ 更逆更从：春夏为阳，阴盛为逆，阳盛为从；秋冬为阴，阳盛为逆，阴盛为从。

30 阳者，天气也，主外；阴者，地气也，主内。故阳道实，阴道虚。故犯贼风虚邪者，阳受之；食饮不节，起居不时者，阴受之。阳受之则入六府，阴受之则入五藏。入六府则身热，不时卧，上为喘呼；入五藏则膜满闭塞，下为飧泄，久为肠澼。（《素问·太阴阳明论》）

【提要】

太阴和阳明（阴经和阳经）疾病的虚实变化、发病部位、证候的具体区别。

【句解】

阳道实，阴道虚：属于阳的六腑，多病外感而为实证；属于阴的五脏，多病内伤而为虚证。

31 帝曰：脾病而四支不用，何也？岐伯曰：四支皆禀气于胃，而不得至经，必因于脾，乃得禀也。今脾病不能为胃行其津液，四支不得

禀水谷气，气日以衰，脉道不利，筋骨肌肉皆无气以生，故不用焉。（《素问·太阴阳明论》）

【提要】

论脾主四肢肌肉的原理。

【词解】

① 四支不用：四肢不能随意活动。

② 津液：此指水谷之精气。

【拓展】

“脾病而四支不用”是由于脾失运化，转输精微不力而导致四肢失养。在结构上脾胃以膜相连，在经脉上相互络属，互为表里。胃虽能受纳、腐熟水谷，却不能自行布散水谷之精微，必须依靠脾气散精的作用，才能把水谷精微转输到五脏六腑、皮肉筋骨、四肢百骸，充养全身上下。因此，当“脾病不能为胃行其津液”时，四肢将失去水谷精微的充养，故不能随意运动。经文不仅指出了脾与胃之间的密切关系，而且揭示了脾具有转输、升清的生理功能，以及脾主四肢的原理，具有很重要的临床指导意义。临床常见的肌肉萎缩、不能正常运动之痿病等，可以参考本观点，从健脾、益气、升清的角度立法，采用补中益气汤之类的方药，往往能获得比较好的临床效果。

32 帝曰：脾不主时，何也？岐伯曰：脾者土也，治中央，常以四时长四脏，各十八日寄治，不得独主于时也。脾脏者，常著胃土之精也，土者生万物而法天地，故上下至头足，不得主时也。（《素问·太阴阳明论》）

【提要】

论述“脾不主时”理论。

【句解】

① 脾不主时：脾不单独主某一个时令。

② 上下至头足：脾胃为脏腑之本，故上至头，下至足，皆得其充养。

【拓展】

脾为“仓廪之官”，主运化水谷精微。人体五脏六腑、形体百骸，无时无刻都需要水谷精气的充养，人体要维系正常的生理功能，作为后天之本的脾，就必须“以四时长四脏”，而不能专主某一个时令。因此，在《素问·玉机真藏论》又强调“脾脉者，土也，孤藏以灌四傍者也”。至于“各十八日寄治”，应该是从五行角度，将一年五分之而言，无须拘泥。

33 黄帝问曰：今夫热病者，皆伤寒之类也，或愈或死，其死皆以

六七日之间，其愈皆以十日以上者，何也？不知其解，愿闻其故。岐伯对曰：巨阳者，诸阳之属也。其脉连于风府，故为诸阳主气也。人之伤于寒也，则为病热，热虽甚不死；其两感于寒而病者，必不免于死。（《素问·热论》）

**【提要】**

论热病的病因、病程及预后。

**【词解】**

① 伤寒：病名，有广义和狭义之别。广义伤寒泛指感受四时邪气引起的外感热病；狭义伤寒指感受寒邪引起的外感热病。此处伤寒为广义伤寒，系外感热病的总称。

② 诸阳主气：是所有阳气的统帅，与“诸阳之属”义同。杨上善注：“诸阳者，督脉、阳维脉也。督脉，阳脉之海，阳维，维诸阳脉，总会风府，故属于太阳，故足太阳脉为诸阳主气”。张介宾注：“太阳经脉覆于巅背之表，故主诸阳之气分”。可合参。

③ 两感：表里两经同时受邪发病。如太阳与少阴两感，阳明与太阴两感，少阴与厥阴两感。

**【句解】**

人之伤于寒也，则为病热：寒性收引，感受寒邪则腠理闭固，阳气郁而不得宣发，故病发热。

**【拓展】**

外感病的发展与预后，取决于正邪抗争的力量对比，正胜邪退则疾病向愈，邪胜正衰则病进，伤寒热病亦不例外。太阳经为人体阳气的大会，主持一身之阳气，为三阳之表。热病初始，邪客肌表，正气尚未大衰，足以抗邪，故正邪交争于肌表而常见大热。此时，邪气尚未入内，只要用辛凉发散的方法，药如桑叶、金银花、连翘、薄荷等，方如银翘散、桑菊饮等，使邪从外解，即可病愈，此即“热虽盛不死”之义。

外感热病“两感于寒而病者，必不免于死”，是由于邪胜正衰，失于抗病。两感于寒，表里两经同时发病，邪气猖獗，不仅肌表闭阻、阳郁不通，更因邪气深入而使脏腑气血大衰，机体抗病能力下降，以致预后不佳。

本文“不死”与“死”，只是相对而言，意在强调病情有轻重，预后有吉凶，治疗有难易而已。

**34** 黄帝问曰：肺之令人咳何也？岐伯对曰：五藏六府皆令人咳，非独肺也。帝曰：愿闻其状。岐伯曰：皮毛者，肺之合也，皮毛先受邪气，邪气以从其合也。其寒饮食入胃，从肺脉上至于肺则肺寒，肺寒

则外内合邪因而客之，则为肺咳。五藏各以其时受病，非其时，各传以与之。（《素问·咳论》）

【提要】

论述咳的病因与病机。

【句解】

非其时，各传以与之：五脏在各自所主时令感受邪气，发病之后，皆可波及于肺，从而引起咳病。非其时，指非肺所主的秋季。之，指肺。

【拓展】

本条“五藏六府皆令人咳”已成为后世认识咳嗽的经典学术思想。咳嗽虽然是肺气上逆的症状，但五脏六腑的病理改变，都可以影响到肺的功能，导致肺气上逆而发生咳嗽。由此而提出了“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”的著名论断，这也是《黄帝内经》整体观念在病理学上的运用。

清代医家陈修园在《医学三字经·咳嗽》又说：“咳嗽不止于肺，亦不离乎肺也”。因此，临床必须辨清是肺本脏所病，还是他脏病变所累。除本脏病变外，若因肝火上犯、脾虚不济、肾虚水逆等所致者，则当采用佐金平木、培土生金、金水相生等法以治。

本条“五藏六府皆令人咳”，仅仅是以咳嗽示例，旨在告诫任何病症都应全面考虑五脏六腑的整体关系，唯有从整体联系而准确把握病机实质，才能做到有的放矢，治病求本。至于本节所示咳病与季节的关系，一方面是通过五脏各自主时受邪发病，进而影响到肺，从发病的角度强化了“五藏六府皆令人咳”的观点；另一方面也揭示了五脏对相应季节时邪的易感性，亦是人与自然整体联系在发病观上的反映，从而也启示了治疗必须因时制宜。

35 帝曰：愿闻人之五藏卒痛，何气使然？岐伯对曰：经脉流行不止，环周不休，寒气入经而稽迟，泣而不行，客于脉外则血少，客于脉中则气不通，故卒然而痛。（《素问·举痛论》）

【提要】

论述“五脏痛”的主要病因与基本病机。

【词解】

① 稽迟：经脉气血留滞不行。

② 泣：同“涩”。

【句解】

客于脉外则血少，客于脉中则气不通：互文句，即寒气客于脉外、脉中则血气少，或客于脉外、脉中则血气不通。前者气血不荣则痛，后者气血不通则痛，此为

虚实疼痛机制之总纲。

36 余知百病生于气也。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结，九气不同，何病之生？（《素问·举痛论》）

【提要】

阐发“百病生于气”的发病观点，并具体论述了“九气为病”的内容。

【词解】

① 气上：肝在志为怒，其脏位于隔下，大怒则扰动肝气，肝气向上冲逆，是谓气上。

② 气缓：喜乐而气和志达，荣卫通利，是气机和缓的正常生理状态，暴喜可使心气过缓，以至涣散不收而为病。

③ 气消：悲生于心，使心系拘急。心肺同居上焦，心系急则肺叶上举，阻遏上焦营卫之气的宣发，气郁生热，热消心肺精气，故云气消。消，通“销”，销烁。

④ 气泄：营卫津液之气随汗而耗泄。

37 风寒湿三气杂至，合而为痹也。其风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为著痹也。（《素问·痹论》）

【提要】

论述痹证的病因。

【词解】

① 杂至：夹杂而至。杂，夹杂、混杂。

② 行痹：疼痛具有游走不定特征的痹证，亦称风痹。

③ 痛痹：以疼痛剧烈为特点的痹证，亦称寒痹。

④ 著痹：以痛处重滞固定，或顽麻不仁为特点的痹证，亦称湿痹。

【拓展】

痹病的外在病因是风、寒、湿三气杂至，协同致病。本篇指出了痹病的病因，具有重要的临床指导意义，后世治疗本病都会强调祛风、散寒、除湿三法同用。

临床上还需要辨别行痹、痛痹、著痹之不同，治疗上各有侧重，方能达到“必伏其所主，而先其所因”（《素问·至真要大论》）的效果。行痹，风邪为主，当以祛风为主而兼散寒、除湿，方剂常用防风汤之类加减；痛痹，寒邪为主，当以散寒为主而兼以祛风、除湿，方剂常用乌头汤之类加减；著痹，湿邪为主，当以除湿为主，兼以散寒、祛风，方剂常用薏苡仁汤之类加减。

38 帝曰：善。夫百病之生也，皆生于风寒暑湿燥火，以之化之变也。经言盛者泻之，虚者补之，余锡以方士，而方士用之，尚未能十全。余欲令要道必行，桴鼓相应，犹拔刺雪汙，工巧神圣，可得闻乎？岐伯曰：审察病机，无失气宜，此之谓也。（《素问·至真要大论》）

【提要】

强调审察病机的重要性。

【词解】

① 之化之变：指风、寒、暑、湿、燥、火六气的化生和变化。王冰注："风寒暑湿燥火，天之六气也。静而顺者为化，动而变者为变，故曰之化之变也"。

② 锡：同"赐"，赐予、传授的意思。

③ 方士：方术之士，此指医师。

④ 要道：指医学中重要的理论与技术。

⑤ 桴鼓相应：槌敲鼓声即应，比喻收效迅速。桴，击鼓之槌。

⑥ 拔刺雪汙：拔出皮中之刺，洗去脸上之污，比喻指治疗得心应手、非常顺利。雪，洗也。汙，同"污"。

⑦ 工巧神圣：形容医师的诊法技术非常高明。《难经·六十一难》云："望而知之谓之神，闻而知之谓之圣，问而知之谓之工，切脉而知之谓之巧"。

⑧ 病机：疾病发生、发展、变化的机制。

⑨ 气宜：六气各有主时之宜，此指六气主时的规律。

39 诸风掉眩，皆属于肝。诸寒收引，皆属于肾。诸气膹郁，皆属于肺。诸湿肿满，皆属于脾。诸热瞀瘈，皆属于火。诸痛痒疮，皆属于心。诸厥固泄，皆属于下。诸痿喘呕，皆属于上。诸禁鼓慄，如丧神守，皆属于火。诸痉项强，皆属于湿。诸逆冲上，皆属于火。诸胀腹大，皆属于热。诸躁狂越，皆属于火。诸暴强直，皆属于风。诸病有声，鼓之如鼓，皆属于热。诸病胕肿，疼酸惊骇，皆属于火。诸转反戾，水液浑浊，皆属于热。诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒。诸呕吐酸，暴注下迫，皆属于热。（《素问·至真要大论》）

【提要】

论述疾病的病机与表现。

【词解】

① 掉：摇也，此指肢体动摇，如肌肉痉挛、震颤之类症状。

② 收引：肢体蜷缩、屈曲不伸的症状。收，收缩。引，牵引、拘急。

③ 膹郁：膹，同“贲”，此指气逆喘急。郁，拂郁，此指胸部胀闷。

④ 肿满：肌肤肿胀，腹部胀满。

⑤ 瞀瘛：瞀，昏糊。瘛，抽搐。

⑥ 痒：《说文解字》：“痒，疡也”，即疮疡。

⑦ 腑肿：皮肉肿胀溃烂。腑，同“腐”。

⑧ 暴注下迫：暴注，急剧的腹泻。下迫，下利窘迫，即里急后重。

**【句解】**

① 诸厥固泄：厥，手足逆冷或手足心发热的厥证。固，二便固闭不通。泄，二便泻利不禁。

② 诸禁鼓栗：禁，通“噤”，口噤不开。鼓栗，鼓颔战栗，形容恶寒之甚。

③ 诸痉项强：痉，病名，症见筋脉拘急，身体强直，牙关紧闭等。项强，颈项强直，转动不灵。

④ 诸逆冲上：各种气逆上冲的症状，如呕吐、呃逆等。

⑤ 诸躁狂越：躁，手足躁扰，坐卧不宁。狂，神志狂乱。越，言行举止乖乱失常。

⑥ 诸暴强直：暴，卒然。强直，筋脉拘挛，身体强直不能屈伸。

⑦ 诸病有声，鼓之如鼓：病有声，指因病发出声响的症状。鼓之如鼓，腹胀敲之如鼓响。

⑧ 诸转反戾：筋脉拘挛所致的症状。转，身体左右扭转。反，角弓反张。戾，身曲不直，如犬出户下。

40 故《大要》曰：谨守病机，各司其属，有者求之，无者求之，盛者责之，虚者责之，必先五胜，疏其血气，令其调达，而致和平。此之谓也。（《素问·至真要大论》）

**【提要】**

从临床病象入手，结合藏象理论，分析病象，辨识其病变的原因、性质、部位及邪正交争的态势。

**【句解】**

① 有者求之，无者求之：有此症当探求其机制，无彼症亦应探其因，务求与病机相契合。有者、无者，指与病机相应之症的有无。

② 盛者责之，虚者责之：盛实者，当责究其邪气致病情况；虚弱者，当责究其正气不足的情况。盛者，邪气实；虚者，正气不足。

③ 必先五胜：先要掌握天之五气和人之五脏之气的偏盛偏衰。五胜，五行之气更替相胜，而五脏之气与之相应，故常将两者联系起来分析。

【拓展】

历代医家对“有者求之，无者求之”注解不一，众说纷纭，但都有道理，值得参考。观点一，认为此二句意为辨别症状与病机间的对应关系，并推求有或无此症此机的道理，以最终确定病机的归属；观点二，认为“有”“无”针对病机十九条，即疾病所表现的症状、体征。病机十九条已有论述的，可根据其所示以探求其病位、病性之归属。若病机十九条尚未论述的，亦可根据同中求异，异中求同，各司其属的精神予以分析；观点三，从分析病机的角度，将此二句理解为根据一般病机推论，不应该出现某症状、体征而出现者，当探求其何以出现的机制。应该出现某症状、体征而未出现者，亦应寻求其不出现的机制；观点四，认为“有”“无”针对外邪，即有外邪者，当求其外感何邪；无外邪者，当求其内伤何因。

41 帝曰：何谓逆从？岐伯曰：逆者正治，从者反治，从少从多，观其事也。帝曰：反治何谓？岐伯曰：热因寒用，寒因热用，塞因塞用，通因通用，必伏其所主，而先其所因。其始则同，其终则异，可使破积，可使溃坚，可使气和，可使必已。（《素问·至真要大论》）

【提要】

论述正治反治和虚实寒热真假的治疗原则。

【句解】

① 热因寒用，寒因热用：此论反治法，据下文“塞因塞用，通因通用”之例当改为“热因热用，寒因寒用”。即以热性药物治疗真寒假热之证，以寒性药物治疗真热假寒之证。如用通脉四逆汤治疗脉微欲绝，其人面色赤之假热证，用白虎汤治脉滑而厥之里热证。

② 塞因塞用：用补益药治疗正虚所致的胀满闭塞不通之证。如用补中益气汤治疗脾虚便秘之证，此为真虚假实。

③ 通因通用：用通利攻下药治疗邪实于内的下利之证。如用承气汤治疗“热结旁流”之证，此为真实假虚。

④ 必伏其所主，而先其所因：治病一定要制服所导致的本质，又要先求其所发生的原因。张介宾注：“必伏其所主，制病之本也；先其所因者，求病之由也”。伏，制服、降伏；主，疾病的本质。

⑤ 其始则同，其终则异：反治法的用药初始，药性与假象相同，如以热药治假热，以寒药治假寒；治疗过程中，假象逐渐消失，真象显露，最终仍是药性与病性相反的治法。

42 帝曰：论言治寒以热，治热以寒，而方士不能废绳墨而更其

道也。有病热者，寒之而热，有病寒者，热之而寒，二者皆在，新病复起，奈何治？岐伯曰：诸寒之而热者取之阴，热之而寒者取之阳，所谓求其属也。（《素问·至真要大论》）

【提要】

论述阴阳虚衰所致虚寒、虚热的治则。

【句解】

① 诸寒之而热者取之阴：用寒药治热证，热势不减者，为阴虚发热，当用补阴之法治疗。

② 热之而寒者取之阳：用热药治寒证，寒象不消者，为阳虚生寒，当用补阳之法治疗。

43 天之在我者德也，地之在我者气也，德流气薄而生者也，故生之来谓之精，两精相搏谓之神，随神往来者谓之魂，并精而出入者谓之魄。（《灵枢·本神》）

【提要】

论述生命及精神意识、思维活动的产生。

【词解】

两精相搏：男女两性生殖之精相结合。

【句解】

① 德流气薄而生者：天德下流，地气上交，阴阳相错，升降相因，始有生化之机，产生生命。

② 随神往来者谓之魂：魂是神支配下的意识活动，如梦寐恍惚，变幻游行。

③ 并精而出入者谓之魄：魄是以精为物质基础的生理本能，如感知和动作等。

44 所以任物者谓之心，心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思，因思而远慕谓之虑，因虑而处物谓之智。（《灵枢·本神》）

【提要】

论述心神从“任物”到“处物”的活动过程。

【词解】

任物：主管认识和处理事物。任，担任、主管。

【句解】

① 心有所忆谓之意：心感知事物后，根据记忆产生意念，但尚未成定见之时的思维。

② 意之所存谓之志：意念积累之后形成的认识称之志。存，积累。志，志向。

③ 因志而存变谓之思：对已形成的认识进行反复思考的过程称为思。存变，反复思量。

④ 因思而远慕谓之虑：通过反复思考，对事物进行由近及远，由浅入深的推理、预测，称为虑。远慕，深谋远虑。

⑤ 因虑而处物谓之智：经过深思远虑而作出正确的判断和处理，称为智。

45 人受气于谷，谷入于胃，以传与肺，五藏六府皆以受气。其清者为营，浊者为卫，营在脉中，卫在脉外，营周不休，五十而复大会。阴阳相贯，如环无端。卫气行于阴二十五度，行于阳二十五度，分为昼夜，故气至阳而起，至阴而止。（《灵枢·营卫生会》）

**【提要】**

论述营卫的生成和运行。

**【句解】**

① 清者为营，浊者为卫：水谷精气之清纯柔和者为营，剽悍滑利捍卫者为卫。“清”与“浊”，指营卫之气的性能而言。

② 气至阳而起，至阴而止：卫气昼行于阳经则寤，夜行于阴经则寐。

46 黄帝曰：夫血之与气，异名同类，何谓也？岐伯答曰：营卫者，精气也；血者，神气也。故血之与气，异名同类焉。故夺血者无汗，夺汗者无血。故人生有两死，而无两生。（《灵枢·营卫生会》）

**【提要】**

论述血与气的关系。

**【句解】**

营卫者，精气也；血者，神气也：营卫都由水谷精气化生，血是水谷精微奉心神化生的。

47 黄帝曰：余闻人有精、气、津、液、血、脉，余意以为一气耳，今乃辨为六名，余不知其所以然。岐伯曰：两神相搏，合而成形，常先身生，是谓精。何谓气？岐伯曰：上焦开发，宣五谷味，熏肤、充身、泽毛，若雾露之溉，是谓气。何谓津？岐伯曰：腠理发泄，汗出溱溱，是谓津。何谓液？岐伯曰：谷入气满，淖泽注于骨，骨属屈伸，泄泽，补益脑髓，皮肤润泽，是谓液。何谓血？岐伯曰：中焦受气取汁，变化而赤，是谓

血。何谓脉？岐伯曰：壅遏营气，令无所避，是谓脉。（《灵枢·决气》）

【提要】

论述一气与六气的关系，以及六气的生成及生理作用。

【词解】

① 宣五谷味：宣发布散水谷之精微。

② 汗出溱溱：形容汗出较多。

③ 淖泽：水谷精微中质稠浊如膏泽的部分。

④ 壅遏：限制、约束。

48 黄帝问于岐伯曰：夫百病之始生也，皆生于风雨寒暑、清湿、喜怒。喜怒不节则伤脏，风雨则伤上，清湿则伤下。三部之气，所伤异类，愿闻其会。岐伯曰：三部之气各不同，或起于阴，或起于阳，请言其方。喜怒不节则伤脏，脏伤则病起于阴也；清湿袭虚，则病起于下；风雨袭虚，则病起于上，是谓三部。至于其淫泆，不可胜数。（《灵枢·百病始生》）

【提要】

依据病因来源、发病途径、侵犯人体的始发部位，对病因进行分类。

【词解】

① 三部之气：即伤于上部的风雨，伤于下部的清湿，伤于五脏的喜怒邪气。

② 淫泆：浸淫传布。

49 风雨寒热，不得虚，邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而不病者，盖无虚，故邪不能独伤人，此必因虚邪之风，与其身形，两虚相得，乃客其形，两实相逢，众人肉坚。其中于虚邪也，因于天时，与其身形，参以虚实，大病乃成。气有定舍，因处为名，上下中外，分为三员。（《灵枢·百病始生》）

【提要】

正气不足是发病的内在根据，邪气侵扰是发病的重要条件。

【词解】

虚邪之风：致病的异常气候。虚邪，虚风之邪，气候异常为虚风，气候正常为实风。

【句解】

① 不得虚：不遇到正气虚的机体。

② 两虚相得，乃客其形：虚邪遇到正气虚弱之人，则会留滞于人体而发病。

两虚，虚邪之风与正气虚弱的机体。相得，相逢、相遇。

50 忧思伤心；重寒伤肺；忿怒伤肝；醉以入房，汗出当风伤脾；用力过度，若入房汗出，浴则伤肾。此内外三部之所生病者也。（《灵枢·百病始生》）

**【提要】**

五脏受伤的病因。

# 二级条文(70条)

1 夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰朴。是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖不惧于物,故合于道。所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。(《素问·上古天真论》)

【提要】

提出三个养生要求:一是对外要适应自然环境,"虚邪贼风,避之有时";二是对内要调摄精神,保持"恬惔虚无",做到"精神内守";三是形神共养,形与神俱。

【词解】

① 虚邪贼风:泛指异常气候和外来致病因素。

② 恬淡虚无:思想闲静,没有杂念。恬惔,安静淡泊。虚无,心无杂念和妄想。

③ 不惧于物:不为外界物欲所惊扰。

④ 德全不危:懂得修身养性之道,并身体力行之,即可免受内外邪气的侵害。德,修养有得于心;全,全面实施养生之道。不危,不会有内外邪气干扰和侵害。

2 女子七岁,肾气盛,齿更发长。二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。三七,肾气平均,故真牙生而长极。四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕。六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。(《素问·上古天真论》)

【提要】

论述女子生长壮老的规律。

【词解】

① 天癸至:天癸是指肾气充盛而产生的促进生殖功能发育、成熟、旺盛的精微物质。天,先天;癸,癸水。至,极也,此有充盛之意。

② 平均：充满而均衡。

③ 真牙：智齿。

④ 地道不通：月经停止来潮。

3 丈夫八岁，肾气实，发长齿更。二八，肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子。三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极。四八，筋骨隆盛，肌肉满壮。五八，肾气衰，发堕齿槁。六八，阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白。七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾藏衰，形体皆极。八八，则齿发去。（《素问·上古天真论》）

【提要】

论述男子生长壮老的规律。

【词解】

阴阳和：指男女媾和。一说指男女气血阴阳调和。

4 夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也。逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人行之，愚者佩之。从阴阳则生，逆之则死，从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是谓内格。（《素问·四气调神大论》）

【提要】

论述顺应四时养生的原则及预防思想。

【词解】

① 佩：同“悖”，古通用。悖，违背，违反。

② 内格：人体内在生理功能与自然界四时阴阳变化不相协调。

【句解】

① 春夏养阳，秋冬养阴：在春夏季节要顺应自然界的生长规律来调养阳气，在秋冬季节要顺应自然界的收藏规律来调养阴气。养阳即养生养长，养阴即养收养藏。

② 与万物沉浮于生长之门：人与万物一样，在生长收藏的生命过程中运动不息。沉，隐没，此指收藏。浮，与沉相对而言，此指生长。门，门径，道路。

【拓展】

“春夏养阳，秋冬养阴”是《黄帝内经》重要的养生思想，它以“四时阴阳者，万物之根本”为理论依据，旨在强调顺应自然，强调人与四时的协调统一。认为春

夏阳气生长，养生应助养阳气；秋冬阳气收藏，养生应蓄养阴精。具体养生方法如起居作息要适合四时的昼夜长短，春夏要多室外活动，秋冬要安居少出。精神情志也要顺应四时，春夏要欢快活泼，秋冬要恬静内藏等。

后世医家进一步拓展《黄帝内经》“春夏养阳，秋冬养阴”的养生思想，主要有三类认识：观点一，以张志聪为代表，从阴阳虚盛而论，认为“春夏之时，阳盛于外而虚于内；秋冬之时，阴盛于外而虚于内。故圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根而培养也”。其意以内为根，春夏之时，人体阳气内虚，故养内虚之阳以从其根。秋冬之时，人体阴气内虚，故养内虚之阴以从其根。观点二，以张介宾为代表，从阴阳互根而论，认为养春夏之阳是为了养秋冬之阴，故春夏应避风凉生冷，以免伤其阳气。养秋冬之阴是为了养春夏之阳，故秋冬应忌纵欲过热，以免伤其阴气。观点三，以王冰为代表，从阴阳互制而论，认为春夏阳盛，宜食寒凉以制其阳，“全阴则阳气不极”。秋冬阴盛，宜食温热以抑其阴盛，“全阳则阴气不穷”。王冰认为养即制也，通过互制，达到互养，使阴阳不偏，平衡协调。

“春夏养阳，秋冬养阴”的养生原则，不仅用于指导养生，后世还拓展应用到疾病治疗，主要是指春夏治病要注意加用升浮药；秋冬治病要加用沉降药。如李时珍在《本草纲目·卷一》中指出：“升降浮沉则顺之，寒热温凉则逆之，故春月宜加辛温之药，薄荷、荆芥之类，以顺春升之气；夏月宜加辛热之药，香薷、生姜之类，以顺夏浮之气……秋月宜加酸温之药，芍药、乌梅之类，以顺秋降之气；冬月宜加苦寒之药，黄芩、知母之类，以顺冬沉之气，所谓顺时气而养天和地”。

近代医家对此原则又提出许多新的见解，如冬病夏治，夏病冬治；春夏温补阳气，秋冬滋养阴液；春夏调理肝心，秋冬调理肺肾；春夏顾护六腑，秋冬调补五脏；依据体质偏颇，顺应四时调补等。

5 是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎！（《素问·四气调神大论》）

**【提要】**

论述治未病。

**【拓展】**

治未病包括未病先防和既病防变两方面，本条所论侧重于未病先防，并以“渴而穿井，斗而铸锥”之喻，强调治未病的重要性。

《黄帝内经》治未病思想对后世影响深远，如张仲景在《金匮要略》中明确指出：“夫治未病者，见肝之病，知肝传脾，当先实脾”；葛洪指出：“是以圣人消未起之患，治未病之疾，医之于无事之前，不追于既逝之后”；朱震亨也说：“与其救疗

于有疾之后，不若摄养于无疾之先，盖疾成而后药者，徒劳而已。是故已病而后治，所以为医家之法；未病而先治，所以明摄生之理。夫如是，则思患而预防之者，何患之有哉？此圣人不治已病治未病之意也”。明代医家徐春甫在批评不知治病于微者时说：“今人治已病不治未病，盖谓病形未着，不加慎防，直待病势已着，而后求医以治之，则其微之不谨，以至于着，斯可见矣”。

6 阳气者若天与日，失其所则折寿而不彰，故天运当以日光明。是故阳因而上，卫外者也。（《素问·生气通天论》）

**【提要】**

根据“天人相应”思想，应用取象比类方法，论述阳气的重要性。

**【词解】**

① 折寿而不彰：人的寿命夭折而不彰著于世。

② 天运：天体的运行。

7 阳气者，烦劳则张，精绝，辟积于夏，使人煎厥。目盲不可以视，耳闭不可以听，溃溃乎若坏都，汩汩乎不可止。

阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥。有伤于筋，纵，其若不容。汗出偏沮，使人偏枯。汗出见湿，乃生痤痈。高梁之变，足生大丁，受如持虚。劳汗当风，寒薄为皶，郁乃痤。（《素问·生气通天论》）

**【提要】**

论述阳亢阴竭、阳气逆乱、阳气偏阻、阳热滞积、阳气郁遏等阳气的病理变化。

**【词解】**

① 烦劳则张：“烦”通“繁”，频繁。烦劳即过于劳累。张，亢盛，过盛。

② 煎厥：古病名。逢夏季之盛阳，阳气亢盛无制，煎熬阴精所致阳气上逆昏厥的病症。

③ 汩汩：水势急流的样子。

④ 菀：通“郁”，郁结。

⑤ 薄厥：古病名。因大怒而气血上冲，脏腑经脉之气阻绝不通所导致的昏厥病。“薄”，通“暴”，突然。

⑥ 其若不容：肢体不能随意运动。若，乃。“容”，通“用”。

⑦ 汗出偏沮：半身汗出，半身无汗。沮，阻止。

⑧ 受如持虚：形容患病之易，就像拿着空虚的器皿受纳东西一样容易。

⑨ 皶：粉刺。

8 阳气者，精则养神，柔则养筋。开阖不得，寒气从之，乃生大偻。陷脉为瘘，留连肉腠。俞气化薄，传为善畏，及为惊骇。营气不从，逆于肉理，乃生痈肿。魄汗未尽，形弱而气烁，穴俞以闭，发为风疟。（《素问·生气通天论》）

【提要】

论述阳气的生理功能，以及阳虚邪恋的病理变化

【词解】

① 大偻：腰背和下肢弯曲，不能直起之病。

② 俞气化薄：邪气从腧穴传入而内迫五脏。

③ 魄汗：体汗。

【句解】

精则养神，柔则养筋：当作“养神则精，养筋则柔”解。精，精神爽慧；柔，筋脉柔和，活动自如。

9 阴者藏精而起亟也；阳者卫外而为固也。阴不胜其阳，则脉流薄疾，并乃狂。阳不胜其阴，则五藏气争，九窍不通。是以圣人陈阴阳，筋脉和同，骨髓坚固，气血皆从。如是则内外调和，邪不能害，耳目聪明，气立如故。（《素问·生气通天论》）

【提要】

论述阴精与阳气的辨证关系。

【词解】

① 起亟：阴精与阳气相应。亟，频数。

② 脉流薄疾：脉中气血流动急迫迅速。“薄”，通“迫”。

③ 并乃狂：阳邪入于阳分，阳热内盛，扰乱神明而发为狂病。

④ 五藏气争：五脏功能失调，气机失和。

10 故积阳为天，积阴为地。阴静阳躁，阳生阴长，阳杀阴藏。阳化气，阴成形。寒极生热，热极生寒。寒气生浊，热气生清。清气在下，则生飧泄；浊气在上，则生腹胀。此阴阳反作，病之逆从也。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

以自然现象说明阴阳的属性特征，阴阳相互对立、相互依存、相互转化的关系，并以此说明人体的生理病理现象。

【词解】

膜胀：胸膈胀满。

【句解】

阳生阴长，阳杀阴藏：互文。阴阳既为生杀之本，亦为长藏之本。阳既能生万物，亦能杀万物；阴既能长万物，亦能藏万物。

11 水为阴，火为阳，阳为气，阴为味。味归形，形归气，气归精，精归化，精食气，形食味，化生精，气生形。味伤形，气伤精，精化为气，气伤于味。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论述味、形、气、精、化的关系。

【句解】

① 味归形，形归气：药物饮食五味有滋养形体的作用，而形体又依赖于真气的充养。归，归附、归属，在此有滋养、充养、化生之义。形，形体，包括脏腑精血等有形物质。气，人体的真元之气。

② 气归精，精归化：药物饮食之气有化生阴精的作用，而人体的阴精又依赖气化功能产生。气，药食之气。化，气化、化生。

③ 精食气，形食味：补充说明“气归精，味归形”。食，音义同“饲”，以食予人。

④ 化生精，气生形：补充说明“精归化”“形归气”。精归化，故化生精。形归气，故气生形。

⑤ 味伤形，气伤精：指味归形、形食味及气归精、精食气的太过自伤。

⑥ 精化为气，气伤于味：阴精化生元气，元气因药物饮食之味太过而耗伤。

12 阴味出下窍，阳气出上窍。味厚者为阴，薄为阴之阳。气厚者为阳，薄为阳之阴。味厚则泄，薄则通。气薄则发泄，厚则发热。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论药物饮食气味的阴阳属性及其性能。

【句解】

阴味出下窍，阳气出上窍：凡药物饮食之味属阴，多沉降下行而走下窍；凡药物饮食之气属阳，多升散上行而达上窍。

13 寒伤形，热伤气。气伤痛，形伤肿。故先痛而后肿者，气伤形也；先肿而后痛者，形伤气也。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论寒热邪气伤人的特点。

【词解】

气：气机。

14 天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑燥湿风。人有五藏五气，以生喜怒悲忧恐。故喜怒伤气，寒暑伤形。暴怒伤阴，暴喜伤阳。厥气上行，满脉去形。喜怒不节，寒暑过度，生乃不固。故重阴必阳，重阳必阴。故曰：冬伤于寒，春必温病；春伤于风，夏生飧泄；夏伤于暑，秋必痎疟；秋伤于湿，冬生咳嗽。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论述外感六淫、内伤七情的致病特点，以及“伏邪”发病。

【词解】

① 厥气：此指病机，气血阴阳逆乱。

② 满脉：经络血脉扩张。

15 故邪风之至，疾如风雨，故善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治筋脉，其次治六府，其次治五藏。治五藏者，半死半生也。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

外感邪气侵犯人体的传变规律是由浅入深，由表及里。提示治疗疾病的层次必须准确，并强调早期治疗与预防传变的重要性。

16 病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。故因其轻而扬之，因其重而减之，因其衰而彰之。形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论治病要掌握时机，因势利导。

【句解】

① 形不足者，温之以气：阳气不足者，宜用气厚之品。

② 精不足者，补之以味：阴精虚损者，宜用味厚之品。

17 其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中满者，泻之于内；其有邪者，渍形以为汗；其在皮者，汗而发之；其慓悍者，按而收之；其实者，散而泻之。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论述因势利导的治则思想。

【句解】

其剽悍者，按而收之：腠理不固，卫阳耗散之证，宜用固摄收敛之法。

18 审其阴阳，以别柔刚，阳病治阴，阴病治阳，定其血气，各守其乡，血实宜决之，气虚宜掣引之。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论述因势利导的治则思想。

【句解】

气虚宜掣引之：气虚证宜用益气升提之法。

【拓展】

“因势利导”本是中国古代兵法术语，如《史记·孙子吴起列传》云：“善战者，因其势而利导之”。《黄帝内经》虽未直接引用此语，但在论述治则治法的诸多篇章都反映出“因势利导”思想，强调具体治法必须根据邪正的虚实强弱、病位的上下表里、病势的盛衰进退，顺势而为。

19 凡此十二官者，不得相失也。故主明则下安，以此养生则寿，殁世不殆，以为天下则大昌。主不明则十二官危，使道闭塞而不通，形乃大伤，以此养生则殃，以为天下者，其宗大危，戒之戒之！（《素问·灵兰秘典论》）

【提要】

强调以心为主宰协调下的五脏一体观及其重要性。

【词解】

① 主明：明，圣明，此指心脏的生理功能正常。

② 相失：彼此失去正常的协调关系。

③ 使道：相使之道，即脏腑相互联系的通道。

20 脑、髓、骨、脉、胆、女子胞，此六者地气之所生也，皆藏于阴而象于地，故藏而不泻，名曰奇恒之府。夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胱，此五者，天气之所生也，其气象天，故泻而不藏，此受五藏浊气，名曰传化

之府。此不能久留，输泻者也。魄门亦为五藏使，水谷不得久藏。所谓五藏者，藏精气而不泻也，故满而不能实。六府者，传化物而不藏，故实而不能满也。所以然者，水谷入口，则胃实而肠虚；食下，则肠实而胃虚。故曰实而不满，满而不实也。（《素问·五藏别论》）

【提要】

论述“脏藏腑泻”的功能特点，以及脏与腑的区别。

【句解】

① 此受五藏浊气：五脏不与外界直接相通，故通过六腑帮助其排泄浊气。浊气，五脏气化后的产物。

② 满而不能实：五脏贮藏精气的特点是保持盈满，但不能壅滞不畅。张介宾注：“精气质清，藏而不泻，故但有充满而无积实”。

③ 实而不能满：六腑传化水谷的基本特点是虚实更迭，不能满滞不行。

【拓展】

“魄门亦为五藏使”旨在揭示大便虽由肛门排泄，却要受到五脏的支配，是整体观在脏腑生理功能方面的体现。正常情况下，肛门启闭功能，受到心神主宰，肝气条达，脾气升提，肺气宣降，肾气固摄，方能不失常度。因此，肛门的启闭功能不仅反映了消化道功能正常与否，还反映出五脏的功能状况。五脏功能失调，可导致肛门启闭异常而见便秘、泄泻等病症。故便秘、泄泻等疾病可通过调理五脏而治疗。

21 帝曰：气口何以独为五藏主？岐伯曰：胃者，水谷之海，六府之大源也。五味入口，藏于胃以养五藏气，气口亦太阴也。是以五藏六府之气味，皆出于胃，变见于气口。故五气入鼻，藏于心肺，心肺有病，而鼻为之不利也。（《素问·五藏别论》）

【提要】

论述诊寸口脉以察全身疾病的原理。

【句解】

气口亦太阴也：气口虽为手太阴，而实即足太阴所归。

22 帝曰：形弊血尽而功不立者何？岐伯曰：神不使也。帝曰：何谓神不使？岐伯曰：针石，道也。精神不进，志意不治，故病不可愈。今精坏神去，营卫不可复收，何者？嗜欲无穷，而忧患不止，精气弛坏，荣泣卫除，故神去之而病不愈也。（《素问·汤液醪醴论》）

【提要】

强调神气在疾病治疗和转归中的重要意义。

【词解】

道：导引。

【句解】

① 神不使：神气衰败，对各种治疗都不能作出反应。

② 精气弛坏，营泣卫除：精气败坏，营卫之气运行凝涩，丧失了正常功能。泣(sè)，音义同“涩”。

23 帝曰：夫病之始生也，极微极精，必先入结于皮肤。今良工皆曰：病成名曰逆，则针石不能治，良药不能及也。今良工皆得其法，守其数，亲戚兄弟远近音声日闻于耳，五色日见于目，而病不愈者，亦何暇不早乎？岐伯曰：病为本，工为标，标本不得，邪气不服，此之谓也。(《素问·汤液醪醴论》)

【提要】

基于患者神气在疾病治疗和转归中的重要作用，强调“病为本，工为标”。

【句解】

① 守其数：遵循治病的规律与法则。

② 标本不得：患者的机体为本，医师的治疗措施为标。若患者神机衰败，医师治疗难以发挥应有的作用。

【拓展】

对于“病为本，工为标”的理解，古今医家大致有三种解释。其一，患者的神机为本，医师的治疗措施为标，程士德等持此观点；其二，患者为本，医师为标，“标本不得”指患者和医师不配合，王冰、吴崑、张介宾等持此观点；其三，疾病为本，医师的治疗手段为标，杨上善等持此观点。上述观点，各有其理。结合上下文意，第一类观点或更恰当，强调神气在疾病的治疗和转归中的重要作用。

24 切脉动静而视精明，察五色，观五藏有余不足，六府强弱，形之盛衰，以此参伍，决死生之分。(《素问·脉要精微论》)

【提要】

论述四诊合参的诊病原则。

【词解】

参伍：彼此相参互证。

25 夫脉者，血之府也，长则气治，短则气病，数则烦心，大则病进，上盛则气高，下盛则气胀，代则气衰，细则气少，涩则心痛，浑浑革至如涌泉，病进而色弊，绵绵其去如弦绝，死。（《素问·脉要精微论》）

【提要】

论述脉象原理，以及病脉举例。

【句解】

① 浑浑革至如涌泉：脉来如汹涌的泉水，洪大而急速，提示病情加剧而危重（太过）。

② 绵绵其去如弦绝：脉来微弱不显，似有似无，缓慢迟滞，乃至如弓弦猝断，为脏气衰竭，生机已尽，故主死（不及）。

26 夫精明者，所以视万物，别白黑，审短长。以长为短，以白为黑，如是则精衰矣。（《素问·脉要精微论》）

【提要】

面目的神色变化，可以测知人体脏腑气血的盛衰，预测疾病的顺逆，是中医望诊的重要内容。

27 五藏者，中之守也，中盛脏满，气胜伤恐者，声如从室中言，是中气之湿也。言而微，终日乃复言者，此夺气也。衣被不敛，言语善恶，不避亲疏者，此神明之乱也。仓廪不藏者，是门户不要也。水泉不止者，是膀胱不藏也。得守者生，失守者死。（《素问·脉要精微论》）

【提要】

从望、闻、问诊查病情以判断疾病的性质，以及五脏失守的吉凶。

【句解】

中盛脏满：腹中邪盛，气机壅滞以致脏气胀满。中，体内。脏满，内脏之气胀满。

【拓展】

“五藏者，中之守也”是闻诊、问诊的理论依据。人以五脏为本，五脏主藏精气、舍神明而居守于内，是生命活动的内在基础。人体生命活动的种种外在表现，都是五脏所藏精气神反映于外的征象。五脏精足、气充、神旺，藏而勿失，则语声、二便等功能活动正常，故曰“得守者生”；若五脏精亏、气虚、神衰，不能内守而妄泄，则语声、二便等失常，提示疾病预后不良，故曰“失守者死”。

28 夫五藏者，身之强也，头者，精明之府，头倾视深，精神将夺

矣。背者，胸中之府，背曲肩随，府将坏矣。腰者，肾之府，转摇不能，肾将惫矣。膝者，筋之府，屈伸不能，行则偻附，筋将惫矣。骨者，髓之府，不能久立，行则振掉，骨将惫矣。得强则生，失强则死。（《素问·脉要精微论》）

**【提要】**

望形态可以测知内脏的病变，并指出五脏是形体强健的根本。

**【词解】**

① 头倾视深：头低垂不能举，目光深陷无神。视，眼睛。

② 惫：同“败”，败坏、衰败。

③ 偻附：身体屈曲不伸，必依附外物而行。偻，曲也。附，依附。

**【拓展】**

“夫五藏者，身之强也”是望形体以诊察疾病的理论依据。五脏精气为身形强健之根本，头、背、腰、膝、骨是产生形体动态的五个重要部位，是五脏精气聚集之处，称为“五府”。因此，通过观察“五府”的动静姿态，可以察知五脏精气的盛衰。

29 是故冬至四十五日，阳气微上，阴气微下；夏至四十五日，阴气微上，阳气微下。阴阳有时，与脉为期，期而相失，知脉所分，分之有期，故知死时。微妙在脉，不可不察，察之有纪，从阴阳始，始之有经，从五行生，生之有度，四时为宜，补泻勿失，与天地如一，得一之情，以知死生。是故声合五音，色合五行，脉合阴阳。（《素问·脉要精微论》）

**【提要】**

自然界四时阴阳的变化规律，以冬至和夏至为两个转折点。强调诊断时要“分之有期”，即根据四时生理脉象的标准来分析判断病理脉象的变化，从而指导临床治疗。

30 黄帝问曰：平人何如？岐伯对曰：人一呼脉再动，一吸脉亦再动，呼吸定息，脉五动，闰以太息，命曰平人。平人者，不病也。常以不病调病人，医不病，故为病人平息，以调之为法。（《素问·平人气象论》）

**【提要】**

论述平人呼吸与脉率的关系，以及平息调脉的基本方法。

**【句解】**

闰以太息：脉搏有余不尽而又复动一次，即“脉五动”。

【拓展】

“为患者平息，以调之为法”，是《黄帝内经》“知常达变”方法在诊法上的具体体现和运用。医师通过平调自己的呼吸，以测定患者脉搏的频率、节律。该方法历经两千多年的实践，至今仍不失为简便、可行和有效的方法。其依据就是“以不病调患者”而“医不病”。显而易见，是以健康人的表现作为标准，去衡量患者的体征，这是有着科学依据与事实基础的，因为任何异常都是正常的改变，而正常的改变必然导致相应的异常。

31 黄帝曰：余闻虚实以决死生，愿闻其情。岐伯曰：五实死，五虚死。帝曰：愿闻五实五虚。岐伯曰：脉盛，皮热，腹胀，前后不通，闷瞀，此谓五实。脉细，皮寒，气少，泄利前后，饮食不入，此谓五虚。帝曰：其时有生者，何也？岐伯曰：浆粥入胃，泄注止，则虚者活；身汗得后利，则实者活。此其候也。（《素问·玉机真脏论》）

【提要】

论述“五实”“五虚”的表现与转归。

【词解】

① 闷瞀：心胸烦闷，眼目昏花。

② 后利：大便通利。

【拓展】

“五实”是邪气亢盛，充斥于五脏的临床表现，“五虚”是正气衰败的临床表现。祛邪以出外，扶正以存内，至为关键。治疗实证在于给邪气以出路，使在表之邪随汗而解，在里之邪随便而出，邪气去则正气可存，生机恢复有望。虚证的转机，在于浆粥尚能入胃则表明胃气尚存，人体即可得到水谷精微的资助补充。泄利停止，说明气血津液不再继续流失耗散，五脏精气有望恢复。

可见，疾病的预后转归，取决于病势发展的顺逆，对于实证要及时驱邪，开通邪气的出路，可采用汗、吐、攻下、放血等治法。对于虚证要及时补充精气来源，减少气血津液的流失，以恢复胃气为前提。

32 毒药攻邪，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气。（《素问·藏气法时论》）

【提要】

五谷、五果、五畜、五菜等药食有五味，五味分属四（五）时、五脏，药食气味在养生与治病中各有不同的作用。

33 故喉主天气，咽主地气。故阳受风气，阴受湿气。故阴气从足上行至头，而下行循臂至指端；阳气从手上行至头，而下行至足。故曰阳病者上行极而下；阴病者下行极而上。故伤于风者，上先受之；伤于湿者，下先受之。（《素问·太阴阳明论》）

【提要】

阴经和阳经因其阴阳属性、循行部位等不同，疾病的发病部位、传变趋向等也各有所别。

34 帝曰：脾与胃以膜相连耳，而能为之行其津液何也？岐伯曰：足太阴者，三阴也，其脉贯胃属脾络嗌，故太阴为之行气于三阴。阳明者表也，五藏六府之海也，亦为之行气于三阳。脏腑各因其经而受气于阳明，故为胃行其津液。四支不得禀水谷气，日以益衰，阴道不利，筋骨肌肉无气以生，故不用焉。（《素问·太阴阳明论》）

【提要】

论“脾主四肢”的原理。

【拓展】

脾与胃的关系密切，共为后天之本。脾主运化，具有转输、升清、主四肢等生理功能。若“脾病不能为胃行其津液”，四肢失却水谷精微的充养，可见肌肉枯萎、功能丧失之痿病，根据本论，治以健脾、益气、升清的补中益气汤方类，常获良效。

35 治之各通其脏脉，病日衰已矣。其未满三日者，可汗而已；其满三日者，可泄而已。（《素问·热论》）

【提要】

论外感热病的治疗原则与具体治法。

【拓展】

根据疾病在某一脏腑所连属经脉，采用针刺方法疏通其经，以使气血畅通，不仅发热可退，亦可逐邪外出。根据病程长短与病位深浅，可选择发汗或泄热之法。若邪气尚在三阳之表，当用发汗解表法；若邪气已入三阴之里，则当用清泄里热法。本条经文体现了《黄帝内经》辨证论治与因势利导的治疗观念，《伤寒论》在此基础上，提出的汗、吐、下、和、温、清、消、补等法，则是对本论内容的丰富和发展。

36 帝曰：热病已愈，时有所遗者何也？岐伯曰：诸遗者，热甚而

强食之，故有所遗也。若此者，皆病已衰而热有所藏，因其谷气相薄，两热相合，故有所遗也。帝曰：善。治遗奈何？岐伯曰：视其虚实，调其逆从，可使必已矣。帝曰：病热当何禁之？岐伯曰：病热少愈，食肉则复，多食则遗，此其禁也。（《素问·热论》）

【提要】

论述伤寒热病遗复与饮食禁忌。

【拓展】

热病开始减退，尚未痊愈，正气尚未完全恢复，脾胃虚弱，运化力差，此时若强食肉类或暴饮暴食，不仅难于消化，还可使未尽余热与谷气之热两相结合，以使热邪反炽，导致热病复发或余热迁延不去。

37 黄帝问曰：有病温者，汗出辄复热，而脉躁疾不为汗衰，狂言不能食，病名为何？岐伯对曰：病名阴阳交，交者死也。帝曰：愿闻其说。岐伯曰：人所以汗出者，皆生于谷，谷生于精。今邪气交争于骨肉而得汗者，是邪却而精胜也，精胜则当能食而不复热，复热者邪气也，汗者精气也，今汗出而辄复热者，是邪胜也，不能食者，精无俾也，病而留者，其寿可立而倾也。且夫《热论》曰：汗出而脉尚躁盛者死。今脉不与汗相应，此不胜其病也，其死明矣。狂言者，是失志，失志者死。今见三死，不见一生，虽愈必死也。（《素问·评热病论》）

【提要】

论述阴阳交的概念、病机、表现与预后。

【词解】

① 阴阳交：阳邪在表不解，由阳分深入阴分，与阴精交结不解，以致阴精耗竭的危重症。

② 三死：指在汗出辄复热的同时，出现不能食、脉躁疾、狂言三症。

【拓展】

阳热邪气唯借阴精正气以制胜的观点，对临床实践及后世温病学说的形成与发展均有重要指导意义。凡温病汗出，若见脉静身凉，为邪随汗出的佳兆；若汗出热不退，脉象躁盛，是正不胜邪的凶象；如更见烦躁不安，汗出如豆，气喘，神昏，谵语等症状，则是温邪劫烁津液，精气耗竭的危候。后世温病学说“治温病宜刻刻顾其津液”“留得一分津液，便有一分生机”“热病以救阴为先，救阴以泄热为要”等理论，无不受本文观点的启发和影响。

38 此皆聚于胃，关于肺，使人多涕唾而面浮肿气逆也。（《素

问·咳论》）

【提要】

咳病与肺胃关系最为密切。

【拓展】

脾主运化，转输水液上输于肺，而肺脉“还循胃口”。脾失运化，水湿集聚，易上逆于肺，贮存为痰，闭阻宣降而生咳嗽，此即“聚于胃，关于肺”的道理。后世“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”之说，实源于此，从而就有了“治咳先治痰，治痰先治脾”的经验之谈。

39 怒则气逆，甚则呕血及飧泄，故气上矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

怒则气上的病机。

【词解】

飧泄：泻下夹有未完全消化的食物。《针灸甲乙经》《黄帝内经太素》均作“食而气逆”，可参。

40 喜则气和志达，荣卫通利，故气缓矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

喜则气缓的病机。

【词解】

气缓：此指气机运行过于迟缓，以致涣散而为病。

41 悲则心系急，肺布叶举，而上焦不通，荣卫不散，热气在中，故气消矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

悲则气消的病机。

【词解】

心系急：心与肺相连的脉络拘急。

42 恐则精却，却则上焦闭，闭则气还，还则下焦胀，故气不行矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

恐则气下的病机。

【词解】

① 精却：精气下陷。却，退也。

② 气不行：林亿云："当为'气下行'也"。与上文"恐则气下"义合，为是。

43 寒则腠理闭，气不行，故气收矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

寒则气收的病机。

44 炅则腠理开，荣卫通，汗大泄，故气泄。（《素问·举痛论》）

【提要】

炅则气泄的病机。

【词解】

气泄：热使腠理开而汗大泄，气随汗泄。

45 惊则心无所倚，神无所归，虑无所定，故气乱矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

惊则气乱的病机。

46 劳则喘息汗出，外内皆越，故气耗矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

劳则气耗的病机。

【词解】

外内皆越：过度劳累而喘息，又兼汗出，喘息则气从内而散，汗出则气从外而散，故曰外内皆越。越，散失。

47 思则心有所存，神有所归，正气留而不行，故气结矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

思则气结的病机。

48 帝曰：其有五者何也？岐伯曰：以冬遇此者为骨痹，以春遇此者为筋痹，以夏遇此者为脉痹，以至阴遇此者为肌痹，以秋遇此者为皮痹。（《素问·痹论》）

【提要】

论五体痹与季节时邪的关系。

49 帝曰：荣卫之气，亦令人痹乎？岐伯曰：荣者，水谷之精气也，和调于五藏，洒陈于六府，乃能入于脉也，故循脉上下，贯五藏，络六府也。卫者，水谷之悍气也，其气慓疾滑利，不能入于脉也，故循皮肤之中，分肉之间，熏于肓膜，散于胸腹。逆其气则病，从其气则愈。不与风寒湿气合，故不为痹。（《素问·痹论》）

【提要】

论营卫之气与痹证的关系。

【词解】

① 悍气：性质勇猛，运行急疾之气。

② 肓膜：泛指胸膜腔内及肉里间的脂膜。

【拓展】

痹病的发生，虽以风寒湿邪侵袭为重要条件，但营卫之虚是发病根本。治疗痹病，不仅要驱逐外邪，而且要扶助正气、养营益卫，是以黄芪、当归等药物，则在必用之列，更须贯穿始终，方能事半功倍，此亦“逆其气则病，从其气则愈”之精要所在。

50 黄帝问曰：五藏使人瘘，何也？岐伯对曰：肺主身之皮毛，心主身之血脉，肝主身之筋膜，脾主身之肌肉，肾主身之骨髓。故肺热叶焦，则皮毛虚弱急薄，著则生瘘蹙也。心气热，则下脉厥而上，上则下脉虚，虚则生脉瘘，枢折挈，胫纵而不任地也。肝气热，则胆泄口苦，筋膜干，筋膜干则筋急而挛，发为筋瘘。脾气热，则胃干而渴，肌肉不仁，发为肉瘘。肾气热，则腰脊不举，骨枯而髓减，发为骨瘘。（《素问·瘘论》）

【提要】

论瘘病与“五藏气热”病机。

【词解】

① 肺热叶焦：病机概念，指肺叶受到火热熏灼，导致津液损伤的病理状态。《黄帝内经太素》《针灸甲乙经》“肺”下均有“气”字，据其下文例，可从。

② 枢折挈：形容关节松弛，不能转动提举，犹如户枢断折，不能转动。枢，此指关节。折，断也。挈，提举。

【拓展】

瘘病病变部位通常表现在四肢，但发病根本却在五脏，尤以肺为关键。五脏精气津液均依赖肺气的敷布，方能濡养五体。若肺受邪热，精气津液被灼，肺失所养，可致肺叶焦缩，不能布散精气津液于四肢，五体失养，则发为瘘。

51 帝曰：如夫子言可矣，论言治痿者，独取阳明何也？岐伯曰：阳明者，五藏六府之海，主润宗筋，宗筋主束骨而利机关也。冲脉者，经脉之海也，主渗灌溪谷，与阳明合于宗筋，阴阳揔宗筋之会，会于气街，而阳明为之长，皆属于带脉，而络于督脉。故阳明虚，则宗筋纵，带脉不引，故足痿不用也。（《素问·痿论》）

【提要】

论“治痿独取阳明”的机制。

【词解】

宗筋：诸筋汇聚之处，此泛指全身筋膜。

【句解】

阴阳揔宗筋之会：阴经与阳经大会于前阴。宗筋，此指前阴。

52 帝曰：治之奈何？岐伯曰：各补其荥而通其俞，调其虚实，和其逆顺，筋脉骨肉，各以其时受月，则病已矣。（《素问·痿论》）

【提要】

论针刺治疗痿病的基本原则

【句解】

① 各补其荥而通其俞：针刺治疗，在所病之经脉。施以补法，针其荥穴以补其气；施以泻法，针其俞穴以行其气，即“调其虚实，和其逆顺”之意。

② 各以其时受月：分别在各脏所主的季节进行治疗。姚止庵注：“时受月者，五藏各有应旺之月，如肝伤则筋病，欲治筋病，必于春月木旺之时，因时以受旺月之气，则邪易去而正易复也”。

【拓展】

治疗痿病不仅要重视阳明，而且要针对相关脏腑经脉进行辨证论治，或补或泻。针刺的穴位只是示例，除针取荥穴和俞穴外，还可以循经取穴或近端取穴。此外，治痿病还可按照脏腑所主时令取穴论治，这对后世子午流注等治法有一定启示。

53 治反为逆，治得为从。

先病而后逆者治其本，先逆而后病者治其本。先寒而后生病者治其本，先病而后生寒者治其本，先热而后生病者治其本，先热而后生中满者治其标，先病而后泄者治其本，先泄而后生他病者治其本，必且调之，乃治其他病。先病而后先中满者治其标，先中满而后烦心者治其本。人有客气，有同气。小大不利治其标，小大利治其本。病发而有

余，本而标之，先治其本，后治其标。病发而不足，标而本之，先治其标，后治其本。谨察间甚，以意调之，间者并行，甚者独行。先小大不利而后生病者治其本。（《素问·标本病传论》）

**【提要】**

论标本缓急的治疗原则。

**【句解】**

① 间者并行：病情较轻者，应同时施用治标治本之法。间者，病轻。并行，标本同治。

② 甚者独行：病情重危者，应单独施用治标或治本之法。甚者，病重。独行，单用一法。

**【拓展】**

“治标与本”是《黄帝内经》五大治则之一。标本是一个相对概念，在《黄帝内经》中主要表示疾病的本质与现象，原因与结果，原发与继发。前者可决定后者属于本，后者受支配于前者，属于标。通常情况下，治宜从本，本论十种所谓治本之例即为此意。有时，“标”特别严重，有碍治本，甚至威胁生命（中满、小大不利等），此时权当从急，及时解除危急或治本的后顾之忧，后世所谓“急则治标，缓则治本”即由此悟出。

54 帝曰：善，五味阴阳之用何如？岐伯曰：辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。六者或收或散，或缓或急，或燥或润，或耎或坚，以所利而行之，调其气使其平也。（《素问·至真要大论》）

**【提要】**

论五味的阴阳属性及其作用。

**【词解】**

① 涌泄：催吐法和通泻法。张介宾注：“涌，吐也；泄，泻也”。

② 渗泄：利尿法。张介宾注：“渗泄，利小便及通窍也”。

③ 急：荡涤攻下。

④ 坚：坚阴止泻。

55 寒者热之，热者寒之，微者逆之，甚者从之，坚者削之，客者除之，劳者温之，结者散之，留者攻之，燥者濡之，急者缓之，散者收之，损者温之，逸者行之，惊者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，开之发之，适事为故。（《素问·至真要大论》）

【提要】

正治法举例。

【句解】

① 薄之劫之：用峻猛之药迫邪外出，或截邪发作。

② 适事为故：不论选用何种治法，一定要以适应病情为原则。

56 故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔。如是则僻邪不至，长生久视。（《灵枢·本神》）

【提要】

论养生法则。

【词解】

① 僻邪不至：邪气不能入侵人体。

② 长生久视：健康长寿。《吕氏春秋·本生》高诱注："视，活也"。

57 是故怵惕思虑者则伤神，神伤则恐惧流淫而不止。因哀悲动中者，竭绝而失生。喜乐者，神惮散而不藏。愁忧者，气闭塞而不行。盛怒者，迷惑而不治。恐惧者，神荡惮而不收。（《灵枢·本神》）

【提要】

论情志致病的特点。

【词解】

① 怵惕：恐惧惊慌。

② 流淫：此指滑精、带下之类病症。

③ 动中：伤及内脏。动，动摇，引申为损伤。中，内脏。

④ 竭绝而失生：内脏精气衰竭而丧失生命。

58 心怵惕思虑则伤神，神伤则恐惧自失，破胭脱肉，毛悴色夭，死于冬。（《灵枢·本神》）

【提要】

论情志过激，耗伤心神的表现及预后。

【词解】

① 破胭脱肉：形容极度消瘦，或肌肉萎缩。胭，肌肉突起之处。

② 毛悴色夭：皮毛憔悴，色泽枯暗。

59 脾忧愁而不解则伤意，意伤则悗乱，四支不举，毛悴色夭，死

于春。(《灵枢·本神》)

【提要】

论情志过激,伤及于脾的表现及预后。

【词解】

悗乱:心烦意乱。悗,同"闷"。

60 肝悲哀动中则伤魂,魂伤则狂忘不精,不精则不正,当人阴缩而挛筋,两胁骨不举,毛悴色夭,死于秋。(《灵枢·本神》)

【提要】

论情志过激,伤及于肝的表现及预后。

【词解】

狂忘不精:神志狂乱,言行妄为,愚钝不明,不能理事。忘,《黄帝内经太素》《针灸甲乙经》均作"妄",为是。不精,精明丧失、愚钝不明。

61 肺喜乐无极则伤魄,魄伤则狂,狂者意不存人,皮革焦,毛悴色夭,死于夏。(《灵枢·本神》)

【提要】

论情志过激,伤及于肺的表现及预后。

62 肾盛怒而不止则伤志,志伤则喜忘其前言,腰脊不可以俯仰屈伸,毛悴色夭,死于季夏。恐惧而不解则伤精,精伤则骨痠痿厥,精时自下。(《灵枢·本神》)

【提要】

论情志过激,伤及于肾的表现及预后。

63 是故五藏主藏精者也,不可伤,伤则失守而阴虚,阴虚则无气,无气则死矣。是故用针者,察观病人之态,以知精、神、魂、魄之存亡,得失之意,五者以伤,针不可以治之也。(《灵枢·本神》)

【提要】

情志过激伤及五脏精气神,甚者可导致生命危险,提醒医家治疗疾病要重视情志致病因素。

【词解】

五者以伤:神、魂、魄、意、志皆已受伤。以,通"已",已经。《黄帝内经太素》作"五藏已伤",亦可。

64 肝藏血，血舍魂，肝气虚则恐，实则怒。脾藏营，营舍意，脾气虚则四支不用，五藏不安，实则腹胀经溲不利。心藏脉，脉舍神，心气虚则悲，实则笑不休。肺藏气，气舍魄，肺气虚则鼻塞不利少气，实则喘喝胸盈仰息。肾藏精，精舍志，肾气虚则厥，实则胀，五藏不安，必审五藏之病形，以知其气之虚实，谨而调之也。（《灵枢·本神》）

【提要】

论五脏藏五神及其虚实病证的特点。

【词解】

① 经溲不利：诸注不一。有谓大小便不利，有谓月经不调。然月经不调、二便异常，脾气壅实皆可导致，故可并存。

② 厥：此指下肢发凉或发热。《素问·厥论》云："阳气衰于下，则为寒厥；阴气衰于下，则为热厥"。

【拓展】

本节所论，心、肝多侧重于神志病证，肺、脾、肾多侧重于躯体病证，但就五脏总体而言，更突出脾、肾两脏在五脏系统中的重要地位。因为肾为先天之本，脾为后天之本，脾肾病变更容易影响到其他脏腑，以致"五脏不安"，此观点对后世补土学派、温补学派提供了理论依据。

65 故曰：日中而阳陇为重阳，夜半而阴陇为重阴。故太阴主内，太阳主外，各行二十五度，分为昼夜。夜半为阴陇，夜半后而为阴衰，平旦阴尽而阳受气矣。日中为阳陇，日西而阳衰，日入阳尽而阴受气矣。夜半而大会，万民皆卧，命曰合阴。平旦阴尽而阳受气。如是无已，与天地同纪。（《灵枢·营卫生会》）

【提要】

论营卫二气的昼夜运行规律。

【词解】

① 陇：通"隆"，旺盛、强盛。

② 合阴：夜半子时为阴气最盛，营卫二气俱行于阴而大会于手太阴肺，故曰合阴。

③ 与天地同纪：营卫之气日夜运行不息，与自然界阴阳消长规律同步。纪，法则、规律。

【句解】

太阴主内，太阳主外：手太阴肺经主营气循行，而营行脉中，足太阳膀胱经主卫气循行，而卫行脉外。张介宾注："太阴，手太阴也。太阳，足太阳也。内言营

气，外言卫气。营气始于手太阴而复会太阴，故太阴主内。卫气始于足太阳而复会于太阳，故太阳主外”。

66 黄帝曰：愿闻中焦之所出。岐伯答曰：中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此，故独得行于经隧，命曰营气。（《灵枢·营卫生会》）

【提要】

论营气的来源及化生过程。

【词解】

经隧：此指十二经脉。

67 黄帝曰：六气者，有余不足，气之多少，脑髓之虚实，血脉之清浊，何以知之？岐伯曰：精脱者，耳聋；气脱者，目不明；津脱者，腠理开，汗大泄；液脱者，骨属屈伸不利，色夭，脑髓消，胫痠，耳数鸣；血脱者，色白，夭然不泽，其脉空虚。此其候也。（《灵枢·决气》）

【提要】

论六气耗脱的临床表现。

68 黄帝曰：六气者，贵贱何如？岐伯曰：六气者，各有部主也，其贵贱善恶，可为常主，然五谷与胃为大海也。（《灵枢·决气》）

【提要】

六气虽然不同，但皆由水谷精微所化生，与脾胃关系密切。

69 黄帝曰：夫百病之所始生者，必起于燥湿寒暑风雨，阴阳喜怒，饮食居处，气合而有形，得藏而有名，余知其然也。夫百病者，多以旦慧、昼安、夕加、夜甚，何也？岐伯曰：四时之气使然。（《灵枢·顺气一日分为四时》）

【提要】

疾病因阳气的消长及其抗邪能力的强弱而出现旦慧、昼安、夕加、夜甚的规律性变化。

【词解】

阴阳：此指男女性生活不节。

【句解】

① 气合而有形，得藏而有名：邪气入侵，邪气与正气相搏结，症状和体征反

映于外，据邪气所在脏腑或部位，而给予命名。气，邪气。合，侵入机体。形，病形，即疾病表现出来的脉症。得，停留。脏，脏腑，亦指某个部位。名，病证之名。

② 旦慧、昼安、夕加、夜甚：清晨减轻，白天稳定，傍晚加重，夜深严重。慧，神清气爽。安，自觉舒适。甚，病情严重。

70 黄帝曰：愿闻四时之气。岐伯曰：春生、夏长、秋收、冬藏，是气之常也，人亦应之。以一日分为四时，朝则为春，日中为夏，日入为秋，夜半为冬。朝则人气始生，病气衰，故旦慧；日中人气长，长则胜邪，故安；夕则人气始衰，邪气始生，故加；夜半人气入脏，邪气独居于身，故甚也。（《灵枢·顺气一日分为四时》）

【提要】

疾病的“旦慧、昼安、夕加、夜甚”特点与自然界阳气消长规律一致。

【词解】

人气：此指阳气。

# 三级条文(90条)

1 帝曰：有其年已老而有子者何也？岐伯曰：此其天寿过度，气脉常通，而肾气有余也。此虽有子，男不过尽八八，女不过尽七七，而天地之精气皆竭矣。帝曰：夫道者年皆百数，能有子乎？岐伯曰：夫道者能却老而全形，身年虽寿，能生子也。(《素问·上古天真论》)

【提要】

肾气有余是人年老而有子的原因。

【词解】

① 天寿过度：先天禀赋超过常人的限度。

② 天地：指男女。

③ 全形：保全形体，使之不衰。

2 春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣，夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生，生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚，此春气之应，养生之道也。逆之则伤肝，夏为寒变，奉长者少。(《素问·四气调神大论》)

【提要】

论春季养生之法。

【词解】

① 发陈：形容春季万物生发、欣欣向荣的自然景象。发，生发，发散。陈，敷布、布陈，也有理解为“陈旧”。王冰注：“春阳上升，气潜发散，生育庶物，陈其姿容，故曰发陈也”。

② 天地俱生，万物以荣：自然界生发之气旺盛，万物因此欣欣向荣。

③ 被发缓形：被，同“披”。《广雅·释诂》：“披，散也”。缓形，使身体舒缓。

④ 寒变：由于春季失于调摄，生长之气不足所致的寒性病变。

⑤ 奉长者少：供给夏季生长之气减少。姚止庵注：“苟不能应春而反逆其生发之气，至夏自违其融合之令，是所奉者少”，下文“奉收”“奉藏”“奉生”义同此。

3 夏三月，此谓蕃秀，天地气交，万物华实。夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外，此夏气之应，养长之道也。逆之则伤心，秋为痎疟，奉收者少，冬至重病。（《素问·四气调神大论》）

【提要】

论夏季养生之法。

【词解】

① 蕃秀：形容夏季万物生长茂盛的自然景象。王冰注："蕃，茂也，盛也。秀，华也，美也"。

② 华实：开花结果。华，同"花"。

③ 华英成秀：人的精神饱满，以适应夏气，成其秀美。张介宾注："华英，言神气也"。秀，茂盛、秀美，引申为旺盛、充沛。

④ 所爱在外：人的精神外向，意气舒展，顺应阳气宣发于外，像夏气如火上炎之象。

⑤ 痎疟：疟疾的总称。

4 秋三月，此谓容平，天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴，使志安宁，以缓秋刑，收敛神气，使秋气平，无外其志，使肺气清，此秋气之应，养收之道也。逆之则伤肺，冬为飧泄，奉藏者少。（《素问·四气调神大论》）

【提要】

论秋季养生之法。

【词解】

① 容平：秋季万物成熟，形态平定不再生长的自然景象。容，生态、相貌。平，平定。

② 以缓秋刑：减缓秋天肃杀之气的影响。缓，缓解。秋刑，秋天的气候能使草木凋谢，能使人体内的阳气收敛。张介宾注："肃杀之气"。

【句解】

天气以急，地气以明：秋风劲急，萧瑟肃杀，万物萧条，山川之象清肃景净。杨上善注："天气急者，风清气凉也。地气明者，山川景净也"。

5 冬三月，此谓闭藏，水冰地坼，无扰乎阳，早卧晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺，此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。（《素

问·四气调神大论》）

【提要】

论冬季养生之法。

【词解】

① 闭藏：形容冬季阳气闭藏，生机潜伏的自然景象。

② 坼：裂开、分裂。

③ 使气亟夺：亟，多次、频数。夺，耗夺、剥夺。

④ 痿厥：四肢枯萎、软弱无力的痿病，以及四肢逆冷的厥病。杨上善注："痿厥，不能行也，一曰偏枯也。"

6 故风者，百病之始也。清静则肉腠闭拒，虽有大风苛毒，弗之能害，此因时之序也。

故病久则传化，上下不并，良医弗为。故阳畜积病死，而阳气当隔。隔者当泻，不亟正治，粗乃败之。故阳气者，一日而主外，平旦人气生，日中而阳气隆，日西而阳气已虚，气门乃闭。是故暮而收拒，无扰筋骨，无见雾露，反此三时，形乃困薄。（《素问·生气通天论》）

【提要】

阳气闭阻不通的危证及调养方法。

【词解】

① 不并：失于交感、交通。并，合、交也。

② 粗：此指诊疗技术低劣的医师。

③ 暮而收拒：日暮之后，人的阳气内藏，故应清静安卧，以免阳气耗散。

④ 三时：此指平旦、日中、日西。

⑤ 形乃困薄：形体憔悴虚损。《广雅·释言》："困，悴也"。《吕氏春秋》高诱注："薄，犹损也"。

【拓展】

阳气闭阻不通则病重而危，治之当以通阳开闭为重为务。阳气失常，若治疗不及时，或治不得法，发展到气机闭阻不行，则有"阴阳离绝"之虞。经文之所以"上下不并""阳蓄积病死""阳气当隔"，三次指出同一病机，意在提示预后不佳，也从病理角度证明"失其所则折寿而不彰"的重要性。此时，须急以通泻之法，散邪通阳，使人体上下通利，阳气运行恢复正常，以期转危为安，此即"隔者当泻"之义。如《伤寒论》所记载的热深厥深，甚至神昏谵语者，即属此类，治当通里攻下，以交通阴阳，则阳回厥除，可望向愈。而叶桂"通阳不在温，而在利小便"，亦属深得经旨之说。

7 风客淫气，精乃亡，邪伤肝也。因而饱食，筋脉横解，肠澼为痔。因而大饮，则气逆。因而强力，肾气乃伤，高骨乃坏。（《素问·生气通天论》）

【提要】

各种病因致病的举例。

【词解】

① 筋脉横解：筋脉弛纵不收。横，放纵；解，同“懈”，松弛。

② 肠澼为痔：便下脓血和痔疮。

③ 强力：房事无度。王冰注：“强力，谓强力入房也”。

④ 高骨：腰间脊柱棘突。

8 帝曰：法阴阳奈何？岐伯曰：阳胜则身热，腠理闭，喘麤为之俛仰，汗不出而热，齿干以烦冤，腹满死，能冬不能夏。阴胜则身寒汗出，身常清，数栗而寒，寒则厥，厥则腹满死，能夏不能冬。此阴阳更胜之变，病之形能也。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

论“阳胜则热”“阴胜则寒”的病理表现。

【词解】

① 法阴阳：遵循阴阳法则，用以辨别疾病。法，遵循。

② 喘麤为之俛仰：呼吸困难，喘息急促，头为之前俯后仰。麤，同“粗”。俛，同“俯”。

③ 烦冤：心胸烦闷不安。冤，《针灸甲乙经》作“闷”；《黄帝内经太素》作“愠”。愠，通“闷”，义同。

④ 能：通“耐”。

⑤ 清：同“清”（qìng），寒冷。《广雅·释诂》：“清，寒也”。

⑥ 病之形能：疾病之表现及转化。能，通“态”，形态、态势。

9 故天之邪气，感则害人五藏；水谷之寒热，感则害于六府。地之湿气，感则害皮肉筋脉。（《素问·阴阳应象大论》）

【提要】

不同邪气，伤人部位不同。

10 凡治病必察其下，适其脉，观其意志，与其病也。拘于鬼神者，不可与言至德。恶于针石者，不可与言至巧。病不许治者，病必不

治，治之无功矣。（《素问·五藏别论》）

【提要】

四诊合参，唯物无神。

【词解】

① 必察其下：《黄帝内经太素》作“必察其上下”，可从。上察“鼻”等，下察“魄门”，乃整体审察之义。

② 至德：医学道理最为科学。

③ 至巧：针石治病最为巧妙。

【拓展】

本条强调了诊病必须要上下、脉神等整体审察，四诊合参，体现了《黄帝内经》一贯的诊法原则。文中“拘于鬼神者，不可与言至德”体现了《黄帝内经》反对鬼神的鲜明的唯物主义思想。临床实践中发现，患者迷信鬼神，往往会对疾病的发生与防治产生错误认识，经常讳疾忌医，拒绝正确治疗，此时若强行施治，也会由于患者不配合而疗效不佳。

11 故东方之域，天地之所始生也，鱼盐之地，海滨傍水，其民食鱼而嗜咸，皆安其处，美其食。鱼者使人热中，盐者胜血，故其民皆黑色疏理，其病皆为痈疡，其治宜砭石。故砭石者，亦从东方来。（《素问·异法方宜论》）

【提要】

论东方之域的地理气候特征、疾病特点和治疗手段。

【词解】

① 热中：热积于内。

② 盐者胜血：盐味咸，咸入血，少则养，过则害。过多食盐则伤血。

③ 疏理：皮肉腠理疏松。

④ 砭石：古代治疗工具，用石头制成的尖石、石针或扁而有刃的石块。

12 西方者，金玉之域，沙石之处，天地之所收引也，其民陵居而多风，水土刚强，其民不衣而褐荐，其民华食而脂肥，故邪不能伤其形体，其病生于内，其治宜毒药。故毒药者，亦从西方来。（《素问·异法方宜论》）

【提要】

论西方之域的地理气候特征、疾病特点和治疗手段。

【词解】

① 收引：此指风急气冷。太阳由西而降，气温变冷，古人认为阳气收敛于西方。收，收敛。引，劲急。

② 华食而脂肥：吃鲜美的酥酪、肉类食物，而致形体肥胖。华，鲜美。

③ 毒药：此泛指能治病的所有药物。

【句解】

其民不衣而褐荐：当地的百姓不讲究穿衣，只披着兽皮或麻草编织的短衣。

13 北方者，天地所闭藏之域也，其地高陵居，风寒冰冽，其民乐野处而乳食，藏寒生满病，其治宜灸焫。故灸焫者，亦从北方来。（《素问·异法方宜论》）

【提要】

论北方之域的地理气候特征、疾病特点和治疗手段。

【词解】

① 闭藏：北方气候寒冷，万物收藏，因此古人认为北方是阳气闭藏的地方。

② 灸焫：用艾炷灸治。

14 南方者，天地所长养，阳之所盛处也，其地下，水土弱，雾露之所聚也，其民嗜酸而食腑，故其民皆致理而赤色，其病挛痹，其治宜微针。故九针者，亦从南方来。（《素问·异法方宜论》）

【提要】

论南方之域的地理气候特征、疾病特点和治疗手段。

【词解】

① 长养：南方气候炎热，万物生长较快，常年繁茂，因此古人认为南方是阳气长养的地方。

② 腑：通“腐”。此指经过发酵的食物，如豉、酢、酱之类，也指熟食。

③ 致理：腠理致密。王冰注：“酸味收敛，故人皆肉理密致”。后世也有医家认为，此可能是“疏理”之误。

④ 微针：指下句中的九针。九针，古代用于针刺治疗的九种针具。

15 中央者，其地平以湿，天地所以生万物也众，其民食杂而不劳，故其病多痿厥寒热，其治宜导引按跷。故导引按跷者，亦从中央出也。（《素问·异法方宜论》）

【提要】

论中央之域的地理气候特征、疾病特点和治疗手段。

【句解】

① 所以生万物：中央地区气候温和，最适宜万物的生长、繁殖，因此古人认为中央是阳气化生的地方。

② 导引按跷：古代用来保健和治病的方法，如气功、按摩、健身操之类。

16 人一呼脉一动，一吸脉一动，曰少气。人一呼脉三动，一吸脉三动而躁，尺热曰病温，尺不热脉滑曰病风，脉涩曰痹。人一呼脉四动以上曰死，脉絶不至曰死，乍疏乍数曰死。（《素问·平人气象论》）

【提要】

论脉息变化所反应的病脉、死脉及疾病。

【词解】

少气：一呼一吸，脉各一动，则一息二至，少于常人之半。此正气虚衰不足所致。

【句解】

① 尺热曰病温：尺肤发热，是温热邪气壅滞于内，故可诊为温病。

② 尺不热脉滑曰病风：脉数滑而尺肤不热，非温热而风邪盛，故可诊为风证。

③ 脉涩曰痹：涩为气血不调，故当病痹。

④ 脉绝不至曰死：脉至即绝，复不再来，为脉气断绝，是五脏之精气绝竭，神气已去，故易死。

⑤ 乍疏乍数曰死：脉来忽快忽慢，为阴阳衰竭、后天化源已绝，故为死脉。高世栻注："乍疏乍数，则脉错乱之极，故死"。数，快也。疏，慢也。

17 春胃微弦曰平，弦多胃少曰肝病，但弦无胃曰死，胃而有毛曰秋病，毛甚曰今病。藏真散于肝，肝藏筋膜之气也。（《素问·平人气象论》）

【提要】

论肝脏的平脉、病脉和死脉。

【句解】

① 春胃微弦曰平：春季的正常脉象是有胃气而略带弦脉之象。弦脉，为春时肝主脉象。吴崑注："弦，脉引而长，若琴弦也。胃，冲和之名。春脉宜弦，必于冲和之中微带弦，是曰平调之脉"。

② 弦多胃少曰肝病：春季脉象弦急而少从容和缓之象，为胃气衰少，肝气偏盛，故曰肝病。张介宾注："弦多者，过于弦也；胃少者，少和缓也。是肝邪之盛，胃气之衰，故曰肝病"。

③ 但弦无胃曰死：春季脉象只见弦急而毫无从容和缓之象，为胃气已绝，肝之真脏脉现，故预后不良。张介宾注："但有弦急而无冲和之气者，是春季胃气已绝，而肝之真藏见也，故曰死"。

④ 胃而有毛曰秋病：春季脉象虽来柔和，但出现了秋季毛脉，预示秋季将会发病。张介宾注："毛为秋脉属金，春时得之，是为贼邪，以胃气尚存，故至秋而后病"。

⑤ 毛甚曰今病：春季不仅出现毛脉，而且特别明显，提示即刻就会发病。王冰注："木受金邪，故今病"。吴崑注："若脉来毛甚，则无胃气，肝木受伤已深，不必至秋，今即病矣"。两注相补，当合参。

18 夏胃微钩曰平，钩多胃少曰心病，但钩无胃曰死，胃而有石曰冬病，石甚曰今病。藏真通于心，心藏血脉之气也。（《素问·平人气象论》）

**【提要】**

论心脏的平脉、病脉和死脉。

**【词解】**

① 钩：钩脉，即洪脉，浮盛隆起，前曲后倨，为夏时心主脉象。吴崑注："钩，前曲后倨，如带钩状也。"张琦注："钩，即洪也，浮盛隆起，中虚而圆滑，故曰钩"。两注相补，当合参。

② 藏真通于心：夏时心火主气，故五脏真气贯通于心。

19 长夏胃微耎弱曰平，弱多胃少曰脾病，但代无胃曰死。耎弱有石曰冬病，弱甚曰今病。藏真濡于脾，脾藏肌肉之气也。（《素问·平人气象论》）

**【提要】**

论脾脏的平脉、病脉和死脉。

**【词解】**

① 耎弱：耎，同"软"，软弱，此非指虚弱，乃指柔和而不劲急的脉象，为长夏脾主脉象。吴崑注："耎弱，脾之脉也。长夏属土，脉宜耎弱，必于冲和胃气之中微带耎弱，谓之平调之脉"。

② 代：脉来极为软弱。代脉之义，诸注不一，如王冰注："谓动而中止，不能

自还也”。此与病脉之代脉相混，不可。高世栻注：“代，软弱之极也。软弱极而无胃气，则曰死脉”。从本篇论四时五脏平脉而言，当以软弱为是。张介宾注：“代，更代也。脾主四季，脉当随时而更，然必欲兼和耎，方得脾脉之平。若四季相代，而但弦、但钩、但毛、但石，是但代无胃，见真藏也，故曰死”。从脾不主时而旺四季看，可参。

**【句解】**

① 耎弱有石曰冬病：长夏脉象本软弱，但软弱之中又出现了冬季的石脉，则预示冬季将会发病。张介宾注：“石为冬脉属水，长夏阳气正盛，而见沉石之脉，以火土气衰，而水反乘也，故至冬而病”。

② 弱甚曰今病：长夏脉象软弱特别明显，现在就要发病。王冰注：“弱甚为土气不足，故今病”。弱甚，《针灸甲乙经》《备急千金要方》均作“石甚”。张介宾注：“弱，当作石。长夏石甚者，火土大衰，故不必至冬，今即病矣”。可参。

③ 藏真濡于脾：长夏脾土主气，故五脏真气润泽于脾。

20 秋胃微毛曰平，毛多胃少曰肺病，但毛无胃曰死，毛而有弦曰春病，弦甚曰今病。藏真高于肺，以行荣卫阴阳也。（《素问·平人气象论》）

**【提要】**

论肺脏的平脉、病脉和死脉。

**【词解】**

毛：毛脉，脉来轻浮微涩，如循羽毛，为秋季肺主脉象。吴崑注：“毛，脉来浮涩，类羽毛也。秋脉宜毛，必于冲和胃气之中，脉来微毛，是曰平调之脉”。

**【句解】**

藏真高于肺：秋时肺金主气，而肺位最高，故五脏之真气上升于肺。

21 冬胃微石曰平，石多胃少曰肾病，但石无胃曰死，石而有钩曰夏病，钩甚曰今病。藏真下于肾，肾藏骨髓之气也。（《素问·平人气象论》）

**【提要】**

论肾脏的平脉、病脉和死脉。

**【词解】**

石：石脉，脉沉有力，如石沉水，为冬时肾主脉象。吴崑注：“石，脉来沉实也。冬脉宜石，必于冲和胃气之中，脉来微石，是曰平调之脉”。

**【句解】**

藏真下于肾：冬时肾水主气，而肾居下焦，故五脏真气下达于肾。

22 黄帝曰：见真藏曰死，何也？岐伯曰：五藏者，皆禀气于胃，胃者五藏之本也。藏气者，不能自致于手太阴，必因于胃气，乃至于手太阴也。故五藏各以其时，自为而至于手太阴也。故邪气胜者，精气衰也；故病甚者，胃气不能与之俱至于手太阴，故真藏之气独见，独见者病胜藏也，故曰死。（《素问·玉机真藏论》）

【提要】

论真脏脉的机制及其预后。

【词解】

手太阴：此指手太阴肺经在手腕部的寸口脉。

【句解】

① 五藏各以其时，自为而至于手太阴也：五脏之气各按其当旺之时，随同胃气出现于手太阴寸口脉，而呈现弦、钩、毛、石等脉象变化。

② 病胜藏：邪气胜而脏腑之精气衰减。

【拓展】

真脏脉是指毫无胃气，唯见脏腑真气暴露于外的脉象，正如《素问·平人气象论》所云："所谓无胃气者，但得真藏脉，不得胃气也"。寸口脉象是五脏精气盛衰在手太阴脉上的反映，由于胃为五脏之本，"五藏六府之气味，皆出于胃，变见于气口"（《素问·五藏别论》）。脉象的形成离不开胃气的滋养作用，五脏精气只有在胃气的资助下，才能按其当旺的时令，与胃气共同到达寸口部，从而表现为微弦、微钩、微毛、微石的正常脉象。若真脏脉出现，脉象完全失去柔和滑利之象征，即谓"但弦""但钩""但毛""但石"之类，意味着邪气亢盛而精气衰竭，胃气败亡，预后不佳。

23 凡治病，察其形气色泽，脉之盛衰，病之新故，乃治之，无后其时。形气相得，谓之可治；色泽以浮，谓之易已；脉从四时，谓之可治；脉弱以滑，是有胃气，命曰易治，取之以时。（《素问·玉机真藏论》）

【提要】

判断疾病预后，必须综合分析形态、气色、脉象等多方面。

【句解】

① 形气相得：形体强弱与正气盛衰相一致。马莳注："气盛形盛，气虚形虚，谓之相得，其病可治"。

② 色泽以浮：气色润泽明亮。张介宾注："泽，润也。浮，明也。颜色明润者，病必易已也"。

③ 取之以时：根据不同时令，选择相应的治疗方法。

24 形气相失，谓之难治；色夭不泽，谓之难已；脉实以坚，谓之益甚；脉逆四时，为不可治。必察四难，而明告之。（《素问·玉机真藏论》）

【提要】

论四种预后不良的情况。

【词解】

① 色夭不泽：颜色枯槁晦暗。王冰注："夭，谓不明而恶。不泽，谓枯燥也"。

② 四难：即上文"形气相失""色夭不泽""脉实以坚""脉逆四时"。

25 所谓逆四时者，春得肺脉，夏得肾脉，秋得心脉，冬得脾脉，其至皆悬绝沉涩者，命曰逆四时。未有藏形，于春夏而脉沉涩，秋冬而脉浮大，名曰逆四时也。病热脉静，泄而脉大，脱血而脉实，病在中脉实坚，病在外脉不实坚者，皆难治。（《素问·玉机真藏论》）

【提要】

论"脉逆四时"和"脉证不应"。

【词解】

① 悬绝沉涩：指无胃气的脉象。悬，虚浮在外而无根。绝，突然断绝而不至。沉，深沉在内而不显。涩，涩滞而不畅。

② 未有藏形：不见五脏主时应有之脉象，如春不见弦，夏不见钩之类。

26 伤寒一日，巨阳受之，故头项痛，腰脊强。二日阳明受之，阳明主肉，其脉侠鼻络于目，故身热目痛而鼻干，不得卧也。三日少阳受之，少阳主胆，其脉循胁络于耳，故胸胁痛而耳聋。三阳经络皆受其病，而未入于脏者，故可汗而已。四日太阴受之，太阴脉布胃中络于嗌，故腹满而嗌干。五日少阴受之，少阴脉贯肾络于肺，系舌本，故口燥舌干而渴。六日厥阴受之，厥阴脉循阴器而络于肝，故烦满而囊缩。三阴三阳，五藏六府皆受病，荣卫不行，五藏不通，则死矣。（《素问·热论》）

【提要】

论单经受邪时的外感热病六经传变规律及其临床表现。

【词解】

① 一日：此指热病发展或转愈过程中的次序和阶段，非为具体的日数。下文中的二日、三日……十一日、十二日等，义同。

② 身热：此指身体发热特别厉害。张介宾注："伤寒多发热，而独此云身热

者，盖阳明主肌肉，身热尤甚也”。

③ 未入于藏：阳经连于腑、主表，阴经连于脏、主里，故虽三阳经皆受病邪，但邪气仍在形体之表，尚未入里入阴。

④ 嗌：咽喉。

⑤ 烦满：心中烦闷。满，同“懑”，即闷。

⑥ 囊缩：阴囊收缩。

**【拓展】**

张介宾指出：“人身经络，三阳为表，三阴为里。三阳之序，则太阳为三阳，阳中之阳；阳明为二阳，居太阳之次；少阳为一阳，居阳明之次，此三阳为表也。三阴之序，则太阴为三阴，居少阴之次；少阴为二阴，居太阴之次；厥阴为一阴，居少阴之次，此三阴为里也。其次序之数，则自内而外，故各有一二三之先后者如此。又如邪之中人，必自外而内……此所以邪必先于皮毛，经必始于太阳，而后三阴三阳五藏六府皆受病”。

27 其不两感于寒者，七日巨阳病衰，头痛少愈；八日阳明病衰，身热少愈；九日少阳病衰，耳聋微闻；十日太阴病衰，腹减如故，则思饮食；十一日少阴病衰，渴止不满，舌干已而嚏；十二日厥阴病衰，囊纵，少腹微下，大气皆去，病日已矣。（《素问·热论》）

**【提要】**

单经受邪时，邪气逐经缓解的规律。

**【词解】**

① 少愈：稍愈。

② 不满：《针灸甲乙经》无此二字，且上文少阴病中无“满”症，故有注家认为属于衍文，也有注家根据后文“两感”条中有“烦满”，认为是“不再烦满”，可参。

③ 大气：此指邪气。王冰注：“大气，谓大邪之气”。

**【句解】**

囊纵，少腹微下：阴囊不收而松缓，少腹不再拘急亦渐渐舒缓。

28 帝曰：其病两感于寒者，其脉应与其病形何如？岐伯曰：两感于寒者，病一日则巨阳与少阴俱病，则头痛口干而烦满；二日则阳明与太阴俱病，则腹满身热，不欲食，谵言；三日则少阳与厥阴俱病，则耳聋，囊缩而厥，水浆不入，不知人，六日死。帝曰：五藏已伤，六府不通，荣卫不行，如是之后，三日乃死，何也？岐伯曰：阳明者，十二经脉之长也，其血气盛，故不知人，三日其气乃尽，故死矣。凡病伤寒而成温者，

先夏至日者为病温，后夏至日者为病暑。暑当与汗皆出，勿止。（《素问·热论》）

【提要】

论表里两经同时受邪时，外感热病六经传变的规律及其临床表现。

【词解】

① 谵言：胡言乱语，语无伦次。

② 厥：此指四肢逆冷。

【句解】

① 脉应与其病形：脉象与病的症状相呼应。

② 水浆不入，不知人，六日死：热水、米汤之类灌之不进，患者神志昏迷、人事不知，病势多危，预后不良。

③ 暑当与汗皆出，勿止：暑邪可随汗而泄，故不可止汗。高世栻注："暑，热之极也。暑热之病，汗出而散；温热之病，亦当汗出。故暑当与汗皆出勿止，汗虽多不可止之也"。

29 人与天地相参，故五藏各以治时感于寒则受病，微则为咳，甚则为泄为痛。乘秋则肺先受邪，乘春则肝先受之，乘夏则心先受之，乘至阴则脾先受之，乘冬则肾先受之。（《素问·咳论》）

【提要】

论五脏主时与感寒发病。

【词解】

乘：趁。

30 肺咳之状，咳而喘息有音，甚则唾血。心咳之状，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿喉痹。肝咳之状，咳则两胁下痛，甚则不可以转，转则两胠下满。脾咳之状，咳则右胁下痛，阴阴引肩背，甚则不可以动，动则咳剧。肾咳之状，咳则腰背相引而痛，甚则咳涎。（《素问·咳论》）

【提要】

论五脏咳的临床表现。

【词解】

① 喉中介介如梗状：咽部不舒，如物梗阻。

② 喉痹：咽喉肿痛，吞咽不利之病。

③ 两胠：两腋下的胁肋部。

④ 阴阴：隐隐。

⑤ 涎：清稀痰涎。

31 帝曰：六府之咳奈何？安所受病？岐伯曰：五藏之久咳，乃移于六府。脾咳不已，则胃受之，胃咳之状，咳而呕，呕甚则长虫出。肝咳不已，则胆受之，胆咳之状，咳呕胆汁。肺咳不已，则大肠受之，大肠咳状，咳而遗失。心咳不已，则小肠受之，小肠咳状，咳而失气，气与咳俱失。肾咳不已，则膀胱受之，膀胱咳状，咳而遗溺。久咳不已，则三焦受之，三焦咳状，咳而腹满，不欲食饮。（《素问·咳论》）

【提要】

论六腑咳的临床表现。

【词解】

① 长虫：蛔虫。

② 遗失：大便失禁。失，《针灸甲乙经》《黄帝内经太素》均作“矢”，通“屎”。

③ 失气：矢气，俗称放屁。

④ 遗溺：小便失禁。溺，同“尿”。

【拓展】

“脏病”和“腑病”的关系，一般而言，脏为阴，腑为阳，脏病重，腑病轻，“脏病”变为“腑病”时多提示疾病由阴出阳，由里出表，疾病减轻。但上述只是一般规律，咳嗽就是一个例外，“五脏咳”传为“六腑咳”是由于五脏咳经久不愈，病情加重发展而成为六腑咳，帮咳嗽的“腑病”比“脏病”严重。

32 帝曰：其痛或卒然而止者，或痛甚不休者，或痛甚不可按者，或按之而痛止者，或按之无益者，或喘动应手者，或心与背相引而痛者，或胁肋与少腹相引而痛者，或腹痛引阴股者，或痛宿昔而成积者，或卒然痛死不知人有少间复生者，或痛而呕者，或腹痛而后泄者，或痛而闭不通者。凡此诸痛，各不同形，别之奈何？（《素问·举痛论》）

【提要】

论疼痛的多种表现。

【词解】

① 喘动应手：血脉搏动急促，按之应手。喘，此为“动”之义。

② 少腹：脐下为小腹，两侧为少腹。

③ 阴股：大腿内侧。

④ 宿昔：稽留日久。宿，留也。昔，久远。

⑤ 死不知人：此指昏迷。

33 寒气客于脉外则脉寒，脉寒则缩踡，缩踡则脉绌急，绌急则外引小络，故卒然而痛，得炅则痛立止，因重中于寒，则痛久矣。寒气客于经脉之中，与炅气相薄则脉满，满则痛而不可按也。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气客于脉所导致的疼痛。

【词解】

炅：热。

34 寒气稽留，炅气从上，则脉充大而血气乱，故痛甚不可按也。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气稽留所导致的疼痛。

35 寒气客于肠胃之间，膜原之下，血不得散，小络急引故痛，按之则血气散，故按之痛止。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气客于肠胃之间，膜原之下所导致的疼痛。

【词解】

膜原：胸膜与膈肌之间的部位。

36 寒气客于侠脊之脉，则深按之不能及，故按之无益也。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气客于侠脊之脉所导致的疼痛。

【词解】

侠脊之脉：脊柱两旁深部的经脉。此言邪客之深，下文“喘动应手”，则言邪客之浅。

37 寒气客于冲脉，冲脉起于关元，随腹直上，寒气客则脉不通，脉不通则气因之，故喘动应手矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气客于冲脉所导致的疼痛。

38 寒气客于背俞之脉则脉泣，脉泣则血虚，血虚则痛，其俞注于

心，故相引而痛，按之则热气至，热气至则痛止矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气客于背俞之脉所导致的疼痛。

【词解】

背俞之脉：指足太阳膀胱经脉。俞穴是指五脏六腑精气输注于背部的腧穴，均在足太阳膀胱经上，故名。

39 寒气客于厥阴之脉，厥阴之脉者，络阴器系于肝，寒气客于脉中，则血泣脉急，故胁肋与少腹相引痛矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气客于厥阴之脉所导致的疼痛。

40 厥气客于阴股，寒气上及少腹，血泣在下相引，故腹痛引阴股。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气客于阴股所导致的疼痛。

【词解】

厥气：指寒逆之气。根据上下文义，“厥气”疑与下文“寒气”误倒，即应作“寒气客于阴股，厥气上及少腹”，理义乃通。

41 寒气客于小肠膜原之间，络血之中，血泣不得注于大经，血气稽留不得行，故宿昔而成积矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

论积的成因。

【词解】

① 大经：脏腑之大络。

② 宿昔：稽留日久。宿，留也。昔，久远。

42 寒气客于五藏，厥逆上泄，阴气竭，阳气未入，故卒然痛死不知人，气复反则生矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气客于五脏所导致的疼痛。

【句解】

厥气上泄，阴气竭，阳气未入：寒气客于五脏，阴气闭阻于内，阳气泄越于外，

相互暂时离决。泄，外越。竭，阻隔。

43 寒气客于肠胃，厥逆上出，故痛而呕也。寒气客于小肠，小肠不得成聚，故后泄腹痛矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

论寒气客于肠胃所导致的疼痛。

44 热气留于小肠，肠中痛，瘅热焦渴则坚干不得出，故痛而闭不通矣。（《素问·举痛论》）

【提要】

论热气客于小肠所导致的疼痛。

【拓展】

中医学治疗疼痛，贵在辨证论治，从根本上解决“不通”或“不荣”，从而达到止痛的目的。例如，邪阻经脉，不通致痛者，宜祛邪通经；气血不足，不荣致痛者，宜益气养血；寒邪致痛者，当温通散寒；热邪致痛者，当清热逐邪；湿邪致痛者，应化湿利湿；瘀血致痛者，应活血化瘀。

45 帝曰：所谓言而可知者也，视而可见奈何？岐伯曰：五藏六府，固尽有部，视其五色，黄赤为热，白为寒，青黑为痛，此所谓视而可见者也。帝曰：扪而可得奈何？岐伯曰：视其主病之脉，坚而血及陷下者，皆可扪而得也。（《素问·举痛论》）

【提要】

论望诊和切诊主病。

【句解】

① 固尽有部：五脏六腑在面部各有相应的所主部位。张志聪注：“五藏六府之气色，皆见于面，而各有所主之部位”。固，明抄本作“面”，可从。

② 坚而血及陷下者：切按血脉，按之坚硬，局部血脉壅盛者，属实；按之陷下，虚软者，属虚。张介宾注：“脉坚者，邪之聚也。血留者，络必盛而起也。陷下者，血气不足，多阴候也”。

【拓展】

疼痛的辨证须当四诊合参，综合分析。通过问诊了解患者对寒热的反应、疼痛发作的时间、疼痛的部位、性质及兼见症状等；通过对面部颜色变化的观察，了解疼痛的性质；通过切按，观察患者对病处的反应，以及医师的感觉体验，了解具体的情况。在此基础上，综合分析病情资料，从而确定疼痛之属气属血、属脏属

腑、属热属寒、属虚属实，这是古人长期临床实践的总结，也为后世诊察与辨证疼痛奠定了基础，迄今仍有指导意义。

46 帝曰：内舍五藏六府，何气使然？岐伯曰：五藏皆有合，病久而不去者，内舍于其合也。故骨痹不已，复感于邪，内舍于肾。筋痹不已，复感于邪，内舍于肝。脉痹不已，复感于邪，内舍于心。肌痹不已，复感于邪，内舍于脾。皮痹不已，复感于邪，内舍于肺。所谓痹者，各以其时重感于风寒湿之气也。（《素问·痹论》）

【提要】

论五体痹传变为五脏痹的规律。

【词解】

① 内舍：病邪深居于内部。舍，居住之处，张介宾注："舍者，邪入而居之也"。

② 合：内外相合。高世栻注："合，外内相合也。肾合骨，肝合筋，心合脉，脾合肌，肺合皮，五藏皆有合也"。

【句解】

各以其时，重感于风寒湿之气也：各以其时，指各以本脏气旺之季。如肝旺于春，心旺于夏，脾旺于长夏，肺旺于秋，肾旺于冬等。若五体痹久而不愈，又在各相应的季节里，重复感受了风寒湿之邪，则内传为脏腑痹。张志聪注："邪之中人，始伤皮肉筋骨，久而不去，则内舍于所合之脏，而为脏腑之痹矣。"

47 凡痹之客五藏者：肺痹者，烦满喘而呕。心痹者，脉不通，烦则心下鼓，暴上气而喘，嗌干善噫，厥气上则恐。肝痹者，夜卧则惊，多饮数小便，上为引如怀。肾痹者，善胀，尻以代踵，脊以代头。脾痹者，四支解堕，发咳呕汁，上为大塞。肠痹者，数饮而出不得，中气喘争，时发飧泄。胞痹者，少腹膀胱按之内痛，若沃以汤，涩于小便，上为清涕。（《素问·痹论》）

【提要】

论五脏痹、肠痹、胞痹的临床表现。

【词解】

① 尻以代踵：足屈不能伸，从后观之，见尻不见足，意为能坐不能站。尻，尾骶部。踵，足后跟。

② 脊以代头：头俯不能仰，导致后脊高出于头部。

③ 大塞：大，为"不"，系形误。"不"通"否"，《广雅·释诂》："否，不也"。

“否”与“痞”通，“大塞”即“痞塞”。

④ 胞痹：膀胱痹。

⑤ 若沃以汤：自觉小腹内热，如热水浇灌。沃，浇灌。汤，热水。

48 阴气者，静则神藏，躁则消亡。饮食自倍，肠胃乃伤。（《素问·痹论》）

【提要】

五脏精气充盛、平和，神得充养，就能内藏。五脏精气耗伤、妄动，神失所养，就会消亡。暴饮暴食，会损伤肠胃。

49 淫气喘息，痹聚在肺；淫气忧思，痹聚在心；淫气遗溺，痹聚在肾；淫气乏竭，痹聚在肝；淫气肌绝，痹聚在脾。诸痹不已，亦益内也。其风气胜者，其人易已也。（《素问·痹论》）

【提要】

论五脏痹。

【词解】

① 淫气：内脏淫乱之气。

② 肌绝：肌肉消瘦。

③ 益内：邪盛病重，向内发展。益，通“溢”，蔓延之意。

50 帝曰：痹，其时有死者，或疼久者，或易已者，其故何也？岐伯曰：其入脏者死，其留连筋骨间者疼久，其留皮肤间者易已。（《素问·痹论》）

【提要】

论痹病不同预后的原因。

51 帝曰：其客于六府者，何也？岐伯曰：此亦其食饮居处，为其病本也。六府亦各有俞，风寒湿气中其俞，而食饮应之，循俞而入，各舍其腑也。（《素问·痹论》）

【提要】

论痹犯六腑的原因。

52 帝曰：以针治之奈何？岐伯曰：五藏有俞，六府有合，循脉之分，各有所发，各随其过，则病瘳也。（《素问·痹论》）

【提要】

论痹病的针刺治疗原则。

【句解】

① 五藏有俞，六腑有合：互文句。五脏六腑各有俞穴与合穴。

② 各随其过，则病瘳也：根据病变部位之所在，按照经脉所过，主治所及的原则，治之则病愈。过，此指病所，瘳，病愈。

53 帝曰：善。痹，或痛，或不痛，或不仁，或寒，或热，或燥，或湿，其故何也？岐伯曰：痛者，寒气多也，有寒故痛也。其不痛不仁者，病久入深，荣卫之行涩，经络时疏，故不通；皮肤不营，故为不仁。其寒者，阳气少，阴气多，与病相益，故寒也。其热者，阳气多，阴气少，病气胜，阳遭阴，故为痹热。其多汗而濡者，此其逢湿甚也，阳气少，阴气盛，两气相感，故汗出而濡也。（《素问·痹论》）

【提要】

论痹病的不同表现及转归。

【词解】

不通：即不痛。《黄帝内经太素》《针灸甲乙经》均作“不痛”。

【句解】

① 其不痛、不仁者：皮肤对疼痛不敏感，麻木不仁。杨上善注：“仁者，亲也，觉也。营卫及经络之气疏涩，不营皮肤，神不至于皮肤之中，故皮肤不觉痛痒，名曰不仁”。

② 经络时疏：经络空虚。疏，空虚。

③ 阳气少，阴气多，与病相益：指阳虚阴盛体质，又感受风寒湿邪，故寒更甚。病，风寒湿邪；相益，相加也。李中梓注：“痹病本属阴寒，若阳气不足之人，则寒从内生，与外病相助益，故寒也”。

④ 阳气多，阴气少，病气胜，阳遭阴：素体阳盛阴虚，感邪后，阴不胜阳，邪气从阳化热，故为痹热。遭，《针灸甲乙经》作“乘”；乘，战而胜之也。张介宾注：“阳盛遭阴，则阴气不能胜之，故为痹热”。

⑤ 两气相感：人体偏盛之阴气与以湿邪为主的风寒湿邪相互作用。王冰注：“中表相应，则相感也”。中，内也；表，外也。

54 帝曰：夫痹之为病，不痛何也？岐伯曰：痹在于骨则重，在于脉则血凝而不流，在于筋则屈不伸，在于肉则不仁，在于皮则寒，故具此五者，则不痛也。凡痹之类，逢寒则虫，逢热则纵。（《素问·痹论》）

【提要】

论痹病发于不同部位的临床表现。

【句解】

① 痹之为病，不痛：风寒湿三气伤及皮、肉、筋、骨、脉有形之体，而气尚能流通，即未伤气者，故不痛。《素问·阴阳应象大论》云："气伤痛"。

② 逢寒则虫：痹病遇寒，则拘急而痛。

【拓展】

关于"逢寒则虫"的"虫"，《针灸甲乙经》、《黄帝内经太素》均作"急"。张介宾注："虫，《针灸甲乙经》作'急'，于义为得。盖逢寒则筋挛，故急，逢热则筋弛，故纵也"。又孙诒让《札迻》："虫，当为疰之借字……段玉裁《说文解字》注谓：'疰'即疼字"。

55 肺者，脏之长也，为心之盖也，有所失亡，所求不得，则发肺鸣，鸣则肺热叶焦。故曰：五藏因肺热叶焦，发为痿躄，此之谓也。（《素问·痿论》）

【提要】

论"五痿皆由肺热生"的机制。

【词解】

① 失亡：心情不畅，若所爱之人或物亡失。

② 肺鸣：此指呼吸急喘而有声。

56 悲哀太甚，则胞络绝，胞络绝则阳气内动，发则心下崩，数溲血也。故《本病》曰：大经空虚，发为肌痹，传为脉痿。（《素问·痿论》）

【提要】

论脉痿的病因。

【词解】

① 胞络绝：心包络之脉阻隔不通。

② 心下崩：心火下移，迫血妄行，以致大量血尿。

③ 肌痹：《黄帝内经太素》作"脉痹"，据上下文义，为是。

57 思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，宗筋弛纵，发为筋痿，及为白淫。故《下经》曰：筋痿者，生于肝，使内也。（《素问·痿论》）

【提要】

论筋痿的病因。

【词解】

① 宗筋：此指男子前阴。

② 白淫：指男子滑精，女子白带。

③ 使内：此指房事。杨上善注："使内者，亦入房"。

58 有渐于湿，以水为事，若有所留，居处相湿，肌肉濡渍，痹而不仁，发为肉痿。故《下经》曰：肉痿者，得之湿地也。（《素问·痿论》）

【提要】

论肉痿的病因。

【词解】

① 渐：伤也。

② 相湿：《针灸甲乙经》作"伤湿"，即感受湿邪。可从。

③ 肌肉濡渍：湿邪浸润肌肉。

59 有所远行劳倦，逢大热而渴，渴则阳气内伐，内伐则热舍于肾，肾者水脏也，今水不胜火，则骨枯而髓虚，故足不任身，发为骨痿。故《下经》曰：骨痿者，生于大热也。（《素问·痿论》）

【提要】

论骨痿的病因。

【词解】

阳气内伐：此指远行而感受阳热邪气，伐伤体内阴液。

60 帝曰：何以别之？岐伯曰：肺热者色白而毛败，心热者色赤而络脉溢，肝热者色苍而爪枯，脾热者色黄而肉蠕动，肾热者色黑而齿槁。（《素问·痿论》）

【提要】

论五脏气热所致痿病的鉴别。

【词解】

① 络脉溢：表浅部位的血络充盈。

② 肉蠕动：肌肉软弱。

【拓展】

根据五脏外应五色、五体、五华等原理，五脏气热所致痿病，可以通过五色、

五体、五华等进行鉴别。如肺气热，“色白”“毛败”；心气热，“色赤”“络脉溢”；肝气热，“色苍”“爪枯”；脾气热，“色黄”“肉蠕动”；肾气热，“色黑”“齿槁”。上述虽可作为临床参考，但还需结合其他症状，全面分析，才符合《黄帝内经》“四诊合参”的诊病原则。

61 帝曰：实者何道从来？虚者何道从去？虚实之要，愿闻其故。岐伯曰：夫阴与阳，皆有俞会，阳注于阴，阴满之外，阴阳匀平，以充其形，九候若一，命曰平人。（《素问·调经论》）

**【提要】**

论平人的标准。

**【词解】**

① 阴与阳：此指阴经与阳经。

② 俞会：经气输注会合处。

**【句解】**

① 阳注于阴，阴满之外：阳经的气血盈满，可灌注到阴经，阴经的气血盈满，可灌注到阳经。之，至也。外，此指阳经。

② 阴阳匀平：阴阳协调，无所胜衰。

③ 九候若一：三部九候的脉象协调一致。

**【拓展】**

阴经和阳经中的气血充溢，充养于形体，机体阴阳相互协调，三部九候之脉均匀若一，就是正常健康之人。这与《素问·生气通天论》的“阴平阳秘”，《素问·平人气象论》的“平人者，不病也”等的学术思想一致。九候若一而无胜衰异常，在于强调阴阳无处不在，气血无处不到，故而各处皆应协调。

62 夫邪之生也，或生于阴，或生于阳。其生于阳者，得之风雨寒暑。其生于阴者，得之饮食居处，阴阳喜怒。（《素问·调经论》）

**【提要】**

论阴阳两类病因。

**【词解】**

阴阳：此指房事。

63 帝曰：风雨之伤人奈何？岐伯曰：风雨之伤人也，先客于皮肤，传入于孙脉，孙脉满则传入于络脉，络脉满则输于大经脉，血气与邪并客于分腠之间，其脉坚大，故曰实。实者外坚充满，不可按之，按之则

痛。(《素问·调经论》)

【提要】

论外邪侵袭的传变规律。

【词解】

① 其脉坚大：此指经脉坚硬粗大。

② 外坚充满：坚，疑为“邪”之误。即外邪充满。

64 帝曰：寒湿之伤人奈何？岐伯曰：寒湿之中人也，皮肤不收，肌肉坚紧，荣血泣，卫气去，故曰虚。虚者聂辟气不足，按之则气足以温之，故快然而不痛。(《素问·调经论》)

【提要】

论寒湿伤人致病的机制。

【词解】

① 皮肤不收：诸注不一。《针灸甲乙经》《黄帝内经太素》无“不”字，即“皮肤收”，寒主收引之故，且与“肌肉坚紧，营血泣”义合，当从。杨上善注：“皮肤收者，言皮肤急而聚也”。

② 聂辟：诸注不一，据文义，当指皮肤松弛多皱。王冰：“聂为聂皱，辟为辟迭也”。

65 帝曰：善。阴之生实奈何？岐伯曰：喜怒不节则阴气上逆，上逆则下虚，下虚则阳气走之，故曰实矣。(《素问·调经论》)

【提要】

论内伤实证的机制。

【词解】

① 阴之生实：内伤产生实证。

② 阴气：指肝气。肝经为阴经，故云。

【句解】

下虚则阳气走之：肝气上逆则下虚，阴虚于下，阳邪乘虚而入。杨上善注：“阴气既上则是下虚，下虚则阳气乘之，故名曰阴实也”。

66 帝曰：阴之生虚奈何？岐伯曰：喜则气下，悲则气消，消则脉虚空，因寒饮食，寒气熏满，则血泣气去，故曰虚矣。(《素问·调经论》)

【提要】

论内伤虚证的机制。

【词解】

① 喜则气下：过喜而使气虚下陷。《素问·举痛论》作“喜则气缓”，“缓”与“下”同义，唯有程度不同。

② 熏满：寒气内盛。另，《针灸甲乙经》作“动藏”，《黄帝内经太素》作“熏藏”，皆通，即寒邪影响到脏腑。

67 帝曰：经言阳虚则外寒，阴虚则内热，阳盛则外热，阴盛则内寒，余已闻之矣，不知其所由然也。岐伯曰：阳受气于上焦，以温皮肤分肉之间，今寒气在外，则上焦不通，上焦不通，则寒气独留于外，故寒慄。（《素问·调经论》）

【提要】

论“阳虚则外寒”的病机。

【句解】

① 阳受气于上焦：卫气由上焦宣发输布。阳，此指卫气。

② 今寒气在外，则上焦不通，上焦不通，则寒气独留于外，故寒慄：此乃外感初期恶寒产生的机制。张介宾注：“寒气在外，阻遏阳道，故上焦不通，卫气不温于表，而寒气独留，乃为寒慄”。

68 帝曰：阴虚生内热奈何？岐伯曰：有所劳倦，形气衰少，谷气不盛，上焦不行，下脘不通。胃气热，热气熏胸中，故内热。（《素问·调经论》）

【提要】

论“阴虚生内热”的病机。

【词解】

胃气热：谷气留滞胃中而不行，郁久化热。

【句解】

① 阴虚生内热：此指劳倦伤脾，脾虚不运，郁而化热，与一般所说的阴虚内热不同。阴，此指脾胃；虚，气虚。

② 上焦不行，下脘不通：脾虚失运，以致清气不能上升，浊气不能下降。高世栻注：“上焦不能宣五谷味，故上焦不行，下脘不能化谷之精，故下脘不通”。

69 帝曰：阳盛生外热奈何？岐伯曰：上焦不通利，则皮肤致密，腠理闭塞，玄府不通，卫气不得泄越，故外热。（《素问·调经论》）

【提要】

论“阳盛生外热”的病机。

【词解】

玄府：即汗孔。

70 帝曰：阴盛生内寒奈何？岐伯曰：厥气上逆，寒气积于胸中而不泻，不泻则温气去，寒独留，则血凝泣，凝则脉不通，其脉盛大以涩，故中寒。（《素问·调经论》）

【提要】

论“阴盛生内寒”的病机。

【词解】

① 温气：指阳气。

② 中寒：此指胸中寒盛。

【句解】

① 厥气上逆：下焦或中焦的阴寒之气逆行于上。

② 其脉盛大以涩：脉象实大紧急，艰涩不畅。张志聪注：“阴盛则脉大，血凝涩，故脉涩也”。

71 五藏者，故得六府与为表里，经络肢节，各生虚实，其病所居，随而调之。病在脉，调之血；病在血，调之络；病在气，调之卫；病在肉，调之分肉；病在筋，调之筋；病在骨，调之骨。燔针劫刺其下及与急者；病在骨，焠针药熨；病不知所痛，两跻为上；身形有痛，九候莫病，则缪刺之；痛在于左，而右脉病者，巨刺之。必谨察其九候，针道备矣。（《素问·调经论》）

【提要】

论因病施治的治疗原则。

【词解】

① 故：通“固”，本来。

② 血：此指络脉瘀血。如本篇云“视其血络，刺出其血”。

③ 燔针：即温针。燔，烧。

④ 焠针：先将针用火烧红，再刺入。焠，烧。

⑤ 缪刺：以左取右、以右取左的针刺法。

⑥ 巨刺：用长大之针的针刺法。亦说缪刺、巨刺，皆为以左取右，以右取左；不同者，缪刺刺大络，巨刺刺大经。

【句解】

① 调之筋：针刺调治筋节，亦可引申为刺筋会穴。

② 调之骨：针刺调治骨髓，亦可引申为刺骨会穴。

③ 其下及与急者：其下，指筋会穴阳陵泉。急者，指筋脉拘急的部位。

④ 两跷为上：即阴跷阳跷两脉。张介宾注："两跷者，阳跷脉出足太阳之申脉，阴跷脉出足少阴之照海，俱当取之，故曰为上"。

【拓展】

本篇提出"其病所居，随而调之"，即因病施治的治疗原则。具体而言，一是根据病变部位的不同，在相应的部位取穴针刺，如"病在脉，调之血；病在血，调之络……病在骨，调之骨"。二是根据病之寒热、深浅，针刺方法有别，如筋痹者采用燔针劫刺、寒痹者采用药物热熨、骨痹者采用焠刺、身体疼痛者采用巨刺缪刺等。三是根据病之虚实，刺有补泻之殊，如开阖补泻、随迎补泻等。

因病施治是本篇提出的重要治疗法则，尤其是针刺的深浅应根据病位、病性、病程等而定。《黄帝内经》其他篇章也有论述，如《素问·刺要论》云："病有浮沉，刺有深浅，各至其理，无过其道"，《灵枢·卫气失常》云："夫病变化，浮沉深浅，不可胜穷，各在其处，病间者浅之，甚者深之；间者小之，甚者众之。随变而调气"，均指出了针刺部位的深浅、取穴的多少，应根据病情来决定，病轻者可浅刺并取穴较少；病重者可深刺，并取穴较多；病属阳位在上者要浅刺，病属阴位在下者要深刺；病程长者当深刺，病程短者当浅刺。如果不能因病而刺，就会造成危害，因此《素问·刺要论》就告诫道："过之则内伤，不及则生外壅，壅则邪从之。浅深不得，反为大贼，内动五藏，后生大病"。这些都是古人从长期临床实践中所总结出来的真知灼见，值得重视。

72 帝曰：非调气而得者，治之奈何？有毒无毒，何先何后？愿闻其道。岐伯曰：有毒无毒，所治为主，适大小为制也。（《素问·至真要大论》）

【提要】

论制方之法。

【句解】

非调气而得者：不是应和六气胜复变化而发生的疾病。调，应和。

73 帝曰：请言其制。岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。（《素问·至真要大论》）

【提要】

论制方原则。

74 帝曰：善。气调而得者何如？岐伯曰：逆之，从之，逆而从之，从而逆之，疏气令调，则其道也。

帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：从内之外者，调其内；从外之内者，治其外；从内之外而盛于外者，先调其内而后治其外；从外之内而盛于内者，先治其外而后调其内；中外不相及，则治主病。（《素问·至真要大论》）

【提要】

论治病求本。

75 帝曰：不治王而然者何也？岐伯曰：悉乎哉问也！不治五味属也。夫五味入胃，各归所喜攻，酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾。久而增气，物化之常也。气增而久，夭之由也。（《素问·至真要大论》）

【提要】

论药食五味与五脏的关系。

【词解】

喜攻：药物主要发挥作用的部位。张介宾注："喜攻者，谓五味五藏各有所属也"。

【句解】

① 不治五味属：没有掌握五味的归属。治，掌握。

② 久而增气，物化之常也：五味入脏则增益脏气，但需日久才能显其功，这是物质生化的一般规律。

③ 气增而久，夭之由也：五味用之过久，反使相应的脏气偏盛，这是导致疾病的缘由。

【拓展】

《黄帝内经》许多篇章都蕴含"过犹不及"的思想，这种思想也体现了中国传统文化的一个重要观念——"中"。所谓"中"，即凡事应有"度"，超过这个"度"就是"过"，没有达到一定的"度"就是"不及"。处理事情，要合乎这个标准，就是"执中"。"中"这个概念在中国传统文化中由来已久，后经孔子弘扬光大，孔子将"中"的含义解释为"过犹不及""执两用中""中立不倚"。

76 帝曰：善。方制君臣何谓也？岐伯曰：主病之谓君，佐君之谓臣，应臣之谓使，非上下三品之谓也。帝曰：三品何谓？岐伯曰：所以明善恶之殊贯也。（《素问·至真要大论》）

【提要】

论制方法则。

【句解】

善恶之殊贯：药物的上、中、下三品主要根据有毒无毒、毒性大小来区分，以此来说明药物的不同等级。殊，不同。贯，相同。

【拓展】

本条提出了中医最早的组方法则，即以药物在方剂中的作用而设君、臣、使。君为方中主药，臣为辅君之药，使为与臣相呼应的药，利用其协同与制约关系，以达最佳治疗效果，这一制方法则一直为历代医家沿用。

77 帝曰：善。病之中外何如？岐伯曰：调气之方，必别阴阳，定其中外，各守其乡，内者内治，外者外治，微者调之，其次平之，盛者夺之，汗之下之，寒热温凉，衰之以属，随其攸利，谨道如法，万举万全，气血正平，长有天命。（《素问·至真要大论》）

【提要】

论治疗时应当注意的问题

【句解】

① 病之中外：指邪自外来、病发于外的病，或邪自内生、病发于内的病。

② 调气之方：泛指各种治病的方法。

【拓展】

治疗应先别阴阳，定其中外（即表里），分辨微盛（即虚实），察其寒热温凉，在此基础上，随其攸利，采取适当的治疗方法，即可达到气血平和，而尽终其天年的目的。

78 帝曰：凡未诊病者，必问尝贵后贱，虽不中邪，病从内生，名曰脱营。尝富后贫，名曰失精，五气留连，病有所并。医工诊之，不在藏府，不变躯形，诊之而疑，不知病名。身体日减，气虚无精，病深无气，洒洒然时惊。病深者，以其外耗于卫，内夺于荣。良工所失，不知病情，此亦治之一过也。（《素问·疏五过论》）

【提要】

论医之过。

【词解】

脱营、失精：情志抑郁所致的虚损性疾病。前者以营血亏虚为主，后者以精气亏损为主。

【句解】

① 五气留连，病有所并：情志抑郁，以致五脏之气滞留不行，积久而为病。

② 病深无气，洒洒然时惊：病久深重，阳气虚衰，形寒怕冷，时时惊悸。洒洒，恶寒之貌。张介宾注："及其病深，则真气消索，故曰无气。无气则阳虚，故洒然畏寒也。阳虚则神不足，故心怯而惊也"。

79 凡欲诊病者，必问饮食居处，暴乐暴苦，始乐后苦，皆伤精气。精气竭绝，形体毁沮。暴怒伤阴，暴喜伤阳，厥气上行，满脉去形。愚医治之，不知补写，不知病情，精华日脱，邪气乃并，此治之二过也。（《素问·疏五过论》）

【提要】

论医之过。

【词解】

① 沮：败坏。

② 满脉去形：即脉大形衰。张介宾注："气逆于上故满脉。精脱于中故去形"。

③ 邪气乃并：指邪气侵入，聚于正气不足之处。并，聚。

80 善为脉者，必以《比类》《奇恒》《从容》知之，为工而不知道，此诊之不足贵，此治之三过也。（《素问·疏五过论》）

【提要】

论医之过。

【词解】

比类、奇恒、从容：均指古经之名。马莳注："古经有《比类》《奇恒》《从容》诸篇，皆至道之要"。

81 诊有三常，必问贵贱，封君败伤，及欲侯王。故贵脱势，虽不中邪，精神内伤，身必败亡。始富后贫，虽不伤邪，皮焦筋屈，痿躄为挛。医不能严，不能动神，外为柔弱，乱至失常，病不能移，则医事不行，此治之四过也。（《素问·疏五过论》）

【提要】

论医之过。

【词解】

三常：指贵贱、贫富、苦乐三方面常可发生的变化。

【句解】

① 封君败伤，及欲王候：曾为君主而显赫，其后遭贬而失势，倾慕王侯而不得，妄想权贵而违愿。败伤，罢黜、破落。及，倾慕。欲，妄想。

② 皮焦筋屈，痿躄为挛：皮肉干枯，筋脉拘挛，四肢痿废不用。痿躄，“痿”的通称。

③ 医不能严：医师没有严格要求患者。

82 凡诊者，必知终始，有知余绪，切脉问名，当合男女。离绝菀结，忧恐喜怒，五藏空虚，血气离守，工不能知，何术之语。尝富大伤，斩筋绝脉，身体复行，令泽不息。故伤败结，留薄归阳，脓积寒炅。粗工治之，亟刺阴阳，身体解散，四支转筋，死日有期，医不能明，不问所发，唯言死日，亦为粗工，此治之五过也。（《素问·疏五过论》）

【提要】

论医之过。

【句解】

① 有知余绪：又察知疾病的本末。有，通“又”。余绪，枝末。

② 切脉问名，当合男女：切脉问病时，应当注意男女的差异。

③ 离绝菀结：由于生离死别、爱恨恩仇，以致情郁难解。张介宾注：“离者，失其亲爱；绝者，断其所怀；菀，谓思虑抑郁，结，谓深情难解”。

④ 斩筋绝脉，身体复行，令泽不息：筋脉得不到滋养，犹如断绝，身体虽能活动，但津液已不再滋生。

⑤ 故伤败结，留薄归阳，脓积寒炅：气血亏败，滞聚不散，积久化热，壅盛于表，腐败血肉而化脓，并伴畏寒发热。张介宾注：“故，旧也，言旧之所伤，有所败结，血气留薄不散，则郁而成热，归于阳分，故脓血蓄积，令人寒炅交作也”。

⑥ 亟刺阴阳，身体解散，四支转筋，死日有期：不知寒热为脓积血蓄而成，只是频频刺泻阴阳经脉，更是耗气伤阴，以致身体懈惰，筋脉拘挛，危候已现，死期临近。亟，多次。

83 故曰：圣人之治病也，必知天地阴阳，四时经纪，五藏六府，雌雄表里，刺灸砭石，毒药所主，从容人事，以明经道，贵贱贫富，各异品理，问年少长，勇怯之理，审于分部，知病本始，八正九候，诊必副矣。治病之道，气内为宝，循求其理，求之不得，过在表里。守数据治，无失俞理，能行此术，终身不殆。不知俞理，五藏菀熟，痈发六府。诊病不审，是谓失常，谨守此治，与经相明，《上经》《下经》《揆度》《阴阳》《奇恒》《五

中》，决以明堂，审于终始，可以横行。（《素问·疏五过论》）

【提要】

论治病之道。

【词解】

① 经纪：规律，秩序。

② 品理：品行习惯，心理特征。

③ 菀熟：菀，郁也。熟，马莳、吴崑、张志聪等注本，均作“热”，王冰注：“熟，热也”，为是。

④ 明堂：面鼻部位，此指面部色脉。

【句解】

① 从容人事，以明经道：和蔼耐心、全面细致地了解患者的人事生活等变迁情况，明了诊治疾病的常规。

② 八正九候：八正，指立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至八个节气。九候，指脉诊的三部九候。

③ 诊必副矣：诊断必须全面而周到。吴崑注：“副，全也”。

④ 上经下经，揆度阴阳，奇恒五中：《上经》《下经》《揆度》《阴阳》《奇恒》《五中》，均为古代医经。

84 黄帝在明堂，雷公侍坐，黄帝曰：夫子所通书受事众多也，试言得失之意，所以得之，所以失之。雷公对曰：循经受业，皆言十全，其时有过失者，请闻其事解也。

帝曰：子年少智未及邪？将言以杂合耶？夫经脉十二，络脉三百六十五，此皆人之所明知，工之所循用也。所以不十全者，精神不专，志意不理，外内相失，故时疑殆。

诊不知阴阳逆从之理，此治之一失矣。（《素问·征四失论》）

【提要】

论医师临证之失。

【句解】

① 循经受业：依照医经，学习医术。

② 言以杂合：不能将各种理论、学说融会贯通。

③ 志意不理：思想认识上不明白、无条理。

④ 外内相失：不能将内部变化和外部变化加以联系。

85 受师不卒，妄作杂术，谬言为道，更名自功，妄用砭石，后遗身

咎，此治之二失也。（《素问·征四失论》）

【提要】

论医师临证之失。

【句解】

① 受师不卒：学习老师的技术，尚未通晓，就半途而废。张介宾注："受师不卒者，学业未精，苟且自是也"。

② 妄作杂术：胡乱使用旁门左道的疗法。张介宾注："妄作杂术者，不明正道，假借异端也"。

③ 后遗身咎：不但治不好病，反而给患者身体带来损害。咎，灾祸、过错。

86 不适贫富贵贱之居，坐之薄厚，形之寒温，不适饮食之宜，不别人之勇怯，不知比类，足以自乱，不足以自明，此治之三失也。（《素问·征四失论》）

【提要】

论医师临证之失。

【词解】

适：理解、明白之意。下文"适"，义同。《广雅·释言》"适，悟也"。

【句解】

坐之薄厚：居住环境的好坏。坐，居处。

87 诊病不问其始，忧患饮食之失节，起居之过度，或伤于毒，不先言此，卒持寸口，何病能中，妄言作名，为粗所穷，此治之四失也。（《素问·征四失论》）

【提要】

论医师临证之失。

【句解】

卒持寸口：不问病情，便匆促切脉。卒，同"猝"，突然、仓促。

88 雷公问于黄帝曰：禁脉之言，凡刺之理，经脉为始，营其所行，制其度量，内次五藏，外别六府，愿尽闻其道。黄帝曰：人始生，先成精，精成而脑髓生，骨为干，脉为营，筋为刚，肉为墙，皮肤坚而毛发长，谷入于胃，脉道以通，血气乃行。雷公曰：愿卒闻经脉之始生。黄帝曰：经脉者，所以能决死生，处百病，调虚实，不可不通。（《灵枢·经脉》）

【提要】

论经脉的重要作用。

【词解】

① 禁脉：指《灵枢·禁服》。张介宾注："'脉'当作'服'，即本经禁服篇名也"。

② 始：开端，基础。

③ 卒：全部，穷尽。

【句解】

① 营其所行：探求经脉的循行路线。营，度、求。

② 制其度量：确定经脉的长短。制，裁断，确定。度量，经脉的长度。

③ 内次五藏，外别六府：依次分辨出经脉与五脏六腑的内外相通联系。

④ 骨为干：骨骼构成了人体的支架。干，筑墙时置于墙外的木架。

⑤ 筋为刚：肢体运动，以筋为网络维系。刚，通"纲"。

89 经脉十二者，伏行分肉之间，深而不见；其常见者，足太阴过于外踝之上，无所隐故也。诸脉之浮而常见者，皆络脉也。六经络手阳明少阳之大络，起于五指间，上合肘中。饮酒者，卫气先行皮肤，先充络脉，络脉先盛。故卫气已平，营气乃满，而经脉大盛。脉之卒然动者，皆邪气居之，留于本末。不动则热，不坚则陷且空，不与众同，是以知其何脉之动也。

雷公曰：何以知经脉之与络脉异也？黄帝曰：经脉者，常不可见也，其虚实也，以气口知之，脉之见者，皆络脉也。（《灵枢·经脉》）

【提要】

论经脉与络脉的区别。

【词解】

① 分肉：此指深藏于近骨处的肌肉。

② 络脉：由经脉分出而呈网状的大小分支。络脉可分为别络、浮络和孙络。

③ 六经络：此指手三阴、手三阳六经的络脉。

④ 平：充足、充盛。

⑤ 卒然：突然。卒，同"猝"。

⑥ 动：此指经脉发生异常的变动。

【句解】

足太阴过于外踝之上：外踝，《黄帝内经太素》作"内踝"，为是。阴脉行内，阳脉行外，足太阴为阴脉，故过于内踝之上。

90 黄帝曰：其时有反者，何也？岐伯曰：是不应四时之气，藏独主其病者，是必以藏气之所不胜时者甚，以其所胜时者起也。

黄帝曰：治之奈何？岐伯曰：顺天之时，而病可与期。顺者为工，逆者为粗。（《灵枢·顺气一日分为四时》）

**【提要】**

强调治疗必须适应时令。

**【句解】**

① 藏独主其病者：受病脏腑的病邪单独支配着病情的变化。

② 以藏气之所不胜时者甚：受病之脏在克我之脏主气的时间里病情加重。

③ 以其所胜时者起：受病之脏在我克之脏主气的时间里病情减轻。起，减轻。

# 贰 《伤寒论》经典条文

# 一级条文(90条)

1 太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。(《辨太阳病脉证并治》,第1条)

**【提要】**

太阳病的脉证总纲。

**【词解】**

① 头项强痛:颈项疼痛不舒,不柔顺貌。强,不柔和,有拘紧感。

② 恶寒:遇风觉冷,得温不能缓解的感觉。

**【句解】**

① 脉浮:为外邪侵袭,卫气浮盛于表,向外抗邪在脉象上的反映,提示病位在表,正气未虚。

② 头项强痛:太阳病之主症,足太阳经上额交巅还出别下项,太阳受邪,经气运行受阻,故见头项强痛。

③ 恶寒:也包括恶风。外邪束表,卫气被遏,不能正常发挥"温分肉"功能,故见恶寒。本条所列脉证,在太阳病的诊断中同等重要,文中凡言太阳病者,一般均具有提纲所列之一组脉证。

**【拓展】**

太阳为六经藩篱,统摄营卫,主表卫外,故外邪侵袭人体,太阳首当其冲。邪犯太阳,正气奋起抗邪,正邪交争于表,即为太阳病。发热为太阳病中卫气抗邪的反映,常与恶寒并见,但因有时在发病之初,卫阳被遏,尚未伸展,可见暂时不发热,只有恶寒,故《伤寒论》未将发热列为太阳病的基本表现。发热与恶寒并见,是太阳病的证候特征之一,也是太阳病与其他经病的主要区别点。

2 太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。(《辨太阳病脉证并治》,第2条)

**【提要】**

太阳中风的提纲证。

**【词解】**

① 恶风:遇风觉冷,避之可缓。

② 脉缓：脉象宽柔和缓，非怠慢迟缓。

③ 中风：此处为中医学的特定证名，属外感病邪所致的一种表证，与内伤杂病的中风病不同。

**【拓展】**

本条首冠以“太阳病”，当知包括第 1 条脉证。太阳中风证，亦称太阳表虚证。在太阳中风的主要脉证中，以汗出最具特征，因其既可反映太阳中风证卫不外固，营阴外泄的病理机制，又能区别太阳伤寒的无汗。

3 太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒。（《辨太阳病脉证并治》，第 3 条）

**【提要】**

太阳伤寒的提纲证。

**【词解】**

① 脉阴阳俱紧：寸、关、尺三部脉都见紧象。阴阳，指寸关尺三部。紧，与缓相对，脉来紧束、紧张之象。

② 伤寒：证名，属狭义伤寒。

**【拓展】**

本条冠名“太阳病”，主要脉证应结合第 1 条理解，即脉紧当为浮紧，体痛之外当有头痛。本条未言有汗无汗，但据太阳伤寒证营阴郁滞的病理特点，太阳伤寒当有无汗之症，后人又把太阳伤寒证称为风寒表实证。

4 太阳中风，阳浮而阴弱。阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出。啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第 12 条）

**【提要】**

论桂枝汤证的主证、病机、治法。

**【词解】**

① 啬啬：畏缩怕冷之状。啬（sè），畏怯貌。

② 淅淅：淅（xī），冷水洒身不禁其寒之状，形容怕风。

③ 翕翕发热：发热轻浅温和。翕（xē），和顺。

**【句解】**

阳浮而阴弱：一指营卫，卫气浮盛，营阴不足。一指脉象，轻按则浮，重按见弱。

**【方药】**

桂枝汤方：

桂枝三两(去皮)，芍药三两，甘草二两(炙)，生姜三两(切)，大枣十二枚(擘)。上五味，㕮咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。服已须臾，歠热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，遍身絷絷微似有汗者益佳，不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出病差，停后服，不必尽剂。若不汗，更服依前法。又不汗，后服小促其间。半日许，令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服。若不汗出，乃服至二三剂。禁生冷、黏滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

5 太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。(《辨太阳病脉证并治》，第16条)

**【提要】**

论坏病的概念、治则，及太阳伤寒证禁用桂枝汤。

**【词解】**

① 温针：针刺与艾灸合用的一种治疗方法。

② 坏病：即变证。太阳病桂枝汤证，治法自应汗解。若汗不如法，或发汗太过，误治而致病情发生变化，进一步产生的新病证。

③ 不中：不可。

④ 解肌：解除肌表之邪。

⑤ 识(zhì)：记住。

**【拓展】**

本条“观其脉证，知犯何逆，随证治之”十二字的诊治原则，是《伤寒论》的主要精神，不仅为坏病而设，对于一切疾病的辨治皆具有重要的指导意义。

6 太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第20条)

**【提要】**

论过汗导致阳虚汗漏表未解的证治。

**【词解】**

① 遂漏不止：不间断地小量汗出。遂，因而，于是。漏，渗泄不止。

② 小便难：小便量少而且不畅。太阳病发汗太过，汗漏不止，阴津外亡，阳气受损，膀胱气化无力，故见小便少而不畅。

③ 微急：轻度拘急。

【方药】

桂枝加附子汤方：

桂枝三两(去皮)，芍药三两，甘草二两(炙)，生姜三两(切)，大枣十二枚(擘)，附子一枚(炮，去皮，破八片)。

7 太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发。脉微缓者，为欲愈也；脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也；面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。(《辨太阳病脉证并治》，第23条)

【提要】

论太阳病日久不愈的三种转归，以及表郁轻证的证治。

【词解】

① 如疟状：恶寒发热呈阵发性，发无定时，似疟非疟。

② 脉微缓：脉不浮紧，趋于和缓。微，稍微，略微，非指脉象微弱。

③ 热色：红色。

【句解】

① 清便欲自可：大小便尚属正常。清，同“圊”，厕所之古名，此处作动词用。欲，同“尚”。自可，如常之意。

② 阴阳俱虚：表里皆虚。阴阳，此指表里。

【方药】

桂枝麻黄各半汤方：

桂枝一两十六铢(去皮)，芍药、生姜(切)、甘草(炙)、麻黄各一两(去节)，大枣四枚(擘)，杏仁二十四枚(汤浸，去皮尖及两仁者)。

8 服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法。若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。(《辨太阳病脉证并治》，第25条)

【提要】

服桂枝汤大汗出后的转归与治疗。

【词解】

一日再发：一天发作两次。

【拓展】

太阳病服桂枝汤，应遵“微似有汗者益佳，不可令如水流漓”之旨，如汗不得

法，汗出太过者，则可发生种种变化。

【方药】

桂枝二麻黄一汤方：

桂枝一两十七铢(去皮)，芍药一两六铢，麻黄十六铢(去节)，生姜一两六铢(切)，杏仁十六个(去皮尖)，甘草一两二铢(炙)，大枣五枚(擘)。

9 服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第26条)

【提要】

服桂枝汤后，热盛津伤，转属阳明病的证治。

【词解】

大烦渴不解：大热，大渴，虽大量饮水亦不能解。

【方药】

白虎加人参汤方：

知母六两，石膏一斤(碎，绵裹)，甘草二两(炙)，粳米六合，人参三两。上五味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

10 太阳病，发热恶寒，热多寒少。脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。(《辨太阳病脉证并治》，第27条)

【提要】

论表郁内热轻证的证治。

【词解】

无阳：阳气虚。

【拓展】

太阳病，发热恶寒，热多寒少，说明太阳之邪未解，从方中用辛寒之石膏分析，本证应有轻度内热之症，如心烦、口微渴等。

【方药】

桂枝二越婢一汤方：

桂枝(去皮)、芍药、麻黄、甘草(炙)各十八铢，大枣四枚(擘)，生姜一两二铢(切)，石膏二十四铢(碎，绵裹)。

11 太阳病，项背强几几，无汗恶风，葛根汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第31条)

【提要】

论太阳伤寒兼经输不利的证治。

【词解】

项背强几几：项背拘急不舒。

【句解】

太阳病无汗恶风，为太阳伤寒表实证，又兼见项背拘急不舒者，此为风寒袭表，邪客太阳经输，经气不利，气血运行不畅所致。

【方药】

葛根汤方：

葛根四两，麻黄三两(去节)，桂枝二两(去皮)，生姜三两(切)，甘草二两(炙)，芍药二两，大枣十二枚(擘)。上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。余如桂枝法将息及禁忌。

12 太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第32条)

【提要】

论太阳阳明合病下利的证治。

【词解】

自下利：下利自然而作，既非误治，亦非里虚。

【拓展】

太阳与阳明合病，是太阳阳明同时受邪发病。条文所谓“自下利者”，既非误治，亦非里虚，实因风寒所及。其利多为水粪杂下，而无恶臭及肛门灼热感，并见于太阳伤寒证中。

13 太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第33条)

【提要】

论太阳阳明合病呕逆的治法。

【拓展】

本证是太阳表实无汗而呕，与少阳病胸胁满而呕者不同，属太阳与阳明合病，而非太阳与少阳合病。本证仍以太阳病发热、恶寒、无汗、项背强等为主症。

【方药】

葛根加半夏汤方：

葛根四两，麻黄三两(去节)，甘草二两(炙)，芍药二两，桂枝二两(去皮)，生姜二两(切)，半夏半升(洗)，大枣十二枚(擘)。

14 太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也；喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第34条）

【提要】

论太阳病误下，里热挟表邪下利的两种证治。

【句解】

太阳病桂枝汤证，当用汗解，若用攻下，属于误治。医师误用下法，必伤及胃肠，因而下利不止。

【方药】

葛根黄芩黄连汤方：

葛根半斤，甘草二两（炙），黄芩三两，黄连三两。

15 太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘者，麻黄汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第35条）

【提要】

论太阳伤寒的证治。

【方药】

麻黄汤方：

麻黄三两（去节），桂枝二两（去皮），甘草一两（炙），杏仁七十个（去皮尖）。上四味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升半，去滓，温服八合。覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

16 太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服之。服之则厥逆，筋惕肉瞤，此为逆也。（《辨太阳病脉证并治》，第38条）

【提要】

典型大青龙汤的证治。

【词解】

筋惕肉瞤：肌肉跳动。

【方药】

大青龙汤方：

麻黄六两（去节），桂枝二两（去皮），甘草二两（炙），杏仁四十枚（去皮尖），生姜三两（切），大枣十枚（擘），石膏如鸡子大（碎）。上七味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，取微似汗。汗出多者，温粉粉之。一服汗者，停后服。若复服，汗多亡阳遂虚，恶风烦躁，不得眠也。

17 伤寒脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之。（《辨太阳病脉证并治》，第 39 条）

【提要】

论大青龙汤证的变证。

【句解】

① 乍有轻时：病情偶尔有所减轻。

② 无少阴证：没有少阴阴盛阳虚的证。

【拓展】

本条论述大青龙汤证的非典型脉症，由于感邪有轻重，体质有强弱，临床脉症亦多变例。第 38 条言“太阳中风，脉浮紧”，本条言“伤寒脉浮缓”，仲景如此错综立论，提示风寒之邪不可截然分开，其中风证与伤寒证之辨，当以有汗无汗为准。

18 伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利、少腹满，或喘者，小青龙汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第 40 条）

【提要】

太阳伤寒兼水饮的证治。

【词解】

① 心下有水气：心下，泛指心及以下部位。水气，病理概念，即水饮之邪。

② 噎（yē）：咽喉部有气逆梗阻感。

③ 少腹满：小腹或下腹部胀满。少，通“小”。

【拓展】

本证外有表邪，内挟水饮。水饮之邪变动不居，可随三焦气机升降出入，或壅于上，或积于中，或滞于下，故其症状变化多端。

【方药】

小青龙汤方：

麻黄（去节）、芍药、细辛、干姜、甘草（炙）、桂枝各三两（去皮），五味子半升，半夏半升（洗）。

19 伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴，服汤已渴者，此寒去欲解也，小青龙汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第 41 条）

【提要】

补论太阳伤寒兼水饮内停的证治。

【拓展】

小青龙汤证存在许多或然症，并非必然出现，但病机关键为水饮内停。

20 病常自汗出者，此为荣气和，荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中，卫行脉外。复发其汗，荣卫和则愈。宜桂枝汤。（《辨太阳病脉证并治》，第53条）

【提要】

论杂病自汗证的病机。

【词解】

① 荣气和：营气未受邪。荣气，即营气。和，平和，正常。

② 外不谐：卫气发生了病理变化而不调和。外，主要指敷布于体表的卫气。

【拓展】

营卫不和是自汗的常见成因。营气与卫气皆源于水谷精气，营阴行脉中而起濡养之功，卫气行脉外而司温煦推动防御之职，营卫之气各司其守，称营卫协调。今卫气病变，失其固密护卫之职，致营不内守，流泄于外，而发自汗之证。本条冠以“病”字，既包括外感也包括杂病。患者只有自汗出，而无恶寒、头痛、发热等症，则知非为外感，而是杂病。

21 病人脏无他病，时发热，自汗出，而不愈者，此卫气不和也。先其时发汗则愈，宜桂枝汤。（《辨太阳病脉证并治》，第54条）

【提要】

举例论述杂病自汗的病机及治法。

【词解】

① 脏无他病：脏腑无病。

② 时发热自汗出：阵发性发热汗出。

③ 先其时：在发热汗出之前。

【拓展】

本条论汗出伴有发热，提出两点：一是“患者脏无他病”，排除阴虚发热和阳明燥实；二是“不愈”，表明屡医乏效，足见以往治法之不妥，再则表明病程较长。究其病机，实乃“卫气不和”所致，在治疗方面提出“先其时发汗则愈”，此时营卫较为平衡稳定，易于调解，服用桂枝汤可加速愈期。此种治疗方法颇有治在机先的积极意义。

22 下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕，不渴，无

表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第61条）

【提要】

论下后复汗，致肾阳虚烦躁的证治。

【句解】

太阳病，医者先下后汗，治疗失序，继而出现烦躁、发热（微热），察患者不呕（非少阳）、不渴（非阳明）、无表证（非太阳），说明本证不属三阳病证，排除阳热实证之可能，从而断定，斯证已由阳入阴，由实转虚，病在三阴。

【方药】

干姜附子汤方：

干姜一两，附子一枚（生用，去皮，切八片）。上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

23 发汗后，不可更行桂枝汤，汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。（《辨太阳病脉证并治》，第63条）

【提要】

论太阳病汗后，邪热壅肺而致咳喘的证治。

【词解】

更行：即再用之意。更，再也。行，用也。

【方药】

麻黄杏仁甘草石膏汤方：

麻黄四两（去节），杏仁五十个（去皮尖），甘草二两（炙），石膏半斤（碎，绵裹）。

24 发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第64条）

【提要】

论发汗过多，损伤心阳而致心悸的证治。

【词解】

叉手自冒心：两手交叉按压于心胸部位。冒，覆盖、按压。

【句解】

发汗过多，病轻药重，易损伤人体正气。汗为心液，由阳气蒸化而成，过汗则心阳随汗外泄，心阳受损。心脏失去阳气的鼓动，则空虚无主，故见心悸。因阳虚而悸，虚则喜实，故患者喜按心胸部位。

【拓展】

桂枝甘草汤方：

桂枝四两(去皮)，甘草二两(炙)。上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

25 伤寒，若吐、若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第67条)

【提要】

论脾虚水停的证治及治疗禁忌。

【词解】

① 眩：头晕目眩。

② 动经：扰动经脉。

③ 振振：动摇不定貌。

【拓展】

尤在泾认为："发汗则动经，身为振振摇者"，仍属苓桂术甘汤所主的范畴；丹波元简认为："此条之脉沉紧，为苓桂术甘汤证，而身为振振摇者即真武所主也"。对本条病机，多家皆认为系脾阳不足，水气上逆之证，但张志聪等认为系胃虚肝逆所致。

【方药】

茯苓桂枝白术甘草汤方：

茯苓四两，桂枝三两(去皮)，白术、甘草各二两(炙)。

26 太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热，消渴者，五苓散主之。(《辨太阳病脉证并治》，第71条)

【提要】

论太阳蓄水证的病因病机、脉证、治法。

【词解】

① 胃中干：津液耗伤，胃中津液不足。

② 消渴：此非病名，指口渴而饮水不止的症状。

【方药】

五苓散方：

猪苓十八铢(去皮)，泽泻一两六铢，白术十八铢，茯苓十八铢，桂枝半两(去皮)。上五味，捣为散，以白饮和服方寸匕，日三服，多饮暖水，汗出愈，如法将息。

27 发汗后，水药不得入口为逆，若更发汗，必吐下不止。发汗吐

下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊侬，栀子豉汤主之；若少气者，栀子甘草豉汤主之；若呕者，栀子生姜豉汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第76条）

【提要】

汗吐下后热扰胸膈的证治。

【词解】

① 虚烦：由无形邪热所致的心烦。虚，与有形之邪相对而言；烦，心烦。

② 心中懊侬：心中烦闷殊甚，莫可名状。

③ 少气：气少不足以息。

【拓展】

方后注有“得吐者，止后服”一语，后世医家对此颇有争议，如成无已、柯韵伯等认为本方是涌吐剂。现今一般认为栀子豉汤非涌吐之剂。张隐庵认为“方后得吐者，止后服，六字为衍文”。也有医家认为“得吐者，止后服”，含有中病即止之意。诸说可供参考。

【方药】

① 栀子豉汤方：

栀子十四个（擘），香豉四合（绵裹）。上二味，以水四升，先煮栀子，得二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服，得吐者，止后服。

② 栀子甘草豉汤方：

栀子十四个（擘），甘草二两（炙），香豉四合（绵裹）。

③ 栀子生姜豉汤方：

栀子十四个（擘），生姜五两，香豉四合（绵裹）。

28 太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地者，真武汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第82条）

【提要】

论阳虚水泛的证治。

【词解】

振振欲擗地：肢体颤动欲扑倒于地。擗同“仆”，跌倒。

【拓展】

“其人仍发热”一症，喻嘉言认为是表邪未尽，故仍见发热。刘渡舟则认为是少阴阳虚，虚阳外浮所致。关于本病病机，多数医家都认为是阳虚水泛，而钱天来等认为只是阳气不足，而无水饮。《医宗金鉴》则认为系阳虚而兼液涸。

【方药】

真武汤方：

茯苓、芍药、生姜各三两(切)，白术二两，附子一枚(炮，去皮，破八片)。上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。

29 太阳病，发热汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出，欲救邪风者，宜桂枝汤。(《辨太阳病脉证并治》，第95条)

【提要】

论风邪所致营卫不和之发热、汗出的证治。

【词解】

欲救邪风：治疗风邪引起的太阳病。救，解除、治疗。邪风，即风邪。

【拓展】

本条冠以“太阳病”，症见发热、汗出，当有轻微恶风，脉浮等。关于“荣弱卫强”，成无己引《黄帝内经》“阴虚者，阳必凑之”为解，认为系风并于卫，则卫实而营(阴)虚。《医宗金鉴》引《黄帝内经》“邪气盛则实”以释卫强，“精气夺则虚”以解荣弱。程郊倩认为强弱是指有无邪助之故，其曰“卫得邪助故强，营无邪助故弱”。现今一般认为“卫强”并非卫气的正常功能强盛，而是指风邪外袭，卫气浮盛于外，与邪相争而呈发热亢奋的现象。所谓“营弱”亦非营阴真正的虚弱，而是指卫气受邪，失其正常的固外开合之权，营阴不能内守而汗出，与“卫强”相比，呈现相对不足状态。

30 伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸、小便不利，或不渴、身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第96条)

【提要】

论小柴胡汤证的主证、病机、药物组成与加减法。

【词解】

① 往来寒热：恶寒与发热交替出现。

② 胸胁苦满：患者苦于胸胁满闷不适。

③ 嘿嘿：表情沉默，不欲言语。

【方药】

小柴胡汤方：

柴胡半斤，黄芩三两，人参三两，半夏半升(洗)，甘草(炙)、生姜各三两(切)，大枣十二枚(擘)。上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

31 太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡。呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤，下之则愈。（《辨太阳病脉证并治》，第103条）

【提要】

论少阳病误下后出现的大柴胡汤证。

【词解】

① 过经：邪离本经，传入他经。

② 心下急：胃脘部拘急不快或疼痛的感觉。

【方药】

大柴胡汤方：

柴胡半斤，黄芩三两，芍药三两，半夏半升(洗)，生姜五两(切)，枳实四枚(炙)，大枣十二枚(擘)。上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓再煎，温服一升，日三服。一方加大黄二两；若不加，恐不为大柴胡汤。

32 太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外；外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。（《辨太阳病脉证并治》，第106条）

【提要】

论太阳蓄血轻证的证治。

【词解】

① 热结膀胱：邪热与瘀血结于下焦部位。膀胱，此指下焦部位，包括膀胱、小肠、胞宫等。

② 如狂：神志异常而不甚，似狂非狂之状。也可解释为如发狂似的心神不宁。

③ 少腹急结：下腹部拘急硬痛。

【拓展】

关于血蓄的具体部位，则众说不一。有以下几种观点：① 血蓄回肠。如钱天来《伤寒溯源集·太阳上篇》认为“邪热瘀结于膀胱而血受煎迫，溢于回肠。蓄血必从大便而出”。② 血蓄胞宫。如陈修园《伤寒论浅注·卷二》认为“胞为血海，居膀胱之外。热结膀胱，熏蒸胞宫之血”。③ 血蓄膀胱。如《医宗金鉴·订正仲景全书·伤寒论注·太阳中篇》认为“太阳病不解，不传阳阴，邪热随经入里，谓之犯本，犯本者，谓犯膀胱之府也”。④ 血蓄下焦。如汪苓友《伤寒论辨证广注·伤寒辨注·卷四》言“太阳为多血之经，府有热结，则经中之血与热相搏，蓄于下焦”。综合注家观点，并结合桃核承气汤的临床运用，血蓄部位并非固定一

处，只是以下焦血分为病变中心。因此，称太阳蓄血者，可以参考汪苓友的注释。

**【方药】**

桃核承气汤方：

桃仁五十个(去皮尖)，大黄四两，桂枝二两(去皮)，甘草二两(炙)，芒硝二两。

33 太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也。抵当汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第124条)

**【提要】**

蓄血重证的病因病机，证候表现和治法方药。

**【词解】**

结胸：病名。痰水等实邪结于胸膈脘腹，以疼痛为主要表现的疾病。

**【方药】**

抵当汤方：

水蛭(熬)、虻虫各三十个(去翅足，熬)，桃仁二十个(去皮尖)，大黄三两(酒洗)。

34 伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第135条)

**【提要】**

论热实结胸证的证治。

**【词解】**

① 热实：此指结胸证的性质属热属实，与寒实结胸相对而言。

② 石硬：腹痛拒按，腹肌高度紧张，甚则坚硬如石。

35 小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第138条)

**【提要】**

论小结胸病的证治。

**【词解】**

小结胸：痰热相结在心下胃脘部，按之则痛，不按不痛。病变范围局限，病情轻浅，病势较缓，与“大结胸证”水热互结，病变范围广泛，病情深重，病势较急相对而言，故称“小结胸”。

**【方药】**

小陷汤方：

黄连一两，半夏半升(洗)，栝蒌大者一枚。

36 伤寒六七日，发热，微恶寒，肢节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第146条)

【提要】

论少阳兼表的证治。

【词解】

① 肢节烦疼：四肢关节疼痛不舒。

② 心下支结：患者自觉心下有物支撑结聚。

【拓展】

伤寒六七日，一般为表证解除之期，如不解，则有传变之势。本证为太阳表证未解，进而邪犯少阳，实为太阳少阳并病，治宜太少两解之法。

【方药】

柴胡桂枝汤方：

桂枝一两半(去皮)，黄芩一两半，人参一两半，甘草一两(炙)，半夏二合半(洗)，芍药一两半，大枣六枚(擘)，生姜一两半(切)，柴胡四两。

37 伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第147条)

【提要】

论少阳病兼水饮内结的证治。

【方药】

柴胡桂枝干姜汤方：

柴胡半斤，桂枝三两(去皮)，干姜二两，栝蒌根四两，黄芩三两，牡蛎二两(熬)，甘草二两(炙)。

38 伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。若心下满而硬痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之；但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。(《辨太阳病脉证并治》，第149条)

【提要】

论少阳证、大结胸证及痞证。

【词解】

① 蒸蒸而振：高热寒战。蒸蒸，兴盛貌，形容高热；振，寒战。

② 却：然后。

【拓展】

“但满而不痛”是痞证的特征证候。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》谓“呕而肠鸣，心下痞者，半夏泻心汤主之”，是对本条痞证的补充，也是将半夏泻心汤证列为呕利痞的主要依据。

【方药】

半夏泻心汤方：

半夏半升(洗)，黄芩、干姜、人参、甘草(炙)各三两，黄连一两，大枣十二枚(擘)。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

39 心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第154条）

【提要】

论热痞的证候特征与治法。

【词解】

心下痞：心下有窒塞感。

【方药】

大黄黄连泻心汤方：

大黄二两，黄连一两。上二味，以麻沸汤二升渍之，须臾，绞去滓。分温再服。

40 心下痞，而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第155条）

【提要】

热痞兼阳虚的证治。

【方药】

附子泻心汤方：

大黄二两，黄连一两，黄芩一两，附子一枚(炮，去皮破，别煮取汁)。上四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾，绞去滓，内附子汁。分温再服。

41 伤寒，汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下利者，生姜泻心汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第

157条）

【提要】

论胃虚水饮食滞致痞的证治。

【词解】

① 噫：胃中气体上出咽喉所发出的声响，其声长而缓，俗称“打饱嗝”“饱嗝”。噫(ài)，嗳气。

② 食臭：食物的气味。

③ 腹中雷鸣：指肠鸣剧烈。

【方药】

生姜泻心汤方：

生姜四两(切)，甘草三两(炙)，人参三两，干姜一两，黄芩三两，半夏半升(洗)，黄连一两，大枣十二枚(擘)。

42 伤寒中风，医反下之，其人下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕心烦不得安，医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚。此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使硬也。甘草泻心汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第158条)

【提要】

论脾胃虚弱，痞利俱甚的证治。

【词解】

腹中雷鸣：肠鸣音亢进，连绵不绝。

【方药】

甘草泻心汤方：

甘草四两(炙)，黄芩三两，干姜三两，半夏半升(洗)，大枣十二枚(擘)，黄连一两。

43 伤寒发汗，若吐，若下，解后心下痞硬，噫气不除者，旋覆代赭汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第161条)

【提要】

肝气犯胃，胃虚痰阻证的证治。

【词解】

噫气：即嗳气。

【方药】

旋覆代赭汤方：

旋覆花三两，人参二两，生姜五两，代赭一两，甘草三两(炙)，半夏半升(洗)，大

枣十二枚(擘)。

44 太阳病,外证未除,而数下之,遂协热而利,利下不止,心下痞硬,表里不解者,桂枝人参汤主之。(《辨太阳病脉证并治》,第163条)

【提要】

论脾虚兼表的证治。

【词解】

协热而利:表证发热下利。热,发热恶寒。

【方药】

桂枝人参汤方:

桂枝四两(别切),甘草四两(炙),白术三两,人参三两,干姜三两。上五味,以水九升,先煮四味,取五升,内桂,更煮取三升,去滓,温服一升,日再夜一服。

桂枝人参汤煎服法:水煎1次,分3份,白天服2次,晚上服1次。方中理中汤先煎、久煎,桂枝后下。补益药宜久煎,解表药不宜久煎的理论源出于此。

45 伤寒若吐若下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之。(《辨太阳病脉证并治》,第168条)

【提要】

论白虎加人参汤证的证治。

【拓展】

对于“时时恶风”的病机,后世注家的认识颇不一致。柯韵伯《伤寒来苏集·伤寒论注·阳明篇》认为证属表邪未解:“太阳主表,阳明主里,表里俱热,是两阳并病也,恶风为太阳表证未罢,然时时恶风,则有时不恶,表将解矣,与背微恶寒同”。钱天来《伤寒溯源集·太阳下篇》认为是内真寒外假热:“时时恶风者,言时常恶风也,若邪气在表,只称恶风而不曰时时矣……而犹时时恶风,即所谓热则生风,及内热生外寒之义,故不必解表”。周禹载《伤寒论三注》持肌表阳虚之说:“时恶风,阳外虚也”。

【方药】

白虎加人参汤方:

知母六两,石膏一斤(碎),甘草二两(炙),人参二两,粳米六合。

46 太阳与少阳合病,自下利者,与黄芩汤;若呕者,黄芩加半夏生姜汤主之。(《辨太阳病脉证并治》,第172条)

【提要】

辨太少合病下利或呕的证治。

【拓展】

本条“太阳与少阳合病”，却并无太阳之证，方无太阳之药，是有合病之名，而无合病之实，疾病重心偏于少阳。

【方药】

① 黄芩汤方：

黄芩三两，芍药二两，甘草二两(炙)，大枣十二枚(擘)。上四味，以水一斗，煮取三升，去滓。温服一升，日再夜一服。

② 黄芩加半夏生姜汤方：

黄芩三两，芍药二两，甘草二两(炙)，大枣十二枚(擘)，半夏半升(洗)，生姜一两半(一方三两，切)。上六味，以水一斗，煮取三升，去滓。温服一升，日再夜一服。

47 伤寒，胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第173条)

【提要】

论上热下寒腹痛欲呕吐的证治。

【词解】

① 邪气：寒邪。

② 胸中、胃中：此指上下部位而言。热邪偏于上，包括胃脘、上至胸膈，故称“胸中有热”。“胃中有邪气”，即指腹中有寒邪。胃与胸相对，部位偏于下。

【方药】

黄连汤方：

黄连三两，甘草三两(炙)，干姜三两，桂枝三两(去皮)，人参二两，半夏半升(洗)，大枣十二枚(擘)。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓。温服，昼三夜二。

48 伤寒脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第177条)

【提要】

论心阴阳两虚的证治。

【词解】

心动悸：自觉心悸，或见心前搏动。

【句解】

本病成因为外感病，始为太阳而渐内累于心，今外邪已罢，仅存里虚之证。

心主血脉，赖阳气以温煦、阴血以滋养，心阴阳气血不足，则心失所养，故见心动悸；心阳虚鼓动无力，心阴虚脉道不充，心之阴阳俱不足故脉结代。

**【方药】**

炙甘草汤方：

甘草四两(炙)，生姜三两(切)，人参二两，生地黄一斤，桂枝三两(去皮)，阿胶二两，麦冬半升(去心)，麻仁半升，大枣三十枚(擘)。

**49** 阳明之为病，胃家实是也。(《辨阳明病脉证并治》，第180条)

**【提要】**

阳明病的脉证总纲。

**【句解】**

“实”即邪气盛实，是对阳明病热证、实证病理机制的高度概括。阳明为多气多血之腑，阳气旺盛，是以邪入阳明，多易从燥化。胃肠燥热亢盛，其病变每以热实为特征，但分而言之，又有热证、实证之别。然无论是热证，还是实证，均属燥热实证，故以“胃家实”统括之。

**【拓展】**

关于“胃家实”的含义，后世医家见解不尽相同。尤在泾认为“胃家实”即指阳明实证而言，不含阳明热证。汪苓友则认为“胃家实”当包括胃热肠实。

**50** 问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。(《辨阳明病脉证并治》，第182条)

**【提要】**

论阳明病外证。

**【词解】**

外证：阳明病里热实证反映于外的症状。

**【句解】**

阳明病因里热亢盛，蒸腾于外，故见身热；热盛迫液外泄，故汗自出；因邪热炽盛，充斥内外，故不恶寒反恶热，此症为阳明病所独有。

**【拓展】**

对于阳明外证，柯韵伯《伤寒来苏集·阳明病篇》认为胃中虚冷也有此外证，“四证是阳明外证之提纲，故胃中虚冷，亦得称阳明病者，因其外证如此也”。

**51** 三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁，面垢，谵语，遗尿。

发汗则谵语，下之则额上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎汤主之。（《辨阳明病脉证并治》，第219条）

【提要】

论三阳合病，邪热偏重于阳明的证治及治禁。

【词解】

① 口不仁：口中感觉失常，食不知味，语言不利。

② 面垢：面部如蒙油垢。

【拓展】

三阳合病，言太阳、阳明、少阳三经同时发病。然从症状表现看，实以阳明热盛为主。三阳合病，禁用汗、下二法。

52 若脉浮，发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。（《辨阳明病脉证并治》，第223条）

【提要】

论阳明热证误下津伤，膀胱蓄水的证治。

【方药】

猪苓汤方：

猪苓去皮，茯苓、泽泻、阿胶、滑石（碎）各一两。

53 趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬，其脾为约，麻子仁丸主之。（《辨阳明病脉证并治》，第247条）

【提要】

论津伤便结的脾约证证治与机制。

【词解】

① 趺阳脉：为足背动脉，在冲阳穴处，属足阳明胃经。

② 脾约：脾输布津液的功能被胃热所约束，使津液不能还入肠道，肠道失润而导致大便硬。

【方药】

麻子仁丸方：

麻子仁二升，芍药半斤，枳实半斤（炙），大黄一斤（去皮），厚朴一尺（炙，去皮），杏仁一升（去皮尖，熬，别作脂）。上六味，蜜和丸如梧桐子大，饮服十丸，日三服，渐加，以知为度。

54 太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，调胃承气汤主之。（《辨阳明病脉证并治》，第248条）

【提要】

论调胃承气汤证的证治。

【词解】

① 蒸蒸发热：形容发热从内达外，如蒸笼中热气蒸腾之状。

② 属胃：此指转属阳明病。

【拓展】

调胃承气汤服法有两种：一为“少少温服之”，用于阳复太过致胃热谵语者；一为“温顿服之”，取其攻下之力，用于阳明病实证。

55 伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第249条）

【提要】

论调胃承气汤证的证治。

56 伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也，急下之，宜大承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第252条）

【提要】

论述伤寒目睛不和的证治。

【词解】

① 目中不了了：视物不清。

② 睛不和：眼球转动不灵活。

③ 表里：表，表证；里指大便秘结，腹满疼痛拒按等症。

57 阳明病，发热汗多者，急下之，宜大承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第253条）

【提要】

论阳明病发热汗多的证治。

【句解】

本条当指燥热互结于腑的阳明实证。发热汗多，是里热蒸腾，迫津外泄，阳热呈亢极之势，阴津有枯竭之虞。

58 发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第254条）

【提要】

论阳明腑实重证。

【拓展】

阳明急下三证，前有“谵语、发潮热、脉滑而疾者”，犹恐燥实不甚，尚不敢贸然使用大承气，而先试投小承气。这里仅凭“身微热，大便难”“发热，汗多”“发汗不解，腹满痛”，则急用大承气汤泻下，是因为“目中不了了，睛不和”“汗多”“发汗不解”，皆提示阴液、阴精耗损之重，可见大承气汤之用，脉症疑似时，当审以慎；急下存阴时，又应当机立断，不得犹豫彷徨。

59 伤寒发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿在里不解故也，以为不可下也，于寒湿中求之。（《辨阳明病脉证并治》，第259条）

【提要】

论寒湿发黄的证治。

【拓展】

发黄有阳黄与阴黄之别。阳黄多由湿热内郁，熏蒸肝胆所致，其黄色鲜明如橘子色。阴黄多由寒湿中阻或脾虚内生寒湿，以致寒湿内停，进而影响肝胆疏泄功能所致，其黄色晦暗无泽。

60 伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。（《辨阳明病脉证并治》，第260条）

【提要】

论茵陈蒿汤证的病机、临床表现与治法。

61 伤寒瘀热在里，身必黄，麻黄连轺赤小豆汤主之。（《辨阳明病脉证并治》，第262条）

【提要】

论风寒闭表、湿热内郁之发黄的证治。

【词解】

① 瘀热：热邪郁阻于里。

② 连轺：连翘根，今多用连翘。轺(yáo)，音摇。

【方药】

麻黄连轺赤小豆汤方：

麻黄二两(去节)，连轺二两(连翘根)，杏仁四十个(去皮尖)，赤小豆一升，大枣十二枚(擘)，生梓白皮一升(切)，生姜二两(切)，甘草二两(炙)。

62 少阳之为病，口苦，咽干，目眩也。（《辨少阳病脉证并治》，第263条）

【提要】

少阳病脉证提纲。

【拓展】

本条是否可为少阳病提纲历来就有所争议。柯韵伯《伤寒来苏集·少阳脉证》认为可以作少阳病提纲，“太阳主表，头项强痛为提纲，阳明主里，胃家实为提纲，少阳居半表半里之位，张仲景特以口苦、咽干、目眩为提纲，奇而至当也”。山田正珍认为，少阳病提纲缺如，王叔和因缺而补入，非仲景之本意，故不能作为少阳病提纲。李培生、刘渡舟认为本条从胆主相火，而讨论胆火上炎之病变，是从总体上揭示本经纲领。然则尚有邪入少阳，枢机不利，正邪分争，甚至影响脾胃功能的病变，如往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕等，仍需与本条合参，才更为全面。

63 伤寒，脉弦细，头痛发热者，属少阳。少阳不可发汗，发汗则谵语，此属胃。胃和则愈，胃不和，烦而悸。（《辨少阳病脉证并治》，第265条）

【提要】

少阳病禁汗、误汗后的变证及转归。

【拓展】

胃气和，其含义有二：一为热除津复，谵语自止；一为胃热津伤，难以自和，可用和胃泄热之法，下其里实，实邪去则胃自和。若胃气不和，则热盛津伤，阴血不足，心失所养，故见烦、悸之症。此为少阳误汗所致，故少阳病禁用汗法。

64 太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结硬。（《辨太阴病脉证并治》，第273条）

【提要】

太阴病的提纲证。

【词解】

胸下结硬：胸下即胃脘部，指胃脘部痞结胀硬。

【拓展】

本条作为太阴病提纲，各家认识比较一致，但对本证成因及性质，观点有很大分歧。张兼善认为是饮食生冷，饮食过多，损伤脾胃所致；王三阳主张此风寒中于太阴经，非中脏腑之阴证，亦非阳邪传里；成无已、汪苓友认为属阳邪传里之

热证；尤在泾提出不必拘传经、直中，不必究伤寒、杂病，只要出现提纲中证候，即可诊为太阴病。目前多数注家学者，包括各版教材均宗尤在泾之说。

65 自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也，当温之，宜服四逆辈。（《辨太阴病脉证并治》，第277条）

【提要】

论太阴病的主症、病机和治则。

【词解】

① 脏有寒：脾脏虚寒。

② 四逆辈：指四逆汤一类方剂，包括理中汤。

66 少阴之为病，脉微细，但欲寐也。（《辨少阴病脉证并治》，第281条）

【提要】

少阴病的提纲证。

【词解】

但欲寐：精神萎靡，呈似睡非睡状态。

【句解】

少阴属心肾两脏，心主血属火，肾藏精主水，病则心肾虚衰，水火两虚。阳气衰微，鼓脉无力，故脉微；阴血不足，脉道不充，则脉细。心虚神不充则精神萎靡，肾虚精不足则体力疲惫，故患者呈似睡非睡、闭目倦卧的衰弱病状。脉微细反映阴阳俱虚，但欲寐反映心肾虚衰，以此脉症，说明少阴病是以全身性虚衰为病理特征的疾病。

67 少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄细辛附子汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第301条）

【提要】

论少阴寒化兼表的证治。

【方药】

麻黄细辛附子汤方：

麻黄二两（去节），细辛二两，附子一枚（炮，去皮，破八片）。

68 少阴病，得之二三日，麻黄附子甘草汤微发汗。以二三日无证，故微发汗也。（《辨少阴病脉证并治》，第302条）

【提要】

少阴兼表证情轻缓的证治。

【词解】

无证：《金匮玉函经》卷四，《注解伤寒论》卷六均作无里证，指无吐利等里虚寒证。

【方药】

麻黄附子甘草汤方：

麻黄二两（去节），甘草二两（炙），附子一枚（炮，去皮，破八片）。

69 少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第303条）

【提要】

论少阴热化阴虚火旺不寐的证治。

【词解】

不得卧：内心烦扰，不能静卧入眠。

【方药】

黄连阿胶汤方：

黄连四两，黄芩二两，芍药二两，鸡子黄二枚，阿胶三两（一云三挺）。

70 少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第304条）

【提要】

论少阴寒湿身痛证。

【词解】

口中和：指口中不苦、不燥、不渴。

【句解】

本条“口中和”是审证要点，主症是“背恶寒”。口中和并非病症，是指口中不苦、不燥、不渴，主要为排除热证而提出的鉴别指征。督脉循行于背，统督诸阳。少阴病阳虚，背部失于温煦，故背恶寒，灸之可祛寒通阳。

【方药】

附子汤方：

附子二枚（炮，去皮，破八片），茯苓三两，人参二两，白术四两，芍药三两。

71 少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。（《辨

少阴病脉证并治》，第305条）

【提要】

论少阴寒湿身痛证。

【句解】

本条所论病症以疼痛为主要病变。肾阳虚衰，水寒不化，寒湿留着于筋脉骨节肌肉，经脉受阻，经气不利，故身体骨节疼痛；肾阳虚衰，四末失于温养，故手足寒；阳虚湿遏，故脉沉。

72 少阴病，下利便脓血者，桃花汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第306条）

【提要】

论少阴滑脱不禁便脓血证。

【拓展】

本条主症是下利便脓血。少阴寒化，阳虚失于温化，寒湿凝滞，大肠络脉受伤，加之阳虚不能统摄，故下利便脓血。所论之症均属脾肾阳虚，失于固摄，故下利均为滑脱不禁。

【方药】

桃花汤方：

赤石脂一斤（一半全用，一半筛末），干姜一两，粳米一升。

73 少阴病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者，桃花汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第307条）

【提要】

续第306条论少阴滑脱不禁便脓血证。

74 少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第309条）

【提要】

论中阳不足，寒浊中阻，四肢厥逆的证治。

【词解】

烦躁欲死：烦躁难忍。

【句解】

中阳不足，胃寒生浊，升降失司，故见吐利；中阳虚加之寒浊中阻，阳难外达，故手足逆冷。气机逆乱、吐泻交作，故见烦乱不安。

【方药】

吴茱萸汤方：

吴茱萸一升，人参二两，生姜六两(切)，大枣十二枚(擘)。

75 少阴病，下利，白通汤主之。(《辨少阴病脉证并治》，第314条)

【提要】

论少阴病阴盛戴阳的证治。

【拓展】

本条叙证简略，当与315条合参，并需以方测证。

【方药】

白通汤方：

葱白四茎，干姜一两，附子一枚(生，去皮，破八片)。

76 少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛、小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气。其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。(《辨少阴病脉证并治》，第316条)

【提要】

论少阴病阳虚水泛的证治。

【句解】

少阴病二三日不已，至四五日，邪气渐深，肾阳日亏，阳虚寒盛，水气不化而内停，泛溢为患。因水气所居之处不同，故产生腹痛、小便不利、四肢沉重疼痛等诸多证候。

【方药】

真武汤方：

茯苓三两，芍药三两，白术二两，生姜三两(切)，附子一枚(炮，去皮，破八片)。

77 少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之。(《辨少阴病脉证并治》，第317条)

【提要】

论少阴病阴盛格阳的证治。

【词解】

① 下利清谷：泻下粪便如清水，或未消化的食物残渣。

② 利止脉不出：阳气欲绝，下利至甚，无物可下。

**【方药】**

通脉四逆汤方：

甘草二两(炙)，附子大者一枚(生用，去皮，破八片)，干姜三两(强人可四两)。

78 少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。(《辨少阴病脉证并治》，第318条)

**【提要】**

论阳郁厥逆的证治。

**【词解】**

泄利下重：下利重坠不爽感。

**【句解】**

肝郁气滞，阳气内郁不达四肢则四逆。阳气郁遏，气机不畅，故可见咳，悸，小便不利，腹中痛，泄利下重等诸多或然症。

79 少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。(《辨少阴病脉证并治》，第323条)

**【提要】**

论少阴病脉沉的证治。

**【拓展】**

病入少阴，涉及根本，阳亡迅速，故少阴之治，贵在及早。当脉沉显示阳虚征兆时，即当急温，以防亡阳之变。

**【方药】**

四逆汤方：

甘草二两(炙)，干姜一两半，附子一枚(生用，去皮，破八片)。

80 厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蚘，下之利不止。(《辨厥阴病脉证并治》，第326条)

**【提要】**

厥阴病证提纲。

**【词解】**

气上撞心：患者自觉有气上冲心胸部位。

**【句解】**

厥阴为阴尽阳生之经，其病常表现为虚实错杂、上热下寒的情形。上焦有

热，津液被耗则消渴。厥阴风火循经上扰则气上撞心，心脘疼热，嘈杂似饥。肝木乘脾，脾气虚寒不运则不欲食。若勉强进食，则可胃失和降，蛔虫逆动而吐。本证属虚实错杂、上热下寒，若见上热而误用苦寒攻下，则更伤脾肾之阳，下寒更甚而利下不止。

81 凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。（《辨厥阴病脉证并治》，第 337 条）

**【提要】**

论厥的病机与临床表现。

**【词解】**

阴阳气：指阳气与阴气，也指表里之气。

**【拓展】**

阳气不能布达温煦四肢的原因，大抵分为阳气不足与阳气被阻两大类。

82 伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁，无暂安时者，此为脏厥，非蛔厥也。蛔厥者，其人当吐蛔。今病者静，而复时烦者，此为脏寒。蛔上入其膈，故烦，须臾复止，得食而呕，又烦者，蛔闻食臭出，其人常自吐蛔。蛔厥者，乌梅丸主之。又主久利。（《辨厥阴病脉证并治》，第 338 条）

**【提要】**

辨脏厥与蛔厥，以及蛔厥的证治。

**【词解】**

① 脏厥：肾脏真阳极虚所致四肢厥冷。

② 蛔厥：蛔虫内扰，疼痛剧烈，气机逆乱所致四肢逆冷。

**【方药】**

乌梅丸方：

乌梅三百枚，细辛六两，干姜十两，黄连十六两，当归四两，附子六两（炮，去皮），蜀椒四两（去汗），桂枝六两（去皮），人参六两，黄柏六两。上十味，异捣筛，合治之，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五斗米下，饭熟，捣成泥，和药令相得，内臼中，与蜜杵二千下，丸如梧桐子大，先食饮，服十丸，日三服，稍加至二十丸。禁生冷、滑物、臭食等。

83 伤寒脉滑而厥者，里有热，白虎汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第 350 条）

【提要】

论里热炽盛致厥的证治。

【词解】

脉滑而厥：脉象滑数有力而四肢逆冷。

【句解】

本证病机的关键是“里有热”。滑脉还提示了本证虽热邪壅滞，但尚未与有形实邪结聚，治宜大清气分之热。

84 手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第351条）

【提要】

论血虚寒凝致厥的证治。

【词解】

脉细欲绝：脉来如丝，似有似无。

【方药】

当归四逆汤方：

当归三两，桂枝三两（去皮），芍药三两，细辛三两，甘草二两（炙），通草二两，大枣二十五枚（擘，一法，十二枚）。右七味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

85 大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第353条）

【提要】

论阳虚寒厥兼表证的证治。

【词解】

内拘急：腹内拘挛急迫。

【句解】

阳虚卫外不固则大汗出；阳气不足，阴津亏损，筋经失于温养，则内见腹内拘急，外见四肢疼痛；阳虚腐熟无力，则见下利；阳虚失于温煦，则见厥逆而恶寒。

86 热利下重者，白头翁汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第371条）

【提要】

论厥阴热利的证治。

【词解】

热利下重：热性下利，伴里急后重。

【方药】

白头翁汤方：

白头翁二两，黄柏三两，黄连三两，秦皮三两。上四味，以水七升，煮取二升，去滓。温服一升，不愈，更服一升。

87 干呕吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第 378 条）

【提要】

论肝寒犯胃，浊阴上逆的证治。

【词解】

干呕吐涎沫：或干呕，或吐涎沫。

【句解】

肝寒犯胃，胃失和降，则干呕；肝寒犯胃，胃寒饮停，泛溢于口，则吐清稀涎沫。肝经与督脉会于巅顶，阴寒循经上扰，故见巅顶痛。

88 恶寒脉微而复利，利止，亡血也，四逆加人参汤主之。（《辨霍乱病脉证并治》，第 385 条）

【提要】

论霍乱亡阳脱液的证治。

【词解】

亡血：亡失津液。

【方药】

四逆加人参汤方：

甘草二两（炙），附子一枚（生，去皮，破八片），干姜一两半，人参一两。

89 霍乱，头痛发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之；寒多不用水者，理中丸主之。（《辨霍乱病脉证并治》，第 386 条）

【提要】

论霍乱病表里寒热不同的证治。

【词解】

不用水：不渴。

【方药】

理中丸方：

人参、干姜、甘草（炙）、白术各三两。上四味，捣筛，蜜和为丸，如鸡子黄许大。

以沸汤数合，和一丸，研碎，温服之，日三四，夜二服；腹中未热，益至三四丸，然不及汤。

90 伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐，竹叶石膏汤主之。（《辨阴阳易差后劳复病脉证并治》，第397条）

**【提要】**

论病后余热未清，气阴两伤的证治。

**【词解】**

虚羸：虚弱消瘦。

**【句解】**

伤寒解后，气阴两伤，余热未尽，因其津液损伤，不能濡养形骸，故见身体虚弱消瘦；中气不足，故短气不足以息。加之未尽之余热内扰，胃失和降，故气逆欲吐。

**【方药】**

竹叶石膏汤方：

竹叶二把，石膏一斤，半夏半升(洗)，麦冬一升(去心)，人参二两，甘草二两(炙)，粳米半升。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米，煮米熟，汤成去米。温服一升，日三服。

# 二级条文(116条)

1 伤寒二三日,阳明、少阳证不见者,为不传也。(《辨太阳病脉证并治》,第5条)

【提要】

太阳病不传之辨。

【句解】

根据《素问》计日传经说,外感病二日当传阳明,三日当传少阳,四日当传太阴等,现太阳病已二三日,若患者仍未见阳明身热,汗自出,不恶寒反恶热,烦躁,口渴等,又不见少阳口苦,咽干,目眩,往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕等,且太阳见证仍在,由此判断病仍在太阳,未发生传变。

【拓展】

太阳病是否发生传变,主要依据临床症状是否发生变化,不得拘泥于发病时日。

2 太阳病,发热而渴,不恶寒者,为温病。若发汗已,身灼热者,名风温。风温为病,脉阴阳俱浮,自汗出,身重,多眠睡,鼻息必鼾,语言难出。若被下者,小便不利,直视失溲,若被火者,微发黄色,剧则如惊痫,时瘛疭,若火熏之。一逆尚引日,再逆促命期。(《辨太阳病脉证并治》,第6条)

【提要】

论太阳温病的提纲及其误治后的变证。

【词解】

① 温病:外感病之一,属广义伤寒范畴。

② 风温:温病误用辛温发汗后的一种变证。

③ 被火:误用灸、熏、温针等火法治疗。

【拓展】

温病由感受温热病邪所致,突出特点为发热而渴,恶寒轻微,反映了温邪犯表,化热伤津,营卫失和的病理特点,故可作为温病的提纲。若使用辛温药物发汗,以温治温,必致热盛津伤,形成诸多变证。

3 太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。（《辨太阳病脉证并治》，第8条）

【提要】

论太阳病经尽自愈和预防传经之法。

【词解】

① 行其经尽：太阳行经之期已经结束。

② 欲作再经：将传经于阳明。

【句解】

太阳病一般病情轻浅，若不发生传变，正气较旺之人，通过机体的自身调节，正气来复，抗邪外出，症状逐渐减轻直至消失，一周左右即可自愈。若太阳病七日以上，病症不愈，邪气有内传阳明之趋势，则应针刺阳明穴位，疏通经络，振奋正气，防止传变，使邪气仍留太阳，直到正胜邪去而痊愈。

【拓展】

本条单举头痛，是一种省文笔法，其一是根据《黄帝内经》“七日巨阳病衰，头痛少愈”的引申；其二是头为诸阳之会，头痛的减轻与否，能反映太阳病的变化。但临证时不能拘于头痛，应四诊合参，方能准确无误。

4 太阳病欲解时，从巳至未上。（《辨太阳病脉证并治》，第9条）

【提要】

根据天人相应理论，推测太阳病欲解时间。

【词解】

① 欲解时：邪气可能得解的时间，非病必愈之时。

② 从巳至未上：指巳、午、未三个时辰，即上午九时至下午三时。

【拓展】

太阳病解，虽与自然界阳气盛衰有关，但起决定作用者，还是人体内部因素，即患者本身之正气是否充实，同时亦要顾及外部因素。因而对本条所言“欲解”，不可一概而论。

5 风家，表解而不了了者，十二日愈。（《辨太阳病脉证并治》，第10条）

【提要】

预测太阳病解后彻底康复的日期。

【词解】

① 风家：常受风患病者。家，常患某病之人。

② 不了了：病证绝大部分已消除，但仍有不舒适的感觉。了，完毕，结束。

**【句解】**

经常患太阳病者，多有正气不足，若表邪已解，但身体仍觉不适，尚未完全恢复，可能是正气未复，抑或部分余邪未清，此后不必再服药，只需休息静养，待正气恢复，邪气渐去，自可康复。根据仲景经验，预测约十二日即可。

6 太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，桂枝加葛根汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第14条）

**【提要】**

论太阳中风兼太阳经气不舒的证治。

**【词解】**

① 项背强几几：项背拘紧不适，转动俯仰不利。几几，拘紧，固缩。

② 反：反而。

**【方药】**

桂枝加葛根汤方：

葛根四两，麻黄三两(去节)，芍药二两，生姜三两(切)，甘草二两(炙)，大枣十二枚(擘)，桂枝二两(去皮)。上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗，不须歠粥，余如桂枝法将息及禁忌。

7 太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤。方用前法。若不上冲者，不得与之。（《辨太阳病脉证并治》，第15条）

**【提要】**

论太阳病误下后，其气上冲的证治。

**【词解】**

其气上冲：一指患者自觉胸中有气上逆；一指太阳经气上冲，与邪相争。

8 若酒客病，不可与桂枝汤，得之则呕，以酒客不喜甘故也。（《辨太阳病脉证并治》，第17条）

**【提要】**

以酒客为例，提示湿热内蕴者禁用桂枝汤。

**【词解】**

酒客：嗜酒之人。

**【拓展】**

《医宗金鉴》认为酒客病乃太阳中风之类证，因嗜酒太过，湿热内蕴，导致营

卫气血失调，而见头痛，发热，汗出，恶心，呕吐等症，证似外感，实非外感，故桂枝汤不可与之。

9 喘家，作桂枝汤，加厚朴杏子佳。（《辨太阳病脉证并治》，第18条）

【提要】

论外感风寒引发宿疾喘息的证治。

【词解】

喘家：素患喘疾之人。

【句解】

素有咳喘，又复感风寒，引动宿疾，致咳喘发作。

10 太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第21条）

【提要】

论太阳病误下后胸阳不振的证治。

【词解】

脉促：脉象急促有力，或急中一止，止无定数。

【句解】

太阳病误下，胸阳受损，失于布达，则见胸满。然胸阳虽伤，未致大虚，仍能与邪争，邪未全陷，仍有伸展之势，故脉急促。

11 若微寒者，桂枝去芍药加附子汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第22条）

【提要】

论太阳病误下后，阳损较甚，兼表不解的证治。

【词解】

微寒：脉微恶寒。

【方药】

桂枝去芍药加附子汤方：

桂枝三两(去皮)，甘草二两(炙)，生姜三两(切)，大枣十二枚(擘)，附子一枚(炮，去皮，破八片)。

12 太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。（《辨太阳病脉证并治》，第24条）

【提要】

论太阳病服桂枝汤后，反烦不解的证治。

【词解】

① 风池：穴名，枕骨粗隆直下凹陷处与乳突间是穴。

② 风府：穴名，后项入发际一寸，枕骨与第一颈椎之间是穴。

【拓展】

反烦不解乃太阳中风邪气较重，服桂枝汤后正气得药力相助，欲驱邪外出，但力尚不足，正邪相争，邪郁不解，属太阳中风的较重型。

13 服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白术汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第28条）

【提要】

论水气内停而太阳经气受阻的证治。

【词解】

翕翕发热：形容发热轻而温和。

【句解】

水饮内停，气行受阻，胃气壅滞，故见心下满微痛；水饮内停，气化不利，故小便不利；里气失和，在外的阳气被遏，故发热无汗；在外之经输不畅，故见头项强痛。

【方药】

桂枝去桂加茯苓白术汤方：

芍药三两，甘草二两(炙)，生姜(切)、白术、茯苓各三两，大枣十二枚(擘)。

14 伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝欲攻其表，此误也，得之便厥。咽中干，烦躁，吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳。若厥愈足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸。若胃气不和，谵语者，少与调胃承气汤。若重发汗，复加烧针者，四逆汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第29条）

【提要】

论伤寒兼阴阳两虚证误治后的变证。

【词解】

① 厥：手足逆冷。

② 谵语：神志不清，胡言乱语，声音高亢。

【方药】

① 甘草干姜汤方：

甘草四两(炙)，干姜二两。上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

② 芍药甘草汤方：

白芍药、甘草(炙)各四两。上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

15 太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤。(《辨太阳病脉证并治》，第36条)

【提要】

论太阳与阳明合病，喘而胸满的证治。

【词解】

合病：两经或两经以上证候同时出现。

【句解】

太阳与阳明同时发病，孰轻孰重，当仔细分析。首先，喘而胸满，与阳明腹满而喘有别；其次，“不可下”，说明本证以太阳伤寒为主，而阳明次之。即表里同病，表证为主，治宜先表后里，不可早下。

16 太阳病，十日以去，脉浮细而嗜卧者，外已解也。设胸满胁痛者，与小柴胡汤。脉但浮者，与麻黄汤。(《辨太阳病脉证并治》，第37条)

【提要】

论太阳病多日后的三种转归。

【词解】

嗜卧：精神倦怠而喜静卧。

17 太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。(《辨太阳病脉证并治》，第42条)

【提要】

论太阳病，外证未解，脉浮弱的证治。

【词解】

外证：即表证。

18 太阳病，下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏子汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第43条)

【提要】

论太阳病下后表不解兼喘的证治。

【方药】

桂枝加厚朴杏子汤方：

桂枝三两(去皮)，甘草二两(炙)，生姜三两(切)，芍药三两，大枣十二枚(擘)，厚朴二两(炙，去皮)，杏仁五十枚(去皮尖)。

19 太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗。服药已微除，其人发烦目瞑，剧者必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也。麻黄汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第46条)

【提要】

论太阳伤寒日久的证治。

【词解】

① 目瞑：闭目懒睁，有畏光感。

② 阳气重：阳气郁遏较重。

【句解】

太阳伤寒虽经八九日之久，但表证仍在，邪未传变，仍属太阳伤寒表实证，故仍与麻黄汤发汗解表。服麻黄汤后，表证稍减而未愈，同时出现发烦目瞑，甚者鼻衄等，是由于表闭阳郁，阳郁较轻者，服药后正气得药力相助驱邪外出，然正邪交争剧烈，故心烦目瞑，待正胜邪去，则汗出病解；阳郁较重者，由于阳郁太甚，不得汗解，反内迫营血，阳络受损，而致鼻衄。

20 太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者，愈。(《辨太阳病脉证并治》，第47条)

【提要】

论伤寒表实证可自衄而解。

【句解】

表邪外束，玄府郁闭，若不得汗解，邪无出路，郁于经络，重者可损伤阳络而衄血。血汗同源，邪随衄解，故有衄后自愈的转机。

【拓展】

第46条为衄在汗后，汗不解衄乃解；本条为不汗而衄，邪随衄解，属自愈。

21 脉浮数者，法当汗出而愈。若下之，身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解。所以然者，尺中脉微，此里虚，须表里实，津液自和，便

自汗出愈。(《辨太阳病脉证并治》,第 49 条)

【提要】

论误下后里虚,尺中脉微者不可发汗。

【词解】

① 须:等待。

② 表里实:表里,表气与里气。实,正气恢复。

22 脉浮紧者,法当身疼痛,宜以汗解之。假令尺中迟者,不可发汗。何以知然?以营气不足,血少故也。(《辨太阳病脉证并治》,第 50 条)

【提要】

论尺中脉迟营血不足者,禁用发汗。

【词解】

尺中迟:尺脉迟缓无力。

【句解】

脉浮紧,为太阳伤寒表实证之典型脉象。因寒邪束表,营阴郁滞,必有身痛。此时,若脉见"尺中迟",尺以候里,迟涩为营血不足,此乃里虚兼表,不可强发汗。

23 伤寒,不大便六七日,头痛有热者,与承气汤。其小便清者,知不在里,仍在表也,当须发汗。若头痛者,必衄,宜桂枝汤。(《辨太阳病脉证并治》,第 56 条)

【提要】

根据小便清否辨表里证治,亦辨桂枝汤与承气汤证治。

【词解】

清:小便澄澈清冷。

【拓展】

《医宗金鉴》等认为本条所述之证,既有头痛之表证,又有六七日不大便之里证,表里主次,可从小便清否辨之。若小便清白,以表证为主,虽有里热,亦当用桂枝汤解表;若小便黄赤,以里热为主,虽有表证,亦当与承气汤攻下。

24 发汗后,身疼痛,脉沉迟者,桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。(《辨太阳病脉证并治》,第 62 条)

【提要】

论太阳病发汗太过，气营不足身痛的证治。

【词解】

脉沉迟：脉象沉迟无力。

【句解】

身疼痛为太阳病常见症，因风寒束表所致，每随发汗而减。今发汗后身痛不减或更甚，又兼脉象沉迟无力，当属气血不足，营阴耗伤，经脉失养而致身痛。

【方药】

桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方：

桂枝三两(去皮)，芍药四两，甘草二两(炙)，人参三两，大枣十二枚(擘)，生姜四两。

25 发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第65条)

【提要】

论心阳虚，欲作奔豚的证治。

【词解】

奔豚：病名，为肾积。以猪的奔跑状态形容患者自觉有气从少腹上冲胸咽，时作时止，或上或下。

【方药】

茯苓桂枝甘草大枣汤：

茯苓半斤，桂枝四两(去皮)，甘草二两(炙)，大枣十五枚(擘)。上四味，以甘澜水一斗，先煮茯苓，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

26 发汗后，腹胀满者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第66条)

【提要】

论脾虚气滞腹胀的证治。

【方药】

厚朴生姜半夏甘草人参汤方：

厚朴半斤(炙，去皮)，生姜半斤(切)，半夏半斤(洗)，甘草二两，人参一两。

27 发汗，病不解，反恶寒者，虚故也，芍药甘草附子汤主之。(《辨太阳病脉证并治》，第68条)

【提要】

论汗后阴阳两虚的证治。

【词解】

虚：阴阳两虚。

【拓展】

汗后病不解，有表证未罢或产生变证两种可能。若是表证未罢，当见恶寒发热，脉浮等症。今汗后，恶寒加重，又不见发热脉浮等症，提示为汗后产生的变证，并非表证不解。

28 发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第69条）

【提要】

论汗下后阴阳两虚烦躁的证治。

【词解】

病仍不解：非指表证不解，而是病入少阴。

29 发汗已，脉浮数烦渴者，五苓散主之。（《辨太阳病脉证并治》，第72条）

【提要】

论蓄水轻证的证治。

【词解】

烦渴：心烦口渴而饮水不解。

30 伤寒汗出而渴者，五苓散主之；不渴者，茯苓甘草汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第73条）

【提要】

依据口渴与否，辨水停于下或水停于中。

31 中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之。（《辨太阳病脉证并治》，第74条）

【提要】

论蓄水重证的证治。

【词解】

① 表里证：既有太阳表证，又有蓄水里证。

② 水逆：水蓄膀胱，气不化津，津不上承，以致口渴引饮，饮入即吐的一种症状，是蓄水重证的表现。

【句解】

太阳病虽经六七日，病证不解，反增心烦，提示表里同病。水蓄膀胱，气不化津，津不上承，则口渴欲饮。又因水邪不得下行，上逆犯胃，胃失和降，则水入即吐，名曰水逆。

32 发汗若下之，而烦热胸中窒者，栀子豉汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第77条）

【提要】

论热郁胸膈，胸中窒塞的证治。

【词解】

胸中窒：胸中有堵塞不适之感。窒，塞也。

33 伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者，未欲解也，栀子豉汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第78条）

【提要】

论热郁胸膈，心中结痛的证治。

【词解】

心中结痛：心中因热邪郁结而疼痛。

【拓展】

本条“身热不去，心中结痛”，王肯堂认为是表热未除。柯韵伯认为与“热结心中”有关，并提出当与结胸鉴别，而分“水郁折之”“火郁发之”之治。

34 伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第79条）

【提要】

论伤寒下后心烦腹满的证治。

35 伤寒，医以丸药大下之，身热不去，微烦者，栀子干姜汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第80条）

【提要】

论热扰胸膈兼中焦有寒的证治。

【词解】

丸药：指东汉末年流行的一种具有泻下作用的成药。

【句解】

伤寒，理当汗解，医以丸药大下，则属误治。误下后，中阳受损，而致中焦虚寒，又下后表邪乘机内陷，留扰胸膈，形成上焦有热，中焦有寒之证。

36 咽喉干燥者，不可发汗(83)。淋家不可发汗，发汗必便血(84)。疮家，虽身疼痛，不可发汗，汗出则痓(85)。衄家，不可发汗，汗出必额上陷，脉急紧，直视不能眴，不得眠(86)。亡血家，不可发汗，发汗则寒栗而振(87)。汗家，重发汗，必恍惚心乱，小便已阴疼，与禹余粮丸(88)。病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔(89)。(《辨太阳病脉证并治》，第83～89条)

【提要】

论禁汗。

【词解】

① 淋家：久患淋证之人。淋，小便淋漓不尽，尿频、尿少、尿痛。

② 眴：目睛转动。

③ 寒栗而振：寒战。

【拓展】

以上七条，从不同角度阐述汗法禁例及机制。阳加于阴谓之汗，且血汗同源，气血互根，峻汗必伤及气血阴阳，故虚人外感不可用；又因麻黄汤为辛温解表之剂，辛温能助热，故火旺阳亢、风热外感者亦不可用。

37 伤寒，医下之，续得下利，清谷不止，身疼痛者，急当救里；后身疼痛，清便自调者，急当救表。救里宜四逆汤，救表宜桂枝汤。(《辨太阳病脉证并治》，第91条)

【提要】

论伤寒误下后表里缓急的证治。

【词解】

① 清谷：泻下未消化的食物。清，厕所，此处作动词。

② 清便自调：大便已恢复正常。

【句解】

伤寒表证，当先解表，若误用下法，不仅损伤脾阳，而且累及肾阳，火不暖土，易成三阴虚寒、阴盛阳衰之危证，故见“续得下利，清谷不止”。此时虽有身疼痛的表证，因里证急重，故须急救其里，回阳救逆，宜四逆汤。服汤药后如大便恢复正常，是阳回利止，而身疼痛仍在，为表证未罢，则又当急与桂枝汤调和营卫，以

和其表。

**【拓展】**

本条是表里同病，里急治里、先里后表之变法。

**38** 病发热头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里。四逆汤方。（《辨太阳病脉证并治》，第92条）

**【提要】**

论表里同病，治用先里后表法。

**【词解】**

反：病发热头痛，是太阳表证，表证当见脉浮，今见脉沉，沉主里，是表证而见里脉，故曰“反”。

**【拓展】**

本条虽未言治表，实寓解表于回阳救逆之中，待阳回寒散，则不用解表而表自解。

**39** 伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第99条）

**【提要】**

论三阳证见，治从少阳。

**【句解】**

伤寒四五日，身热恶风，乃邪郁太阳之表；胁下满为邪犯少阳，枢机不利；手足温而渴为阳明热盛达于四末，热盛伤津所致。颈项强为三阳兼有之证。三阳证见，邪气由表入里，表邪已微，里热未盛，邪郁少阳，故治从少阳，法宜和解。

**40** 伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤，不差者，小柴胡汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第100条）

**【提要】**

论少阳兼里虚寒证。

**【词解】**

① 阳脉涩：浮取脉涩。

② 阴脉弦：沉取脉弦。

**【拓展】**

本条之腹痛与第96条之腹痛，虽同属木乘土之证，但前者以脾虚为主，少阳次之，治宜先补后和；后者以少阳为主，脾虚次之，治宜先和后补或和补兼施。

41 伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却复发热汗出而解。（《辨太阳病脉证并治》，第101条）

【提要】

论柴胡汤的使用方法及误下后服柴胡汤的转机。

【词解】

蒸蒸而振：寒战高热。蒸蒸，内热状。

【句解】

不论伤寒、中风，只要见到邪犯少阳的一部分主症，即可投以小柴胡汤，不必待主症悉备再行用药，以免贻误病情。凡柴胡证，当用和解之法，不可攻下。若误用下法，容易导致邪气内陷，产生变证；但亦有下之后柴胡证仍在者，仍可再用柴胡汤。但误下后正气受损，抗邪无力，服药后正气得药力相助与邪相争，正邪交争剧烈，必见蒸蒸发热，周身颤抖，至正胜邪去之时，遂发热汗出而解。

42 伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第102条）

【提要】

论伤寒里虚，心中悸而烦的证治。

【词解】

心中悸而烦：心中悸动，神烦不宁。

【方药】

小建中汤方：

桂枝三两（去皮），甘草二两（炙），大枣十二枚（擘），芍药六两，生姜三两（切），胶饴一升。上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内饴，更上微火消解，温服一升，日三服。呕家不可用建中汤，以甜故也。

43 伤寒十三日不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之以不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。潮热者，实也，先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第104条）

【提要】

论少阳兼里实误下的证治。

【词解】

① 日晡所：大约下午三至七时。

② 潮热：定时发热，或定时热甚，如潮汐之有定时。

44 伤寒八九日，下之，胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第107条）

【提要】

论太阳病误治的变证证治。

【词解】

胸满烦惊：胸胁苦满，烦躁易惊。

【句解】

本证属于表证误下，邪气内陷，三焦不利，表里同病，虚实互见。

45 伤寒脉浮，医以火迫劫之，亡阳必惊狂，卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第112条）

【提要】

论心阳虚惊狂的证治。

【词解】

① 以火迫劫之：指用温针、艾灸、熏、熨等法强迫发汗。

② 亡阳：此指亡心阳。

【句解】

伤寒脉浮，病位在表，治宜汗解，医师以烧针等火法强取其汗，必致大汗淋漓。汗为心之液，大汗必致心阳随汗亡失，心神失养，故见惊狂、卧起不安等症。

46 烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚。气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤更加桂二两也。（《辨太阳病脉证并治》，第117条）

【提要】

论心阳虚奔豚的证治。

【词解】

核起而赤：针刺处红肿如核。

47 火逆下之，因烧针烦躁者，桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第118条）

【提要】

论心阳虚烦躁的证治。

【词解】

火逆：指误用烧针、艾灸、熏、熨等治疗而产生的变证。

48 太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也；小便自利，其人如狂者，血证谛也，抵当汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第125条）

【提要】

论蓄血重证的证治。

【词解】

无血：无蓄血的证候。

【句解】

血蓄于里，瘀阻络道，血脉不利，故脉沉而滞，甚则脉沉结。瘀热结于下焦，故少腹硬满。病在血分，膀胱气化功能未受影响，故小便自利。

49 伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵当丸。（《辨太阳病脉证并治》，第126条）

【提要】

论蓄血缓证的证治。

【词解】

不可余药：不可用其他药剂。亦可解释为不可剩余药渣，即连汤带渣一并服下。

50 太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸；小便少者，必苦里急也。（《辨太阳病脉证并治》，第127条）

【提要】

论太阳病水停不化证。

【词解】

里急：小腹硬满而急胀不舒。

51 问曰：病有结胸，有脏结，其状何如？答曰：按之痛，寸脉浮，关脉沉，名曰结胸也。（《辨太阳病脉证并治》，第128条）

【提要】

论结胸与脏结的区别。

【词解】

脏结：因脏气虚衰，阴寒凝结，气血阻滞所致的病症。

52 病发于阳，而反下之，热入因作结胸；病发于阴，而反下之，因作痞也。所以成结胸者，以下之太早故也。（《辨太阳病脉证并治》，第131条）

【提要】

论结胸证和痞证的成因。

【词解】

痞：痞证，心下痞塞不舒，按之柔软不痛。

【拓展】

结胸证和痞证皆因误下所致，不同的是结胸证“病发于阳”，而痞证“病发于阴”。对“阴”“阳”的理解，历代注家认识有异，主要有以下三种认识：表为阳，里为阴；患者体质；病邪的有形与无形。

53 伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤。但结胸，无大热者，此为水结在胸胁也。但头微汗出者，大陷胸汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第136条）

【提要】

论伤寒十余日未愈的转归。

【词解】

热结在里：热结阳明。

54 太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹硬满，而痛不可近者，大陷胸汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第137条）

【提要】

论热实结胸涉及阳明腑实的证治。

【词解】

不可近：疼痛拒按，不可触摸。

【拓展】

舌上燥，在阳明则焦干起刺，本证则舌苔干燥粗厚，自觉干涩。渴，在阳明则大渴引饮，饮后则舒，本证则渴不多饮，饮后反增胀满不舒。阳明潮热，而本证只是小有潮热。以上都是热为水郁所致。

55 寒实结胸，无热证者，与三物小陷胸汤。白散亦可服。（《辨太阳病脉证并治》，第141条）

【提要】

论寒实结胸的证治。

【词解】

白散：方剂名。考《金匮玉函经》《千金翼方》均无“陷胸汤”及“亦可服”六字，可从。

56 结胸者，项亦强，如柔痉状，下之则和，宜大陷胸丸。（《辨太阳病脉证并治》，第131条）

【提要】

论热实结胸邪结高位的证治。

【词解】

柔痉：痉病的主要表现为颈项强直，甚至角弓反张。其中汗出者名柔痉，无汗者名刚痉。

【句解】

水热互结于高位，使颈项部经气运行受阻，津液不布，经脉失于濡润而转动不利，故项亦强。如柔痉状，一指水热互结，热迫津外泄，而有身热，汗出，似柔痉；一指颈项强直并非外感风寒使然，故不恶寒，非柔痉。

57 脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞，按之自濡，但气痞耳。（《辨太阳病脉证并治》，第151条）

【提要】

论痞证的成因与证候特点。

【词解】

① 紧反入里：因误下邪气由表入里。紧，此处借脉象而指在表之寒邪。

② 濡：柔软。“按之自濡”犹言按之软。

③ 气痞：气机窒塞不通。

【拓展】

痞证与结胸证均因太阳病误下，邪陷于里而成，都以心下为主要病变部位。两者的区别是：结胸证为内陷之邪与有形痰水结于心下胸胁，故其证以心下胸胁硬满疼痛为特点，治宜攻下破结之法。痞证为无形邪气内陷心下，气机痞塞，故其证以心下痞，按之濡，不硬不痛为特点，治以理气消痞为主。

58 下后不可更行桂枝汤，若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏子甘草石膏汤。（《辨太阳病脉证并治》，第162条）

【提要】

论邪热壅肺证的证治。

【词解】

更行：更，再也；行，用也。更行即是再用之意。

59 伤寒大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也。不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞。解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。（《辨太阳病脉证并治》，第164条）

【提要】

论热痞兼表证的治法。

【词解】

心下痞：心下有窒塞感。

【句解】

伤寒为病在表，治当发汗解表，若先行攻下而再行发汗，此汗下失序，必致表邪化热内陷，结于心下，滞塞气机，形成热痞，故见心下痞。若表邪尽陷于里，则恶寒罢，表证解。今仍见恶寒者，是表邪未解。

60 伤寒发热，汗出不解，心中痞鞕，呕吐而下利者，大柴胡汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第165条）

【提要】

论少阳兼阳明里实的治法。

【句解】

伤寒发热，若得汗出，则表解而热已，而本证汗出不解，热仍不减，更见心中（下）痞硬，呕吐而下利，是邪已深入少阳，并阳明里实之证。

61 伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第169条）

【提要】

论白虎加人参汤证的证治。

62 伤寒脉浮，发热无汗，其表不解，不可与白虎汤。渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第170条）

【提要】

论白虎汤的禁忌证，以及阳明热盛津伤的辨证要点。

【句解】

伤寒脉浮，发热无汗，为太阳伤寒，当用辛温发表之法。其表不解，即使兼有内热，也当在发汗解表的前提下兼以清里，而不可单用白虎汤。若误用之，在外则冰伏寒邪，在内则直折中阳，极易造成变证，故前人有“无汗不得用白虎”的戒语。只有当外无表寒，而里热已盛，且又伴津气两伤的渴欲饮水诸证时，才宜用白虎加人参汤，清里热，益气津。

63 伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕，不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。若其人大便硬，小便自利者，去桂加白术汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第174条）

【提要】

论风寒湿邪痹阻肌表的证治。

【词解】

① 相搏：相互搏结。

② 疼烦：疼痛剧烈。烦，剧烈。

【句解】

伤寒八九日，说明本证是由感受风寒而引发，日久不愈，风寒湿三气相搏，闭阻于肌表，阻碍气血运行。本证形似太阳表证，故张仲景冠以“伤寒”二字，而实非伤寒表证。风寒湿痹以身体骨节疼痛最为突出，虽有某些症状类似于太阳表证，但因正气虚，脉浮而涩等表现，足以与太阳表证相鉴别。

若“其人大便硬，小便自利者”，是风邪已去，湿邪仍存之象。由于湿邪阻滞，运化失常，脾不能为胃行其津液，水液偏渗膀胱，故大便硬而小便自利。

【方药】

① 桂枝附子汤方：

桂枝四两（去皮），附子三枚（炮，去皮，破），生姜三两（切），大枣十二枚（擘），甘草二两（炙）。上五味，以水六升，煮取二升，去滓。分温三服。

② 去桂加白术汤方：

附子三枚（炮，去皮，破），白术四两，生姜三两（切），甘草二两（炙），大枣十二枚（擘）。上五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。初一服，其人身如痹，半日许复服之，三服都尽，其人如冒状，勿怪，此以附子、白术，并走皮内，逐水气未得除，故使之耳。法当加桂四两，此本一方二法，以大便硬，小便自利，去桂也；以大便不硬，小便不利，当加桂。附子三枚恐多也，虚弱家及产妇，宜减服之。

64 风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第175条）

【提要】

续174条论风寒湿留着关节的证治。

【词解】

掣痛：牵引抽掣疼痛。

【方药】

甘草附子汤方：

甘草二两（炙），附子二枚（炮，去皮，破），白术二两，桂枝四两（去皮）。上四味，以水六升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。初服得微汗则解。能食，汗止复烦者，将服五合。恐一升多者，宜服六七合为始。

65 伤寒脉浮滑，此以表有热，里有寒，白虎汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第176条）

【提要】

论阳明白虎汤证的证治。

【句解】

表有热，里有寒：据林亿等按语，当做表里俱热解。

【拓展】

“表有热，里有寒”句，是《伤寒论》悬而未决的问题之一，注家观点不一。根据以方测证，白虎汤为辛寒重剂，其证当为胃热弥漫，邪热充斥内外，表里俱热，其见症当有身热、汗自出、不恶寒反恶热、心烦、舌干、口渴等。

【方药】

白虎汤方：

知母六两，石膏一斤（碎），甘草二两（炙），粳米六合。上四味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓。温服一升，日三服。

66 问曰：何缘得阳明病？答曰：太阳病，若发汗，若下，若利小便，此亡津液，胃中干燥，因转属阳明。不更衣，内实，大便难者，此名阳明也。（《辨阳明病脉证并治》，第181条）

【提要】

论太阳病转属阳明病的原因。

【词解】

不更衣：即不大便。成无己云：“古人登厕必更衣，不更衣者，通为不大便”。

【拓展】

本条紧承179条，论述太阳病转属阳明的原因。第179条言“脾约”“胃家实”“大便难”分别来自太阳、阳明、少阳病之误治，而本条则言太阳病误治可成“不更衣、内实、大便难”三种证候，两条属互文见义之文法，当参合印证。其真正的含义是：就成因来看，有从太阳、少阳（或三阴）而来者，也有燥热直犯阳明而得者；就证候来说，不论成因如何，均可形成脾约，或胃家实，或大便难之可能，并非从太阳病转属者即为“脾约”，燥热发自阳明者即“胃家实”，从少阳转属者即“大便难”。若拘于条文字句，只从来路而限定证候，既与临床实际不符，也与仲景本旨相悖。

67 问曰：病有得之一日，不发热而恶寒者，何也？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。（《辨阳明病脉证并治》，第183条）

【提要】

论阳明病发病过程中的初见恶寒者。

【句解】

阳明病初起之恶寒，是因阳明初感外邪，阳气内郁，阳明经气未能及时伸展之故。但阳明为多气多血之经，且阳明主燥，其阳气隆盛，使邪入阳明，极易从阳化热化燥，而成里热实证。因此阳明受邪，恶寒历时短暂，程度亦轻，故得之一日，恶寒将自罢，而转为自汗出而恶热。

【拓展】

“虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也”，既是对阳明病始时恶寒特点的描述，也是阳明恶寒有别于太阳恶寒的鉴别要点。陈亦人《伤寒论译释》说：“如属太阳恶寒，应兼见头项强痛等证，今恶寒而没有头项强痛，则非太阳证可知，且太阳证恶寒也不会即将自罢，根据即自汗而恶热的趋势，本条恶寒应是阳明经气被郁未伸所致，与太阳恶寒纯属于表邪不同，所以始虽恶寒，很快恶寒自罢，而自汗恶热了”。

68 问曰：恶寒何故自罢？答曰：阳明居中，主土也，万物所归，无所复传，始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。（《辨阳明病脉证并治》，第184条）

【提要】

论阳明病恶寒“一日自罢”的机制。

【句解】

① 万物所归：阳明胃居中焦，就其生理而言，具有土德之性，既能长养万物，也是万物归宿。从病理而言，阳明以燥为本，诸经病邪，无论表里寒热，只要并入阳明，则必从热从燥而化，因燥成实，如同五行之土，既能生长万物，又是万物的归宿，故云。

② 无所复传：一旦邪气从热从燥而化，进而成实，实则秘固，复得通畅则生，止于秘固则死，故无复传。

③ 始虽恶寒，二日自止：阳明受邪之初，邪尚在经，阳气被伤，温煦失司，故始见恶寒。继则邪归于胃腑，从热化燥，燥热内盛，故恶寒必自罢，而见不恶寒反恶热，这就是阳明病的特征。

69 本太阳，初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明也。伤寒发热，无汗，呕不能食，而反汗出濈濈然者，是转属阳明也。（《辨阳明病脉证并治》，第185条）

【提要】

论太阳病转属阳明病的原因。

【词解】

汗出濈濈然：汗出连绵不断。濈，水外流。

【句解】

本条可分为两段理解。第一段论太阳病初起，虽用汗法治疗，但汗出不彻，邪气不除，就可能出现邪气入里化热而转属阳明。第二段论伤寒发热无汗，本为太阳表证，如见呕不能食，则提示邪已入里化热，而见胃热气逆之征。导致表邪入里化热的原因，多为胃阳素旺或素有内热。如证由无汗而反出现汗出连绵不断的，则为表邪全部入里化热，是病已转属阳明。阳明热盛，逼迫津液外越，故见汗出连绵不断。

70 伤寒三日，阳明脉大。（《辨阳明病脉证并治》，第186条）

【提要】

论阳明病的主脉。

【句解】

阳明为多气多血之经，外邪入于阳明，正盛而邪实，气血沸腾，血脉充盈，故脉应之而大。总而言之，脉大为阳盛内实之征，阳明无论热证、实证，皆以脉大为共同特征；分而言之，阳明热证之脉多为洪大滑数，阳明实证之脉多为沉实而大。以上为阳明热实证的主要脉证，见有以上脉证者，即可辨为阳明病之热实证。

71 伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者，身当发黄；若小便自利者，不能发黄。至七八日大便硬者，为阳明病也。（《辨阳明病脉证并治》，第187条）

【提要】

论太阴转出阳明的机转和特征。

【句解】

本条前半部分内容基本与第278条同，只是末尾略异。第278条论太阴病至七八日，脾阳来复，下利自止，其病向愈；而本条则是阳复太过，转属阳明。太阴脾与阳明胃同属中焦，同属中土，但脾属阴土主湿，胃属阳土主燥，在生理情况下，两者阴阳协调，燥湿相济，维持正常的消化功能。然而，在病理情况下，燥湿可以互化，寒热可以演变，虚实可以转换。本条即属太阴虚寒之证，阳复太过，结果由湿化燥，由寒变热，由虚转实，由阴出阳，变成阳明病。转为阳明病的主要标志是“大便硬”，当然在此是举一端而略其他，临床上，可抓住关键症，以此类推，一隅三反，方不至误诊误治。凡转为阳明病者，当按阳明病辨证论治。

72 伤寒转系阳明者，其人濈然微汗出也。（《辨阳明病脉证并治》，第188条）

【提要】

论伤寒初传阳明的症状表现。

【句解】

太阳伤寒证见无汗，阳明里热证见汗出濈濈然，连绵不断。若太阳之邪初传阳明，里热虽成但未炽盛，故证虽见濈然汗出，仅是微汗而非大汗。汗出虽微，却连绵不断，这是阳明病的特征之一。本条只提一症，言简意赅，意在提示一见濈濈然汗出，说明已现阳明之兆，即应见微知著，及早防治。

73 阳明病欲解时，从申至戌上。（《辨阳明病脉证并治》，第193条）

【提要】

论阳明病可能得解的时间。

【句解】

从申至戌上：系指申、酉、戌三个时辰，即从十五时至二十一时。十五时至二十一时是太阳逐渐西下，自然界阳气逐渐衰减之时。阳明病属阳热亢盛之证，随着自然界的阳气衰减，阳热之邪亦有减退，有利于泄热于外，病情向愈。

74 阳明病，无汗，小便不利，心中懊侬者，身必发黄。（《辨阳明病脉证并治》，第199条）

【提要】

论湿热发黄证的症状表现。

【词解】

心中懊侬：心中烦闷殊甚，莫可名状。

75 阳明病，被火，额上微汗出，而小便不利者，必发黄。（《辨阳明病脉证并治》，第200条）

【提要】

论火劫发黄证。

【词解】

被火：指用火法治疗，如艾灸、温针、热熨、火熏等。

【句解】

阳明病里热亢盛，误用火法治疗，是犯“虚虚实实”之戒，使邪热更炽，津液愈伤。热郁于内，三焦气机阻滞，再加津液内亏，故汗不得畅出，小便不能通调。邪无外泄之路，内迫血气，熏灼肝胆，故成发黄之证。

76 伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻之。（《辨阳明病脉证并治》，第204条）

【提要】

论伤寒呕多禁下。

【拓展】

伤寒病出现频繁呕吐，并兼见阳明证者，多见于三种情况：其一，太阳阳明兼病。太阳之邪不解，内干于胃，影响胃之和降，加之阳明胃热上逆，因而呕吐；其二，阳明里热，其热上聚胸膈，未结胃腑，胃气上逆而致呕；其三，少阳阳明兼病，邪郁胸膈，干犯胃腑，胃气上逆而致呕。这三种情况，皆不可误用攻下之法。因太阳阳明兼病致呕，太阳表病不解，且里证不急，攻下自属误治；阳明里热致呕，病位偏上，在胸膈胃脘而不在腑，且病势向上，也不可逆其势而用攻下之法；少阳阳明兼病致呕，因其病机与阳明热实结于腹部者不同，加之少阳有汗、吐、下三禁，故也不可妄自攻下。

77 阳明病，心下硬满者，不可攻之。攻之利遂不止者死，利止者愈。（《辨阳明病脉证并治》，第205条）

【提要】

论阳明病邪结偏高者当禁下。

【句解】

阳明病邪结于腑，治当攻下，其症当见腹满硬痛，大便不通，潮热谵语等。若只是心下硬满而不痛，且无腹部见症，说明病位偏上，由无形邪热聚结，气机受阻不行所致。此虽是阳明病，但因尚未入腑成实，故不可攻下。

78 阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第207条）

【提要】

论调胃承气汤证。

【句解】

调胃承气汤证的病机为阳明燥热结实，腑气不通，痞满不甚，燥热初结，或腑实证下后邪热结实不甚，病位偏高，程度不重。

【方药】

调胃承气汤方：

甘草二两（炙），芒硝半斤，大黄四两（清酒洗）。上三味，切，以水三升，煮二物至一升，去滓，内芒硝，更上微火一二沸。温顿服之，以调胃气。

79 伤寒，若吐若下后不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死。微者，但发热谵语者，大承气汤主之。若一服利，则止后服。（《辨阳明病脉证并治》，第212条）

【提要】

论阳明腑实重证的证治和预后。

【词解】

循衣摸床：昏迷患者两手无意识地反复触摸衣被床沿的症状。

【句解】

伤寒，采用催吐或攻下法后，病仍不解，是因津液被夺，邪从燥化而入阳明，遂成阳明腑实证，故见多日不大便。日晡潮热是阳明腑实证的典型热型。

80 阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，小承气汤主之。若一服谵语止者，更莫复服。（《辨阳明病脉证并治》，第213条）

【提要】

论阳明病便硬谵语的成因与治疗。

【句解】

阳明病里热炽盛，迫津外泄则多汗。由于汗出过多，津液外泄，以致胃肠内津亏干燥而结实，故大便必硬。又因大便硬结，腑气不通，热浊上攻，扰乱心神，则谵语。然而未见潮热、腹痛等症，是知阳明病实证虽具，但证势并不急重，因此用小承气汤泻热通便，行气和胃。本条最后医嘱十分重要，因为病情不重，一服即可便通热泄，故叮嘱若服后硬便下，谵语止，腑气通，燥热实结已去，即当停服。若再服再下，则有下伤正气之虞。

【方药】

小承气汤方：

大黄四两，厚朴二两(炙)，枳实三枚(大者,炙)。上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓。分温二服，初服汤当更衣，不尔者尽饮之；若更衣者，勿服之。

81 阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。因与承气汤一升，腹中转气者，更服一升，若不转气者，勿更与之。明日又不大便，脉反微涩者，里虚也，为难治，不可更与承气汤也。(《辨阳明病脉证并治》，第214条)

【提要】

论阳明腑实轻证的证治及注意事项。

【词解】

① 脉滑而疾：脉象圆滑流利快速。

② 转气：腹中有矢气转动。

【句解】

阳明病为里热实证，阳明燥结成实，腑气不通，浊热上扰则谵语。阳明经气旺于申酉之时，正气借天气之助而与邪争，邪正斗争剧烈，故见阳明潮热。谵语、潮热若与手足濈然汗出，脉沉实有力等并见，则为大承气汤证。而今脉滑利而疾数，犹恐燥热结实尚浅，不敢贸然投用大承气汤，故试投小承气汤治之。

82 阳明病，谵语，有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也；若能食者，但硬耳。宜大承气汤下之。(《辨阳明病脉证并治》，第215条)

【提要】

辨阳明腑实燥结之微甚。

【句解】

阳明病，谵语发潮热，是腑实已成，但燥结程度之微甚，当结合能食和不能食来分辨。一般而言，胃有热多见消谷善饥，但本证反不能食，提示是由热盛伤津，津伤化燥，燥屎结滞，腑气壅滞不行所致，故言“胃中必有燥屎五六枚也”。既然燥屎已成，则当用大承气汤攻下。

【拓展】

“宜大承气汤”意承“有燥屎五六枚也”句下，为倒装文法。若谵语、潮热而饮食尚可，则知大便虽硬，尚未至燥结坚硬，言外之意，此证不宜大承气汤，可予小承气汤或调胃承气汤。正如章楠《伤寒论本旨》所说：“反不能食者，以胃中燥屎阻结也，故宜大承气下之；若能食，则无燥屎，但便硬尔，以无形邪热扰心而发谵语，胃无实结而能食，若下之，宜调胃承气也”。

83 二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足絷絷汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第220条）

【提要】

论二阳并病，转属阳明腑实的证治。

【句解】

太阳与阳明并病，太阳证罢，只见潮热，大便难而谵语，是邪气已转属阳明。由于四肢禀气于脾胃，阳明燥热逼迫津液外泄，则可见手足絷絷汗出或濈然汗出等外候，此外候和潮热、谵语、大便难并见，则为阳明燥热成实的确征，因此宜用大承气汤泻下。

84 阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重。若发汗则躁，心愦愦反谵语。若加温针，必怵惕、烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊侬，舌上胎者，栀子豉汤主之。（《辨阳明病脉证并治》，第221条）

【提要】

论阳明热证误治后的各种变证。

【词解】

① 心愦愦：心中烦乱不安。愦，糊涂，昏乱。

② 怵惕：恐惧不安。怵，害怕，恐惧。

③ 舌上胎：舌上有黄白薄腻苔垢。胎，即苔。

85 若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。（《辨阳明病

脉证并治》，第 222 条）

【提要】

论阳明热证误下后，胃热津气两伤的证治。

【句解】

本条承第 221 条，论阳明热证误下后，不仅邪热未除，而且又耗伤气津，出现了渴欲饮水，口干舌燥之症，故治以清胃热，益气津，用白虎加人参汤。

86 阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。（《辨阳明病脉证并治》，第 224 条）

【提要】

论猪苓汤的禁例。

【句解】

阳明病汗出多而渴，为阳明胃热弥漫，迫津外泄，津气耗伤所致，若用猪苓汤复利其小便，必竭欲亡之津，故告诫医者不可与之。

87 脉浮而迟，表热里寒，下利清谷者，四逆汤主之。（《辨阳明病脉证并治》，第 225 条）

【提要】

论阳明下焦虚寒之证。

【句解】

脉浮而迟，浮则为表，迟则为寒。阳明戊土不能下合少阴癸水，而独主于外则表热，少阴癸水不能上和阳明戊土，而独主于内则里寒，戊癸不合则下焦生阳之气不升，故下利清谷。

88 阳明病，下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊侬，饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之。（《辨阳明病脉证并治》，第 228 条）

【提要】

论阳明热郁胸膈之栀子豉汤证。

【词解】

饥不能食：嘈杂似饥，而又不能进食。

【句解】

本条是对阳明热郁胸膈栀子豉汤证证治的补充，进一步阐明阳明病早用攻下，以致热郁胸膈的证治。

89 阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，与小柴胡汤。（《辨阳明病脉证并治》，第229条）

【提要】

论阳明病柴胡汤证未去的治法。

【句解】

本条虽谓阳明，实则少阳病未解。凡阳明病发潮热，多为腑实已成之征，除潮热之外，当有腹满硬痛，大便硬结等症。

90 阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白胎者，可与小柴胡汤。上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。（《辨阳明病脉证并治》，第230条）

【提要】

论阳明病柴胡汤证未罢的治法及小柴胡汤的作用机制。

91 阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。（《辨阳明病脉证并治》，第236条）

【提要】

论述茵陈蒿汤证的病机、临床表现与治法。

【词解】

① 热越：热邪向外发越。

② 水浆：泛指饮料，如水、果汁、蔗浆之类。

③ 瘀热：邪热郁滞。

【句解】

阳明病发热汗出，热邪向外发泄，水湿亦同时得到祛除，湿热不能相结，故不能发黄。若发热仅伴有头汗出，而颈部以下周身无汗，又见小便不利，则热和湿邪均不能宣泄外达而蕴结于里，则可见发黄症状。

【方药】

茵陈蒿汤方：

茵陈蒿六两，栀子十四枚（擘），大黄二两（去皮）。上三味，以水一斗二升，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓。分三服。小便当利，尿如皂荚汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。

92 阳明证，其人喜忘者，必有畜血。所以然者，本有久瘀血，故

令喜忘。屎虽硬，大便反易，其色必黑者，宜抵当汤下之。（《辨阳明病脉证并治》，第237条）

【提要】

论述阳明病蓄血证。

【词解】

① 喜忘：健忘。喜，善。

② 畜血：瘀血停留。畜，同“蓄”。

【句解】

本条所论阳明蓄血证是阳明邪热与旧有之瘀血相结所致，症见大便硬，便色黑，喜忘。

【拓展】

关于黑便，王肯堂指出：“邪热燥结，色未尝不黑，但瘀血则溏而黑黏如煤，燥结则硬而黑晦如煤，为明辨也”，颇有参考意义。

93 食谷欲呕，属阳明也，吴茱萸汤主之。得汤反剧者，属上焦也。（《辨阳明病脉证并治》，第243条）

【提要】

论阳明中寒欲呕与上焦有热的鉴别。

【拓展】

食谷欲呕，病位有中焦上焦之分，证有寒热之别。此条提示医者，呕吐一证的原因不同，病位有别，临证当四诊合参，细心分析辨证。

【方药】

吴茱萸汤方：

吴茱萸一升(洗)，人参三两，生姜六两(切)，大枣十二枚(擘)。上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服。

94 本太阳病不解，转入少阳者，胁下硬满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。（《辨少阳病脉证并治》，第266条）

【提要】

论太阳转入少阳的脉证治法。

【句解】

“本太阳病不解”非太阳病仍在而不解，而是邪入少阳，疾病未能痊愈。

95 若已吐下、发汗、温针，谵语，柴胡汤证罢，此为坏病。知犯何

逆，以法治之。（《辨少阳病脉证并治》，第 267 条）

【提要】

论少阳病误治后的变证与救治法则。

【词解】

坏病：即变证。

【拓展】

本条与第 16 条前后关联，皆言误治坏病治疗法则。第 16 条“观其脉症，知犯何逆，随证治之”，本条“知犯何逆，以法治之”，准确表述了对坏病治疗，应详细观察其脉象、证候，综合分析，确立正确诊断和治疗法则，以法选方，恰当治疗。它充分体现了中医学辨证论治法则，不仅用于坏病，也适用于各种疾病治疗，对中医临床有广泛的指导意义。

96 伤寒三日，少阳脉小者，欲已也。（《辨少阳病脉证并治》，第 271 条）

【提要】

辨少阳病欲愈的脉象。

【句解】

邪入少阳，其脉多弦，乃胆火较盛所致，今外感少阳病已过数日，脉象由弦变为小者，说明少阳之邪渐退，其病欲愈。此脉小是脉象渐趋和平，除脉象外，其症状亦必逐渐减轻。

97 少阳病欲解时，从寅至辰上。（《辨少阳病脉证并治》，第 272 条）

【提要】

论少阳病欲解的时间。

【句解】

从寅至辰上：指寅、卯、辰三个时辰，即从三时至九时。

【拓展】

但欲解时并不等于其病必解，临证应乘此有利之时，及时施治，和解少阳，扶正祛邪，以加速疾病向愈。

98 太阴中风，四肢烦疼，阳微阴涩而长者，为欲愈。（《辨太阴病脉证并治》，第 274 条）

【提要】

论太阴中风欲愈的脉证特点。

【词解】

阳微阴涩：脉象浮取微，沉取涩。阴阳，此指脉之浮取沉取。

99 太阴病欲解时，从亥至丑上。（《辨太阴病脉证并治》，第275条）

【提要】

论太阴病欲解的时间。

【句解】

从亥至丑上：指亥、子、丑三个时辰，即从二十一时至次日三时之前。按阴阳消长规律，阴尽则阳生，太阴为阴中之至阴，阴极于亥，阳生于子，至丑时阳气渐增。足太阴脾之气旺于亥、子、丑时，此时脾气来复，阳气渐增，正胜邪却，则疾病有欲解之机。

100 太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤。（《辨太阴病脉证并治》，第276条）

【提要】

论太阴兼表证的证治。

【拓展】

本证为素有脾阳不足，复感风寒之邪而患病，故不可用麻黄汤单纯发汗。然而，对此太阴兼表之表里同病，若里证较重者，应以四逆辈先温其里，后解其表，或用桂枝人参汤，温里为主，兼以解表。

101 伤寒脉浮而缓，手足自温者，系在太阴。太阴当发身黄，若小便自利者，不能发黄。至七八日，虽暴烦下利日十余行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也。（《辨太阴病脉证并治》，第278条）

【提要】

论太阴病转愈的临床表现和机制。

【词解】

① 手足自温：手足温温发热。

② 系在太阴：即病属太阴。系，联系。

③ 脾家实：脾阳恢复。实，正气充实。

④ 腐秽：肠中腐败秽浊之物。

102 本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍

芍汤主之。大实痛者，桂枝加大黄汤主之。（《辨太阴病脉证并治》，第279条）

【提要】

论太阳病误下，邪陷太阴的证治。

【词解】

大实痛：腹痛剧烈，拒按。

【方药】

① 桂枝加芍药汤方：

桂枝三两（去皮），芍药六两，甘草二两（炙），大枣十二枚（擘），生姜三两（切）。上五味，以水七升，煮取三升。去滓，温分三服。本云，桂枝汤，今加芍药。

② 桂枝加大黄汤方：

桂枝三两（去皮），大黄二两，芍药六两，生姜三两（切），甘草二两（炙），大枣十二枚（擘）。上六味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

103 少阴病，欲吐不吐，心烦，但欲寐。五六日自利而渴者，属少阴也，虚故引水自救。若小便色白者，少阴病形悉具。小便白者，以下焦虚，有寒，不能制水，故令色白也。（《辨少阴病脉证并治》，第282条）

【提要】

论少阴寒化证的病机及辨证要点。

【词解】

① 欲吐不吐：泛泛恶心。

② 小便色白：小便清长。

【句解】

少阴寒化证由肾阳虚衰，阴寒内盛所致。肾阳虚衰，脾胃虚寒，胃气上逆则欲吐，复因胃腑空虚，故又无物吐出；阴盛于下，虚阳上扰则心烦；阳虚已甚，精神失养，故虽心烦而仍然但欲寐。

【拓展】

本条对少阴虚寒证的辨证价值极高，为少阴寒化证的辨证纲领：以欲吐不吐，心烦但欲寐，自利而渴，小便色白，指出少阴寒化证的辨证要点；以下焦虚有寒阐明少阴寒化证的病机；以欲吐不吐与腹满而吐，自利而渴与自利不渴相比较，辨少阴虚寒下利与太阴虚寒下利；以心烦但欲寐与心烦不得卧相比较，而辨少阴寒化与少阴热化；以自利而渴小便白与自利而渴小便赤辨少阴寒利与厥阴热利。

104 少阴病欲解时，从子至寅上。（《辨少阴病脉证并治》，第291条）

【提要】

论少阴病欲解的时间。

【句解】

从子至寅上：指子、丑、寅三个时辰，即从二十三时至次日五时。从子时至寅时，为自然界阴气已衰，阳气渐长之时。少阴病多心肾阳衰，阴寒内盛，若正气渐复，又得自然界阳气之助，则有利于阳气的恢复及阴寒的消退，故此三时为少阴病的欲解时。方有执《伤寒论条辨》云："子丑寅，阳生之时也。各经皆解于其所王之时，而少阴独如此而解者，阳进则阴退，阳长则阴消，且天一生水于子，子者少阴生王之地，故少阴之欲解，必于此时欤"。

105 少阴病，下利，脉微者，与白通汤。利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加猪胆汁汤主之。服汤脉暴出者，死，微续者，生。（《辨少阴病脉证并治》，第315条）

【提要】

论少阴病阴盛格阳证服热药后的证治与预后。

【词解】

① 脉暴出：脉搏突然浮大。

② 微续：脉搏由小到大，逐渐浮起。

【方药】

白通加猪胆汁汤方：

葱白四茎，干姜一两，附子一枚（生，去皮，破八片），人尿五合，猪胆汁一合。上五味，以水三升，煮取一升，去滓，内胆汁、人尿，和令相得。分温再服。若无胆，亦可用。

106 少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第319条）

【提要】

论少阴病阴虚水热互结的证治。

【句解】

水热互结下焦，因水性变动不居，若水气偏渗大肠则下利，水气上逆犯胃，胃气不降则呕，水气上逆射肺，肺气不利则咳，水气内停，阴虚失润则渴。心烦不得眠为少阴热化证特征。

【方药】

猪苓汤方：

猪苓(去皮)、茯苓、阿胶、泽泻、滑石各一两。上五味，以水四升，先煮四物，取二升，去滓，内阿胶烊尽。温服七合，日三服。

107 厥阴病欲解时，从丑至卯上。(《辨厥阴病脉证并治》，第328条)

【提要】

论厥阴病的欲解时间。

【句解】

厥阴病欲解时是丑、寅、卯这三个时辰，为凌晨一时至七时。此时，自然界正处在阳气升发的阶段。作为阴尽阳生之脏的厥阴为病，往往会在此时得到自然界阳升之助而有利于其病向愈。

108 若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。(《辨厥阴病脉证并治》，第352条)

【提要】

承第351条论血虚寒凝兼“内有久寒者”的证治。

【词解】

① 内：内脏。

② 久寒：沉寒痼疾。

【方药】

当归四逆加吴茱萸生姜汤方：

当归三两，芍药三两，甘草二两(炙)，通草二两，桂枝三两(去皮)，细辛三两，生姜半斤(切)，吴茱萸二升，大枣二十五枚(擘)。上九味，以水六升，清酒六升，和煮取五升，去滓。温分五服(一方，水酒各四升)。

109 伤寒，厥而心下悸，宜先治水，当服茯苓甘草汤，却治其厥。不尔，水渍入胃，必作利也。(《辨厥阴病脉证并治》，第356条)

【提要】

论水厥的证治。

【词解】

① 却：然后。

② 不尔：不然。

③ 渍：水浸。

110 伤寒本自寒下，医复吐下之，寒格，更逆吐下，若食入口即吐，干姜黄芩黄连人参汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第359条）

【提要】

论上热下寒相格拒的证治。

【词解】

寒格：下寒与上热相格拒。

111 下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第370条）

【提要】

论阴盛格阳下利的证治。

【句解】

下利清谷是脾肾阳衰，阴寒内盛的表现。“里寒外热”是言本证之病机，“里寒”指阳衰阴盛，内有真寒；“外热”指阴盛格阳，外有假热。根据317条等原文来看，这种“外热”往往伴有身反不恶寒，其人面色赤等假象。

112 下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。（《辨厥阴病脉证并治》，第372条）

【提要】

论虚寒下利重证兼表证的治疗原则与主方。

【句解】

仲景治疗表里同病的原则有三，一是先表后里，二是先里后表，三是表里同治，本条属于先里后表的治疗原则。

113 呕而发热者，小柴胡汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第379条）

【提要】

论述邪传少阳致呕的证治。

【拓展】

本证之呕，与肝寒犯胃的吴茱萸汤证和阳虚阴盛的四逆汤证所见的呕吐不同。本证之呕热，既可能是厥阴阳气来复，邪出少阳，也可能是外邪侵入少阳，临证总以辨证为主，不必拘泥来路。不过，“呕而发热”若是厥阴病演变而

成时，须无厥逆、下利等证，否则有可能是阳虚阴盛，虚阳浮越，临证当须细辨，不可不慎。

114 吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝者，通脉四逆加猪胆汤主之。（《辨霍乱病脉证并治》，第390条）

【提要】

论述霍乱阳亡阴竭的证治。

【词解】

吐已下断：吐利因液竭物尽而停止。

115 大病差后，劳复者，枳实栀子豉汤主之。（《辨阴阳易差后劳复病脉证并治》，第393条）

【提要】

论述大病新瘥劳复的证治。

【词解】

① 大病：伤寒热病，统称大病。

② 劳复：大病初愈，因过劳而复发者。

【句解】

大病初愈，正气尚弱，阴阳未和，余热未清，脾胃未调，故必慎起居，节饮食，方可防止疾病复发。若妄动作劳，如多言多虑劳其神，早坐早行劳其力等皆可导致其病复发。此条未叙症状，但从用枳实栀子豉汤治疗推论，此证之病机当属余热复聚，热郁胸隔，气机痞塞，当有心中懊侬，胸膈痞满，食少纳呆，舌苔薄黄略腻等症。

116 大病差后，从腰以下有水气者，牡蛎泽泻散主之。（《辨阴阳易差后劳复病脉证并治》，第395条）

【提要】

论瘥后腰以下有水气的证治。

【词解】

水气：水饮邪气。

【句解】

大病瘥后，因气机不利致湿热壅滞、水饮邪气停聚腰下，其表现当以小便不利，或肿满为特点。以方测证当属湿热实证，可见膝胫足跗皆肿，或伴大腹肿满，然必有小便不利，脉沉实等症。

**【拓展】**

大病瘥后，水气内停而见浮肿者，以虚证为多。若头面肢体皆肿，胸腹胀满，大便不实，少气懒言，舌苔白嫩，口淡不渴，脉沉细无力，则属脾肾阳虚所致，治宜温阳利水，禁用本方。

# 三级条文(90条)

1 伤寒十三日,过经谵语者,以有热也,当以汤下之。若小便利者,大便当硬,而反下利,脉调和者,知医以丸药下之,非其治也。若自下利者,脉当微厥,今反和者,此为内实也,调胃承气汤主之。(《辨太阳病脉证并治》,第105条)

【提要】

论病气随经过于阳明之证。

【句解】

伤寒十三日,再经已周,而又来复于太阳,不解,则病气随经而过在阳明胃腑。

2 形作伤寒,其脉不弦紧而弱。弱者必渴,被火者必谵语。弱者,发热脉浮,解之当汗出愈。(《辨太阳病脉证并治》,第113条)

【提要】

论温病初起的误火之变。

【句解】

① 形作伤寒:指其证候类似太阳伤寒,有发热、恶寒、头身疼痛等症。

② 脉不弦紧而弱:是与伤寒紧脉对举而言,并非微弱之弱。

③ 弱者必渴:当与下文"弱者发热"联系起来理解,即指其人不但脉弱,同时还有发热、口渴、脉浮等症。

3 太阳病,当恶寒发热,今自汗出,反不恶寒发热,关上脉细数者,以医吐之过也。一二日吐之者,腹中饥,口不能食;三四日吐之者,不喜糜粥,欲食冷食,朝食暮吐,以医吐之所致也,此为小逆。(《辨太阳病脉证并治》,第120条)

【提要】

论太阳病误治致脾胃气虚的变证。

【词解】

① 过:过失,错误,即误治的过错。

② 小逆：误治所引起的较轻变证。

【句解】

太阳病，当有恶寒发热，治宜发汗解表，若汗出而表和，则寒热去而病解。今患者汗自出，不恶寒发热，脉象由三部皆浮而转为关脉细数，是表邪已解而里气未和，病情发生了质的变化，其原因是误用了吐法。

4 病人脉数，数为热，当消谷引食。而反吐者，此以发汗，令阳气微，膈气虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。（《辨太阳病脉证并治》，第 122 条）

【提要】

论汗后致胃寒吐逆而见假热之证。

【词解】

① 消谷引食：即消谷善饥，多食而易饥饿。消谷，消化谷物。引食，能食、求食。

② 膈气：膈间阳气。

③ 客热：邪热，此处作假热。

【句解】

患者脉数而又消谷善饥，多为有热。今脉虽数，却反呕吐，是因发汗不当，致令膈间阳气虚弱，胃阳衰微，胃失和降所致。

5 妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除而脉迟身凉，胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也。当刺期门，随其实而取之。（《辨太阳病脉证并治》，第 143 条）

【提要】

论述热入血室的证治。

【词解】

① 血室：指胞宫，即子宫。

② 期门：肝经募穴，在乳中线上，乳头下二寸，当第六肋间隙取之。

【句解】

妇人中风，发热恶寒，是为表证。经水适来，则血室空虚，在表之邪乘机内陷，热与血搏结于血室，称为热入血室。

6 妇人中风，七八日续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。（《辨太阳病

脉证并治》，第 144 条）

【提要】

论热入血室寒热如疟的证治。

【句解】

妇人中风而经水适来，邪热内陷血室，血热相结，正邪分争，故寒热发作而有时，症状如疟疾之时寒时热。

7 妇人伤寒，发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室。无犯胃气及上二焦，必自愈。（《辨太阳病脉证并治》，第 145 条）

【提要】

论热入血室的证治及禁例。

【词解】

上二焦：此指上焦和中焦。

【句解】

妇人伤寒发热，适逢经水来潮，邪热乘虚陷入血室，热与血相结，则为热入血室。气属阳而主日，血属阴而主夜，本病邪在血分，故患者白天神志清楚，入暮则神志模糊，谵语妄言，如有所见。因谵语非胃实所致，故不可攻下，以免触犯胃气。邪亦不在表在膈，故不可发汗、涌吐。所谓“必自愈”是说瘀血尚有出路，邪热有外泄之机，病有自愈的可能，并非不治自愈。

8 太阳中风，下利，呕逆，表解者，乃可攻之。其人絷絷汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也，十枣汤主之。（《辨太阳病脉证并治》，第 152 条）

【提要】

论太阳中风，胸胁停水的证治。

【句解】

本条首冠以“太阳中风”，提示当有恶风寒，头痛，发热，脉浮，汗出等症。表邪引动了里饮，饮停胃肠可见呕逆下利，结于胸膈可见心下痞硬满，结于胁胁可见胁下痛，饮停于肺可见呼吸气短。是证虽有头痛、汗出、干呕之表现，与太阳中风相似，而实非太阳中风证。

【方药】

十枣汤方：

芫花(熬)，甘遂，大戟。上三味，等分，各别捣为散，以水一升半，先煮大枣肥者

十枚，取八合，去滓，内药末，强人服一钱匕，羸人服半钱，温服之，平旦服。若下少，病不除者，明日更服，加半钱。得快下利后，糜粥自养。

9 伤寒服汤药，下利不止，心下痞硬，服泻心汤已，复以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚。理中者，理中焦，此利在下焦，赤石脂禹余粮汤主之。复不止者，当利其小便。（《辨太阳病脉证并治》，第159条）

【提要】

辨误下导致心下痞硬、下利不止的不同证治。

【句解】

① 下利不止：伤寒为病在表，服汤药致下利不止，心下痞硬，提示误用泻下药物，损伤了脾胃之气，邪气内陷，寒热错杂，升降失常，清阳不升，故下利不止。

② 心下痞硬：浊阴不降，气机痞塞，则心下痞硬。此痞利俱甚之候，当投甘草泻心汤一类方剂，补中和胃，消痞止利。

【方药】

赤石脂禹余粮汤方：

赤石脂一斤（碎），太一禹余粮一斤（碎）。上二味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

10 伤寒吐下后，发汗，虚烦，脉甚微，八九日心下痞硬，胁下痛，气上冲咽喉，眩冒，经脉动惕者，久而成痿。（《辨太阳病脉证并治》，第160条）

【提要】

论伤寒误用汗吐下后形成的痿证。

【词解】

痿：两足痿软无力。

【句解】

伤寒经过催吐和攻下以后，又用汗法治疗，因而出现虚烦不安，脉来极微弱。到八九天的时候，又出现心下痞闷坚硬，胁下疼痛，有气上冲咽喉，头目眩晕，全身经脉跳动不宁的，日久不愈就会成为痿证。

11 病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲喉咽不得息者，此为胸有寒也。当吐之，宜瓜蒂散。（《辨太阳病脉证并治》，第166条）

【提要】

论瓜蒂散证的主要病理和证治。

【词解】

① 微浮：微，轻度。浮，代表有力的阳脉。

② 胸有寒：胸膈有痰饮停聚。寒，作“邪”解，此指痰饮。

【句解】

① 病如桂枝证：是指患者有发热、汗出、恶风等症，与太阳中风相似。然其头不痛，项不强，寸脉独浮，则知其非为太阳表证。

② 寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲咽喉：提示有上焦痰实阻滞，气机上逆。

【方药】

瓜蒂散方：

瓜蒂一分(熬黄)，赤小豆一分。上二味，各别捣筛，为散已，合治之，取一钱匕，以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁和散，温顿服之。不吐者，少少加，得快吐乃止。诸亡血虚家，不可与瓜蒂散。

12 阳明中风，口苦咽干，腹满微喘，发热恶寒，脉浮而紧，若下之，则腹满小便难也。(《辨阳明病脉证并治》，第189条)

【提要】

论阳明病兼表邪未解者。

【句解】

本条虽云阳明中风，实属三阳合病。其脉浮而紧，发热恶寒，是太阳表证未解。口苦咽干，是少阳证在。腹满微喘，属阳明里证。阳明有热证与实证之分，本证里热未盛，腑未成实，又伴有太阳、少阳之证，故不可轻易使用下法。若误用之，则表邪内陷，气机失运，腹满加重；津液损伤，故小便难。

13 阳明病，若能食，名中风；不能食，名中寒。(《辨阳明病脉证并治》，第190条)

【提要】

论阳明中风与中寒的辨别要点。

【句解】

① 中风：风为阳邪而主动，阳能化谷，故能食，称为阳明中风。

② 中寒：寒为阴邪而主静，阴不化谷，故不能食，称为阳明中寒。

【拓展】

外邪伤阳明而成中风者，多胃阳素旺，成中寒者多胃阳素虚。太阳病以有汗

无汗分风、寒，是因太阳主表而司开合的缘故；阳明病以能食不能食分风、寒，是因阳明主里而司受纳的缘故。

14 阳明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濈然汗出，此欲作固瘕，必大便初硬后溏。所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。（《辨阳明病脉证并治》，第 191 条）

**【提要】**

论阳明中寒证。

**【词解】**

固瘕：指胃中虚寒，水谷不消而结积的病症，表现为大便初头硬，后溏薄，且日久不愈。

**【句解】**

阳明中寒证的形成是由于中阳不足，复感寒邪，或寒从内生所致。胃主受纳和腐熟水谷，脾胃为气机升降之枢纽，故阳明中寒证的临床表现除不能食外，还可见饮水则哕，小便不利，手足濈然汗出，大便初硬后溏。

15 阳明病，初欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂，然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。（《辨阳明病脉证并治》，第 192 条）

**【提要】**

论阳明中风证。

**【词解】**

① 奄然：忽然。

② 谷气：水谷之精气。

**【句解】**

阳明病，初欲食：提示明阳气甚。

16 阳明病，不能食，攻其热必哕。所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，攻其热必哕。（《辨阳明病脉证并治》，第 194 条）

**【提要】**

论胃中虚冷者禁下。

**【拓展】**

成无己《注解伤寒论·辨阳明病脉证并治》：“不能食，胃中本寒，攻其热，复虚其胃，虚寒相搏，故令哕也。经曰：关脉弱，胃气虚，有热不可大攻之。热去则

寒起，此之谓也”。

17 阳明病，脉迟，食难用饱。饱则微烦头眩，必小便难，此欲作谷瘅。虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。（《辨阳明病脉证并治》，第195条）

【提要】

论阳明中寒欲作谷瘅及其治禁。

【词解】

谷瘅：病名，症见寒热不食，食即头眩，心胸不安，小便难，发黄等。瘅，通“疸”，黄疸病之一。

【句解】

阳明病见脉迟，多为不发热或发热轻微，脉迟有力多为实证，迟而无力多为虚证。谷疸有湿热和寒湿之分，湿热多为实证，寒湿大多夹虚。本证用攻下逐邪法，腹满不愈，当属寒湿为患偏虚之证。

【拓展】

《医宗金鉴·订正仲景全书·伤寒论注·阳明全篇》：“阳明病不更衣，已食如饥，食辄腹满脉数者，则为胃热，可下之证也。今脉迟，迟为中寒，中寒不能化谷，所以虽饥欲食，食难用饱，饱则烦闷，是健运失度也。清者阻于上升，故头眩；浊者阻于下降，故小便难。食郁湿瘀，此欲作谷疸之征，非阳明热湿，腹满发黄也。虽下之腹满暂减，顷复如故，所以然者，脉迟中寒故也”。

18 阳明病，法多汗。反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。（《辨阳明病脉证并治》，第196条）

【提要】

论阳明津伤无汗证。

【句解】

阳明病多里实热证，因里热迫津外出，当见汗出一症。若证见无汗，身痒，病机主要有两种：一是素体津气不足，汗出无源，热欲外越而不得作汗，邪热郁于肌肤所致；二是阳明发黄证后期，湿邪阻于肌肤日久，同时津血不足，肌肤腠理去陈生新功能下降所致。

19 阳明病，反无汗而小便利，二三日呕而咳，手足厥者，必苦头痛。若不咳不呕，手足不厥者，头不痛。（《辨阳明病脉证并治》，第197条）

【提要】

论阳明中寒，饮邪上逆证。

【拓展】

本证病机在于阳明胃寒气逆，逆则呕、咳、头痛而手足厥。仲景未出方治，据证论方，似以吴茱萸汤为宜。阳明病虽以里热实证为主，但也有虚寒之证，故不可不明。

20 阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人咽必痛。若不咳者，咽不痛。（《辨阳明病脉证并治》，第198条）

【提要】

论阳明中风，热邪上扰证。

【句解】

阳明病以能食不能食辨中风与伤寒，本证“能食”属阳明中风。“不恶寒”排除了表证的可能性，提示为阳明里热证。

21 阳明病，脉浮而紧者，必潮热，发作有时。但浮者，必盗汗出。（《辨阳明病脉证并治》，第201条）

【提要】

论阳明病之脉浮紧。

【句解】

脉浮紧为太阳伤寒之脉，为风寒束表所致。阳明病见浮紧之脉，则临床意义不同，浮为阳明热盛，气血充盈于体表，紧为邪实，肠胃有结聚。故阳明病见浮紧脉，为阳明热盛腑实已成之候。

【拓展】

柯韵伯《伤寒来苏集·伤寒论注·阳明脉证上》：“阳明脉证与太阳脉证不同，太阳脉浮紧者，必身疼痛，无汗，恶寒发热不休。此则潮热有时，是恶寒将自罢，将发潮热时之脉也。此紧反入里之谓，不可拘紧则为寒之说矣。太阳脉但浮者，必无汗，今盗汗出，是因于内热，且与本经初病但浮无汗而喘者不同，又不可拘浮为在表之法矣。脉浮紧，但浮而不合麻黄证，身热汗出而不是桂枝证。麻桂下咽，阳盛则毙耳。此脉从经异，非脉从病反，要知仲景分经辨脉，勿专据脉谈证”。

22 阳明病，口燥，但欲漱水不欲咽者，此必衄。（《辨阳明病脉证并治》，第202条）

【提要】

论阳明病之衄血证。

【拓展】

仲景指出“口燥，但欲漱水不欲咽”，为热在血分的重要标志，此观点为后世医家所认同。尤在泾《伤寒贯珠集·阳明篇上》：“阳明口燥，欲饮水者，热在气而属腑，口燥但欲漱水不欲咽者，热在血而属经。经中热甚，血被热迫，必妄行为衄也”。

23 阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此必大便硬故也。以亡津液，胃中干燥，故令大便硬。当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出。今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。（《辨阳明病脉证并治》，第203条）

【提要】

根据小便情况来推测肠燥便硬的程度。

【拓展】

通过观察小便来推测大便的方法，是《伤寒论》中经常使用的方法，具有一定的临床意义。方有执《伤寒论条辨·辨阳明病脉证并治》：“差，小愈也。以亡津液至大便硬，是申释上文。当问其小便日几行至末，是详言大便出不出之所以然。盖水谷入胃，其清者为津液，粗者为渣滓，津液之渗而外出者为汗，潴而下行者为小便，故汗与小便出多，皆能令人亡津液，所以渣滓之为大便者，干燥硬结而难出也。然二者水谷分行之道路，此通则彼塞，此塞则彼通。小便出少，则津液还停胃中，胃中津液足，则大便软滑，其所以必出可知也”。

24 阳明病，潮热，大便微硬者，可与大承气汤；不硬者，不可与之。若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中，转失气者，此有燥屎也，乃可攻之。若不转失气者，此但初头硬，后必溏，不可攻之，攻之必胀满不能食也。欲饮水者，与水则哕。其后发热者，必大便复硬而少也，以小承气汤和之。不转失气者，慎不可攻也。（《辨阳明病脉证并治》，第209条）

【提要】

论大、小承气汤的运用指征及误用攻下后的变证。

【词解】

失气：通“矢气”，俗称放屁。

【句解】

阳明病，潮热、便硬为腑实已成的标志。大承气汤为峻下之剂，治典型腑实证，若大便结实不甚，腑实未成者，不可用之。对于不大便六七日，可能有燥屎的腑实疑似证，可用小承气汤试探。若服小承气汤后，腹中转矢气者，为腑实结聚已成，且气机尚有通畅之机，为可攻之证，可进一步用大承气汤攻下。若不转矢气，为腑实未成，仅大便初硬，后必溏，为热而不实，或有虚寒，故不可攻，攻之则损伤脾胃之气，而出现腹部胀满，不能食，饮水则哕等变证。

25 夫实则谵语，虚则郑声。郑声者，重语也。直视，谵语，喘满者死，下利者亦死。（《辨阳明病脉证并治》，第 210 条）

【提要】

辨谵语、郑声的性质、特征与预后。

【词解】

① 谵语：神识不清，语无伦次，声高有力，属实证。

② 郑声：神识不清，语言重复，时断时续，语声低微，属虚证。

【拓展】

谵语与郑声均是意识不清而言语错乱，然有虚实之分。《医宗金鉴·订正仲景全书·伤寒论注·阳明全篇》："实则谵语，阳明热甚，上乘于心，乱言无次，其声高朗，邪气实也。虚则郑声，精神衰乏，不能自主，语言重复，其声微短，正气虚也"。

26 发汗多，若重发汗者，亡其阳。谵语，脉短者死，脉自和者不死。（《辨阳明病脉证并治》，第 211 条）

【提要】

论误汗亡阳出现的谵语及其预后判别。

【词解】

亡其阳：此指阳气随大汗而外泄。

【句解】

本条所言谵语因过汗亡阳，心神失养所致。其预后取决于阳气的恢复与否。如阳衰阴竭，脉道不充，则脉短，证属危重，故曰"死"；脉不短而平和，是真气未败，正气尚有恢复之机，故曰"不死"。

【拓展】

陈修园《伤寒论浅注·阳明篇》："有亡阳而谵语者，汗为心液，心为阳中之太阳，发汗多，则心液虚矣。若重发汗者，心液为阴，阴虚于内则心主之阳无所附而

遂亡于外矣。亡其阳则神气亦昏而谵语。脉乃血脉，脉短者，心液亡，心气绝故死。若脉不短而且自和者，病虽剧，亦不死”。

27 阳明病，下血、谵语者，此为热入血室。但头汗出者，刺期门，随其实而泻之，濈然汗出则愈。（《辨阳明病脉证并治》，第216条）

**【提要】**

论阳明病热入血室的表现。

**【词解】**

血室：即指胞宫，是近来多数学者所主张。

**【句解】**

热入血室属邪热侵犯血分。血热上扰神明则谵语，血热妄行则下血，包括便血或阴道出血等症。本证大多伴有月经适来或适断，或伴胸胁满或少腹急结。但头汗出，提示气机不通，血热不能外透而熏蒸于上。热入血室证虽病变部位主要在胞宫，但与冲脉和肝脏均有关联，其治可刺期门穴。

28 伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语。（《辨阳明病脉证并治》，第218条）

**【提要】**

论误汗津伤之谵语。

**【句解】**

里热炽盛，腑气壅滞，则见腹满。里热炽盛，肺气不利则喘。若医者失察，而误用汗法，必致津液外泄，胃肠燥热更盛，而大便难出。盖误汗则虚其表，汗出津伤，里热更炽，因循失误，久必神明被扰，故发谵语。

**【拓展】**

柯韵伯《伤寒来苏集·伤寒论注·阳明脉证上》：“喘而胸满者，为麻黄证。然必脉浮者，病在表，可发汗。今脉沉为在里，则喘满属于里矣。反攻其表则表虚，故津液大泄，喘而满者，满而实矣。因转属阳明，此谵语所由来也，宜少与调胃。汗出为表虚，然是谵语，归重只在里实”。

29 若胃中虚冷，不能食者，饮水则哕。（《辨阳明病脉证并治》，第226条）

**【提要】**

论阳明中寒证。

**【句解】**

阳明中寒证的特点是中阳不足，胃中虚冷。胃中虚冷，不主受纳，和降失司，

故不能食，饮水则上逆而为呃逆。

30 脉浮发热，口干鼻燥，能食者则衄。（《辨阳明病脉证并治》，第227条）

**【提要】**

论阳明病热在气分的衄血证。

**【句解】**

足阳明胃经起于鼻旁，环口，循于面部。邪热盛于阳明之经，尚未入腑，故见脉浮、发热、口干鼻燥、能食。热迫血妄行，血随经上逆，故见鼻衄。

**【拓展】**

柯韵伯《伤寒来苏集·伤寒论注·阳明脉证》："液之与血，异名同类，津液竭，血脉因之亦伤。故阳明主津液所生病，亦主血所生病。阳明经起于鼻，系于口齿，阳明病，则津液不足，故口鼻干燥。阳盛则阳络伤，故上盛而为衄也。口鼻之津液枯涸，故欲漱水不欲咽者，热在口鼻，未入乎内也。能食者，胃气强也。以脉浮发热之证，而见口干鼻燥之病机，如病在阳明，更审其能食。不欲漱水之病情，知热不在气分，而在血分矣"。

31 阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干，不得汗，嗜卧，一身及目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后肿，刺之小差。外不解，病过十日，脉续浮者，与小柴胡汤。（《辨阳明病脉证并治》，第231条）

**【提要】**

论少阳阳明郁热的证治。

**【句解】**

"阳明中风"，揭示阳明经感受风邪，"脉弦浮大"，提示阳明少阳两经同受邪扰。其余诸症，皆为阳明少阳同受邪扰，邪热壅滞经脉，并且有经腑同病的表现。

**【拓展】**

本证为阳明少阳两经同病之湿热发黄，治用小柴胡汤原因有三：一是少阳有三禁，即禁汗、吐、下；二是小柴胡汤可以和解半表半里，少阳枢机利，则表里之邪热皆除；三是本证以少阳脉证为主，由于少阳枢机不利，三焦不畅，肝胆疏泄失常而发黄疸。故治从少阳，用小柴胡汤疏利肝胆、通畅三焦、清利湿热，诚如《金匮要略·黄疸病脉证并治》所载："诸黄，腹痛而呕者，宜柴胡汤"。

32 脉但浮，无余证者，与麻黄汤。若不尿，腹满加哕者，不治。

（《辨阳明病脉证并治》，第 232 条）

【提要】

承第 231 条论少阳阳明郁热的证治。

【句解】

“脉但浮”，是指脉由原来的弦浮大变成单纯的浮脉。“无余证”指少阳、阳明证不明显，而以太阳表证为主，便可用麻黄汤解表散邪。若见小便闭，腹满加哕，则证情危重，是胃气衰败，邪闭气阻之证，邪实正虚，故属难治。

【拓展】

钱天来《伤寒溯源集·阳明上篇》：“若脉但浮，浮为邪气在表，且从前诸余证悉无者，是邪尽还表，复出太阳营卫之间矣。治之无难，一汗而愈矣，故重与麻黄汤……若邪不复外出而郁于里，则大气不得升降，津液不得流行，而三焦之气化绝，故不尿，中气闭塞而腹满甚，胃阳败绝而加哕者，乃必死不治之证，故无治法也”。

33 阳明病，自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽硬不可攻之，当须自欲大便，宜蜜煎导而通之。若土瓜根及大猪胆汁，皆可为导。（《辨阳明病脉证并治》，第 233 条）

【提要】

论论津伤便硬自欲大便时的外导法。

【词解】

① 导：有因势利导之意。用润滑类药物纳入肛门，引起排便，叫做导法。

② 土瓜根：土瓜又名王瓜，气味苦寒无毒，其根呈长块状，富于汁液，将其捣汁灌肠可通便。《肘后备急方》：“治大便不通，土瓜采根捣汁，筒吹入肛门中，取通”。

【方药】

蜜煎方：

食蜜（七合）。上一味，于铜器内，微火煎，当须凝如饴状，搅之勿令焦着，欲可丸，并手捻作挺，令头锐，大如指，长二寸许。当热时急作，冷则鞕。以内谷道中，以手急抱，欲大便时乃去之。疑非仲景意，已试甚良。又大猪胆一枚，泻汁，和少许法醋，以灌谷道内，如一食顷，当大便出宿食恶物，甚效。

34 阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。（《辨阳明病脉证并治》，第 234 条）

【提要】

论阳明太阳同病的桂枝汤证。

【句解】

条文句首冠以阳明病，又伴微恶寒，提示阳明太阳同病。其表未解，故治疗不宜攻下而应解表，用桂枝汤。

35 阳明病，脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。（《辨阳明病脉证并治》，第235条）

【提要】

论阳明太阳同病的麻黄汤证。

【句解】

条文句首冠以阳明病，但太阳伤寒证的表现尤为明显。风寒邪气在表，卫气奋起抗邪外出，故见脉浮，其症当有发热恶寒，是条文省其症，但以脉象示之。寒邪侵犯营卫，腠理闭塞，营阴郁滞，故无汗。邪犯肺卫，肺气失宣，上逆而喘，此均为麻黄汤主症。本条文中虽未提及阳明病表现，从证候分析看，似为大便不通，肠胃有病邪结聚，但病势较轻，故治疗当从太阳。

36 阳明病，下之，心中懊侬而烦，胃中有燥屎者，可攻；腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第238条）

【提要】

辨阳明病的可攻与不可攻。

【词解】

① 胃中：胃泛指胃肠，此处当指肠中。

② 燥屎：结聚肠内异常干硬之粪块。

【方药】

大承气汤方：

大黄四两（酒洗），厚朴半斤（炙，去皮），枳实五枚（炙），芒硝三合。上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，内大黄，更煮取二升，去滓，内芒硝，更上微火一两沸，分温再服，得下余勿服。

37 病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热者，属阳明也。脉实者，宜下之；脉浮虚者，宜发汗。下之与大承气汤，发汗宜桂枝汤。（《辨阳明病脉证并治》，第240条）

【提要】

论太阳病转属阳明病的证治。

【句解】

脉实表示实邪结于里，正气不虚，是用大承气汤攻下的适应证。反之，脉不实，表示燥结未成，或正气有亏，均不宜妄用攻下。本条所言脉浮虚，浮为表邪未尽，虚为里实未成，病偏于表，故宜用汗法，不用攻下。

38 大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第241条）

【提要】

论大下后燥屎复结的证治。

【词解】

宿食：停积于胃肠内未尽消化的食物。

【拓展】

阳明病有一下腑实不除而再下之法。能否再下，要以辨证为依据。本条下后六七日不大便，烦不解，腹满痛，自是辨大承气汤证的关键。如不大便，心烦腹满，结实未甚，当用小承气汤。若下后心烦，谵语，不大便，蒸蒸发热，则治宜调胃承气汤。

39 太阳病，寸缓、关浮、尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也。如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也。小便数者，大便必硬，不更衣十日，无所苦也。渴欲饮水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散。（《辨阳明病脉证并治》，第244条）

【提要】

论太阳病向阳明病转化的三种变证。

【拓展】

本条论述重在辨证：一辨表证误下成痞与自然传经入阳明的区别；二辨肠燥津亏证与邪热结聚肠胃的区别；三辨津伤口渴与停饮津不上承口渴的区别。

40 脉阳微而汗出少者，为自和也；汗出多者，为太过。阳脉实，因发其汗，出多者，亦为太过。太过者，为阳绝于里，亡津液，大便因硬也。（《辨阳明病脉证并治》，第245条）

【提要】

论汗多津伤所引起的便硬症。

【句解】

① 脉阳微：此指脉浮取而微。提示表证轻，只要适当发汗，即可痊愈。如果汗出太多，反伤正气。

② 阳脉实：指脉轻取有力。提示邪气盛而表证重，故用汗法治疗，以遍身絷絷汗出为佳。

③ 阳绝于里：阳气极盛于里。绝，极度。

41 脉浮而芤，浮为阳，芤为阴，浮芤相搏，胃气生热，其阳则绝。（《辨阳明病脉证并治》，第 246 条）

【提要】

论阳明胃热津亏的脉证。

【句解】

本条承接第 245 条，脉浮为阳气盛，芤为阴血虚，此乃阴液伤而胃气生热。津愈伤则热更炽，热愈炽则津更伤，故曰“其阳则绝”。

【拓展】

此证亦可用麻子仁丸治之。

42 得病二三日，脉弱，无太阳柴胡证，烦躁，心下硬。至四五日，虽能食，以小承气汤，少少与，微和之，令小安。至六日，与承气汤一升。若不大便六七日，小便少者，虽不受食，但初头硬，后必溏，未定成硬，攻之必溏；须小便利，屎定硬，乃可攻之，宜大承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第 251 条）

【提要】

论阳明病辨小便以测大便的方法。

【句解】

得病二三日，既无太阳表证，又无少阳柴胡证，却症见烦躁、心下硬满，提示为阳明里实证。原则上应取攻下法，但有不宜攻下的症状，一是心下硬，病邪部位较高，不能强攻；二是脉弱，正气不足，恐不能耐受攻下。故暂时不用下法，须动态观察。

若至四五日，患者能食，一方面说明胃气尚可，虽脉弱但能耐受攻下；另一方面，能食表示邪结已下肠腑，可以用小承气汤“少少与，微和之”，望腑气能通，邪得去。若其效不显者，至六日再予小承气汤。

若六七日仍不大便，要考虑两种情况，一是热结肠腑没有进一步燥化成实，症见大便先硬结后溏，如再用攻下，必然出现大便溏薄。二是热结肠胃证情加

重，完全燥化成实，此时当用大承气汤峻下。

43 阳明少阳合病，必下利，其脉不负者，为顺也。负者，失也，互相克贼，名为负也。脉滑而数者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。（《辨阳明病脉证并治》，第256条）

【提要】

论阳明少阳合病的证治。

【词解】

克贼：伤害。

【句解】

其脉不负者，为顺也：阳明病之脉当见滑数而大，少阳病之脉当见弦直。阳明属土，少阳属木。今阳明少阳合病而见下利，若纯见少阳弦脉，则木旺土虚，木来克土，病情为逆，即“负者，失也”；若纯见阳明滑数之脉，则土气旺，木不克土，病情为顺，即“其脉不负者，为顺也”。

【拓展】

本条阳明少阳之合病，因属阳明有宿食内结，故其下利多属热结旁流，应伴潮热、腹满疼痛、不欲食等症。

44 病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热则消谷喜饥，至六七日不大便者，有瘀血，宜抵当汤。（《辨阳明病脉证并治》，第257条）

【提要】

论辨阳明腑实与有瘀血的证治。

【拓展】

本证下后浮脉去而数脉存，大便复秘，消谷善饥，说明气分之热已去大半，而血分之热未除，必有瘀血在胃肠，用抵当汤下之，确属无疑。然而临证中，据此断为阳明瘀血证，尚不全面，应合参第237条“其人喜忘，屎虽硬，大便反易，其色必黑”才能确诊无误。本条言“发热七八日”，验之于临床，多属于持续性低热，此为瘀血发热之特征。

45 少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊。（《辨少阳病脉证并治》，第264条）

【提要】

论少阳中风证症状、禁忌及误治后变证。

【句解】

足少阳经起于目锐眦，走入耳中，下胸中，贯膈；手少阳之脉上耳后，入耳中，出耳前，止于目锐眦，其支者布胸中，络心包，下膈。少阳中风，为风邪侵袭少阳之经，少阳主相火，又为风邪所犯，风火相煽，循经上扰，清窍不利，故耳聋、目赤；邪滞少阳经脉，胆火上炎，枢机不利则胸中满而烦。由此可见本证是无形之风火上扰少阳经脉所致，应治以和解枢机，清降胆火之法。若误认胸满而烦为实邪阻滞，而用吐下之法，势必耗伤气血，导致胆气内虚，心失所养，而出现心悸、惊惕等变证，故少阳病禁用吐下之法。

46 三阳合病，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合则汗。（《辨少阳病脉证并治》，第 268 条）

【提要】

论三阳合病的脉证。

【句解】

三阳合病，指太阳、阳明、少阳同病。浮为太阳之脉，大为阳明之脉，故脉浮大者，是太阳与阳明同病之脉。“上关上”言脉势有余，长直有力，与少阳之弦脉相同。可见脉浮大，上关上，为三阳合病之脉。

47 伤寒六七日，无大热，其人躁烦者，此为阳去入阴故也。（《辨少阳病脉证并治》，第 269 条）

【提要】

论表病入里之证。

【词解】

阳去入阴：即去表入里之意。

48 太阴为病，脉弱，其人续自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。（《辨太阴病脉证并治》，第 280 条）

【提要】

承第 279 条续论太阳病误下，邪陷太阴的证治。

【句解】

① 脉弱：是太阴病的主脉，属脾阳虚弱，鼓动无力所致。

② 易动故也：若有脾阳虚弱，又兼苦寒药用量过大，更伤脾阳，易生变证，故曰“易动故也”。

49 少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。（《辨少阴病脉证并治》，第285条）

【提要】

论少阴里证禁汗。

【句解】

少阴病属里虚证，脉多沉细，不可发汗。少阴病热化证，虚火可致脉数。少阴病寒化证，虚阳外越亦可致脉数。阴虚热化证误汗，则易致伤阴动血之变；阳虚寒化证误汗，则必致虚阳外脱之变。故本条提示：只要属少阴里证，无论热化寒化，均禁用发汗。

【拓展】

本条以脉代证，提示少阴里证不可发汗，这是基本原则，但兼表证时，又可以温少阴为主，兼以发汗解表，如麻黄细辛附子汤温经解表即是。

50 少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也；阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下之。（《辨少阴病脉证并治》，第286条）

【提要】

论少阴病阴阳两虚禁用汗下。

【句解】

“脉微”是由肾阳虚衰鼓脉无力所致，是少阴寒化证的主脉。既是脉微阳虚，自然不可发汗，发汗则导致阳气外脱。汗易伤阳，下多伤阴，阴血虚弱，非但不可发汗，亦不可下之。

51 少阴病，脉紧，至七八日，自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦，下利必自愈。（《辨少阴病脉证并治》，第287条）

【提要】

论少阴病阳回自愈的辨证。

【拓展】

本条用“手足反温”、“脉紧反去”，既示人以少阴寒化证向愈的临床表现，更喻人此类病证，必用扶阳抑阴之法，促使阳气恢复，阴寒消退的治疗思想。

52 少阴中风，脉阳微阴浮者，为欲愈。（《辨少阴病脉证并治》，第290条）

【提要】

论少阴中风欲愈的脉象。

【词解】

① 阴：此指尺脉。

② 阳：此指寸脉。

【句解】

少阴中风是少阴感受风邪之证。少阴为阴经，其病多有正气不足，故少阴中风证，寸脉当浮，尺脉应沉。

【拓展】

刘渡舟《伤寒论讲解·辨少阴病脉证并治第十一》："少阴中风，风由外来，寸脉当浮，今不浮而微，说明风邪之势渐退；少阴病，里气不足，尺脉当沉，今尺脉不沉而反浮，是为阴病而见阳脉，正气已经来复"。

53 少阴病，八九日，一身手足尽热者，以热在膀胱，必便血也。（《辨少阴病脉证并治》，第293条）

【提要】

论少阴阴虚热化，移热膀胱的证治。

【句解】

少阴与太阳互为表里，疾病容易表里互传。太阳误治可伤及少阴，少阴病易波及太阳之膀胱腑。本证即少阴病肾阴亏虚，化生内热，虚火日炽，八九日后，移热于膀胱，变为膀胱热证，症见一身手足尽热，又可小便见血。

【拓展】

治宜育阴清热，宁络止血。清代医家柯韵伯认为，轻者可用猪苓汤，重者用黄连阿胶汤，可供临床参考。

54 少阴病，但厥无汗，而强发之，必动其血，未知从何道出，或从口鼻，或从目出者，是名下厥上竭，为难治。（《辨少阴病脉证并治》，第294条）

【提要】

论少阴病强汗动血的变证。

【词解】

下厥上竭：因阳气虚于下而厥逆，故称下厥；因阴血出于上而耗竭，故称上竭。

【句解】

少阴肾阳虚衰，外不能温煦四肢则手足厥逆，内不能蒸腾津液故无汗，治当温补肾阳。今但厥无汗，并无表证，而强发其汗，元阳大伤，阴寒益盛，虚阳浮躁，

激动营血，血随虚阳而上溢。此时，所有空窍都可能出血，或从口鼻出，或从目出等。

55 少阴病，四逆，恶寒而身蜷，脉不至，不烦而躁者，死。（《辨少阴病脉证并治》，第298条）

【提要】

论少阴病阴盛阳绝而神亡的危候。

【词解】

不烦而燥：神志昏迷而手足无意识的躁动。

【句解】

① 四逆，恶寒而身蜷：为肾阳虚衰、阴寒内盛之象。

② 脉不至，不烦而燥：为阳气欲绝，神气浮越的表现。

【拓展】

柯韵伯《伤寒来苏集·伤寒论注·少阴脉证》："阳盛则烦，阴极则燥，烦属气，燥属形，烦发于内，燥见于外，形从气动也。时自烦，是阳渐回，不烦而燥，是气已先亡，惟形独存耳"。

56 少阴病，脉微细沉，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六日自利，复烦躁，不得卧寐者，死。（《辨少阴病脉证并治》，第300条）

【提要】

论少阴病阴寒极盛，阳气脱绝的危候。

【句解】

① 脉微细沉：是少阴病本脉。

② 但欲卧：是少阴病本证。

③ 汗出不烦：汗出，为阴盛阳衰，阳气外越。不烦，是阳衰至极，无力与阴邪相争。

④ 自欲吐：为阳虚阴盛，阴寒上逆。

57 少阴病，下利，咽痛，胸满，心烦，猪肤汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第310条）

【提要】

论少阴病阴虚咽痛的证治。

【句解】

手少阴心脉，起于心中，出属心系，下络小肠，其支脉挟咽；足少阴肾经，从肾

上贯肝膈，入肺中，循咽喉，挟舌本，故仲景将咽喉病，皆冠以“少阴病”。本条下利伤阴，阴虚生热，虚热循经上扰，经气不利，故见咽痛、胸满、心烦诸症。

**【方药】**

猪肤汤方：

猪肤一斤。上一味，以水一斗，煮取五升，去滓，加白蜜一升，白粉（即米粉，亦作小麦粉）五升，熬香，和令相得（调和均匀），温分六服。

58 少阴病二三日，咽痛者，可与甘草汤，不差，与桔梗汤。（《辨少阴病脉证并治》，第311条）

**【提要】**

论少阴客热咽痛的证治。

**【句解】**

少阴病二三日，为病之初起。咽痛，乃邪热客于咽喉所致。因病属初起，邪热不甚，病变较轻，故咽部仅见轻微红肿疼痛，一般无全身症状。

**【方药】**

① 甘草汤方：

甘草二两。上一味，以水三升，煮取一升半，去滓，温服七合，日二服。

② 桔梗汤方：

桔梗一两，甘草二两。上二味，以水三升，煮取一升，去滓，温分再服。

59 少阴病，咽中伤，生疮，不能语言，声不出者，苦酒汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第312条）

**【提要】**

论少阴病咽中生疮的证治。

**【词解】**

生疮：咽部受到损伤，局部肿胀或溃烂。

**【句解】**

少阴病症见咽部损伤，局部肿胀或溃烂，致使语言困难，声音不出，是痰浊阻闭咽喉所致。痰浊闭阻，波及会厌，局部肿胀，使声门不利，则不能言语，声不能出。

**【方药】**

苦酒汤方：

半夏十四枚（洗，破如枣核），鸡子一枚（去黄，内上苦酒，着鸡子壳中）。上二味，内半夏著苦酒（即米醋）中，以鸡子壳置刀环（刀柄端之圆环）中，安火中，令三沸，去滓，少少含

咽之，不差，更作三剂。

60 少阴病，咽中痛，半夏散及汤主之。（《辨少阴病脉证并治》，第313条）

【提要】

论少阴病咽中痛的治疗。

【句解】

少阴病寒邪痰湿客阻咽喉，故咽部一般不见红肿，同时可伴见恶寒、痰涎多、气逆欲呕、舌淡苔润等。

【方药】

半夏散及汤方：

半夏(洗)，桂枝(去皮)，甘草(炙)。上三味，等分。各别捣筛已，合治之，白饮和服方寸匕，日三服。若不能散服者，以水一升，煎七沸，内散两方寸匕，更煮三沸，下火令小冷，少少咽之。半夏有毒，不当散服。

61 少阴病，得之二三日，口燥咽干者，急下之，宜大承气汤。（《辨少阴病脉证并治》，第320条）

【提要】

论少阴急下证的证治。

【句解】

口燥咽干者：少阴病二三日，时间较短即出现口燥咽干，说明素体阴虚，感邪后伤阴燥化迅速，为热邪炽盛灼津，肾阴亏损。

【拓展】

多数注家皆认为，方用大承气汤急下，当有可急下之阳明腑实证，只有口燥咽干似不足凭，这是符合临床实际的。张正昭之“全在于攻其里热，而不是为了下燥屎”，可供参考。但有认为是转经邪热，复归阳明；有认为是伏气发于少阴；有认为是土燥水竭；有认为是水竭土燥，土燥而水更竭。诸说不一，皆因分析的角度不同，当据症而辨。

62 少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，可下之，宜大承气汤。（《辨少阴病脉证并治》，第321条）

【提要】

论少阴急下证的证治。

【词解】

可：《金匮玉函经》卷四、《注解伤寒论》卷六作“急”。

【句解】

自利清水：是指燥屎内结，迫液旁流，所下之物为黑色臭秽粪水。

【拓展】

刘渡舟《伤寒论讲解·辨少阴病脉证并治第十一》："少阴病下利，多属虚寒，所下之物多为稀薄清冷，或完谷不化，治宜急温少阴。本条之下利，为青黑色之污水，其气臭秽而无屎块，并伴有口干舌燥之证，此是燥热内结，逼迫津液下渗所致。津液下渗，少阴阴液被劫夺，故见口干、舌燥之证。然燥结之干屎，却又滞留肠间，而不随泻下排出体外，故又见里气壅实的'心下必痛'等证，此证愈甚，则津液愈伤而燥结亦愈重，热结旁流，不涸不止，治当急下存阴，宜大承气汤"。

63 少阴病，六七日，腹胀，不大便者，急下之，宜大承气汤。（《辨少阴病脉证并治》，第322条）

【提要】

论少阴急下证的证治。

64 少阴病，下利，脉微涩，呕而汗出，必数更衣，反少者，当温其上，灸之。（《辨少阴病脉证并治》，第325条）

【提要】

论少阴病阳虚血少，气陷下利的证治。

【句解】

① 数更衣，反少者：大便次数多，而量反少。

② 当温其上，灸之：即温灸上部之穴位，如灸百会穴。

【拓展】

本证以阳虚气陷为主症，而以灸法温之，提示临证当注意药、针、灸并用，并指出少阳寒化证以阳气为要，及少阴寒化证急温之的原则。

65 厥阴中风，脉微浮为欲愈，不浮为未愈。（《辨厥阴病脉证并治》，第327条）

【提要】

从脉象论厥阴中风证预后。

【句解】

脉微浮为欲愈：邪入厥阴乃属里证，其脉当见沉迟细弱之象。今厥阴中风，脉见微浮，乃是正胜邪却，阳气来复之佳兆，故断为欲愈。

【拓展】

临床还须结合其他见症状，综合分析，始能做出正确诊断，切不可仅凭脉象

定其愈或不愈。同时，还须注意的是，如果脉象不是微浮而是但浮，按之无根，或脉象暴浮者，则多为虚阳越脱之象，万不可认为是欲愈之候而放松警惕。

66 厥阴病，渴欲饮水者，少少与之愈。（《辨厥阴病脉证并治》，第329条）

【提要】

论厥阴病阳复口渴的调护之法。

【句解】

厥阴病在邪退阳复，诸症消减时，见到“渴欲饮水”者，多为阳气初复，津液一时不能上承所致。本证的辨证关键在于，他症消失，唯存口渴。这种口渴，不需药疗，只需少少饮水，以滋润其津液，阴津得充，阳自不亢，阴阳平衡，则不药可愈。

67 诸四逆厥者，不可下之，虚家亦然。（《辨厥阴病脉证并治》，第330条）

【提要】

论虚寒厥证不可用下法。

【词解】

① 诸：此特指虚寒性厥证，因后文有“虚家亦然”相对参。

② 虚家：身体素虚的人。

【拓展】

对于“虚家”而言，“下”可扩展为攻邪的泻法，一切泻法对于寒厥和虚证均当慎用。

68 伤寒，先厥后发热而利者，必自止，见厥复利。（《辨厥阴病脉证并治》，第331条）

【提要】

论厥热与寒利的关系。

【句解】

① 伤寒，先厥：伤寒病入厥阴，若系寒化病证，病愈之机依赖于阳气来复。患者先见四肢厥冷，是阳气衰微，不能外达于四肢所致。

② 后发热而利：医疗调护得当，阳气来复，则厥冷自消。阳气恢复，脾运得健，则下利可止，这是阳复佳兆。

69 伤寒脉迟六七日，而反与黄芩汤彻其热。脉迟为寒，今与黄芩汤复除其热，腹中应冷，当不能食，今反能食，此名除中，必死。（《辨厥阴病脉证并治》，第333条）

【提要】

论误治转为除中的危候。

【词解】

① 彻其热：彻，除也。即除其热。

② 除中：证候名，中气败绝之危候，表现为证情危殆之时，突然反思饮食。

70 伤寒，一二日至四五日厥者，必发热，前热者，后必厥；厥深者，热亦深；厥微者，热亦微。厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。（《辨厥阴病脉证并治》，第335条）

【提要】

论热厥的证治与治禁。

【拓展】

热厥的形成，主要是邪热深伏，阳气内伏，以致阴阳之气不相顺接所致。患者在出现厥冷之前，必有发热症状，并且，厥冷之时也有里热症状。四肢厥冷愈甚，则表明邪热郁伏愈深；四肢厥冷较轻，则表明邪热郁伏亦浅。厥冷的轻重与里热郁伏的浅深相应，这是热厥证的辨证要点。

71 伤寒，热少微厥，指头寒，默默不欲食，烦躁，数日小便利，色白者，此热除也，欲得食，其病为愈。若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。（《辨厥阴病脉证并治》，第339条）

【提要】

论热厥轻证及其转归。

【句解】

伤寒热少微厥：为热厥轻证，症见指头寒，默默不欲饮食、烦躁等，故有自愈的可能。

【拓展】

热厥轻证也有转为热厥重证的可能，由指头寒变为厥，由不欲食发展为呕，由烦躁发展为胸胁烦满；热邪郁伏，还可波及血分，出现便血之症。

72 病者手足厥冷，言我不结胸，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元也。（《辨厥阴病脉证并治》，第340条）

【提要】

论冷结膀胱关元证。

【词解】

膀胱关元：指小腹部位。

【句解】

患者手足厥冷，小腹满，按之痛，自述无结胸，提示病在下焦，为沉寒内伏，凝结于小腹所致，可视为寒厥之变。本证还可见喜温怕寒，小便清长，苔白脉迟等。

【拓展】

原文未出治法与方药，但根据病机，当以温阳祛寒为法，可外用灸熨，内服药物。灸可选关元、气海等穴，药物可酌选当归四逆加吴茱萸生姜汤之类。

73 伤寒六七日，不利，便发热而利，其人汗出不止者，死。有阴无阳故也。（《辨厥阴病脉证并治》，第346条）

【提要】

论阳气外亡的危候。

【词解】

有阴无阳：下利为阴邪甚，汗出不止为阳外亡，故称为有阴无阳。

【句解】

① 伤寒六七日不利：即在六七日期间，患者可能出现四肢厥冷等寒象，却没有下利。

② 有阴无阳：六七日后，忽见发热与下利并见，提示本证为阴盛格阳，阳虚不固则汗出，汗出不止则阳亡，故称“有阴无阳故也”。

74 伤寒脉促，手足厥逆，可灸之。（《辨厥阴病脉证并治》，第349条）

【提要】

论脉促厥逆可用灸法。

【句解】

伤寒见脉促，当辨其寒热虚实。脉促有力，为阳盛主热；脉促无力，为阳虚主寒。本条所述脉促与手足厥逆同见，多为阴盛阳虚之证。

【拓展】

温灸何处，有医家主张灸太冲穴，亦有主张灸关元、气海穴者，可酌情选之。亦可灸药并用，适当选用回阳救逆之剂，如四逆汤、通脉四逆汤等。

75 病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。（《辨厥阴病脉证并治》，第355条）

【提要】

论痰厥。

【词解】

① 脉乍紧：脉象忽然出现紧脉。乍，忽然。紧脉主寒主痛，亦主内伤饮食。

② 邪：此指痰邪。

【句解】

① 邪结在胸中：痰食有形之邪阻遏胸中阳气，不能充达四末，故见手足厥冷，脉紧；胸阳被郁，浊阴不降，而见心下满而烦。

② 当须吐之：本病在胸中，病位偏高，病势向上，故用瓜蒂散因势利导，涌吐胸中之实邪。即《黄帝内经》所谓“其高者，因而越之”。

76 伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，喉咽不利，唾脓血，泄利不止者，为难治，麻黄升麻汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第357条）

【提要】

论正虚阳郁，上热下寒的证治。

【词解】

下部脉：有两种解释，一是指寸口脉中的尺脉；一是指人体上中下三部中的趺阳脉和太溪脉。

【拓展】

伤寒六七日，有表证未解，部分邪气可能入里，此时当遵守表先里后的治疗原则，先解其表，表解后乃可攻里。若先治以大下，反使表邪内陷，阳气郁遏，伤阴损阳，发生一系列变证。

【方药】

麻黄升麻汤方：

麻黄二两半（去节），升麻一两一分，当归一两一分，知母十八铢，黄芩十八铢，葳蕤十八铢（一作菖蒲），芍药六铢，天门冬六铢（去心），桂枝六铢（去皮），茯苓六铢，甘草六铢（炙），石膏六铢（碎，绵裹），白术六铢，干姜六铢。上十四味，以水一斗，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，分温三服。相去如炊三斗米顷令尽，汗出愈。

77 下利清谷，不可攻表，汗出必胀满。（《辨厥阴病脉证并治》，第364条）

【提要】

论虚寒下利兼表证误汗形成的变证。

【句解】

下利清谷，为脾肾阳虚，温运失常所致，此时即便有表证，治疗也应当先里后表。若用汗法先治其表证，汗出则阳气外泄，正气更虚，虚而不运，浊阴内阻，则腹必胀满。

【拓展】

本条旨在强调虚寒下利兼表证之时，应先温里，后解表，而不可先攻表的基本原则。

78 下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒汗出而解，病人必微厥。所以然者，其面戴阳，下虚故也。（《辨厥阴病脉证并治》，第366条）

【提要】

论寒利阳虚出现郁冒的脉证和机制。

【词解】

① 郁冒：头昏目眩如物覆蒙。

② 戴阳：阴寒内盛，虚阳浮越而出现两颧潮红的假热症状。

③ 下虚：此指下焦虚寒。

79 下利后，脉绝，手足厥冷，晬时脉还，手足温者生，脉不还者死。（《辨厥阴病脉证并治》，第368条）

【提要】

论下利后突见脉绝肢冷的两种转归。

【词解】

脉绝：脉伏不见，不能触及。

【句解】

下利后，突然出现脉绝、手足厥冷者，多因骤然泻下，津液过度损失，阳气一时脱绝所致。这种病证，突发而至，病势急迫，如果脉还肢温，意味着阳气来复，便有生机；如果脉仍不起，厥仍不回，便为死候。

【拓展】

本条的重点在于论述危急重症生死转归的判断方法，临证时既要准确诊断，

更要选用四逆加人参汤等方剂积极救治。

80 伤寒，下利日十余行，脉反实者，死。（《辨厥阴病脉证并治》，第 369 条）

【提要】

论虚寒下利的脉实证。

【句解】

虚寒下利，每天十余次，正气必然大虚，脉当沉微，这才是脉证相符。若反见脉实，提示正气衰竭而邪气独盛，是胃气已经败绝的征兆，即《黄帝内经》所谓“真脏脉见”，此时攻补两难，预后不良，故断为死候。

【拓展】

陆渊雷《伤寒论今释·辨厥阴病脉证并治》：“下利脉实，乃心脏起虚性兴奋，以图背城借一，卒之心脏愈益疲敝以死”。

81 下利欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第 373 条）

【提要】

承第 371 条补述厥阴热利的证治。

82 下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也，宜栀子豉汤。（《辨厥阴病脉证并治》，第 375 条）

【提要】

论下利后热扰胸膈的证治。

【词解】

利后更烦：下利虽止，反见心烦。更，反、却。

【句解】

下利已停止，却反而出现心烦症状，其病机有虚有实，有寒有热。今从用栀子豉汤来看，当知是热扰心神的实热证，故可伴见口渴、舌红、脉数等热证表现。

83 呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者，难治，四逆汤主之。（《辨厥阴病脉证并治》，第 377 条）

【提要】

论阳虚阴盛呕吐的证治。

【句解】

① 呕而脉弱：呕为气逆，脉弱为虚，呕而脉弱，其证属虚。

② 小便复利：小便通利而清长。

【拓展】

本证为阳虚阴盛，虚阳外越的阴阳格拒证。对于这种虚寒性的呕吐，仲景在治疗上，因其见到四肢厥冷，说明阳虚较重而不选用理中汤类，又因其见到“身有微热”，说明格阳不甚而不选用通脉四逆汤。此处言“四逆汤主之”者，意在说明本证只宜使用四逆汤温经回阳，盖阳回阴去则其呕自止，反映了仲景辨证论治的准确与精妙。

84 问曰：病发热头痛，身疼恶寒吐利者，此属何病？答曰：此名霍乱。霍乱自吐下，又利止，复更发热也。（《辨霍乱病脉证并治》，第383条）

【提要】

论霍乱兼表证及其与伤寒的鉴别。

【句解】

霍乱虽病在脾胃，但亦有因感受外邪而发者，故除见吐利交作外，亦可兼表证，表现为头痛身疼，恶寒发热等。

85 吐利止，而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。（《辨霍乱病脉证并治》，第387条）

【提要】

论霍乱里和而表未解的证治。

【词解】

① 消息：斟酌病情之轻重，灵活变通而用药。

② 小和：即不宜用药过量，且不可令汗出过多，正如方有执《伤寒论条辨》所言：“小和，言少少与之，不令过度之意也”。

【句解】

① 吐利止：吐利是霍乱的主证，吐利止，说明里气已和，脾胃升降之机已复，病自向愈。

② 身痛不休：提示表邪未罢。

86 吐利汗出，发热恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。（《辨霍乱病脉证并治》，第388条）

【提要】

论霍乱吐利交作，伤及脾肾阳气。

【词解】

拘急：拘挛急迫。

87 既吐且利，小便复利，而大汗出，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之。（《辨霍乱病脉证并治》，第389条）

【提要】

论霍乱亡阳，里寒外热的证治。

【句解】

① 既吐且利：即霍乱吐利交作，上吐下利。

② 内寒外热：即真寒假热的阴盛格阳证。

88 吐利发汗，脉平，小烦者，以新虚不胜谷气故也。（《辨霍乱病脉证并治》，第391条）

【提要】

论霍乱病后的饮食调护。

【词解】

① 脉平：脉见平和之象。霍乱病经过治疗之后，脉见平和，说明大邪已去，病情向愈。

② 小烦：微觉烦闷。

【拓展】

疾病后期，治疗有效而疾病向愈时，患者可感觉“微烦不适”症状，属于脾胃之气尚弱，不能消化食物所致，此时只要节制饮食，注意调养即可。如《医宗金鉴·订正仲景全书·伤寒论注·辨霍乱病脉证并治》：“霍乱吐利已断，汗出已止，脉平和者，内外俱解也。法当食，食用小烦者，以吐下后新虚不胜谷气故也，节其饮食，自可愈也”。

89 伤寒差以后，更发热，小柴胡汤主之。脉浮者，以汗解之；脉沉实者，以下解之。（《辨阴阳易差后劳复病脉证并治》，第394条）

【提要】

论伤寒瘥后更见发热的证治。

【句解】

伤寒瘥后更见发热，应分析其原因，或因大邪已去而余邪未尽，或因病后体

虚，不慎调理而复感外邪，其治当凭脉辨证。

90 病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱，不能消谷，故令微烦，损谷则愈。（《辨阴阳易差后劳复病脉证并治》，第398条）

**【提要】**

论瘥后微烦的机制及调治法。

**【词解】**

① 脉已解：病脉已解，即脉象平和之意。

② 损谷：减少饮食。

**【句解】**

大病新瘥，出现日暮时心烦之象，是由于病后脾胃气弱，不慎饮食，或勉强进食导致饮食难化，积滞胃肠的缘故。人与天地之气相应，日暮阳消阴长，此时体内脾胃之虚阳得不到天阳之气的资助，消化能力因之减弱，食积而生热，上扰神明，故表现心中烦热。本证非宿食停滞，故不需药物治疗，只要节制饮食，即可自愈。

**【拓展】**

本条与第391条“新虚不胜谷气”所致“脉平小烦者”病机基本相似，可互参。本条强调了病后应节制饮食的重要性，在临床上有重要指导意义。并以此作为全书结尾，是突出《伤寒论》始终重视胃气的思想。

# 叁　《金匮要略》经典条文

# 一级条文(95条)

1 问曰：上工治未病，何也？师曰：夫治未病者，见肝之病，知肝传脾，当先实脾，四季脾王不受邪，即勿补之。中工不晓相传，见肝之病，不解实脾，惟治肝也。(《脏腑经络先后病脉证第一》第1条第1段)

【提要】

从整体观出发，论杂病的治疗法则。

【词解】

① 上工：高明的医生。

② 治未病：此指治未病的脏腑。

③ 实脾：调补脾脏。

④ 四季脾王：农历三、六、九、十二各月之末十八天，为脾土当旺之时。这里可理解为一年四季脾气都很旺盛之意。王，通“旺”。

2 夫肝之病，补用酸，助用焦苦，益用甘味之药调之。(《脏腑经络先后病脉证第一》第1条第2段)

【提要】

以肝病为例，说明治疗当分虚实。

3 夫病痼疾，加以卒病，当先治其卒病，后乃治其痼疾也。(《脏腑经络先后病脉证第一》第15条)

【提要】

论痼疾加卒病的先后缓急治则。

【词解】

① 卒病：新病。

② 痼疾：原有的旧病。

4 夫诸病在脏，欲攻之，当随其所得而攻之。如渴者，与猪苓汤。余皆仿此。(《脏腑经络先后病脉证第一》第17条)

【提要】

举例说明治疗杂病应当掌握审因论治的原则。

【词解】

① 诸病在脏：泛指一切在里的疾病。

② 攻：作治疗解。

③ 所得：指病邪相结合的意思。

5 湿家身烦疼，可与麻黄加术汤发其汗为宜，慎不可以火攻之。（《痉湿暍病脉证治第二》第20条）

【提要】

论湿病寒湿表实的证治。

【词解】

火攻：指艾灸、温针、熨、熏等治法。

6 病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，名风湿。此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致也。可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。（《痉湿暍病脉证治第二》第21条）

【提要】

论湿病风湿表实的成因和证治。

【词解】

日晡：申时，即下午三时至五时左右。

【方药】

麻黄杏仁薏苡甘草汤方：

麻黄（去节）半两（汤泡），甘草一两（炙），薏苡仁半两，杏仁十个（去皮尖，炒）。右锉麻豆大，每服四钱匕，水盏半，煮八分，去滓，温服，有微汗，避风。

7 风湿，脉浮，身重，汗出，恶风者，防己黄芪汤主之。（《痉湿暍病脉证治第二》第22条）

【提要】

论风湿表虚的证治。

【方药】

防己黄芪汤方：

防己一两，甘草半两（炒），白术七钱半，黄芪一两一分（去芦）。右锉麻豆大，每抄五钱匕，生姜四片，大枣一枚，水盏半，煎八分，去滓温服，良久再服。

8 论曰：百合病者，百脉一宗，悉致其病也。意欲食复不能食，常默默欲卧不能卧，欲行不能行，饮食或有美时，或有不用闻食臭时，如寒无寒，如热无热，口苦，小便赤，诸药不能治，得药则剧吐利，如有神灵者，身形如和，其脉微数。（《百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》第1条第1段）

【提要】

论百合病的病因病机与脉症。

【词解】

① 百脉一宗：百脉，泛指全身之脉；宗，根本。

② 身形如和：和，和顺，安和，引申为无病。此言患者看上去无明显病态。

9 百合病，不经吐、下、发汗，病形如初者，百合地黄汤主之。（《百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》第5条）

【提要】

论百合病的正治法。

【词解】

病形如初：证情如百合病第一条所述无变化者。

【方药】

百合地黄汤方：

百合七枚(劈)，生地黄汁一升。右以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，内地黄汁，煎取一升五合，分温再服。中病，勿更取。大便当如漆。

10 狐惑之为病，状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安，蚀于喉为惑，蚀于阴为狐，不欲饮食，恶闻食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白。蚀于上部则声喝一作"嗄"，甘草泻心汤主之。（《百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》第10条）

【提要】

论狐惑病的证治。

【词解】

① 狐惑病：由于湿热虫毒蕴结，导致以目赤、咽喉及前后阴蚀烂为主要表现的病。

② 蚀：腐蚀溃烂。

③ 声喝(yè)：说话声音噎塞或嘶哑。

④ 嘎(shà)：声音嘶哑。

**【方药】**

甘草泻心汤方：

甘草四两，黄芩三两，人参三两，干姜三两，黄连一两，大枣十二枚，半夏半斤。右七味，水一斗，煮取六升，去滓再煎，温服一升，日三服。

11 邪在于络，肌肤不仁；邪在于经，即重不胜；邪入于腑，即不识人；邪入于脏，舌即难言，口吐涎。(《中风历节病脉证并治第五》第2条第2段)

**【提要】**

中风病位深浅的辨证，是中风的辨治纲领。

**【词解】**

重不胜：肢体重滞难举。

12 诸肢节疼痛，身体魁羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。(《中风历节病脉证并治第五》第8条)

**【提要】**

论风湿历节的证治。

**【词解】**

① 身体魁羸：关节肿大，身体瘦弱。

② 脚肿如脱：小腿肿胀，麻木不仁，似要脱离身体一般。

③ 温温：作“蕴蕴”解，指心中郁郁不舒。

**【方药】**

桂枝芍药知母汤方：

桂枝四两，芍药三两，甘草二两，麻黄二两，生姜五两，白术五两，知母四两，防风四两，附子二枚(炮)。右九味，以水七升，煮取二升，温服七合，日三服。

13 病历节，不可屈伸，疼痛，乌头汤主之。(《中风历节病脉证并治第五》第10条)

**【提要】**

论寒湿历节的证治。

**【方药】**

乌头汤方：

麻黄，芍药，黄芪各三两，甘草(炙)，川乌五枚(咬咀，以蜜二升，煎取一升，即出乌豆)。右五味，

咬咀四味，以水三升，煮取一升，去滓，内蜜煎中，更煎之，服七合。不知，尽服之。

14 血痹阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状，黄芪桂枝五物汤主之。（《血痹虚劳病脉证并治第六》第2条）

【提要】

论血痹重证的证治。

【词解】

① 阴阳俱微：包括两层含义，既表示脉象，指寸脉、关脉浮取、沉取皆微；亦表示病机，指营卫气血俱不足。

② 风痹：以肌肉麻木和疼痛为主症的疾病。

【方药】

黄芪桂枝五物汤方：

黄芪三两，芍药三两，桂枝三两，生姜六两，大枣十二枚。右五味，以水六升，煮取二升，温服七合，日三服。

15 夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩一作目眶痛，发落，脉极虚芤迟，为清谷，亡血，失精，脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝加龙骨牡蛎汤主之。（《血痹虚劳病脉证并治第六》第2条）

【提要】

论虚劳阴阳两虚的失精证治。

【词解】

① 失精家：指经常梦遗、滑精之人。

② 清谷：泻下清冷，完谷不化。

③ 梦交：夜梦性交。

④ 芤动微紧：芤动为阳，是阴虚阳浮之象；微紧为阴，是阳虚内寒之征。

【方药】

桂枝加龙骨牡蛎汤方：

桂枝、芍药、生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚，龙骨、牡蛎各三两。右七味，以水七升，煮取三升，分温三服。

16 虚劳里急，悸，衄，腹中痛，梦失精，四肢酸疼，手足烦热，咽干口燥，小建中汤主之。（《血痹虚劳病脉证并治第六》第13条）

【提要】

论虚劳阴阳两虚腹痛的证治。

【词解】

里急：腹部有挛急感，但按之不硬。

【方药】

小建中汤方：

桂枝三两(去皮)，甘草三两(炙)，大枣十二枚，芍药六两，生姜三两，胶饴一升。右六味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火消解，温服一升，日三服。

17 虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味肾气丸主之。(《血痹虚劳病脉证并治第六》第15条)

【提要】

论虚劳肾气不足腰痛的证治。

【方药】

八味肾气丸方：

干地黄八两，山茱萸、薯蓣各四两，泽泻、茯苓、牡丹皮各三两，桂枝、附子(炮)各一两。右八味，末之，炼蜜和丸，梧子大，酒下十五丸。日再服。

18 虚劳诸不足，风气百疾，薯蓣丸主之。(《血痹虚劳病脉证并治第六》第16条)

【提要】

论虚劳兼风的证治。

【词解】

风气：泛指外邪。因风为百病之长，入侵人体，能引起多种疾病。

【方药】

薯蓣丸方：

薯蓣三十分，当归、桂枝、干地黄、豆黄卷各十分，甘草二十八分，芎䓖、麦门冬、芍药、白术、杏仁各六分，人参七分，柴胡、桔梗、茯苓各五分，阿胶七分，干姜三分，白敛二分，防风六分，大枣百枚(为膏)。右二十一味，末之，炼蜜和丸，如弹子大，空腹酒服一丸，一百丸为剂。

19 虚劳虚烦不得眠，酸枣汤主之。(《血痹虚劳病脉证并治第六》第17条)

【提要】

论虚劳阴虚失眠的证治。

【方药】

酸枣汤方：

酸枣仁二升，甘草一两，知母二两，茯苓二两，芎䓖二两。右五味，以水八升，煮酸枣仁，得六升，内诸药，煮取三升，分温三服。

20 五劳虚极羸瘦，腹满不能饮食，食伤，忧伤，饮伤，房室伤，饥伤，劳伤，经络营卫气伤，内有干血，肌肤甲错，两目黯黑。缓中补虚，大黄䗪虫丸主之。（《血痹虚劳病脉证并治第六》第18条）

【提要】

论虚劳兼干血的证治。

【词解】

① 五劳：有两种解释：一指心劳、肝劳、脾劳、肾劳、肺劳；一指“久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋”（《素问·宣明五气》）。

② 肌肤甲错：皮肤粗糙干枯，如鳞甲形状。

③ 两目黯黑：有三种认识：一指两眼白珠呈青黯色或有黯黑斑块；二指望诊目眶周围黯黑；三指患者视物时觉黯黑不清。

④ 干血：瘀血日久，则新血不生；瘀久又可化热伤阴。因其瘀血内阻，阴血亏乏，濡养失职，故为干血。

⑤ 缓中补虚：虚劳干血的治法。峻剂丸服，缓攻瘀血，攻中兼补，达到祛瘀不伤正，扶正不留瘀的作用。

【方药】

大黄䗪虫丸方：

大黄十分(蒸)，黄芩二两，甘草三两，桃仁一升，杏仁一升，芍药四两，干地黄十两，干漆一两，虻虫一升，水蛭百枚，蛴螬一升，䗪虫半升。右十二味，末之，炼蜜和丸小豆大，酒饮服五丸，日三服。

21 肺痿吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遗尿，小便数，所以然者，以上虚不能制下故也。此为肺中冷，必眩，多涎唾，甘草干姜汤以温之。若服汤已渴者，属消渴。（《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》第5条）

【提要】

论虚寒肺痿病的证治。

【词解】

上虚不能制下：肺冷气弱，治节不用，水液直趋下焦，故遗尿或小便频数。

【方药】

甘草干姜汤方：

甘草四两(炙)，干姜二两(炮)。咬咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

22 咳而上气，喉中水鸡声，射干麻黄汤主之。(《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》第6条)

【提要】

论寒饮郁肺咳嗽上气的证治。

【词解】

水鸡声：形容喉中痰声犹如蛙鸣，连绵不绝。水鸡，即青蛙，俗名田鸡。

【方药】

射干麻黄汤方：

射干十三枚，麻黄四两，生姜四两，细辛三两，紫菀三两，款冬花三两，五味子半斤，大枣七枚，半夏大者八枚(洗)。右九味，以水一斗二升，先煮麻黄两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。

23 大逆上气，咽喉不利，止逆下气者，麦门冬汤主之。(《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》第10条)

【提要】

论虚火咳喘的证治。

【词解】

大逆：徐彬、尤怡、吴谦等注本作“火逆”。

【方药】

麦门冬汤方：

麦门冬七升，半夏一升，人参三两，甘草二两，粳米三合，大枣十二枚。右六味，以水一斗二升，煮取六升，温服一升，日三夜一服。

24 咳而上气，此为肺胀，其人喘，目如脱状，脉浮大者，越婢加半夏汤主之。(《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》第13条)

【提要】

论饮热郁肺咳喘的证治。

【词解】

① 目如脱状：两目胀突，有如脱出之状。

② 肺胀：由外感实邪，内有水饮，兼夹郁热，外内合邪，令肺气胀满。

【方药】

越婢加半夏汤方：

麻黄六两，石膏半斤，生姜三两，大枣十五枚，甘草二两，半夏半升。右六味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。

25 肺胀，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，小青龙加石膏汤主之。（《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》第14条）

【提要】

论外寒内饮夹热咳喘的证治。

【词解】

心下有水：胃脘部素有水饮内伏。

【方药】

小青龙加石膏汤方：

麻黄、芍药、桂枝、细辛、甘草、干姜各三两，五味子，半夏各半升，石膏二两。右九味，以水一斗，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升。强人饮一升，羸者减之，日三服，小儿服四合。

26 师曰：奔豚病，从少腹起，上冲咽喉，发作欲死，复还止，皆从惊恐得之。（《奔豚气病脉证治第八》第1条）

【提要】

论奔豚气病的主症。

27 奔豚气上冲胸，腹痛，往来寒热，奔豚汤主之。（《奔豚气病脉证治第八》第2条）

【提要】

论肝郁气逆所致奔豚的证治。

【方药】

奔豚汤方：

甘草、芎劳、当归各二两，半夏四两，黄芩二两，生葛五两，芍药二两，生姜四两，甘李根白皮一升。右九味，以水二斗，煮取五升，温服一升，日三夜一服。

28 师曰：夫脉当取太过不及，阳微阴弦，即胸痹而痛，所以然者，责其极虚也。今阳虚知在上焦，所以胸痹、心痛者，以其阴弦故也。（《胸痹心痛短气病脉证治第九》第1条）

【提要】

从脉象论述胸痹、心痛的病因病机。

【词解】

① 太过不及：脉象盛于正常为太过，主邪实；脉象不足于正常为不及，主正虚。

② 阳微阴弦：阳微，指关前之寸脉微；阴弦，指关后之尺脉弦。

29 胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数，栝蒌薤白白酒汤主之。（《胸痹心痛短气病脉证治第九》第3条）

【提要】

论胸痹病的典型证候和治疗。

【词解】

① 小紧：脉体细小紧急。

② 白酒：米酒初熟者称为白酒。

【方药】

栝蒌薤白白酒汤方：

栝蒌实一枚(捣)，薤白半斤，白酒七升。右三味，同煮，取二升，分温再服。

30 胸痹不得卧，心痛彻背者，栝蒌薤白半夏汤主之。（《胸痹心痛短气病脉证治第九》第4条）

【提要】

论痰饮壅盛胸痹的证治。

【词解】

心痛彻背：《说文解字》“彻，通也”；《广韵》“彻，达也”。心痛彻痛，即心痛放射至后背，牵引背脊亦痛。

【方药】

栝蒌薤白半夏汤方：

栝蒌实一枚，薤白三两，半夏半斤，白酒一斗。右四味，同煮，取四升，温服一升，日三服。

31 胸痹心中痞，留气结在胸，胸满，胁下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之。人参汤亦主之。（《胸痹心痛短气病脉证治第九》第5条）

【提要】

论胸痹气结在胸，偏虚、偏实的证治。

【词解】

心中痞：指心胸或胃院部有痞塞不通感。

【句解】

① 留气结在胸：此言“心中痞”的病机，是胸中寒饮羁留，阻滞气机，留结成痞。

② 胁下逆抢心：胁下气逆上冲心胸。抢(qiāng)，撞、冲。

【方药】

枳实薤白桂枝汤方：

枳实四枚，厚朴四两，薤白半斤，桂枝一两，栝蒌实一枚(捣)。右五味，以水五升，先煮枳实、厚朴，取二升，去滓，内诸药，煮数沸，分温三服。

人参汤方：

人参、甘草、干姜、白术各三两。右四味，以水八升，煮取三升，温服一升，日三服。

32 胸痹缓急者，薏苡附子散主之。(《胸痹心痛短气病脉证治第九》第7条)

【提要】

论胸痹寒湿急证的证治。

【词解】

缓急：偏义复词，其义偏在“急”字，在古文中常用来表述情势急迫、困危之意。

【方药】

薏苡附子散方：

薏苡仁十五两，大附子十枚(炮)。右二味，杵为散，服方寸匕，日三服。

33 心痛彻背，背痛彻心，乌头赤石脂丸主之。(《胸痹心痛短气病脉证治第九》第9条)

【提要】

论阴寒痼结心痛的证治。

【方药】

乌头赤石脂丸方：

蜀椒一两，乌头一分(炮)，附子半两(炮)，干姜一两，赤石脂一两。右五味，末之，蜜丸如梧子大，先食服一丸，日三服。

34 病腹满，发热十日，脉浮而数，饮食如故，厚朴七物汤主之。(《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第9条)

【提要】

论里实腹满兼表寒的证治。

【方药】

厚朴七物汤方：

厚朴半斤，甘草三两，大黄三两，大枣十枚，枳实五枚，桂枝二两，生姜五两。右七味，以水一斗，煮取四升，温服八合，日三服。

35 腹中寒气，雷鸣切痛，胸胁逆满，呕吐，附子粳米汤主之。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第10条）

【提要】

论虚寒饮逆腹满痛的证治。

【词解】

雷鸣切痛：形容肠鸣严重如同雷鸣、腹痛剧烈如刀切之状。

【方药】

附子粳米汤方：

附子一枚(炮)，半夏半升，甘草一两，大枣十枚，粳米半升。右五味，以水八升，煮米熟，汤成，去滓，温服一升，三日服。

36 痛而闭者，厚朴三物汤主之。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第11条）

【提要】

论里实腹满，胀重于积的证治。

【词解】

闭：大便闭结不通。

【方药】

厚朴三物汤方：

厚朴八两，大黄四两，枳实五枚。右三味，以水一斗二升，先煮二味，取五升，内大黄，煮取三升，温服一升，以利为度。

37 心胸中大寒痛，呕不能饮食，腹中寒，上冲皮起，出见有头足，上下痛而不可触近，大建中汤主之。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第14条）

【提要】

论虚寒性腹满痛的证治。

【句解】

上冲皮起，出见有头足：是形容腹中寒气攻冲，腹皮突起如头足样的块状物上下冲动。

【方药】

大建中汤方：

蜀椒二合(去汗)，干姜四两，人参二两。右三味，以水四升，煮取二升，去滓，内胶饴一升，微火煎取一升半，分温再服；如一炊顷，可饮粥二升，后更服，当一日食糜，温覆之。

38 胁下偏痛，发热，其脉紧弦，此寒也，以温药下之，宜大黄附子汤。(《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第15条)

【提要】

论寒实内结腹满痛的证治。

【方药】

大黄附子汤方：

大黄三两，附子三枚(炮)，细辛二两。右三味，以水五升，煮取二升，分温三服若强人煮取二升半，分温三服，服后如人行四五里，进一服。

39 寒疝腹中痛，及胁痛里急者，当归生姜羊肉汤主之。(《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第18条)

【提要】

论血虚寒疝的证治。

【词解】

寒疝：由寒邪凝滞引起腹中拘急疼痛为主要症状的病症。

【方药】

当归生姜羊肉汤方：

当归三两，生姜五两，羊肉一斤。右三味，以水八升，煮取三升，温服七合，日三服。

40 肝着，其人常欲蹈其胸上，先未苦时，但欲饮热，旋覆花汤主之。(《五脏风寒积聚病脉证并治第十一》第7条)

【提要】

论肝着病的证治。

【词解】

① 肝着：肝经气血郁滞，留着而不畅行的病证。着(zhuó)：留滞附着。

② 蹈其胸上：蹈，原为足踏之意，蹈其胸上，可理解为用手推揉按压或捶打胸部。

【方药】

旋覆花汤方：

旋覆花三两，葱十四茎，新绛少许。右三味，以水三升，煮取一升，顿服之。

41 肾着之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，饮食如故，病属下焦，身劳汗出，衣一作表里冷湿，久久得之。腰以下冷痛，腹重如带五千钱，甘姜苓术汤主之。（《五脏风寒积聚病脉证并治第十一》第16条）

【提要】

论肾着病的成因和证治。

【词解】

肾着：寒湿痹着于腰部的病证，因腰为肾之外府，故名肾着。

【方药】

甘草干姜茯苓白术汤方：

甘草二两，白术二两，干姜四两，茯苓四两。右四味，以水五升，煮取三升，分温三服，腰中即温。

42 问曰：四饮何以为异？师曰：其人素盛今瘦，水走肠间，沥沥有声，谓之痰饮。饮后水流在胁下，咳唾引痛，谓之悬饮。饮水流行，归于四肢，当汗出而不汗出，身体疼重，谓之溢饮；咳逆倚息，短气不得卧，其形如肿，谓之支饮。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第2条）

【提要】

论饮病分类及主症。

【词解】

① 痰饮：饮停肠胃的病症。

② 悬饮：饮积胁下，妨碍肝肺气机升降，咳唾引胸胁疼痛的病证。

③ 溢饮：饮流四肢肌肤，阻碍肺气宣发，当汗出而不汗出，身体疼痛沉重的病证。

④ 支饮：饮聚胸膈，致肺失宣降，心阳阻遏，出现咳喘倚息，短气不能平卧，外形如肿的病证。

43 病痰饮者，当以温药和之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》

第15条）

**【提要】**

论痰饮病的治则。

**【词解】**

和之：调和、调理。一是用温药不可过于刚燥，二是遣温药勿专于温补，应根据病情，恰当配合行、消、开、导、清等药。

44 心下有痰饮，胸胁支满，目眩，苓桂术甘汤主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第16条）

**【提要】**

论脾阳虚，饮停心下的证治。

**【方药】**

苓桂术甘汤方：

茯苓四两，桂枝三两，白术三两，甘草二两。右四味，以水六升，煮取三升，分温三服，小便则利。

45 病者脉伏，其人欲自利，利反快，虽利，心下续坚满，此为留饮欲去故也，甘遂半夏汤主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第18条）

**【提要】**

论留饮邪实欲去的证治。

**【词解】**

脉伏：饮留日久且深，阻遏阳气，妨碍血行，故脉伏。

**【方药】**

甘遂半夏汤方：

甘遂（大者）三枚，半夏十二枚（以水一升，煮取半升，去滓），芍药五枚，甘草如指大一枚（炙）。右四味，以水二升，煮取半升，去滓，以蜜半升和药汁，煎取八合，顿服之。

46 病悬饮者，十枣汤主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第22条）

**【提要】**

论悬饮邪实证的治疗。

**【方药】**

十枣汤方：

芫花(熬)、甘遂、大戟各等分。右三味，捣筛，以水一升五合，先煮肥大枣十枚，取九合，去滓，内药末，强人服一钱匕，羸人服半钱，平旦温服之；不下者，明日更加半钱。得快下后，糜粥自养。

47 病溢饮者，当发其汗，大青龙汤主之；小青龙汤亦主之。(《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第23条)

【提要】

论溢饮的治法与主方。

【方药】

① 大青龙汤方：

麻黄六两(去节)，桂枝二两(去皮)，甘草二两(炙)，杏仁四十个(去皮尖)，生姜三两(切)，大枣十二枚，石膏如鸡子大(碎)。右七味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，取微似汗，汗多者，温粉粉之。

② 小青龙汤方：

麻黄三两(去节)，芍药三两，五味子半升，干姜三两，甘草三两(炙)，细辛三两，桂枝三两(去皮)，半夏半升(洗)。右八味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

48 膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其脉沉紧，得之数十日，医吐下之不愈，木防己汤主之。虚者即愈，实者三日复发。复与不愈者，宜木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤主之。(《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第24条)

【提要】

论支饮喘满痞坚的证治。

【词解】

① 心下痞坚：胃脘部位有痞塞坚实感。

② 黧黑：面色黑而晦黄。黧(lí)，黑中带黄的颜色。

③ 虚者：心下痞坚变虚软。

④ 实者：心下痞坚结实如故。

【方药】

① 木防己汤方：

木防己三两，石膏十二枚(鸡子大)，桂枝二两，人参四两。右四味，以水六升，煮取二升，分温再服。

② 木防己去石膏加茯苓芒硝汤方：

木防己二两，桂枝二两，人参四两，芒硝三合，茯苓四两。右五味，以水六升，煮取二升，去滓，内芒硝，再微煎，分温再服，微利则愈。

49 心下有支饮，其人苦冒眩，泽泻汤主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第25条）

【提要】

论水饮冒眩的证治。

【词解】

冒眩：《金匮要略心典》："冒是昏冒而神不清，如有物冒蔽之也。眩者，目眩转而乍见玄黑也"。

【方药】

泽泻汤方：

泽泻五两，白术二两。右二味，以水二升，煮取一升，分温再服。

50 支饮胸满者，厚朴大黄汤主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第26条）

【提要】

论支饮胸满兼腑实的证治。

【方药】

厚朴大黄汤方：

厚朴一尺，大黄六两，枳实四枚。右三味，以水五升，煮取二升，分温再服。

51 腹满，口舌干燥，此肠间有水气，己椒苈黄丸主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第29条）

【提要】

论肠间饮结成实的证治。

【方药】

己椒苈黄丸方：

防己、椒目、葶苈(熬)、大黄各一两。右四味，末之，蜜丸如梧子大，先食饮服一丸，日三服，稍增，口中有津液。

52 男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗，肾气丸主之。（《消渴小便不利淋病脉证并治第十三》第3条）

【提要】

论肾气亏虚的消渴证治。

【词解】

消渴：有两种含义，一为消渴证，是指口渴引饮，无多食多尿之症。一指消渴病，以口渴多饮、多食易饥、小便频多，久则形体消瘦为主要特征。

【方药】

肾气丸方：

干地黄八两，薯蓣四两，山茱萸四两，泽泻三两，茯苓三两，牡丹皮三两，桂枝一两，附子(炮)一两。右八味末之，炼蜜和丸，梧子大，酒下十五丸，加至二十五丸，日再服。

53 小便不利者，有水气，其人若渴，栝蒌瞿麦丸主之。(《消渴小便不利淋病脉证并治第十三》第10条)

【提要】

论上燥下寒水停小便不利的证治。

【词解】

若渴："若"《医统正脉》本作"苦"，宜从。

【方药】

栝蒌瞿麦丸方：

栝蒌根二两，茯苓三两，薯蓣三两，附子一枚(炮)，瞿麦一两。右五味，末之，炼蜜丸梧子大，饮服三丸，日三服，不知，增至七八丸，以小便利，腹中温为知。

54 小便不利，蒲灰散主之；滑石白鱼散、茯苓戎盐汤并主之。(《消渴小便不利淋病脉证并治第十三》第11条)

【提要】

论小便不利的三种治法。

【方药】

① 蒲灰散方：

蒲灰七分，滑石三分。右二味，杵为散，饮服方寸匕，日三服。

② 滑石白鱼散方：

滑石二分，乱发二分(烧)，白鱼二分。右三味，杵为散，饮服方寸匕，日三服。

③ 茯苓戎盐汤方：

茯苓半斤，白术二两，戎盐弹丸大一枚。

55 渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。（《消渴小便不利淋病脉证并治第十三》第12条）

【提要】

论肺胃热盛、津气两伤的消渴证治。

【方药】

白虎加人参汤方：

知母六两，石膏一斤(碎)，甘草二两，粳米六合，人参三两。右五味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

56 师曰：病有风水，有皮水，有正水，有石水，有黄汗。风水，其脉自浮，外证骨节疼痛，恶风；皮水，其脉亦浮，外证附肿，按之没指，不恶风，其腹如鼓，不渴，当发其汗。正水，其脉沉迟，外证自喘；石水，其脉自沉，外证腹满不喘。黄汗，其脉沉迟，身发热，胸满，四肢头面肿，久不愈，必致痈脓。（《水气病脉证并治第十四》第1条）

【提要】

论风水、皮水、正水、石水、黄汗的主要脉证。

【词解】

① 风水：指由于外邪袭表，肺气不宣，通调失职，水气泛溢肌肤而致，以脉浮，恶风，骨节疼痛，头面肿及一身悉肿为主要临床表现的水肿病。

② 皮水：指因脾失健运，肺失通调，水气停留于皮肤之中，以脉浮，不恶风，四肢、身体浮肿，按之没指，其腹如故为主要临床表现的水肿病。

③ 正水：指由于脾肾阳虚，水气失于温化，聚而成肿，以脉沉迟，腹满而喘为主要临床表现的水肿病。

④ 石水：指因肝肾阳衰，阴寒水气凝结下焦而致，以脉自沉，腹满坚硬，不喘为主要临床表现的水肿病。

⑤ 黄汗：指因水湿外侵，浸淫肌腠，导致营郁卫阻，湿热蕴蒸所致，以汗出色黄沾衣，四肢头面肿，发热，胸中烦闷，脉沉迟为主要特征的一种病证。

⑥ 附肿：肌肤浮肿。《素问·水热穴论》："上下溢于皮肤，故曰附肿。附肿者，聚水而生病也"。附(fū)，通"肤"。

⑦ 其腹如鼓：《诸病源候论》作"其腹如故而不满"。

57 里水者，一身面目黄肿，其脉沉，小便不利，故令病水。假如小便自利，此亡津液，故令渴也。越婢加术汤主之。（《水气病脉证并治第十四》第5条）

【提要】

论皮水夹热的脉证及治疗。

【词解】

里水：此应作“皮水”理解。

【方药】

越婢加术汤方：

麻黄六两，石膏半斤，生姜三两，甘草二两，白术四两，大枣十五枚。右六味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。

58 师曰：诸有水者，腰以下肿，当利小便；腰以上肿，当发汗乃愈。（《水气病脉证并治第十四》第18条）

【提要】

论水气病发汗和利小便的治疗方法。

59 风水，脉浮身重，汗出恶风者，防己黄芪汤主之。腹痛者加芍药。（《水气病脉证并治第十四》第22条）

【提要】

论风水表虚的证治。

【方药】

防己黄芪汤方：

防己一两，黄芪一两一分，白术三分，甘草半两(炙)。右锉，每服五钱匕，生姜四片，枣一枚，水盏半，煎取八分，去滓，渴服，良久再服。

60 风水恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热，越婢汤主之。（《水气病脉证并治第十四》第23条）

【提要】

论风水夹热的证治。

【词解】

不渴：《金匮要略心典》作“而渴”，宜从之。

【方药】

越婢汤方：

麻黄六两，石膏半斤，生姜三两，大枣十五枚，甘草二两。右五味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。

61 皮水为病，四肢肿，水气在皮肤中，四肢聂聂动者，防己茯苓汤主之。（《水气病脉证并治第十四》第24条）

【提要】

论皮水气虚阳郁的证治。

【词解】

聂聂动：形容其动轻微，多为自觉症状。聂（zhé，哲），树叶动貌。

【方药】

防己茯苓汤方：

防己三两，黄芪三两，桂枝三两，茯苓六两，甘草二两。右五味，以水六升，煮取二升，分温三服。

62 里水，越婢加术汤主之；甘草麻黄汤亦主之。（《水气病脉证并治第十四》第25条）

【提要】

论皮水表实证的治疗。

【词解】

里水：此即皮水之意。

【方药】

甘草麻黄汤方：

甘草二两，麻黄四两。右二味，以水五升，先煮麻黄，去上沫，内甘草，煮取三升，温服一升，重覆汗出，不汗，再服，慎风寒。

63 水之为病，其脉沉小，属少阴；浮者为风，无水虚胀者，为气。水，发其汗即已。脉沉者，宜麻黄附子汤；浮者，宜杏子汤。（《水气病脉证并治第十四》第26条）

【提要】

论风水与正水证治，以及水气病和虚胀的鉴别。

【方药】

麻黄附子汤方：

麻黄三两，甘草二两，附子一枚（炮）。右三味，以水七升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取二升半，温服八分，日三服。

64 阴阳相得，其气乃行，大气一转，其气乃散。（《水气病脉证并治第十四》第30条16字）

【提要】

论气分病的治疗大法。

【词解】

① 阴阳相得：营卫二气相互协调。

② 大气：此指胸中之宗气。

65 寸口脉浮而缓，浮则为风，缓则为痹。痹非中风，四肢苦烦，脾色必黄，瘀热以行。（《黄疸病脉证并治第十五》第1条）

【提要】

总论湿热黄疸的病机。

66 谷疸之为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄，为谷疸，茵陈蒿汤主之。（《黄疸病脉证并治第十五》第13条）

【提要】

论谷疸证治。

【词解】

① 谷疸：是由外感邪毒，内伤饮食，脾胃运化失常，湿邪无从外泄，或从热化，或从寒化，久久发黄的一类黄疸。

② 寒热不食：湿热蕴积脾胃，导致营卫生化之源壅滞而形寒发热，但此“寒热”与外感表证之寒热不同。湿热困阻脾胃，运化失司，则不能饮食。

【方药】

茵陈蒿汤方：

茵陈蒿六两，栀子十四枚，大黄二两。右三味，以水一斗，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓，分温三服。

67 酒黄疸，心中懊侬，或热痛，栀子大黄汤主之。（《黄疸病脉证并治第十五》第15条）

【提要】

论酒疸证治。

【词解】

① 酒黄疸：因饮酒过度，湿热内蕴于中焦所致的一种黄疸。

② 懊侬：郁闷不舒，烦郁难堪。

【方药】

栀子大黄汤方：

栀子十四枚，大黄一两，枳实五枚，豆豉一升。右四味，以水六升，煮取二升，分温三服。

68 诸病黄家，但利其小便。假令脉浮，当以汗解之，宜桂枝加黄芪汤主之。（《黄疸病脉证并治第十五》第16条）

【提要】

论黄疸的基本治则及黄疸兼表虚证的证治。

【方药】

桂枝加黄芪汤方：

桂枝三两，芍药三两，甘草二两，生姜三两，大枣十二枚，黄芪二两。右六味，以水八升，煮取三升，温服一升，须臾饮热稀粥一升余，以助药力，温服取微汗；若不汗，更取。

69 黄疸腹满，小便不利而赤，自汗出，此为表和里实，当下之，宜大黄硝石汤。（《黄疸病脉证并治第十五》第19条）

【提要】

论热盛里实黄疸的证治。

【词解】

表和里实：表和无病，里热成实。

【方药】

大黄硝石汤方：

大黄、黄柏、硝石各四两，栀子十五枚。右四味，以水六升，煮取二升，去滓，内硝，更煮取一升，顿服。

70 病人胸满，唇痿舌青，口燥，但欲漱水不欲咽，无寒热，脉微大来迟，腹不满，其人言我满，为有瘀血。（《惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六》第10条）

【提要】

论瘀血的脉证。

【词解】

① 唇痿：口唇色萎不泽。

② 脉微大来迟：脉体虽大，但脉势不足，往来涩滞迟缓，为瘀血阻滞之象。

③ 我满：患者自觉腹满。

71 心下悸者，半夏麻黄丸主之。（《惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六》第13条）

【提要】

论水饮致悸的治法。

【方药】

半夏麻黄丸方：

半夏、麻黄等分。右二味，末之，炼蜜和丸小豆大，饮服三丸，日三服。

72 吐血不止者，柏叶汤主之。（《惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六》第14条）

【提要】

论虚寒吐血的治法。

【方药】

柏叶汤方：

柏叶、干姜各三两，艾三把。右三味，以水五升，取马通汁一升，合煮取一升，分温再服。

73 下血，先便后血，此远血也，黄土汤主之。下血，先血后便，此近血也，赤小豆当归散主之。（《惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六》第15条、16条）

【提要】

论远血、近血的治法。

【词解】

① 远血：大便在先，出血在后，说明血来自直肠以上的部位，故称为远血。

② 近血：血在前，便在后，说明血来自直肠附近，其血色多鲜红。

【方药】

① 黄土汤方：

甘草、干地黄、白术、附子(炮)、阿胶、黄芩各三两，灶中黄土半斤。右七味，以水八升，煮取三升，分温二服。

② 赤小豆当归散方：

赤小豆三升(浸，令芽出，曝干)，当归三两。右二味，杵为散，浆水服方寸匕，日三服。

74 心气不足，吐血、衄血，泻心汤主之。（《惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六》第17条）

【提要】

论热盛吐衄的证治。

【词解】

不足：当从《千金》改作“不定”为是，即心烦不安之意。

【方药】

泻心汤方：

大黄二两，黄连一两，黄芩一两。右三味，以水三升，煮取一升，顿服之。

75 朝食暮吐，暮食朝吐，宿谷不化，名曰胃反。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第5条16字）

【提要】

论虚寒胃反的证候。

【词解】

胃反：本篇有两处出现“胃反”一词，其概念不同。一指虚寒胃反，是因脾胃虚寒，腐熟运化失职，胃气上逆，津伤肠燥所引起的一种病证，以朝食暮吐，暮食朝吐，宿谷不化为主症，尚可见心下痞硬，神疲乏力，形体消瘦，大便燥结如羊屎状等症。二指反复呕吐的现象。

76 诸呕吐，谷不得下者，小半夏汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第12条）

【提要】

论寒饮停胃呕吐的证治。

【方药】

小半夏汤方：

半夏一升，生姜半斤。右二味，以水七升，煮取一升半，分温再服。

77 胃反呕吐者，大半夏汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第16条）

【提要】

论虚寒胃反的证治。

【方药】

大半夏汤方：

半夏二升，人参三两，白蜜一升。右三味，以水一斗二升，和蜜扬之二百四十遍，煮取二升半，温服一升，余分再服。

78 食已即吐者，大黄甘草汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第17条）

【提要】

论胃肠实热呕吐的证治。

【方药】

大黄甘草汤方：

大黄四两，甘草一两。右二味，以水三升，煮取一升，分温再服。

79 干呕，吐逆，吐涎沫，半夏干姜散主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第20条）

【提要】

论脾胃阳虚，寒饮内盛呕吐的证治。

【方药】

半夏干姜散方：

半夏，干姜各等分。右二味，杵为散，取方寸匕，浆水一升半，煎取七合，顿服之。

80 病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，彻心中愦愦然无奈者，生姜半夏汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第21条）

【提要】

论寒饮搏结于胸胃的证治。

【句解】

彻心中愦愦然无奈：指胸胃中懊侬不宁，心烦意乱，痛苦无可名状，使人有无可奈何之感。彻，通；愦，《大宋重修广韵》："愦，心乱也"。

【方药】

生姜半夏汤方：

半夏半升，生姜汁一升。右二味，以水三升，煮半夏，取二升，内生姜汁，煮取一升半，小冷，分四服，日三夜一服。止，停后服。

81 肠痈之为病，其身甲错，腹皮急，按之濡，如肿状，腹无积聚，身无热，脉数，此为肠内有痈脓，薏苡附子败酱散主之。（《疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八》第3条）

【提要】

论肠痈脓已成的证治。

【词解】

① 其身甲错：身体皮肤粗糙，似如鳞甲。

② 按之濡：指腹部按之柔软。

【方药】

薏苡附子败酱散方：

薏苡仁六十分，附子二分，败酱五分。右三味，杵末，取方寸匕，以水二升，煎减半，顿服。

82 肠痈者，少腹肿痞，按之即痛如淋，小便自调，时时发热，自汗出，复恶寒。其脉迟紧者，脓未成，可下之，当有血。脉洪数者，脓已成，不可下也。大黄牡丹汤主之。（《疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八》第4条）

【提要】

论肠痈脓未成的证治。

【词解】

肿痞：有形之痈肿痞塞于肠中，患者自觉少腹痞塞不通。

【句解】

① 按之即痛如淋：按压少腹患病处，如有患淋病那样的牵引至前阴的刺痛感觉。

② 大黄牡丹汤主之：根据原文精神，“大黄牡丹汤主之”一句，应当紧接在“脓未成，可下之”之后，方宜。仲景倒置此句，意在正反对举，强调鉴别诊断，属于倒装文法。

【方药】

大黄牡丹汤方：

大黄四两，牡丹一两，桃仁五十个，瓜子半升，芒硝三合。右五味，以水六升，煮取一升，去滓，内芒硝，再煎沸，顿服之，有脓当下；如无脓，当下血。

83 妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月，衄也。所以血不止者，其癥不去故也。当下其癥，桂枝茯苓丸主之。（《妇人妊娠病脉证并治第二十》第2条）

【提要】

论癥病的证治，及其与妊娠的鉴别。

【词解】

① 癥病：病名，指腹内有瘀阻积块的疾病。

② 衃(pēi)：一般指色紫而黯的瘀血，又作癥痼的互辞。

【方药】

桂枝茯苓丸方：

桂枝、茯苓、牡丹(去心)、桃仁(去皮尖，熬)、芍药各等分。右五味末之，炼蜜和丸，如兔屎大，每日食前服一丸。不知，加至三丸。

84 师曰：妇人有漏下者，有半产后因续下血都不绝者，有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛，为胞阻，胶艾汤主之。(《妇人妊娠病脉证并治第二十》第4条)

【提要】

论冲任虚寒所致妇人三种下血的证治。

【词解】

① 漏下：妇女不在行经时间，阴道流血，量不多，淋漓不止，称为漏下或经漏。

② 半产：未足月而流产者，三个月以前为小产，三个月以后为半产。

③ 胞阻：以妊娠期间下血腹痛为主症。“胞”言其病位，“阻”概其病机，凡冲任亏损，阴血下漏，不能入胞养胎而出现的妊娠下血、腹痛称为胞阻或胞漏。

【方药】

胶艾汤方：

芎劳二两，阿胶二两，甘草二两，艾叶三两，当归三两，芍药四两，干地黄六两。右七味，以水五升，清酒三升，合煮取三升，去滓，内胶，令消尽，温服一升，日三服。不差，更作。

85 妇人怀妊，腹中疗痛，当归芍药散主之。(《妇人妊娠病脉证并治第二十》第5条)

【提要】

论妊娠肝脾不和腹痛的证治。

【词解】

疗痛：疗，读“绞”(jiǎo)或“鸠”时，指腹中急痛；读“朽”时，指绵绵作痛，本条即腹中拘急，绵绵作痛。

【方药】

当归芍药散方：

当归三两，芍药一斤，茯苓四两，白术四两，泽泻半斤，芎劳半斤。右六味，杵为散，取方寸匕，酒和，日三服。

86 妊娠呕吐不止，干姜人参半夏丸主之。（《妇人妊娠病脉证并治第二十》第6条）

【提要】

论脾胃虚弱，寒饮上逆恶阻重证的治疗。

【方药】

干姜人参半夏丸方：

干姜一两，人参一两，半夏二两。右三味，末之，以生姜汁糊为丸，如梧子大，饮服十九，日三服。

87 妊娠小便难，饮食如故，当归贝母苦参丸主之。（《妇人妊娠病脉证并治第二十》第7条）

【提要】

论妊娠血虚热郁的小便不利证治。

【方药】

当归贝母苦参丸方：

当归，贝母，苦参各四两。右三味，末之，炼蜜丸如小豆大，饮服三丸，加至十丸。

88 产后腹痛，烦满不得卧，枳实芍药散主之。（《妇人产后病脉证治第二十一》第5条）

【提要】

论气血郁滞的产后腹痛证治。

【方药】

枳实芍药散方：

枳实（烧令黑，勿太过），芍药等分。右二味，杵为散，服方寸匕，日三服，并主痈脓，以麦粥下之。

89 师曰：产妇腹痛，法当以枳实芍药散，假令不愈者，此为腹中有干血着脐下，宜下瘀血汤主之。亦主经水不利。（《妇人产后病脉证治第二十一》第6条）

【提要】

论瘀血内结的产后腹痛证治。

【方药】

下瘀血汤方：

大黄二两，桃仁二十枚，蠐虫二十枚(熬，去足)。右三味，末之，炼蜜和为四丸，以酒一升，煎一丸，取八合，顿服之。

**90** 妇人乳中虚，烦乱呕逆，安中益气，竹皮大丸主之。(《妇人产后病脉证治第二十一》第10条)

**【提要】**

论产后中虚内热，胃失和降的证治。

**【词解】**

① 乳中虚：指新产后哺乳期间，阴血耗伤，中焦虚乏。

② 烦乱呕逆：心烦呕吐严重之意。

**【方药】**

竹皮大丸方：

生竹茹二分，石膏二分，桂枝一分，甘草七分，白薇一分。右五味，末之，枣肉和丸弹子大，以饮服一丸，日三夜二服。

**91** 妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之。(《妇人杂病脉证并治第二十二》第5条)

**【提要】**

论气郁痰凝梅核气的证治。

**【词解】**

炙脔：肉切成块名脔，炙脔即烤肉块。

**【方药】**

半夏厚朴汤方：

半夏一升，厚朴三两，茯苓四两，生姜五两，干苏叶二两。右五味，以水七升，煮取四升，分温四服，日三夜一服。

**92** 妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如神灵所作，数欠伸，甘麦大枣汤主之。(《妇人杂病脉证并治第二十二》第6条)

**【提要】**

论脏躁的证治。

**【词解】**

① 脏躁：主要表现为精神失常，症如“喜悲伤欲哭”，以哭笑无常，喜怒不节，语言不能自主，频作伸欠，神疲乏力等为主症。

② 数欠伸：频频打呵欠，伸懒腰。

【方药】

甘草小麦大枣汤方：

甘草三两，小麦一斤，大枣十枚。右三味，以水六升，煮取三升，温分三服。

93 妇人之病，因虚、积冷、结气，为诸经水断绝，至有历年，血寒积结，胞门寒伤，经络凝坚。（《妇人杂病脉证并治第二十二》第8条第1段）

【提要】

论妇人杂病的病因病机。

【词解】

① 积冷：寒冷久积，多因阳气虚衰，温煦功能减弱，寒邪凝结不散所致。

② 结气：气机郁结，多由情志刺激所致。

③ 胞门：子宫。

94 问曰：妇人年五十所，病下利数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹满，手掌烦热，唇口干燥，何也？师曰：此病属带下。何以故？曾经半产，瘀血在少腹不去。何以知之？其证唇口干燥，故知之，当以温经汤主之。（《妇人杂病脉证并治第二十二》第9条）

【提要】

论妇人冲任虚寒夹有瘀血而致崩漏的证治。

【词解】

下利：多数注家认为当是“下血”。

【方药】

温经汤方：

吴茱萸三两，当归二两，芎䓖二两，芍药二两，人参二两，桂枝二两，阿胶二两，生姜二两，牡丹皮二两（去心），甘草二两，半夏半斤，麦门冬一升（去心）。右十二味，以水一斗，煮取三升，分温三服。

95 妇人少腹满如敦状，小便微难而不渴，生后者，此为水与血并结在血室也，大黄甘遂汤主之。（《妇人杂病脉证并治第二十二》第13条）

【提要】

论妇人水血并结血室的证治。

【词解】

① 敦(duì)：古代盛食物的器具，上下稍锐，中部肥大。

② 生后：即产后。

【方药】

大黄甘遂汤方：

大黄四两，甘遂二两，阿胶二两。右三味，以水三升，煮取一升，顿服之，其血当下。

# 二级条文(50条)

1 夫人禀五常,因风气而生长,风气虽能生万物,亦能害万物,如水能浮舟,亦能覆舟。若五脏元真通畅,人即安和。客气邪风,中人多死。千般疢难,不越三条:一者,经络受邪,入脏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刃、虫兽所伤。以此详之,病由都尽。(《脏腑经络先后病脉证第一》第2条)

【提要】

论杂病发病观、病因与发病途径。

【词解】

① 人禀五常:禀,受的意思。五常,即五行。

② 风气:此指自然气候。

③ 元真:元气或真气。

④ 客气邪风:外至曰客,不正曰邪,指能够令人致病的不正常的气候。

⑤ 疢(chèn)难:疾病。

2 清邪居上,浊邪居下。大邪中表,小邪中里。槩饪之邪,从口入者,宿食也。五邪中人,各有法度,风中于前,寒中于暮,湿伤于下,雾伤于上,风令脉浮,寒令脉急,雾伤皮腠,湿流关节,食伤脾胃,极寒伤经,极热伤络。(《脏腑经络先后病脉证第一》第13条第2段)

【提要】

论五邪中人的特征。

【词解】

① 清邪:雾露之邪。

② 浊邪:水湿之邪。

③ 大邪:风邪。

④ 小邪:寒邪。

⑤ 槩饪之邪:即宿食。

3 问曰：病有急当救里、救表者，何谓也？师曰：病，医下之，续得下利清谷不止，身体疼痛者，急当救里；后身体疼痛，清便自调者，急当救表也。（《脏腑经络先后病脉证第一》第14条）

【提要】

论表里同病时的先后缓急治则。

4 师曰：五脏病各有所得者愈，五脏病各有所恶，各随其所不喜者为病。病者素不应食，而反暴思之，必发热也。（《脏腑经络先后病脉证第一》第16条）

【提要】

临床应根据五脏喜恶进行治疗和护理。

【词解】

① 所得：适合患者的饮食居处。

② 所恶：患者所厌恶的饮食居处。

5 太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉，栝蒌桂枝汤主之。（《痉湿暍病脉证治第二》第11条）

【提要】

论柔痉的证治。

【词解】

几几然：项背强急，俯仰不能自如的样子。几（shū），鸟之短羽。几几，小鸟伸颈欲飞貌。

【方药】

栝蒌桂枝汤方：

栝蒌根二两，桂枝三两，芍药三两，甘草二两，生姜三两，大枣十二枚。右六味，以水九升，煮取三升，分温三服，取微汗。汗不出，食顷，啜热粥发之。

6 太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。（《痉湿暍病脉证治第二》第12条）

【提要】

论欲作刚痉的证治。

【方药】

葛根汤方：

葛根四两，麻黄三两（去节），桂枝二两（去皮），芍药二两，甘草二两（炙），生姜三两，

大枣十二枚。右七味，㕮咀，以水七升，先煮麻黄、葛根，减二升，去沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝汤法将息及禁忌。

7 太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细一作缓者，此名湿痹。湿痹之候，小便不利，大便反快，但当利其小便。（《痉湿暍病脉证治第二》第14条）

【提要】

论湿痹的证候及治法。

【词解】

① 烦：引申为剧烈之意，形容关节疼痛的程度。

② 湿痹：即湿病。痹，《说文解字》“湿病也”。

8 湿家之为病，一身尽疼，发热，身色如熏黄也。（《痉湿暍病脉证治第二》第15条）

【提要】

论湿病发黄的证候。

【词解】

① 湿家：患湿病的人。

② 熏黄：黄而晦暗，犹如烟熏之状。

9 风湿相搏，一身尽疼痛，法当汗出而解，值天阴雨不止，医云此可发汗。汗之，病不愈者，何也？盖发其汗，汗大出者，但风气去，湿气在，是故不愈也。若治风湿者，发其汗，但微微似欲出汗者，风湿俱去也。（《痉湿暍病脉证治第二》第18条）

【提要】

论风湿在表使用汗法的要求——微汗。

10 伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕，不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。若大便坚，小便自利者，去桂加白术汤主之。（《痉湿暍病脉证治第二》第23条）

【提要】

论风湿表阳虚的证治。

【方药】

① 桂枝附子汤方：

桂枝四两(去皮)，生姜三两(切)，附子三枚(炮去皮，破八片)，甘草二两(炙)，大枣十二枚(擘)。右五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

② 白术附子汤方：

白术二两，附子一枚半(炮去皮)，甘草一两(炙)，生姜一两半(切)，大枣六枚。右五味，以水三升，煮取一升，去滓，分温三服。一服觉身痹，半日许再服，三服都尽。

11 风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。(《痉湿暍病脉证治第二》第24条)

【提要】

论风湿表里阳气俱虚的证治。

【方药】

甘草附子汤方：

甘草二两(炙)，白术二两，附子二枚(炮击皮)，桂枝四两(去皮)。右四味，以水六升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服，初服得微汗则解。能食，汗出复烦者，服五合。恐一升多者，取六七合为妙。

12 蚀于下部则咽干，苦参汤洗之。蚀于肛者，雄黄熏之。(《百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》第11条、12条)

【提要】

论狐惑病蚀于前阴、后阴的治法。

【方药】

苦参汤方：

苦参一升，以水一斗，煎取七升，去滓，熏洗，日三服。

雄黄熏方：

雄黄。右一味为末，筒瓦二枚合之，烧，向肛熏之。

13 病者脉数，无热微烦，默默但欲卧，汗出。初得之三四日，目赤如鸠眼，七八日，目四眦一本有黄字黑。若能食者，脓已成也，赤豆当归散主之。(《百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》第13条)

【提要】

论狐惑病酿脓的证治。

【词解】

① 无热：无寒热，是无表证的互词。

② 鸠眼：鸠，斑鸠，其目珠色赤。此处以之喻患者之目色。

③ 四眦：两眼内外眦。眦(zì)，眼角。

**【方药】**

赤豆当归散方：

赤小豆三升(浸，令芽出，曝干)，当归三两。右二味，杵为散，浆水服方寸匕，日三服。

14 寸口脉沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即为肾，弱即为肝。汗出入水中，如水伤心，历节黄汗出，故曰历节。(《中风历节病脉证并治第五》第4条)

**【提要】**

论肝肾不足，寒湿内侵所致历节的病机。

**【词解】**

① 如水伤心：心主血脉。如水伤心，犹言水湿伤及血脉。

② 黄汗：此指历节病的并发症状，即关节痛处溢出黄汗，与黄汗病全身汗出色黄不同。

15 问曰：血痹病从何得之？师曰：夫尊荣人，骨弱肌肤盛，重困疲劳汗出，卧不时动摇，加被微风，遂得之。但以脉自微涩，在寸口、关上小紧，宜针引阳气，令脉和紧去则愈。(《血痹虚劳病脉证并治第六》第1条)

**【提要】**

论血痹病因病机及轻证的治法。

**【词解】**

尊荣人：养尊处优、好逸恶劳之人。

16 虚劳里急，诸不足，黄芪建中汤主之。(《血痹虚劳病脉证并治第六》第14条)

**【提要】**

上承小建中汤条，论虚劳阴阳两虚腹痛的证治。

**【方药】**

黄芪建中汤：于小建中汤内加黄芪一两半，余依上法。

17 问曰：热在上焦者，因咳为肺痿。肺痿之病，何从得之？师曰：或从汗出，或从呕吐，或从消渴，小便利数，或从便难，又被快药下

利，重亡津液，故得之。曰：寸口脉数，其人咳，口中反有浊唾涎沫者何？师曰：为肺痿之病。若口中辟辟燥，咳即胸中隐隐痛，脉反滑数，此为肺痈，咳唾脓血。脉数虚者为肺痿；数实者为肺痈。（《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》第1条）

**【提要】**

论肺痿病的成因，及其与肺痈的鉴别诊断。

**【词解】**

① 肺痿：因肺气痿弱不振所致，以多唾浊沫、短气为主症的一类疾病，有虚热和虚寒之分。

② 快药：作用峻猛的攻下药。

③ 浊唾涎沫：浊唾指稠痰，涎沫指稀痰。

④ 辟辟燥：形容口中干燥状。

18 咳逆上气，时时唾浊，但坐不得眠，皂荚丸主之。（《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》第7条）

**【提要】**

论痰浊壅肺的咳喘证治。

**【方药】**

皂荚丸方：

皂荚八两（刮去皮，用酥炙）。右一味，末之，蜜丸梧子大，以枣膏和汤，取三丸，日三夜一服。

19 咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之。脉沉者，泽漆汤主之。（《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》第8条、第9条）

**【提要】**

论寒饮夹热上迫于肺的咳嗽上气证治。

**【方药】**

① 厚朴麻黄汤方：

厚朴五两，麻黄四两，石膏如鸡子大，杏仁半升，半夏半升，干姜二两，细辛二两，小麦一升，五味子半升。右九味，以水一斗二升，先煮小麦熟，去滓，内诸药，煮取三升，温服一升，日三服。

② 泽漆汤方：

半夏半升，紫参五两，泽漆三斤（以东流水五斗，煮取一斗五升），生姜五两，白前五两，甘草、黄芩、人参、桂枝各三两。右九味，㕮咀，内泽漆汁中，煮取五升，温服五合，至

夜尽。

20 咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者，为肺痈，桔梗汤主之。（《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七》第12条）

【提要】

论肺痈成脓的证治。

【词解】

浊唾腥臭：吐出脓痰，气味腥臭。

【方药】

桔梗汤方：

桔梗一两，甘草二两。右二味，以水三升，煮取一升，分温再服，则吐脓血也。

21 胸痹，胸中气塞，短气，茯苓杏仁甘草汤主之；橘枳姜汤亦主之。（《胸痹心痛短气病脉证治第九》第6条）

【提要】

论胸痹饮阻气滞轻证的不同证治。

【方药】

① 茯苓杏仁甘草汤方：

茯苓三两，杏仁五十个，甘草一两。右三味，以水一斗，煮取五升，温服一升，日三服（不差，更服）。

② 橘枳姜汤方：

橘皮一斤，枳实三两，生姜半斤。右三味，以水五升，煮取二升，分温再服。

22 心中痞，诸逆，心悬痛，桂枝生姜枳实汤主之。（《胸痹心痛短气病脉证治第九》第8条）

【提要】

论寒饮气逆致心痛的证治。

【词解】

① 诸逆：停留于胃脘的寒邪、痰饮向上冲逆。

② 心悬痛：形容从心窝部位向上牵引疼痛感。

【方药】

桂枝生姜枳实汤方：

桂枝三两，生姜三两，枳实五枚。右三味，以水六升，煮取三升，分温三服。

23 趺阳脉微弦，法当腹满，不满者必便难，两胠疼痛，此虚寒从下上也，当以温药服之。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第1条）

【提要】

论虚寒性腹满的病因、辨证与治法。

【词解】

胠(qū)：胸胁两旁当臂之处。《广雅》："胁也"；《素问》王冰注："胠，谓胁上也"。

24 病者腹满，按之不痛为虚，痛者为实，可下之。舌黄未下者，下之黄自去。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第2条）

【提要】

论腹满虚实的辨证和实证腹满的治则。

25 腹满时减，复如故，此为寒，当与温药。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第3条）

【提要】

论虚寒性腹满的辨证与治则。

26 寒气厥逆，赤丸主之。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第16条）

【提要】

论寒饮上逆腹痛的证治。

【词解】

厥逆：此处有两层含义：一指寒饮上逆的病机，一指手足逆冷的症状。

【方药】

赤丸方：

茯苓四两，乌头二两(炮)，半夏四两(洗)，细辛一两。右四味，末之，内真朱为色，炼蜜丸如麻子大，先食酒饮下三丸，日再，夜一服，不知，稍增之，以知为度。

27 腹痛，脉弦而紧，弦则卫气不行，即恶寒，紧则不欲食，邪正相搏，即为寒疝。绕脐痛，若发则白汗出，手足厥冷，其脉沉弦者，大乌头煎主之。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第17条）

【提要】

论寒疝的病机和证治。

【词解】

寒疝：寒邪凝滞，引起腹中拘急疼痛为主要症状的病症。

【方药】

大乌头煎方：

乌头大者五枚。右以水三升，煮取一升，去滓，内蜜二升，煎令水气尽，取二升，强人服七合，弱人服五合。不差，明日更服，不可一日再服。

28 寒疝腹中痛，逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺诸药不能治，抵当乌头桂枝汤主之。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第19条）

【提要】

论寒疝兼有表证的证治。

【方药】

乌头桂枝汤方：

乌头。右一味，以蜜二斤，煎减半，去滓，以桂枝汤五合解之，得一升后，初服二合，不知，即取三合；又不知，复加至五合。其知者，如醉状，得吐者，为中病。

29 夫心下有留饮，其人背寒冷如手大。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第8条）

【提要】

论狭义痰饮久留不去的证候。

【词解】

留饮：水饮久留不去者。

30 留饮者，胁下痛引缺盆，咳嗽则辄已。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第9条）

【提要】

论悬饮久留不去的证候。

31 夫病人饮水多，必暴喘满；凡食少饮多，水停心下，甚者则悸，微者短气。脉双弦者，寒也，皆大下后善虚；脉偏弦者，饮也。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第12条）

【提要】

论痰饮病的成因和脉症。

【词解】

① 双弦：一谓左右两手之脉俱弦；二谓“有一手两条脉，亦曰双弦，此乃元气不壮之人，往往多见此脉，亦属虚”（徐彬《金匮要略论注》）。

② 偏弦：或左或右之一手脉弦。

32 夫短气，有微饮，当从小便去之，苓桂术甘汤主之；肾气丸亦主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第17条）

【提要】

论阳虚微饮的证治。

33 呕家本渴，渴者为欲解。今反不渴，心下有支饮故也，小半夏汤主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第28条）

【提要】

论心下饮逆致呕的预后及治疗。

34 假令瘦人，脐下有悸，吐涎沫而癫眩，此水也，五苓散主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第31条）

【提要】

论下焦饮逆致悸吐眩的证治。

【方药】

五苓散方：

泽泻一两一分，猪苓三分（去皮），茯苓三分，白术三分，桂枝二分（去皮）。右五味，为末，白饮服方寸匕，日三服，多饮暖水，汗出愈。

35 问曰：病有血分、水分，何也？师曰：经水前断，后病水，名曰血分，此病难治；先病水，后经水断，名曰水分，此病易治。何以故？去水，其经自下。（《水气病脉证并治第十四》第20条）

【提要】

论病水血分与水分的区别，并将其预后加以比较。

【词解】

① 血分：先有经闭而后水肿者。

② 水分：先有水肿而后经闭者。

36 问曰：黄汗之为病，身体肿，发热汗出而渴，状如风水，汗沾

衣，色正黄如柏汁，脉自沉，何从得之？师曰：以汗出入水中浴，水从汗孔入得之，宜芪芍桂酒汤主之。（《水气病脉证并治第十四》第28条）

**【提要】**

论黄汗的病机与证治。

**【词解】**

黄汗：因水湿浸淫肌腠，湿郁化热，湿热熏蒸，营卫失调所致，以汗出色黄沾衣为主症。

**【方药】**

黄芪芍桂苦酒汤方：

黄芪五两，芍药三两，桂枝三两。右三味，以苦酒一升，水七升，相和，煮取三升，温服一升，当心烦，服至六七日乃解。若心烦不止者，以苦酒阻故也。

37 气分，心下坚，大如盘，边如旋杯，水饮所作，桂枝去芍药加麻辛附子汤主之。（《水气病脉证并治第十四》第31条）

**【提要】**

论气分病阳虚阴凝的证治。

**【词解】**

旋杯：即复杯，为水饮凝聚心下的病症，中高边低，按之外坚内软，故曰复杯。

**【方药】**

桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤方：

桂枝三两，生姜三两，甘草二两，大枣十二枚，麻黄二两，细辛二两，附子一枚(炮)。右七味，以水七升，煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取二升，分温三服，当汗出，如虫行皮中，即愈。

38 心下坚，大如盘，边如旋盘，水饮所作，枳术汤主之。（《水气病脉证并治第十四》第32条）

**【提要】**

论气分病脾虚气滞的证治。

**【方药】**

枳术汤方：

枳实七枚，白术二两。右二味，以水五升，煮取三升，分温三服，腹中软，即当散也。

39 黄家日晡所发热，而反恶寒，此为女劳得之。膀胱急，少腹满，身尽黄，额上黑，足下热，因作黑疸。其腹胀如水状，大便必黑，时溏，此女劳之病，非水也。腹满者难治。硝石矾石散主之。（《黄疸病脉证并治第十五》第14条）

【提要】

论女劳疸兼瘀血证治。

黑疸：是黄疸病误治或久治不愈，以致湿热夹瘀，出现目青面黑，大便正黑，皮肤不仁的病症。

【方药】

硝石矾石散方：

硝石，矾石(烧)等分。右二味，为散，以大麦粥汁和服方寸匕，日三服。病随大小便去，小便正黄，大便正黑，是候也。

40 干呕，吐涎沫，头痛者，茱萸汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第9条）

【提要】

论肝胃虚寒，寒饮上逆的呕吐证治。

【方药】

茱萸汤方：

吴茱萸一升，人参三两，生姜六两，大枣十二枚。右四味，以水五升，煮取三升，温服七合，日三服。

41 呕而肠鸣，心下痞者，半夏泻心汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第10条）

【提要】

论寒热错杂的呕吐证治。

【方药】

半夏泻心汤方：

半夏半升(洗)，黄芩三两，干姜三两，人参三两，黄连一两，大枣十二枚，甘草三两(炙)。右七味，以水一斗，煮取六升，去滓再煮，取三升，温服一升，日三服。

42 下利气者，当利其小便。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第31条）

【提要】

论气滞湿困下利气的治法。

【词解】

下利气：泄泻与矢气并见，因气随利出，频频不已，故称气利。

43 气利，诃梨勒散主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第47条）

【提要】

论虚寒性肠滑气利的证治。

【方药】

诃梨勒散方：

诃梨勒十枚(煨)。上一味，为散，粥饮和，顿服。（疑非仲景方。）

44 师曰：诸痈肿，欲知有脓无脓，以手掩肿上，热者为有脓，不热者为无脓。（《疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八》第2条）

【提要】

辨别痈肿有脓无脓的一种方法。

45 阴狐疝气者，偏有小大，时时上下，蜘蛛散主之。（《趺蹶手指臂肿转筋阴狐疝蚘虫病脉证治第十九》第4条）

【提要】

论阴狐疝气的证治。

【词解】

阴狐疝气：简称狐疝，是一种阴囊偏大偏小，时上时下的病症。

【方药】

蜘蛛散方：

蜘蛛十四枚(熬焦)，桂枝半两。右二味，为散，取八分一匕，饮和服，日再服。蜜丸亦可。

46 师曰：妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠，桂枝汤主之。（《妇人妊娠病脉证并治第二十》第1条前半段）

【提要】

论妊娠的诊断及恶阻轻证的调治。

【词解】

① 平脉：脉象平和如常人，无太过不及之象。

② 阴脉小弱：阴脉指尺部脉，小弱是细软无力的脉象。

47 妊娠有水气，身重，小便不利，洒淅恶寒，起即头眩，葵子茯苓散主之。（《妇人妊娠病脉证并治第二十》第8条）

【提要】

论妊娠水气的证治。

【方药】

葵子茯苓散方：

葵子一斤，茯苓三两。右二味，杵为散，饮服方寸匕，日三服，小便利则愈。

48 产后腹中疠痛，当归生姜羊肉汤主之，并治腹中寒疝，虚劳不足。（《妇人产后病脉证治第二十一》第4条）

【提要】

论产后血虚里寒的腹痛证治，也体现了当归生姜羊肉汤的异病同治。

49 产后风，续之数十日不解，头微痛，恶寒，时时有热，心下闷，干呕汗出，虽久，阳旦证续在耳，可与阳旦汤（即桂枝汤，方见下利中）。（《妇人产后病脉证治第二十一》第8条）

【提要】

论产后中风营卫不和的证治。

50 妇人中风，七八日续来寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。（《妇人杂病脉证并治第二十二》第1条）

【提要】

论热入血室的证治。

【词解】

血室：狭义指子宫；广义血室包括肝、冲任二脉、子宫。

【方药】

小柴胡汤方：

柴胡半斤，黄芩三两，人参三两，甘草三两，半夏半斤，生姜三两，大枣十二枚。右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓再煎，取三升，温服一升，日三服。

# 三级条文(65条)

1 问曰：病人有气色见于面部，愿闻其说。师曰：鼻头色青，腹中痛，苦冷者死。鼻头色微黑者，有水气。色黄者，胸上有寒。色白者，亡血也。设微赤，非时者，死。其目正圆者，痉，不治。又，色青为痛，色黑为劳，色赤为风，色黄者便难，色鲜明者有留饮。(《脏腑经络先后病脉证第一》第3条)

【提要】

面部望诊在临床的应用举例。

2 师曰：病人语声寂然，喜惊呼者，骨节间病；语声喑喑然不彻者，心膈间病；语声啾啾然细而长者，头中病。(《脏腑经络先后病脉证第一》第4条)

【提要】

闻诊在临床的应用举例。

【词解】

① 语声寂然：安静无声。

② 喑喑然：声音低微而不清。

③ 啾啾然：声音细小而长。

3 师曰：息摇肩者，心中坚；息引胸中上气者，咳；息张口短气者，肺痿唾沫。(《脏腑经络先后病脉证第一》第5条)

【提要】

察呼吸、望形态以诊断疾病的方法。

4 师曰：寸口脉动者，因其王时而动。假令肝王色青，四时各随其色。肝色青而反色白，非其时色脉，皆当病。(《脏腑经络先后病脉证第一》第7条)

【提要】

论脉象与四时五色相结合的诊病方法。

【词解】

① 寸口：两手的寸、关、尺三部脉。

② 王：通“旺”。

5 问曰：有未至而至，有至而不至，有至而不去，有至而太过，何谓也？师曰：冬至之后，甲子夜半少阳起，少阳之时阳始生，天得温和。以未得甲子，天因温和，此为未至而至也；以得甲子而天未温和，此为至而不至也；以得甲子而天大寒不解，此为至而不去也；以得甲子而天温如盛夏五六月时，此为至而太过也。（《脏腑经络先后病脉证第一》第8条）

【提要】

气候与节令当相应，太过不及都会引发疾病。

【词解】

① 未至而至：前一“至”字指时令到，后一“至”字指与时令相应的气候到。下同。

② 甲子：是古代用天干、地支配合起来推算年月日的方法。天干十个（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸），地支十二个（子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥），相互配合，始于甲子，终于癸亥，共六十个。“甲子”是其中第一个。此指冬至后六十日第一个甲子夜半，此时正当雨水节。

③ 少阳：此指古代用来代表时令的名称。

6 师曰：病人脉浮者在前，其病在表；浮者在后，其病在里，腰痛背强不能行，必短气而极也。（《脏腑经络先后病脉证第一》第9条）

【提要】

本条提示同一脉象，出现部位不同，主病不同。

7 太阳病，发热无汗，反恶寒者，名曰刚痉。（《痉湿暍病脉证治第二》第1条）

【提要】

论刚痉的证候。

8 太阳病，发热汗出而不恶寒，名曰柔痉。（《痉湿暍病脉证治第二》第2条）

【提要】

论柔痉的证候。

9 夫痉脉，按之紧如弦，直上下行。（《痉湿暍病脉证治第二》第9条）

【提要】

论痉病的主脉。

10 阳毒之为病，面赤斑斑如锦纹，咽喉痛，唾脓血。五日可治，七日不可治，升麻鳖甲汤主之。（《百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》第14条）

【提要】

论阳毒病的证治和预后。

【词解】

① 阳毒：阴阳毒病包括阳毒和阴毒，均与感染疫毒，热毒炽盛有关，以发斑、咽喉痛为主症。疫毒上迫，发斑色赤，咽喉肿痛者，称为阳毒；疫毒侵入营血，瘀血凝滞，内闭不宣，表现为发斑色青，身痛剧烈者，称为阴毒。

② 锦纹：丝织品的花纹，此处形容面部色斑。

【方药】

升麻鳖甲汤方：

升麻二两，当归一两，蜀椒（炒去汗）一两，甘草二两，雄黄半两（研），鳖甲手指大一片（炙）。右六味，以水四升，煮取一升，顿服之，老小再服，取汗。

11 阴毒之为病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛。五日可治，七日不可治，升麻鳖甲汤去雄黄、蜀椒主之。（《百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》第15条）

【提要】

论阴毒病的证治和预后。

【句解】

身痛如被杖：身体如遭棍棒击打一样疼痛。

12 病疟，以月一日发，当以十五日愈。设不差，当月尽解；如其不差，当云何？师曰：此结为癥瘕，名曰疟母，急治之，宜鳖甲煎丸。（《疟病脉证并治第四》第2条）

【提要】

论疟母的形成及其证治。

【词解】

① 癥瘕：腹中有积聚结块的统称，此指胁下有结块。

② 疟母：疟病迁延日久，反复发作，正气渐衰，疟邪假血依痰，结成痞块，居于胁下而形成结块的一类疟病。

【方药】

鳖甲煎丸方：

鳖甲十二分(炙)，乌扇三分(烧)，黄芩三分，柴胡六分，鼠妇三分(熬)，干姜三分，大黄三分，芍药五分，桂枝三分，葶苈一分(熬)，石韦三分(去毛)，厚朴三分，牡丹五分(去心)，瞿麦二分，紫葳三分，半夏一分，人参一分，蠐虫五分(熬)，阿胶三分(炙)，蜂窠四分(炙)，赤硝十二分，蜣螂六分(熬)，桃仁二分。右二十三味，为末，取锻灶下灰一斗，清酒一斛五斗，浸灰，候酒尽一半，着鳖甲于中，煮令泛烂如胶漆，绞取汁，内诸药，煎为丸，如梧子大，空心服七丸，日三服。

13 温疟者，其脉如平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕，白虎加桂枝汤主之。(《疟病脉证并治第四》第4条)

【提要】

论温疟的证治。

【词解】

① 温疟：里热炽盛，又兼表寒的一种疟病。

② 其脉如平：指脉象和平时常见的温疟脉象一样，多见“弦数”。

【方药】

白虎加桂枝汤方：

知母六两，甘草二两(炙)，石膏一斤，粳米二合，桂枝(去皮)三两。右锉，每五钱，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，汗出愈。

14 夫男子平人，脉大为劳，极虚亦为劳。(《血痹虚劳病脉证并治第六》第3条)

【提要】

论虚劳病的脉象总纲。

【词解】

平人：此指外形看似无病，内脏气血已经虚损之人，即《难经》所说“脉病形不病”者。

15 按之心下满痛者，此为实也，当下之，宜大柴胡汤。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第12条）

【提要】

论里实腹满兼少阳的证治。

【方药】

大柴胡汤方：

柴胡半斤，黄芩三两，芍药三两，半夏半升(洗)，枳实四枚(炙)，大黄二两，大枣十二枚，生姜五两。右八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，温服一升，日三服。

16 腹满不减，减不足言，当须下之，宜大承气汤。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第13条）

【提要】

论里实腹满积胀并重的证治。

【方药】

大承气汤方：

大黄四两(酒洗)，厚朴半斤(去皮，炙)，枳实五枚(炙)，芒硝三合。右四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，内大黄，煮取二升，内芒硝，更上火微一二沸，分温再服，得下，余勿服。

17 脉数而滑者，实也，此有宿食，下之愈，宜大承气汤。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第22条）

【提要】

论宿食下利的证治。

18 脉紧如转索无常者，有宿食也。（《腹满寒疝宿食病脉证治第十》第25条）

【提要】

论宿食的脉象。

19 师曰：热在上焦者，因咳为肺痿；热在中焦者，则为坚；热在下焦者，则尿血，亦令淋秘不通。大肠有寒者，多鹜溏；有热者，便肠垢。小肠有寒者，其人下重便血，有热者，必痔。（《五脏风寒积聚病脉证并治第十一》第19条）

【提要】

论热在三焦及大小肠的寒热证。

【词解】

① 淋秘："淋"指小便淋沥涩痛；"秘"指小便癃闭不通。

② 鹜溏：大便水粪杂下，状如鸭粪。鹜，鸭。

20 问曰：病有积，有聚，有槩气，何谓也？师曰：积者，脏病也，终不移；聚者，腑病也，发作有时，辗转痛移，为可治。槩气者，胁下痛，按之则愈，复发为槩气。（《五脏风寒积聚病脉证并治第十一》第20条前段）

【提要】

论积、聚、槩气的区别。

【词解】

槩气：即谷气，指水谷之气停积留滞之病。

21 胸中有留饮，其人短气而渴，四肢历节痛。脉沉者，有留饮。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第10条）

【提要】

论水饮停留在胸中或四肢的脉症。

22 膈上病痰，满喘咳吐，发则寒热，背痛腰疼，目泣自出，其人振振身瞤剧，必有伏饮。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第11条）

【提要】

论膈上伏饮的表现。

【词解】

伏饮：痰饮潜伏胸膈，深痼难除或不易察觉。

23 脉沉而弦者，悬饮内痛。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第21条）

【提要】

论悬饮的脉症。

24 支饮不得息，葶苈大枣泻肺汤主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第27条）

**【提要】**

论支饮壅肺化热的证治。

**【方药】**

葶苈大枣泻肺汤方：

葶苈（熬令黄色，捣丸如弹子大），大枣十二枚。右先以水三升，煮枣取二升，去枣，内葶苈，煮取一升，顿服。

25 卒呕吐，心下痞，膈间有水，眩悸者，小半夏加茯苓汤主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第30条）

**【提要】**

论膈间饮停呕吐兼痞眩悸的证治。

**【方药】**

小半夏加茯苓汤方：

半夏一升，生姜半斤，茯苓三两。右三味，以水七升，煮取一升五合，分温再服。

26 咳逆倚息不得卧，小青龙汤主之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第35条）

**【提要】**

论支饮兼外寒咳逆的证治。

27 青龙汤下已，多唾口燥，寸脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足痹，其面翕热如醉状，因复下流阴股，小便难，时复冒者，与茯苓桂枝五味甘草汤，治其气冲。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第36条）

**【提要】**

从本条至以下五条，以案例形式论述支饮体虚者服小青龙汤后的变证及治疗。此承上条论述服小青龙汤后引发冲气上逆的证治。

**【词解】**

① 面翕热如醉状：面部微红乍热，如酒醉之样。

② 阴股：大腿内侧。

**【方药】**

桂苓五味甘草汤方：

茯苓四两，桂枝四两（去皮），甘草三两（炙），五味子半升。右四味，以水八升，煮

取三升，去滓，分三温服。

28 冲气即低，而反更咳，胸满者，用桂苓五味甘草汤去桂加干姜、细辛，以治其咳满。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第37条）

【提要】

承前条论支饮冲气已平而寒饮复动的证治。

【方药】

苓甘五味姜辛汤方：

茯苓四两，甘草三两，干姜三两，细辛三两，五味子半升。右五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，日三。

29 咳满即止，而更复渴，冲气复发者，以细辛、干姜为热药也。服之当遂渴，而渴反止者，为支饮也。支饮者，法当冒，冒者必呕，呕者复内半夏，以去其水。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第38条）

【提要】

承前条论服苓甘五味姜辛汤的转归及兼冒呕的治疗。

30 水去呕止，其人形肿者，加杏仁主之。其证应内麻黄，以其人遂痹，故不内之。若逆而内之者，必厥，所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第39条）

【提要】

承前条论体虚支饮兼形肿的治疗。

31 若面热如醉，此为胃热上冲熏其面，加大黄以利之。（《痰饮咳嗽病脉证并治第十二》第40条）

【提要】

承前条论支饮兼胃肠实热上冲的证治。

32 厥阴之为病，消渴，气上冲心，心中疼热，饥而不欲食，食即吐，下之不肯止。（《消渴小便不利淋病脉证并治第十三》第1条）

【提要】

论厥阴消渴的证候与治禁。

33 寸口脉浮而迟，浮即为虚，迟即为劳，虚则卫气不足，劳则荣

气竭。趺阳脉浮而数，浮即为气，数即消谷而大坚一作紧。气盛则溲数，溲数即坚，坚数相搏，即为消渴。（《消渴小便不利淋病脉证并治第十三》第2条）

【提要】

论消渴分属虚劳和胃热的病机。

【词解】

大坚：《医宗金鉴》《金匮要略方论本义》等均作“大便坚”。

34 淋之为病，小便如粟状，小腹弦急，痛引脐中。（《消渴小便不利淋病脉证并治第十三》第7条）

【提要】

论淋病的症状。

【词解】

小便如粟状：小便排出粟状之物。

35 夫病水人，目下有卧蚕，面目鲜泽，脉伏，其人消渴。病水腹大，小便不利，其脉沉绝者，有水，可下之。（《水气病脉证并治第十四》第11条）

【提要】

论水气病可用攻下逐水法的适应脉症。

【词解】

脉沉绝：脉沉之甚，有如欲绝之状。

36 心水者，其身重而少气，不得卧，烦而躁，其人阴肿。（《水气病脉证并治第十四》第13条）

【提要】

论心水病症。

【词解】

身重：《千金》作“身肿”。

37 肝水者，其腹大，不能自转侧，胁下腹痛，时时津液微生，小便续通。（《水气病脉证并治第十四》第14条）

【提要】

论肝水病症。

【词解】

① 津液微生：口中时时微微有津液。

② 小便续通：小便时通时不通。

38 肺水者，其身肿，小便难，时时鸭溏。（《水气病脉证并治第十四》第15条）

【提要】

论肺水病症。

39 脾水者，其腹大，四肢苦重，津液不生，但苦少气，小便难。（《水气病脉证并治第十四》第16条）

【提要】

论脾水病症。

40 肾水者，其腹大，脐肿腰痛，不得溺，阴下湿如牛鼻上汗，其足逆冷，面反瘦。（《水气病脉证并治第十四》第17条）

【提要】

论肾水病症。

41 趺阳脉紧而数，数则为热，热则消谷；紧则为寒，食即为满。尺脉浮为伤肾，趺阳脉紧为伤脾。风寒相搏，食谷即眩，谷气不消，胃中苦浊，浊气下流，小便不通，阴被其寒，热流膀胱，身体尽黄，名曰谷疸。额上黑，微汗出，手足中热，薄暮即发，膀胱急，小便自利，名曰女劳疸；腹如水状不治。心中懊侬而热，不能食，时欲吐，名曰酒疸。（《黄疸病脉证并治第十五》第2条）

【提要】

论黄疸的病机、分类及主症。

【词解】

① 苦浊：苦作“病”解，浊指湿热。下“浊气”亦为湿热。

② 谷疸：外感邪毒，内伤饮食，脾胃运化失常，湿邪无从外泄，或从热化，或从寒化，久久发黄的一类黄疸。

③ 女劳疸：房劳过度，耗伤肾阴，兼瘀血湿热内蕴所致的一种黄疸。

④ 酒疸：饮酒过度，湿热内蕴于中焦所致的一种黄疸。

42 酒疸下之，久久为黑疸，目青面黑，心中如啖蒜薤状，大便正黑，皮肤爪之不仁，其脉浮弱，虽黑微黄，故知之。（《黄疸病脉证并治第十五》第7条）

【提要】

论酒疸误下变为黑疸的证候。

【句解】

① 心中如啖蒜薤状：形容胃中灼热不舒。啖（dǎn），同“啖”，吃的意思；薤（jǐ），捣碎的姜蒜、韭菜等。

② 爪之不仁：肌肤麻痹不仁，搔之无痛痒感。

43 诸黄，猪膏发煎主之。（《黄疸病脉证并治第十五》第17条）

【提要】

论胃肠燥结兼瘀血之黄疸的证治。

【方药】

猪膏发煎方：

猪膏半斤，乱发如鸡子大三枚。右二味，和膏中煎之，发消药成，分再服，病从小便出。

44 黄疸病，茵陈五苓散主之。（《黄疸病脉证并治第十五》第18条）

【提要】

论湿重于热的黄疸证治。

【方药】

茵陈五苓散方：

茵陈蒿末十分，五苓散五分。右二物和，先食饮方寸匕，日三服。

45 黄疸病，小便色不变，欲自利，腹满而喘，不可除热，热除必哕。哕者，小半夏汤主之。（《黄疸病脉证并治第十五》第20条）

【提要】

论黄疸误治变哕的证治。

46 诸黄，腹痛而呕者，宜柴胡汤。（《黄疸病脉证并治第十五》第21条）

【提要】

论黄疸兼少阳的证治。

47 男子黄，小便自利，当与虚劳小建中汤。（《黄疸病脉证并治第十五》第22条）

【提要】

论脾胃虚弱萎黄的证治。

48 病者如热状，烦满，口干燥而渴，其脉反无热，此为阴伏，是瘀血也，当下之。（《惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六》第11条）

【提要】

论瘀血化热的脉症和治法。

【词解】

阴伏：患者自觉有热，心烦胸满，口干燥而渴，但诊其脉，并无热象，是因瘀血日久，郁而化热，伏于血分所致，因此热非伏于气分，而在血分，故名阴伏。

49 夫呕家有痈脓，不可治呕，脓尽自愈。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第1条）

【提要】

论胃有痈疡致呕的治疗禁忌。

50 先呕却渴者，此为欲解。先渴却呕者，为水停心下，此属饮家。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第2条前句）

【提要】

论水饮所致呕吐的脉症。

51 病人欲吐者，不可下之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第6条）

【提要】

论欲吐的治禁。

52 干呕哕，若手足厥者，橘皮汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第22条）

【提要】

论胃寒气逆致干呕、哕逆的证治。

【方药】

橘皮汤方：

橘皮四两，生姜半斤。右二味，以水七升，煮取三升，温服一升，下咽即愈。

53 哕逆者，橘皮竹茹汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第23条）

【提要】

论胃虚夹热的哕逆证治。

【方药】

橘皮竹茹汤方：

橘皮二升，竹茹二升，大枣三十枚，生姜半斤，甘草五两，人参一两。右六味，以水一斗，煮取三升，温服一升，日三服。

54 下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第36条）

【提要】

论虚寒下利兼表证的证治。

55 下利便脓血者，桃花汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第42条）

【提要】

论虚寒下利便脓血的证治。

【方药】

桃花汤方：

赤石脂一斤（一半封、一半筛末），干姜一两，粳米一升。右三味，以水七升，煮米令熟，去滓，温服七合，内赤石脂末方寸匕，日三服，若一服愈，余勿服。

56 热利下重者，白头翁汤主之。（《呕吐哕下利病脉证治第十七》第43条）

【提要】

论热利下重的证治。

【方药】

白头翁汤方：

白头翁二两，黄连三两，黄柏三两，秦皮三两。右四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服一升。不愈，更服。

57 蚘厥者，乌梅丸主之。（《趺蹶手指臂肿转筋阴狐疝蚘虫病脉证治第十九》第8条）

【提要】

论蛔厥的证治。

【方药】

乌梅丸方：

乌梅三百枚，细辛六两，干姜十两，黄连一斤，当归四两，附子六两（炮），川椒四两（去汗），桂枝六两，人参六两，黄柏六两。右十味，异捣筛，合治之，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之五升米下，饭熟捣成泥，和药令相得，内臼中，与蜜杵二千下，丸如梧子大，先食饮服十丸，三服，稍加至二十丸。禁生冷滑臭等食。

58 妇人怀娠六七月，脉弦发热，其胎愈胀，腹痛恶寒者，少腹如扇，所以然者，子脏开故也，当以附子汤温其脏。（《妇人妊娠病脉证并治第二十》第3条）

【提要】

论妊娠阳虚寒盛腹痛证治。

【词解】

① 胎愈胀：妊娠后期常常腹胀，称“胎胀”，“其胎愈胀”指腹胀加重之意。

② 少腹如扇：小腹寒冷较甚，如扇冷风入腹之状。

③ 子脏开：徐彬《金匮要略论注》云：“子脏，子宫也。开者，不敛也”。

59 产后中风发热，面正赤，喘而头痛，竹叶汤主之。（《妇人产后病脉证治第二十一》第9条）

【提要】

论产后中风兼阳虚的证治。

【方药】

竹叶汤方：

竹叶一把，葛根三两，防风、桔梗、桂枝、人参、甘草各一两，附子一枚（炮），大枣十五枚，生姜五两。右十味，以水一斗，煮取二升半，分温三服，温覆使汗出。

60 产后下利虚极，白头翁加甘草阿胶汤主之。（《妇人产后病脉证治第二十一》第11条）

【提要】

论产后热痢伤阴的证治。

【方药】

白头翁加甘草阿胶汤方：

白头翁、甘草、阿胶各二两，秦皮、黄连、柏皮各三两。右六味，以水七升，煮取二升半，内胶令消尽，分温三服。

61 妇人经水闭，不利，脏坚癖不止，中有干血，下白物，矾石丸主之。（《妇人杂病脉证并治第二十二》第15条）

【提要】

论瘀血内阻，湿热带下的外治法。

【词解】

① 脏坚癖不止：胞宫内有干血坚结不散。

② 白物：白带。

③ 内脏中：将药物放入阴道中。脏，阴道。

【方药】

矾石丸方：

矾石三分(烧)，杏仁一分。右二味，末之，炼蜜和丸枣核大，内脏中，剧者再内之。

62 妇人六十二种风，及腹中血气刺痛，红蓝花酒主之。（《妇人杂病脉证并治第二十二》第16条）

【提要】

论风血相搏，血凝气滞的腹痛证治。

【句解】

妇人六十二种风：泛指一切风邪。

【方药】

红蓝花酒方(疑非仲景方)：

红蓝花一两，右一味，以酒一大升，煎减半，顿服一半，未止，再取。

63 妇人腹中诸疾痛，当归芍药散主之。（《妇人杂病脉证并治第二十二》第17条）

【提要】

论妇人肝脾不调腹痛的治疗。

64 问曰：妇人病，饮食如故，烦热不得卧而反倚息者，何也？师曰：此名转胞，不得溺也，以胞系了戾，故致此病。但利小便则愈，宜肾气丸主之。（《妇人杂病脉证并治第二十二》第19条）

【提要】

论妇人转胞的证治。

【词解】

① 转胞：病名，以小便不通，脐下急痛为主症。胞（pāo），同“脬”，即膀胱。

② 胞系了戾：膀胱之系缭绕不顺。了，通“缭”；戾，扭曲。

65 胃气下泄，阴吹而正喧，此谷气之实也，膏发煎导之。（《妇人杂病脉证并治第二十二》第22条）

【提要】

论阴吹的成因和证治。

【词解】

① 阴吹：前阴出气，犹如后阴矢气一样。

② 喧：前阴出气频繁，声响连续不断。

# 肆　温病学经典条文

# 一级条文(40条)

1 温邪上受,首先犯肺,逆传心包。肺主气属卫,心主血属营,辨营卫气血虽与伤寒同,若论治法则与伤寒大异也。(《温热论》第1条)

**【提要】**

温病的证治总纲,概括了温病的病因、感邪途径、发病部位、传变趋势及与伤寒的区别。

**【词解】**

① 温邪:温病致病因素的总称。

② 上受:邪从口鼻而上犯于肺。

③ 逆传心包:温邪侵犯肺卫后,可不顺传于阳明气分,直接内陷心包,出现高热、神昏、舌謇、肢厥等症。

**【句解】**

① 温邪上受,首先犯肺,逆传心包:肺居上焦,开窍于鼻,温邪伤人,特别是风温、湿温等外感温病,多从口鼻而入,首犯手太阴肺经而出现肺卫表证。叶氏指出,这种首犯肺卫的温邪有两种传变方式:一是逆传,即本条所言"逆传心包",直陷心营而出现高热、神昏、舌謇、肢厥等症;二是顺传,即从肺卫内传入阳明气分。值得注意的是,此处"顺传"只是相对于"逆传"病情较轻而已,二者均是邪气深入,病情进展的标志。

② 辨营卫气血虽与伤寒同,若论治法则与伤寒大异也:指出了温病与伤寒初起的异同。营卫气血是维持人体生命活动的精微物质,无论伤寒或温病,其病邪传变皆由表入里,由浅入深,均可伤及营卫气血,故有共同之处。但伤寒与温病毕竟是两类性质不同的外感病,寒温有别,侵犯部位各异,病证性质更是大不相同,因而在初期治疗上有很大区别。

**【拓展】**

风温初起多属邪在肺卫,治疗以辛凉解表为主,方如银翘散、桑菊饮等;后期多肺胃阴伤,当滋养肺胃,方如沙参麦冬汤等。伤寒则是先犯太阳,治疗以辛温解表为主,方如麻黄汤、桂枝汤等。由于寒邪易伤阳气,后期多用温补太阴或少阴之法,方如理中汤、四逆汤等。

2 盖伤寒之邪留恋在表，然后化热入里。温邪则热变最速，未传心包，邪尚在肺，肺主气，其合皮毛，故云在表。在表初用辛凉轻剂，挟风则加入薄荷、牛蒡之属，挟湿加芦根、滑石之流。或透风于热外，或渗湿于热下，不与热相搏，势必孤也。（《温热论》第2条）

【提要】

论述伤寒与温病传变的区别，并提出温病初起邪在肺卫及挟风挟湿的治法。

【词解】

辛凉轻剂：用轻清宣透之品，以疏散肺卫温邪之剂，如《温病条辨》中的银翘散、桑菊饮之类。

【句解】

① 伤寒之邪留恋在表，然后化热入里：寒属阴邪，收引凝滞。邪犯太阳，正邪交争于表，症见恶寒无汗，头项强痛等症。若治之不及时，或治之不力，持续一定时间后，邪传入里，寒郁化热，出现里热之证。

② 温邪则热变最速：温热邪气，其性属热，初起即呈表热证，如风温、湿温等。首犯手太阴肺，热变迅速，可出现明显的肺经热盛证候。

③ 在表初用辛凉轻剂：肺为清虚之脏，外合皮毛。温邪犯肺，卫受邪郁，故应用辛凉轻剂，透散表邪，凉解邪热。又温为阳邪，易伤津液，故禁用辛温表散之法，否则化热伤津，有痉厥之变。也不可早用苦寒遏伏表邪，反使邪不能解。

【拓展】

外感温病，除须分析温邪的病变部位、邪热轻重外，还须辨别温邪兼夹，对症用药。临床常以银翘散、桑菊饮为主方加减治疗。温病早期，若出现恶风寒、流涕、喷嚏、咽喉发痒等风邪兼挟症状时，常用荆芥、薄荷、牛蒡子、蝉蜕等辛凉散风；若出现头目昏重，午后热盛，苔腻脉濡等湿邪兼挟症状时，既可用芦根、滑石利湿透热，也可选用杏仁、白蔻仁、橘皮、桔梗等轻苦微辛之品宣通气滞，芳香逐秽。

3 不尔，风挟温热而燥生，清窍必干，谓水主之气不能上荣，两阳相劫也。湿与温合，蒸郁而蒙蔽于上，清窍为之壅塞，浊邪害清也。其病有类伤寒，其验之之法，伤寒多有变证，温热虽久，在一经不移，以此为辨。（《温热论》第3条）

【提要】

论温邪未传心包，邪尚在肺失治误治的两种病。

【词解】

① 清窍：此指眼、耳、口、鼻等头面部诸窍。

② 水主之气：此泛指人体的津液。

③ 浊邪害清：湿与热合谓之“浊邪”。湿热蒙蔽于上，阻遏清阳，清窍为之壅塞，可出现耳聋、鼻塞等症状。

**【句解】**

① 两阳相劫：风为阳邪，其性开泄，易袭阳位；温邪亦为阳邪，其性炎热，易伤津液。风挟温热，两阳相合，风火交炽，津液受劫，清窍失养，称为“两阳相劫”，除肺卫表证之外，还可见口鼻干燥、咽干等症。

② 湿与温合：温邪夹湿，湿热相搏，蒸灼上焦，蒙蔽清阳，清窍壅塞，可见头目昏重，耳聋，闭塞，甚至昏谵等“浊邪害清”症状。

③ 伤寒多有变证，温热虽久，在一经不移：湿属阴邪，温邪夹湿，蒙蔽清阳，初起某些症候类似伤寒，但湿邪氤氲黏滞，转化较慢，虽有较长病程，但变化不明显，故叶氏谓“温热虽久，在一经不移”。而伤寒初起，正邪交争于表，后可化热入里，其病邪传变之途径，始自太阳，或传阳明，或传少阳，或传入三阴，在其传变过程中，证候性质也相随发生变化，即所谓“伤寒多有变证”。

**【拓展】**

风热袭表，误用辛温而致肺津耗伤，可见发热、干咳、口干、鼻干等症，故当在辛凉散风之剂中佐以甘润，如银翘散中酌加麦冬、沙参等味；若将湿热郁表误用辛温发汗，易致湿热蒸腾上逆而蒙蔽清阳，成为浊邪害清之证，症见恶寒发热、鼻塞、头重、身困等，当予芳香化湿宣窍为首要，可选用藿香、佩兰、石菖蒲、苦杏仁等，若湿热蒙蔽心包，出现神志昏蒙，当予化湿开窍，可用藿朴夏苓汤加细辛、石菖蒲、郁金等味。

4　前言辛凉散风，甘淡驱湿，若病仍不解，是渐欲入营也。营分受热，则血液受劫，心神不安，夜甚无寐，或斑点隐隐，即撤去气药。如从风热陷入者，用犀角、竹叶之属；如从湿热陷入者，犀角、花露之品，参入凉血清热方中。若加烦躁，大便不通，金汁亦可加入，老年或平素有寒者，以人中黄代之，急急透斑为要。（《温热论》第4条）

**【提要】**

论温邪传入营分的证治。

**【词解】**

花露：菊花露、金银花露等。

**【句解】**

① 营分受热：心主血属营，邪热传入营分，心神受扰而见心神不安，夜甚无寐，血络受损，则现斑点隐隐，营阴受灼，则身热夜甚，舌绛，脉细数等症。

② 急急透斑为要：斑的治疗大法是“宜清化，勿宜提透”，斑出密布是热邪深入血分、热毒深重的标志，因而在治疗斑时，并不需要使斑大量地透发。叶氏此言“透斑”，实际上是指透达热毒，使斑能顺利外透，邪热不致壅结于里之意，与营分证的“透热转气”治疗意图是一致的。临床对于里热壅结，斑疹不易外透者，可加入大黄等通下之品，里气宣通，斑疹反易外透，此亦寓透斑之意，这是叶氏对营分证治法的补充，主要适用于血分证发斑者的治疗，切不能把“透斑”理解为辛散提透。如汪曰桢注解此条时，就特别强调若以胡荽、浮萍等为透法是错误的。因误用辛散提透，必导致热毒愈炽，津气愈耗而变化丛生。

**【拓展】**

邪入营分，病情危重，临床观察应注意三点：一是神志状态，如出现烦躁、意识模糊，甚至有时出现谵语，即为热扰心神。凡心神受扰，皆属病情严重，应予高度重视。若辨证为心营热盛，宜及时清心开窍，如牛黄、黄连、水牛角、天竺黄、石菖蒲、郁金等宜及时使用，或直接予安宫牛黄丸；二是皮肤斑疹，要仔细诊查胸腹部、四肢、颜面的斑疹情况，即使斑点隐隐可见，亦可视为邪热入于营（血），应把握时机，急急凉血解毒，如大青叶、水牛角、紫草、赤芍、丹皮等可随证加入；三是注意灵活看待舌象。叶天士说：“邪热入营，舌色必绛”。此是言其常，临床中常因前期治疗的不同，邪气兼夹的差别，舌象往往有异，此时就需要四诊合参，不可固执。

5 若斑出热不解者，胃津亡也，主以甘寒，重则如玉女煎，轻则如梨皮、蔗浆之类。或其人肾水素亏，虽未及下焦，先自彷徨矣，必验之于舌，如甘寒之中加入咸寒，务在先安未受邪之地，恐其陷入易易耳。（《温热论》第5条）

**【提要】**

论斑出热不解的病机和治法。

**【词解】**

① 彷徨：犹豫不决，去向难以决定。此处指邪热有可能传入下焦而尚未传入下焦之时。

② 先安未受邪之地：指在治疗已病脏腑的同时，按其将传变的趋势，扶助未病脏腑正气，以防病邪陷入。

**【句解】**

温病发斑为阳明热毒，内迫营血。若斑出而邪热不解，为胃津消灼，水不济火所致，治疗当用甘寒之剂清热生津。若肾水素亏，邪热易于乘虚传入下焦，其治疗非单纯甘寒可救，可于甘寒中加入咸寒之品兼滋肾阴，以杜邪热深入。

【拓展】

临床凡见斑块或出血点，均为病情严重的表现，需要小心，提高警惕。斑出热不解，多为必然；斑出热解，也许为偶然。另，斑出热不解，不仅责之胃阴亡或肾水枯竭，其营分热毒炽盛也是不可忽视的因素，临床上要审其证而明其机制，辨证用药，方可不脱离实际。

6　若其邪始终在气分流连者，可冀其战汗透邪，法宜益胃，令邪与汗并，热达腠开，邪从汗出。解后胃气空虚，当肤冷一昼夜，待气还自温暖如常矣。（《温热论》第6条）

【提要】

论邪气流连气分的治法。

【词解】

① 战汗：邪气流连气分，邪正相搏，正气奋起鼓邪外出，而出现战栗、高热、全身汗出的表现。

② 益胃：以轻清之品，清气生津，宣展气机，并灌溉汤液，以振奋正气，使邪气随汗外透。

③ 邪与汗并：温邪入侵，阳气奋起抗邪，蒸腾汗液，使气机宣透，腠理开泄，邪气随汗而从皮肤外泄。

【句解】

温邪由卫分进入气分，既不外解，又不深传营分，始终在气分停留，说明邪正力量相当而相持。若此时正气奋起鼓邪外出，则可出现战汗。促进战汗发生的治法在于“益胃”，即清气生津，宣展气机，并灌溉汤液，使气机宣通，腠理开泄，热达汗出，邪随汗解。

战汗后体温骤然下降，甚至可降到常温以下，出现肌肤厥冷，这是因为邪解过程中，胃气受损，阳气随汗出外泄，暂失温煦之职，待阳气恢复，体温自然恢复正常。

【拓展】

对于“益胃”，王孟英注云：“益胃者，在疏瀹其气机，灌溉汤水，俾邪气松达与汗偕行”。可见此处的“益胃”不是补益胃气，而是指清气生津，宣展气机之品，具体用药如陈光淞云：“如《温病条辨》中之雪梨浆、五汁饮、桂枝白虎等方，均可采用；热盛者食西瓜，战时饮米汤、白水，所谓令水与汗并，热达腠开，得通泄也”。可供临床参考。另，还可从广义方面进行理解，即包括益胃之气阴和祛胃家有余之实邪（包括无形邪热与有形热结），祛邪可起到间接益胃的作用。

7 盖战汗而解，邪退正虚，阳从汗泄，故渐肤冷，未必即成脱证。此时宜令病者，安舒静卧，以养阳气来复，旁人切勿惊惶，频频呼唤，扰其元神，使其烦躁。（《温热论》第6条）

【提要】

论战汗后的临床护理。

【句解】

战汗后，邪退正虚，阳气随汗外泄，肢体暂失温煦之能，故肌肤稍凉，这与冷汗淋漓的脱证不同。此时宜让患者静卧温覆，以生养阳气，并禁止对患者频频呼唤及翻动躯体等，以免使其烦躁，损耗元气。

【拓展】

战汗之症，当与亡阴、亡阳、气脱之大汗症相鉴别。例如，亡阳证之大汗，常见冷汗淋漓，同时伴见手足厥冷，目合口开，手撒尿遗，脉微细欲绝等症，是由阳气暴脱，阴阳离绝所致。温病战汗多发生在高热持续阶段，症见大汗淋漓，提示正邪剧烈抗争，是疾病即将出现转归的标志。因此，临床凡见战汗之症，必须密切关注病情变化。

8 但诊其脉，若虚软和缓，虽倦卧不语，汗出肤冷，却非脱证；若脉急疾，躁扰不卧，肤冷汗出，便为气脱之证矣。（《温热论》第6条）

【提要】

判断战汗预后的方法。

【词解】

脉急疾：指脉来急速，成人至数在一息七八至以上，且伴随有脉躁动之象。

【句解】

出现战汗症状，判断病势的要诀在于对脉象和神态的考察。若脉象虚软和缓，热退身凉，提示邪气退却，预后良好。神态倦卧不语，是正气暂虚之象。若出现脉细而急疾，躁扰不能安卧，是正不胜邪，邪炽乖张，阴津将亡，气无所附的征兆。

9 更有邪盛正虚，不能一战而解，停一二日再战汗而愈者，不可不知。（《温热论》第6条）

【提要】

论“不能一战而解”之战汗。

【句解】

若邪气过于盛实，正气虽可抗邪，正邪抗争常不能一决而已。此时，不能战

汗一次即脉静，身凉，热退而病解，多有停一二日再发战汗而病情缓解。

**【拓展】**

战汗不能一战而解，病势可见两端：一是停一二日再发战汗而病愈。其处理，是战汗前仍须“益胃”，方如前法，此不复赘；二是正气耗伤，津液亡却，病情转恶。对此，章虚谷作了补充：“或汗已出而身仍热，其脉急疾而烦躁者，此正不胜邪，即《黄帝内经》所云阴阳交，交者死也”。

10　再论气病有不传血分，而邪留三焦，亦如伤寒中少阳病也。彼则和解表里之半，此则分消上下之势，随证变法，如近时杏、朴、苓等类，或如温胆汤之走泄。因其仍在气分，犹可望其战汗之门户，转疟之机括。（《温热论》第7条）

**【提要】**

论邪留三焦的治疗及转归。

**【词解】**

① 三焦：此指手少阳三焦，为六腑之一。

② 门户：此指出路。

**【句解】**

气分温邪久稽，既不外解，又不深传血分，而留滞于三焦。三焦属少阳，司气机升降出入及水道通行，若邪留三焦，使气机郁滞，水道失于通调，易酿生痰湿，症多见腹胁满闷，小便不利等。

三焦气郁水停，以“消”法为主治，治疗当着眼于宣展气机，消散气滞，以利水通行，常可以苦杏仁开上焦，厚朴疏中焦，茯苓利下焦，或温胆汤宣气化湿，三焦同治，或令邪与汗并，则战汗邪解，或转成疟状而解。

**【拓展】**

痰湿留滞少阳三焦，枢机不利，多见寒热起伏不退，腹胁胀满，小便不利，舌苔厚浊等。治疗除了以杏、朴、苓或温胆汤宣展气机，泄化痰湿外，还应加入柴胡、青蒿、黄芩、绿茶、竹茹等少阳经药，以领邪外出而使邪解。临床上不可拘泥柴胡竭肝阴而畏用，其解热作用明显，与青蒿同用，其解热透邪之力尤为佳。

11　大凡看法，卫之后方言气，营之后方言血。在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气，如犀角、玄参、羚羊角等物，入血就恐耗血动血，直须凉血散血，如生地、丹皮、阿胶、赤芍等物。否则前后不循缓急之法，虑其动手便错，反致慌张矣。（《温热论》第8条）

【提要】

论温病的辨治纲领。

【词解】

① 汗之：指用辛凉清解之品使汗徐出，非辛温发汗。章虚谷谓："辛凉开肺，便是汗剂"。

② 透热转气：指邪热入营，治宜清营热、滋营阴，佐以轻清透邪之品，使营分热邪透转到气分而解的治疗方法。

【句解】

温邪初起病在肺卫，病情轻浅；继而入里传至气分，病情较重；深入营分，病情更重；最后陷入血分，则病情最重，病位最深。提示了一般温病病情由卫及气，至营入血的病机传变规律。

温病治疗大法：一、温邪侵犯卫分，出现表证，治宜透汗解表，令邪随汗解；二、温邪由卫分入气，治宜清气泄热；三、温邪入营，未见动血耗血之际，可冀透热外达气分而解，其方法是在凉营养阴的基础上，伍以透泄之品，令邪转气分，此即"透热转气"，药如犀角、玄参、羚羊角、连翘、金银花、竹叶等；四、温邪深入营血，叶天士提出凉血化瘀养阴的治疗原则，药如生地黄、牡丹皮、阿胶、赤芍等物。

12 且吾吴湿邪害人最广，如面色白者，须要顾其阳气，湿胜则阳微也，法应清凉，然到十分之六七，即不可过于寒凉，恐成功反弃，何以故耶？湿热一去，阳亦衰微也。（《温热论》第9条）

【提要】

论阳虚体质感受湿邪的治疗原则及注意事项。

【词解】

吴：地名，江苏吴县，即现在的苏州一带。

【句解】

苏州一带气候潮湿，湿为阴邪，易伤阳气，故易见阳虚体质而患湿热病者。治疗阳虚湿热之证，用药不可过于寒凉，需用清凉之法，并须固护阳气。

13 面色苍者，须要顾其津液，清凉到十分之六七，往往热减身寒者，不可就云虚寒而投补剂，恐炉烟虽熄，灰中有火也，须细察精详，方少少与之，慎不可直率而往也。（《温热论》第9条）

【提要】

论阴虚体质感受湿邪的治疗原则及注意事项。

【词解】

直率而往：粗疏草率、不详细诊察病情而肆意用药。

【句解】

凡面色青白而形体消瘦者，多属于阴虚火旺体质，再感受湿热病邪，每易湿从燥化而更伤阴液，治疗时应注意顾护阴液。用清凉之剂到十分之六七，患者热退身凉后，切不可误认为虚寒证而投温补，须防湿邪未尽，而导致“炉灰复燃”，病情复作。

14　又有酒客里湿素盛，外邪入里，里湿为合。在阳旺之躯，胃湿恒多；在阴盛之体，脾湿亦不少，然其化热则一。（《温热论》第9条）

【提要】

论酒客感受湿邪的病机特点。

【词解】

① 酒客：嗜好饮酒之人。

② 胃湿：胃腑湿热偏重，热重于湿。

③ 脾湿：脾脏湿热偏重，湿重于热。

【句解】

① 外邪入里，里湿为合：湿邪有内湿、外湿的区分，外湿即感受时令之湿，多发于长夏。内湿多由嗜饮酒茶，脾胃失于健运而生。里湿素盛之人，感受外湿，内外之湿常常相合而病。

② 在阳旺之躯，胃湿恒多；在阴盛之体，脾湿亦不少：湿热病以脾胃为病变中心，不同体质状态可以引起病性变化，从而出现热重于湿或湿重于热的病理状态。阳气盛者，多从热化而归阳明，病见热重于湿；阴气盛者，多从湿化而留恋于太阴，病见湿重于热。但无论湿重热轻，或热重湿轻，其湿邪都有可能化热或燥化。

15　热病救阴犹易，通阳最难。救阴不在血，而在津与汗；通阳不在温，而在利小便，然较之杂证，则有不同也。（《温热论》第9条）

【提要】

论热病救阴及湿病通阳的治疗要点。

【句解】

热病伤阴是温病的一般规律，养阴、救阴属于正治之法，其治疗相对容易。湿热病既有湿邪郁滞气机，阻遏阳气而不能布达的一面，又有邪热伤阴的一面。通阳犹恐伤阴，养阴不当则恋湿助邪，更碍阳气通达，所以治疗颇难。救阴的目的不在于滋补阴血，而是在于生津充液，防止汗泄过多而损伤津液。湿为阴邪，容易闭郁气机，阳气因而不能布达，故治疗在于宣展气机，淡渗利尿，使湿邪尽从

小便而去，湿去气通，阳气自然布达。

16 再论三焦不得从外解，必致成里结。里结于何，在阳明胃与肠也。亦须用下法，不可以气血之分，就不可下也。但伤寒邪热在里，劫烁津液，下之宜猛；此多湿邪内搏，下之宜轻。伤寒大便溏为邪已尽，不可再下；湿温病大便溏为邪未尽，必大便硬，慎不可再攻也，以粪燥为无湿矣。（《温热论》第10条）

【提要】

论湿热与积滞搏结肠腑的病机、治法，以及与《伤寒论》阳明腑实证的区别。

【词解】

里结：指湿热与积滞搏结肠腑，出现大便溏垢不爽，胸腹灼热，舌苔厚腻等症。

【句解】

邪留三焦，经分消走泄，邪不外解，可里结于阳明胃肠，治疗当用下法。但所用下法与伤寒阳明腑实证的下法不同。伤寒阳明腑实证为寒邪化热入里，劫烁津液，形成燥屎，故下之宜猛，以急下存阴；湿热积滞搏结肠腑则便溏，非有燥屎形成，下之宜轻宜频。伤寒腑实证大便溏为燥屎已去，不可再攻；湿温大便转硬方为湿邪已尽，不可再下。

【拓展】

轻下频下是湿热积滞搏结肠腑的基本治法：因湿热与积滞，相互搏结，黏滞于肠道，而非燥屎里结，故须消积导滞与泻下湿热并举，方药宜轻宜缓，使湿热积滞缓消渐散。此证若误用承气攻下，则正气徒伤，而湿热仍然胶结不去。诚如章虚谷说："湿热凝滞，大便本不干结，以阴邪瘀闭不通，若用承气猛下，其行速，而气徒伤，湿仍胶结不去，故当轻法频下"。石寿堂所著《医原》说："设使大剂攻下，走而不守，则必宿垢不行，反行稀水，徒伤正气，变成坏症。所谓频下，是指湿热黏腻，非一下即已，常需再三下之，直至邪退热净，大便成形，舌苔转为正常为止"。常用方如枳实导滞汤等。

17 湿热证，始恶寒，后但热不寒，汗出胸痞，舌白，口渴不引饮。（《湿热病篇》第1条）

【提要】

湿热病提纲。

【词解】

① 胸痞：胸中窒闷不舒的症状。

② 舌白：舌苔白。

【句解】

湿热受自口鼻，由膜原直走中道，壅阻脾胃。湿遏卫阳，肌表失于温煦则畏寒；郁久化热，传入气分则畏寒消失，反有恶热；邪热蒸湿为汗，故有汗出；湿邪闭阻肺胃气机则胸痞；湿邪偏盛则舌苔白腻或白厚，津液为湿浊所阻，不能上潮于口故口渴；湿饮内停，格拒不纳，故不引饮。

18 湿热证，恶寒无汗，身重头痛，湿在表分。宜藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、牛蒡子等味。头不痛者，去羌活。（《湿热病篇》第2条）

【提要】

论湿邪伤表，尚未化热的证治。

【句解】

湿热之邪初犯机体，以湿邪为主，热象不显，湿困卫表，故为“阴湿伤表”。卫阳郁闭，机体失于温煦，故恶寒，湿性阴凝，表气不通故无汗。头为诸阳之会，湿邪蒙蔽清阳，阻遏气机，则见头重昏蒙。对于此湿重而热不甚，邪在卫表者，治疗以芳香辛散，透表化湿为法，药物藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、牛蒡子等味。头痛乃夹风之症，若不夹风邪，则去羌活。

19 湿热证，恶寒发热，身重关节疼痛，湿在肌肉，不为汗解，宜滑石、大豆黄卷、茯苓皮、苍术皮、藿香叶、鲜荷叶、白通草、桔梗等味。不恶寒者，去苍术皮。（《湿热病篇》第3条）

【提要】

论湿邪犯于肌表而湿中蕴热之候的证治。

【句解】

湿热之邪初犯人体，湿郁化热，阻滞经脉，故为“阳湿伤表”。湿为阴邪，阻遏卫阳，肌表失于温煦，故恶寒。湿郁化热，故发热。迫津外泄，故汗出。湿邪阻滞经脉，流滞关节，气机不通，故身重，关节疼痛。治疗宜清化肌表湿热，药如滑石、大豆黄卷、茯苓皮、苍术皮、藿香叶、鲜荷叶、白通草、桔梗等味。若湿邪由卫分传至气分，恶寒症解，则去辛温之苍术皮，而主以辛凉甘淡法。

【拓展】

薛氏根据是否化热，将在表湿热划分为阴湿和阳湿，其辨证的关键在于“汗出”“关节疼痛”“乃阳湿伤表之候”。

20 湿热证，寒热如疟，湿热阻遏膜原，宜柴胡、厚朴、槟榔、草果、

藿香、苍术、半夏、干菖蒲、六一散等味。(《湿热病篇》第 8 条)

【提要】

论湿热阻遏膜原的证治。

【句解】

湿热从口鼻而入,伏于膜原,湿热阻遏,营卫气争,故寒热交替,或寒热起伏,症如疟状。治疗当疏利透达膜原湿浊之邪,药如柴胡、厚朴、槟榔、草果、藿香、苍术、半夏、干菖蒲、六一散等味。

【拓展】

薛氏此方由吴又可"达原饮"加减化裁而来,与吴氏原方比较,去掉了白芍、知母酸甘恋邪之品,增加了清透少阳邪热的柴胡,渗湿泄热的"六一散",更有藿香、苍术、半夏、干菖蒲之苦辛开泄,对于湿热伏遏膜原,湿邪较重的证候颇为适宜。但方较吴又可"达原饮"性偏温燥,所以待湿开热透后,即应调整用药,不可久服,恐有湿邪化燥之虞。

21 湿热证,数日后,脘中微闷,知饥不食,湿邪蒙绕三焦。宜藿香叶、薄荷叶、鲜荷叶、枇杷叶、佩兰叶、芦尖、冬瓜仁等味。(《湿热病篇》第 9 条)

【提要】

论湿热证后期,余湿蒙扰中上二焦的证治。

【词解】

脘:此处主要指胃脘,亦涉及胸腹部。

【句解】

湿热病后期,大邪已去,余湿未解,脾气不舒,胃气未醒,故脘中微闷,知饥而不欲饮食。治疗宜轻清芳化,醒脾苏胃,方用藿香叶、薄荷叶、鲜荷叶、枇杷叶、佩兰叶、芦尖、冬瓜仁等味。

22 湿热证,初起发热,汗出胸痞,口渴舌白,湿伏中焦。宜藿梗、蔻仁、杏仁、枳壳、桔梗、郁金、苍术、厚朴、草果、半夏、干菖蒲、佩兰叶、六一散等味。(《湿热病篇》第 10 条)

【提要】

论湿伏中焦,始见化热,湿重于热的证治。

【句解】

湿热多由初起的邪遏卫分发展而来。湿热交蒸,虽汗出而热不除;湿热遏阻中焦气机,上干于肺,不得宣通,故胸脘痞闷;湿阻津液不得上升故口渴,但渴不

多饮；湿重于热，故舌苔白滑、白腻。治宜辛开化湿为主，少佐清热，药用藿梗、蔻仁、杏仁、枳壳、桔梗、郁金、苍术、厚朴、草果、半夏、干菖蒲、佩兰叶、六一散等味。

【拓展】

本证为中焦湿重热轻之证，所列方药以化湿为主。临床上，本证以中焦为主，虽有热邪，不可寒凉遏之，以防其凝涩气机，使得湿邪无从宣化。

23　湿热证，数日后自利，溺赤，口渴，湿流下焦，宜滑石、猪苓、茯苓、泽泻、萆薢、通草等味。（《湿热病篇》第 11 条）

【提要】

论湿流下焦，泌别清浊失职的证治。

【句解】

湿热之邪流注下焦，导致大肠传导失司，小肠泌别清浊失职，出现自利，小便短涩而少。湿邪阻滞气机，津不上承，故口渴而不引饮。治疗当以分利湿邪为主，用淡渗之品，如滑石、猪苓、茯苓、泽泻、萆薢、通草等味。

【拓展】

本证病机变化不局限于下焦，故薛氏指出还可兼见口渴、胸痞，须佐入桔梗、杏仁、大豆黄卷等，治以开泄中上。

24　湿热证，舌根白，舌尖红，湿渐化热，余湿犹滞，宜辛泄佐清热，如蔻仁、半夏、干菖蒲、大豆黄卷、连翘、绿豆衣、六一散等味。（《湿热病篇》第 13 条）

【提要】

论中焦湿渐化热，湿热参半的证治。

【拓展】

温病学派医家非常重视舌诊，常据舌辨证治疗，如薛生白在本条自注中说："凭验舌以投剂，为临证时要诀"，对于中焦湿热俱重的轻证，薛氏方颇为实用，而对于舌红苔黄厚腻浊的中焦湿热互结，锢结不通，呕而兼痞之证，当用辛开苦降之法，药如半夏、生姜、枳实、黄芩、黄连等，方如半夏泻心汤加减。

25　温病者，有风温，有温热，有温疫，有温毒，有暑温，有湿温，有秋燥，有冬温，有温疟。（《温病条辨·上焦篇》第 1 条）

【提要】

论温病的概念和范围。

【句解】

温病是多种外感温病的总称，包括风温、温热、温疫、温毒、暑温、湿温、秋燥、

冬温、温疟九种。

【拓展】

吴鞠通在此条首揭温病大纲，将温病分为九种。除此之外，《温病条辨》还论述了伏暑、痢、痹、疸等多种疾病。这种分类方法对于确立四时温病的名称，明确四时温病的病因，功不可没。但在论述过程中，常有含混不清之处，比如暑温、湿温，按照本条应各占温病之一格，应是两个病，但吴氏却说："暑之偏于热者为暑温；暑之偏于湿者为湿温"，混同湿与暑的关系，也难怪王孟英评价此书"题旨不清"了，在学习的过程中需引起重视。

26 凡病温者，始于上焦，在手太阴。（《温病条辨·上焦篇》第2条）

【提要】

论温病的发病部位及感邪途径。

【拓展】

温病的起病部位比较复杂，不仅限于手太阴一途。王孟英云："凡病温者，始于上焦，在手太阴……伏气自内而发，则病起于下者有之；胃为藏污纳垢之所，湿温、疫毒病起于中者有之；暑邪夹湿者，亦犯中焦；又暑属火而心为火脏，同气相求，邪极易犯，虽始上焦，亦不能手太阴一经也。"通常，"始于上焦，在手太阴"的温病指风温、温毒、秋燥、冬温等外感温病，伏气温病及部分温疫不在此例。

27 太阴之为病，脉不缓不紧而动数，或两寸独大，尺肤热，头痛，微恶风寒，身热自汗，口渴，或不渴而咳，午后热甚者，名曰温病。（《温病条辨·上焦篇》第3条）

【提要】

论手太阴肺病的脉症。

【词解】

尺肤：由"寸口"的尺部脉起，到肘关节"尺泽穴"处止的一段皮肤。为古代"切诊"法内容之一，名"尺肤诊"。

【句解】

外感温病初起，温邪首犯卫表，卫阳被遏，故身热微恶风寒，头痛；温邪入肺，热气内壅，肺卫失宣，故两寸脉数，自汗，咳而口渴。

【拓展】

本条紧接承上条之意，叙述了温邪犯肺的初起证候特点。就其所述证候来看，多指外感温病初起的证候，所以将此条作为"上焦证（病）提纲"，亦属恰当。

而论中暑温、湿温、温疫等，却与此证候相去甚远，如湿温初起的证候为始恶寒，后但热不恶寒，汗出，胸痞，舌苔白腻或白厚等，又如暑温初起，“夏暑发自阳明”，可直接出现身壮热，汗出，口渴，脉洪大的阳明气分热盛证候，故不可因其“名为温病”，就拟定为所有温病初起的证候。

28 太阴风温，但咳，身不甚热，微渴者，辛凉轻剂桑菊饮主之。（《温病条辨·上焦篇》第6条）

【提要】

论风温犯肺，以咳为主的证治。

【句解】

风热之邪，从口鼻而入，壅阻肺经，肺卫失宣，表现为咳嗽，身热不甚，口中微渴，可用辛凉轻剂桑菊饮辛凉解表，宣肺泄热。

29 太阴温病，脉浮洪，舌黄、渴甚、大汗、面赤、恶热者，辛凉重剂白虎汤主之。（《温病条辨·上焦篇》第7条）

【提要】

论邪入气分，肺胃热盛的证治。

【句解】

太阴温病，邪入气分，肺胃热盛，可见舌黄、大汗、面赤、恶热、脉洪等症，故用辛凉重剂白虎汤辛透退热、甘寒保津。

【拓展】

何秀山对于白虎汤的使用很有体会，常根据邪气兼夹的不同，灵活使用该方，录之以备参考：“兼风加桑叶、薄荷。兼寒加葱白、豆豉。兼暑加青蒿、香薷。兼湿加苍术、川朴。气虚液枯者，加人参、麦冬。血虚火旺者，加鲜生地、丹皮。痰多气滞者，加半夏、橘红。络痹经挛者，加羚羊角、桂枝。火旺生风者，加犀、羚、桑、菊。火实便秘者，加芩、连、硝、黄。惟食积化火，宜用大黄”。

30 白虎本为达热出表，若其人脉浮弦而细者，不可与也；脉沉者，不可与也；不渴者，不可与也；汗不出者，不可与也。常须识此，勿令误也。（《温病条辨·上焦篇》第9条）

【提要】

论白虎汤运用的“四禁”。

【句解】

吴鞠通以“达热出表”精辟归纳了白虎汤的作用特点，此处的“出表”不同

于“解表”，揭示了白虎汤的透热外达之功。对于阳明无形邪热弥漫，邪正剧烈交争，热势由内达外的特点，白虎汤可辛寒清气，达热顺势外出。其作用既与解除表邪的解表方药不同，也与清热解毒直折火势的苦寒清热方药有所区别。

【拓展】

吴鞠通在充分肯定了白虎汤的疗效后，立下“白虎四禁”，示人以规矩，有一定的参考价值，但在临床中仍需四诊合参，仔细甄别，方不失去使用白虎汤的要旨。比如张锡纯就对白虎汤的使用提出了自己的见解，他认为“其脉沉而有力者，当系热邪深陷，其气分素有伤损，不能托邪外出，治以白虎加人参汤，补气即以清热，服后其脉沉者即起，而有力者亦化为和平矣”。又说“其汗不出者，若内蕴有实热，正可助以白虎汤以宣布其热外达……服后即汗出而愈”。二者并不矛盾，读者可参。

31 太阴温病，气血两燔者，玉女煎去牛膝加元参主之。（《温病条辨·上焦篇》第10条）

【提要】

论手太阴肺气血两燔的治疗。

【拓展】

玉女煎用于气营同病而热毒尚未亢盛至极，其清热解毒之力较弱。对于热毒较盛之证，运用时应加清热解毒之品。

32 温病小便不利者，淡渗不可与也，忌五苓、八正辈。（《温病条辨·中焦篇》第30条）

【提要】

论温病伤阴而小便不利者忌用淡渗之理。

【词解】

淡渗不可与：阴伤化源不足的小便不利，不宜淡渗利尿。

【句解】

温病见小便不利，因热盛伤阴，化源不足所致，治疗以滋阴清热为大法，滋阴以益小便之源，清热而去其因。不可一见小便不利，便就认为有水湿停滞，气化不行，从而肆用淡渗利尿之剂。若误用，会进一步耗伤阴液，致使小便难通。

【拓展】

温病小便不利多因阴液耗伤，但也不可一概而论。其他原因所致小便不利，如湿热阻滞三焦引起的小便不利、热结膀胱气化失司引起的小便不利，并非不可

用木通、车前等清热利湿之品。

33 风温、温热、温疫、温毒、冬温，邪在阳明久羁，或已下，或未下，身热面赤，口干舌燥，甚则齿黑唇裂，脉沉实者，仍可下之；脉虚大，手足心热甚于手足背者，加减复脉汤主之。（《温病条辨·下焦篇》第1条）

【提要】

论温病后期，真阴耗伤的证治。

【句解】

阳明邪热炽盛，留连过久，伤及下焦真阴，可出现两种变证：一是脉沉实，并见身热面赤，口干舌燥，甚则齿黑唇裂者，仍属阳明腑实，仍用攻下之法。二是脉虚大，手足心热甚于手足背，邪热少而虚热多，则属肾阴大伤，当用加减复脉汤以滋养肾阴。

【拓展】

加减复脉汤是在《伤寒论》“炙甘草汤”的基础上进行加减，即炙甘草汤去人参、桂枝、生姜、大枣，加白芍而成。因炙甘草汤方中参、桂、姜、枣等补阳益气，而温病真阴亏耗，虚热内生，当禁温补，故去之。加白芍与生地、麦冬等甘寒之品酸甘化阴，以增滋阴之力，阴复以利热退。吴氏将此方作为下焦温病肾阴亏耗的主方。

34 下焦温病，但大便溏者，即与一甲复脉汤。（《温病条辨·下焦篇》第10条）

【提要】

论温病后期，热入下焦的证治。

【拓展】

温病深入下焦，必以救阴为急务。然救阴之药多滑润，但见大便溏，不必待日三、四行，即以一甲复脉法，复阴之中，预防泄阴之弊。

35 少阴温病，真阴欲竭，壮火复炽，心中烦，不得卧者，黄连阿胶汤主之。（《温病条辨·下焦篇》第11条）

【提要】

论温病后期，阴虚火炽不寐的证治。

【词解】

壮火：亢盛之阳气，即病理之火。

【句解】

温病后期，温邪深入下焦，真阴被劫，不能上济心火，导致心火独亢。心主神明，心阳独亢，心神失守，故心烦不得卧，治疗使用育阴清热安神之黄连阿胶汤。

【拓展】

临床中对本证的判断，除原文所述主症之外，还有身热不甚，或热退舌红苔薄黄而干，或薄黑而干，脉细数等。

36 夜热早凉，热退无汗，热自阴来者，青蒿鳖甲汤主之。（《温病条辨·下焦篇》第12条）

【提要】

论温病后期，邪留阴分的证治。

【词解】

夜热早凉：入夜发热，晨起热退身凉。

【句解】

温病后期，阴液已亏，余邪留伏阴分，卫气夜行阴分，与邪抗争，故入夜发热；卫气日行阳分，不与邪争，邪热复归阴分，则晨起热退身凉。治疗用青蒿鳖甲汤滋养营阴，凉营透邪。

【拓展】

本证病机重点在“邪气深伏阴分”，阴液虽亏而未竭，虽有热邪而不甚，临床表现以夜热早凉、热退无汗为主症，常伴形体消瘦、舌红少苔、脉沉细数等症。

37 热邪深入下焦，脉沉数，舌干齿黑，手指但觉蠕动，急防痉厥，二甲复脉汤主之。（《温病条辨·下焦篇》第13条）

【提要】

论下焦温病痉厥将作的证治。

【词解】

痉厥：肢体抽搐，神志不清。

【句解】

下焦温病，肾之真阴耗损，阴虚不能涵木，虚风内动则见手指蠕动等先兆，故急用复脉汤滋养肾阴，加入二甲（牡蛎、鳖甲）介属潜阳，从而防止热灼真阴而致虚风内动的发生。

38 下焦温病，热深厥甚，脉细促，心中憹憹大动，甚则心中痛者，

三甲复脉汤主之。(《温病条辨·下焦篇》第14条)

【提要】

论虚风内动的证治。

【词解】

心中憺憺大动：语出《素问·至真要大论》，形容心中空虚而震动感，类似“怔忡”，为心悸之重症。

【句解】

温病后期，阴精亏损，不能濡养筋脉，则见肢体痉挛、抽搐；水亏不能济火，心气浮动，可见心中憺憺大动，甚至可见心中疼痛。治疗上，在二甲复脉汤基础上加龟板以滋阴潜阳，即三甲复脉汤。

39　壮火尚盛者，不得用定风珠、复脉。邪少虚多者，不得用黄连阿胶汤。阴虚欲痉者，不得用青蒿鳖甲汤。(《温病条辨·下焦篇》第17条)

【提要】

论四个方剂的使用宜忌。

【拓展】

吴氏治疗下焦温病，注重分析病之虚实。大(小)定风珠、复脉汤类方，主用酸甘咸法，偏于填补肝肾精血亏损，潜阳熄风，多用于阴虚欲痉之证；黄连阿胶汤主用苦甘咸寒法，既滋心肾之阴，又泄壮热邪火，多用于壮火尚盛之证；青蒿鳖甲汤乃辛凉合甘寒法，甘寒养津，辛凉透热，对于温病后期，邪伏阴分不能外达的邪少虚多之证，尤其适宜。

40　治外感如将，治内伤如相，治上焦如羽(非轻不举)，治中焦如衡(非平不安)，治下焦如权(非重不沉)。(《温病条辨·杂说·治病法论》)

【提要】

论外感与内伤以及三焦分证的治疗原则。

【词解】

① 羽：羽毛，意为轻。

② 衡：秤杆，意为平。

③ 权：秤砣，意为重。

【句解】

① 治外感如将，治内伤如相：治疗外感病，当如将军指挥作战，兵贵神速，还

要灵活机动；治疗内伤杂病则不同，起势缓，恢复慢，不可急切图功，犹如宰相治理国家，镇定从容，讲求策略，调理脏腑气血，使疾病逐渐向愈。

② 治上焦如羽，治中焦如衡，治下焦如权：邪在上焦，法取轻清，不任意用苦重之药，过重反过病所；治疗中焦病，必平其亢厉，使归于平；邪在下焦，此时肝肾之阴大伤，必须厚味滋填，或介类潜镇，以复其阴，熄其内动之虚风。

**【拓展】**

外感内伤及三焦分证的治疗原则只是言其大概，不能代表各种具体治法。临床中必须根据具体情况，辨证论治，如外感中的气血阴阳虚亏证，就不能一味峻猛，内伤中气滞、血瘀、痰凝，则必须猛药处之。

# 二级条文(30条)

1 再人之体,脘在腹上,其地位处于中,按之痛,或自痛,或痞胀,当用苦泄,以其入腹近也。必验之于舌:或黄或浊,可与小陷胸汤或泻心汤,随证治之。或白不燥,或黄白相兼,或灰白不渴,慎不可乱投苦泄。其中有外邪未解,里先结者,或邪郁未伸,或素属中冷者,虽有脘中痞闷,宜从开泄,宣通气滞,以达归于肺,如近俗之杏、蔻、橘、桔等,是轻苦微辛,具流动之品可耳。(《温热论》第11条)

**【提要】**

论湿热痰浊结于胃脘的主症、治法以及多种类型痞证的治疗。

**【词解】**

① 苦泄:指以苦寒清热之品配合苦辛温燥湿之品,起到清热燥湿的作用,主要用于治疗湿热内阻者,方如泻心汤、小陷胸汤等。

② 开泄:指以轻苦微辛之品,宣畅气机,透邪外出,以去湿化浊,使邪从上、从外而解,治疗湿热为患而湿邪尚未明显化热者,药如杏、蔻、橘、桔等。

**【句解】**

胃脘居于上腹部,位处中焦,若胃脘按之疼痛,或自痛,或痞满胀痛,当用苦泄之法治疗,因其入腹已近,以泄为顺。但脘痞疼痛的原因有多种,治法不一,为了作出正确诊断,要依据舌苔变化来鉴别,即"必验之于舌";若见舌苔黄浊者,为湿热痰浊互结之证,当用苦泄法。若舌苔灰白不渴者,为阴邪壅滞,阳气不化,不可轻投苦泄,宜用开泄法。痰湿重者,可加燥湿化痰之品,如半夏、苍术等;兼表证者可佐以藿梗、紫苏等透表之品;阳气不化而阴邪壅滞者,可酌加附子、干姜、白术等温通之品。

2 手太阴暑温,如上条证,但汗不出者,新加香薷饮主之。(《温病条辨·上焦篇》第24条)

**【提要】**

论暑湿兼表寒的证治。

【句解】

所谓“如上条证”，即如自注所云“形似伤寒”，出现头痛、高热、恶寒等类似伤寒的症状，但本证的特点是汗不出，多因暑气当令之夏月，暑湿之邪先蕴阻于内，复因起居不慎，贪凉过度，导致寒邪外束肌表。寒邪束表，卫气郁闭，表气不通则发热恶寒，头痛无汗，身形拘紧；暑热内郁则面赤口渴；湿邪内阻可出现脘痞苔腻，治疗以新加香薷饮疏表散寒、涤暑化湿。方中香薷辛温香透，既可疏表散寒，又能祛暑化湿，厚朴可燥湿和中、理气开痞，银花、连翘、鲜扁豆花均可清热涤暑。诸药合用，有散寒、化湿、涤暑之效。

3 手太阴暑温，或已经发汗，或未发汗，而汗不止，烦渴而喘，脉洪大有力者，白虎汤主之；脉洪大而芤者，白虎加人参汤主之；身重者，湿也，白虎加苍术汤主之；汗多脉散大，喘喝欲脱者，生脉散主之。（《温病条辨·上焦篇》第26条）

【提要】

论暑温气分证治。

【词解】

① 芤：指芤脉，浮大而软，按之中空如按葱管。

② 喝(hè)：指喘的声音很大。

【拓展】

本条虽冠以“手太阴暑温”，但其病位不局限于肺。白虎汤和白虎加人参汤所主治者，为肺胃热盛；白虎加苍术汤所治者，则属阳明与太阴同病；生脉散所治者则为气阴欲脱。这几种情况，病邪的性质有兼湿不兼湿之别，病证的性质有虚实之异，应当严格区别。

4 脉虚，夜寐不安，烦渴，舌赤，时有谵语，目常开不闭，或喜闭不开，暑入手厥阴也。手厥阴暑温，清营汤主之；舌白滑者，不可与也。（《温病条辨·上焦篇》第30条）

【提要】

论暑温病邪入营分的证治。

5 温病燥热，欲解燥者，先滋其干，不可纯用苦寒也，服之反燥甚。（《温病条辨·上焦篇》第31条）

【提要】

论温病热甚阴伤，不可纯用苦寒之禁。

【拓展】

曹炳章："以苦燥久积能化燥，故人但知芩连等之寒，而不知其化燥，鞠通真是通儒"，盛赞吴鞠通于苦寒药物体会尤深。临床中对温病燥热的治疗，一般采用甘苦合化之法，即清热与养阴并施，如冬地三黄汤汤。临证时还应当权衡热盛伤阴之侧重程度，从而灵活运用。

6　头痛，恶寒，身重疼痛，舌白不渴，脉弦细而濡，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，状若阴虚，病难速已，名曰湿温。汗之则神昏耳聋，甚则目瞑不欲言。下之则洞泄，润之则病深不解。长夏深秋冬日同法，三仁汤主之。（《温病条辨·上焦篇》第43条）

【提要】

论湿温初起的证候特点和治疗宜忌。

【词解】

洞泄：原指食后即腹泻，泻下物完谷不化。此指泻下无度。

【拓展】

湿温初起有三禁。一是禁汗，若见恶寒头痛，身重疼痛，误认为伤寒而用辛温发汗之药，则会耗伤心阳，湿浊随辛温之品上蒙清窍，可致神昏、耳聋、目闭等症；二是禁下，若见胸闷不饥等湿热阻滞脾胃之症，误以为胃肠积滞而妄用苦寒攻下，则脾阳受损，脾气下陷，湿邪下趋而为洞泄；三是禁润，若见午后身热等误以为阴虚，妄用滋腻阴柔之药，势必使湿邪锢结难解，病情加重而难以治愈。

7　秋感燥气，右脉数大，伤手太阴气分者，桑杏汤主之。（《温病条辨·上焦篇》第54条）

【提要】

论秋燥病邪在肺卫的证治。

【句解】

肺主气，寸口肺脉数大，提示有肺热。桑杏汤具有清宣温燥，润肺止咳作用，为治疗"温燥"的常用方。

8　燥伤肺胃阴分，或热或咳者，沙参麦冬汤主之。（《温病条辨·上焦篇》第56条）

【提要】

论秋燥病肺胃阴伤证的证治。

【拓展】

沙参麦冬汤是治疗肺胃阴伤的代表方，方中多为甘寒生津，滋养肺胃之品，同时具有轻清宣透，宣散肺热之功。本方不仅可用于秋燥之燥伤肺胃证，各种温病所引起的肺胃阴伤证皆可使用。

9 燥气化火，清窍不利者，翘荷汤主之。（《温病条辨·上焦篇》第57条）

【提要】

论燥热化火，清窍不利的证治。

【词解】

① 燥气化火：指上焦燥热盛而化火，上炎头面诸窍，引起耳鸣、目赤、龈胀、咽痛等症状。

② 清窍：头面诸窍。

【拓展】

翘荷汤辛凉清宣上焦燥热之火，方中连翘、黑栀皮、绿豆皮清解燥火，薄荷辛凉清利头目，桔梗、甘草利咽而消龈肿。吴氏所用之药均为轻清宣透之品，符合“治上焦如羽”的治疗原则。曹炳章说“燥气上干清窍，见头目之病，此时虽用养液之品，尚觉隔膜一层，故用药先轻宣凉散兼导之下降”。

10 阳明温病，下后汗出，当复其阴，益胃汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第12条）

【提要】

论阳明温病攻下后，汗出伤阴的证治。

【词解】

复其阴：是指复其胃阴而言。

【拓展】

益胃汤方中沙参、麦冬、冰糖清养胃阴，细生地、玉竹生津养液，滋而不腻，为益胃养阴之良方。

11 阳明温病，下后二三日，下证复现，脉下甚沉，或沉而无力，止可与增液，不可与承气。（《温病条辨·中焦篇》第16条）

【提要】

论阳明温病下后，下证复现脉沉无力的证治。

【句解】

阳明温病已采用下法治疗，又出现腑实之证，但从脉象来看，沉而无力，此乃

正虚阴亏之象，禁用承气攻下，只能用滋阴增液，润肠通便。

12 阳明温病，下之不通，其证有五：应下失下，正虚不能运药，不运药者死，新加黄龙汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第17条）

【提要】

论阳明温病腑实兼有正虚不运的证治。

【拓展】

原本应当用攻下治疗的病证，因为没有及时攻下，导致邪气留连，机体正气损伤，不能吸收运化药力，所以投用的攻下方药不能产生作用。患者身热，腹满便秘，伴见口舌干燥，倦怠少气，撮空摸床，肢体震颤，目中不了了，苔干黄或焦黑，脉沉弱或沉细，用新加黄龙汤治疗。方中人参益气扶正，麦冬、生地、当归、海参养阴滋液，和营润燥，大黄、芒硝泻热通腑，姜汁宣畅气机，鼓舞胃气。这种治法称为“邪正合治法”。

13 喘促不宁，痰涎壅滞，右寸实大，肺气不降者，宣白承气汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第17条）

【提要】

论腑实肺壅证的治疗。

【拓展】

患者出现气急喘促，坐卧不安，喉中痰涎壅阻不畅，脉象见右寸实大，其原因是热结肠腑，肺气不能速降，可用宣白承气汤治疗。方中以生石膏清肺胃之热，杏仁、栝蒌皮宣降肺气，化痰定喘；大黄攻下腑实。腑实得下，则肺热易清；肺气清肃，则腑气易通。由于肺于大肠相表里，故这种方法称为“脏腑合治法”。

14 左尺牢坚，小便赤痛，时烦渴甚，导赤承气汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第17条）

【提要】

论肠热盛而腑实的治疗。

【拓展】

患者脉象左尺坚牢，并伴有小便红赤，尿时涩痛，时常感到心烦口渴，为阳明腑实证，伴有小肠热盛，此时宜投导赤承气汤治疗。方中生地、赤芍凉血，滋阴，清心，黄连、黄柏清泻小肠，大黄、芒硝攻下大肠热结，这种治法称为“二肠同治法”。

15 邪闭心包，神昏舌短，内窍不通，饮不解渴者，牛黄承气汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第17条）

【提要】

论腑实窍闭证的治疗。

【拓展】

阳明腑实的同时，又由于热邪内阻心包，机窍堵闭不通，出现神志昏迷，舌短缩，口渴而饮水不能解渴，宜用牛黄承气汤治疗。本方即用安宫牛黄丸清心开窍，加生大黄末攻下腑实。因本证既有热闭心经，又有肾中阴液逐渐耗竭的危险，所以这种治法称为“两少阴合治法”。

16 津液不足，无水舟停者，间服增液，再不下者，增液承气汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第17条）

【提要】

论腑实阴亏的治疗。

【拓展】

由于肠道津液不足，大便传送功能障碍而引起便秘，即所谓“无水舟停”。对这种情况可以先服增液汤，如果服后仍然不大便，说明肠腑热结仍存，应以增液承气汤治疗。方中玄参滋水降火，生地、麦冬滋阴润燥，大黄、芒硝泻热软坚，攻下腑实，这种治法称为“一腑中气血合治法”。

17 阳明斑者，化斑汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第21条）

【提要】

论阳明温病发斑的治疗。

【拓展】

里热炽盛，内迫营血，从肌肉外发为斑，治以清化，用化斑汤治疗。化斑汤为白虎汤加犀角、玄参构成，方中白虎汤清阳明气热，加犀角、玄参解营血热毒。

18 阳明温病，下后疹续出者，银翘散去豆豉，加细生地、大青叶、元参、丹皮汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第22条）

【提要】

论阳明温病出疹的治疗。

【句解】

阳明温病，气热郁肺，内窜营血，从肌肤外发而为疹，肺主皮毛，所以定位在肺，证属太阴风热。在治疗上，既要清宣肺经气分热邪，又要凉营透疹解毒。下

后疹陆续透发，这是由于里气得通，营热从肌肤得以透达。治疗仍以宣肺泄热，凉营透疹为法，方用银翘散加减。

19　阳明温病，无汗，或但头汗出，身无汗，渴欲饮水，腹满，舌燥黄，小便不利者，必发黄，茵陈蒿汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第28条）

【提要】

论阳明温病温热发黄兼见里实的证治。

【句解】

郁热上蒸可见头汗，但身体无汗，提示表闭不通，湿热不能通过肌表汗出而泄。由于“小便不利”，也不能通过小便使热下泄，因此湿热郁蒸，外溢肌肤而发黄。本条“咳欲饮水，腹满舌燥黄”，提示还有里热成实，腑气不通，表里俱闭，里热全无出路，所以用《伤寒论》“茵陈蒿汤”，使郁热从二便泄出，使黄疸消退。

20　阳明温病，无汗，实证未剧，不可下，小便不利者，甘苦合化，冬地三黄汤主之。（《温病条辨·中焦篇》29条）

【提要】

论阳明热结阴亏，小便不利的证治。

【词解】

① 实证未剧：阳明腑实证尚未形成。

② 甘苦合化：甘能和能缓、补益滋养，苦能燥湿清热，合而滋润清热。

【拓展】

吴氏所谓“甘苦合化”，主要是以黄连、黄芩、黄柏三位苦寒药物清泄小肠热结，合以甘寒的麦冬、生地等来滋阴润燥。由于肺金受到火刑，运输津气失常，故方中倍用麦冬以补肺养阴。如此，则源流俱畅，内热下行，小便自然得利。

21　三焦湿郁，升降失司，脘连腹胀，大便不爽，一加减正气散主之。（《温病条辨·中焦篇》第58条）

【提要】

论湿阻脾胃，升降失司的证治。

【句解】

所谓“三焦湿郁”，字面之意似指湿邪郁阻三焦气机，但从主症“脘连腹胀，大便不爽”来看，病变中心实偏于中焦，其病机特点是“升降失司”，即湿邪中阻影响了脾胃的升降功能，故以脘腹胀满，大便溏而不爽为主要临床表现。治以一加减

正气散疏化中焦湿浊，升降脾胃之气。

【拓展】

吴鞠通所用五个加减正气散，均是以《和剂局方》中的藿香正气散加减化裁而来，都有秽湿着里，阻滞气机，脾胃升降失调的病机，以“脘闷”为共有主症，均有藿香、厚朴、茯苓、陈皮四位基本药物，芳香化浊，理气化湿，但其病变程度和兼见症状略有差异，须作相应加减。

一加减正气散在藿香、厚朴、茯苓、陈皮四位药的基础上加茵陈、大腹皮、杏仁、神曲、麦芽。其中杏仁利肺与大肠之气；大腹皮加强行气除湿；茵陈宣湿郁；神曲，麦芽苏醒脾胃之气。该方重在调升降。

22 湿郁三焦，脘闷，便溏，身痛，舌白，脉象模糊，二加减正气散主之。（《温病条辨·中焦篇》第59条）

【提要】

论湿邪内阻脾胃，外滞经络的证治。

【句解】

本证病机特点是湿热内蕴脾胃，升降失司，同时湿热阻滞经络，经气不畅，症见脘闷便溏，为湿蕴中焦脾胃，运化失职之象；身痛系湿邪留注经络的表现；苔白而脉象模糊，则为湿阻气机之象。治用二加减正气散以宣气利湿，疏通经隧。

【拓展】

二加减正气散在藿香、厚朴、茯苓、陈皮四位药的基础上加防己、大豆黄卷、通草、薏苡仁。方中防己走经络中湿郁；大豆黄卷能化蕴酿之湿热；由于“便溏”不比上条之“大便不爽”故加通草；薏苡仁利小便以实大便。该方重在宣经络。

23 秽湿着里，舌黄脘闷，气机不宣，久则酿热，三加减正气散主之。（《温病条辨·中焦篇》第60条）

【提要】

论中焦湿浊久郁，渐趋化热的证治。

【词解】

秽湿：秽浊湿邪。

【句解】

湿郁中阻，气机失畅，故见脘闷；湿郁日久，渐从热化，则舌见黄苔。所以治疗用三加减正气散以宣气化湿，兼以清热。本方在用药上重视宣通肺气，其目的是为了通过利肺气而化湿，同时重用滑石以清湿重之热。本证性质虽属湿热，但湿仍重于热，所以用药侧重于祛湿，清热之力较轻。

【拓展】

三加减正气散在藿香、厚朴、茯苓、陈皮四位药的基础上加杏仁、滑石。方中杏仁利肺气，滑石清利湿中之热。该方重在利湿热。

24 秽湿着里，邪阻气分，舌白滑，脉右缓，四加减正气散主之。（《温病条辨·中焦篇》第61条）

【提要】

论湿困脾阳的证治。

【句解】

湿邪在里，日久必然会损伤阳气。本条所述主要为湿郁日久，伤及脾阳，形成湿盛脾阳受伤之证。文中叙证从简，只言“舌白滑，脉右缓”，目的在于突出湿浊偏重的特点，以作为辨证的关键。此外，当必有脘痞、腹胀等湿阻气滞的见症。治疗用四加减正气散疏化中焦湿浊。

【拓展】

四加减正气散在藿香、厚朴、茯苓、陈皮四位药的基础上加草果、山楂，神曲。方中草果、山楂、神曲运脾阳、消食导滞。该方重在运脾阳。

25 秽湿着里，脘闷便泄，五加减正气散主之。（《温病条辨·中焦篇》第62条）

【提要】

论湿困中焦而泄泻的证治。

【句解】

本证为湿浊偏重，阻于中焦气分之候。湿着于里，胃气受困则脘痞，脾运失健则便溏。治以五加减正气散，重在化湿和中，健运脾胃。

【拓展】

五加减正气散在藿香、厚朴、茯苓、陈皮四位药的基础上加大腹皮、苍术、麦芽。方中大腹皮、苍术运脾气，麦芽升胃气。该方重在和脾胃。

26 湿郁经脉，身热身痛，汗多自利，胸腹白疹，内外合邪，纯辛走表，纯苦清热，皆在所忌，辛凉淡法，薏苡竹叶散主之。（《温病条辨·中焦篇》第66条）

【提要】

论湿热痹表里同病，内外合邪的证治。

【句解】

由于湿热郁阻经脉，故“身热身痛”。一般说来，汗出而不能随汗而解，常为

热兼湿邪为患。《金匮要略》论湿病时曾指出“风湿相搏，一身尽疼痛……汗大出者，但风气去，湿气在，是故不愈也”。因此，不可用“纯辛走表”，意即不能用辛温发汗的方法治疗。“自利”，提示湿热不但伤及在表之经络，而且伤及在里之脾阳，故为“内外合邪”。不可用“纯苦清热”，是说不能再用苦寒药清热，重伤脾胃并有碍化湿。“胸腹白疹”，指胸腹部出现白色疹子，提示属于湿热病。湿热郁蒸肌肤，白疹随汗出得以透发，所以往往疹出而胸闷等证减轻。治疗需表里兼治，湿热两解。在表宜辛凉透疹，不宜辛温发汗；在里宜甘淡化湿利湿，不宜苦寒凉遏，故用薏苡竹叶散辛凉解表，淡渗利湿，该方以竹叶、连翘辛凉透热出表，以白蔻仁、薏苡仁、茯苓、滑石、通草化湿利湿，适于内外合邪湿停热郁之证。

27 热邪久羁，吸烁真阴，或因误表，或因妄攻，神倦瘛瘲，脉气虚弱，舌绛苔少，时时欲脱者，大定风珠主之。（《温病条辨·下焦篇》第16条）

**【提要】**

论少阴温病阴竭风动欲脱的证治。

**【词解】**

瘛瘲：即抽搐，四肢时缩时伸，抽动不止。筋急引缩为瘛，筋缓纵伸为瘲。

**【句解】**

热邪久羁不退，真阴本已耗伤，又误用汗下之药，劫夺肝肾之阴，而致虚风内动，时时欲脱，病情危重。阴精亏虚而心神失养，可见神态疲乏；水不涵木则虚风内动，而手足瘛瘲；真阴大伤，故脉虚弱而舌绛少苔。本证特点是“邪少虚多”，邪气已去八九，真阴仅存一二，故所用之方是在三甲复脉汤的基础上增加了五味子、鸡子黄，血肉有情，复阴恋阳。本方滋阴熄风，为治疗纯虚无邪，虚风内动，风动欲脱的救急之方。

28 时欲漱口不欲咽，大便黑而易者，有瘀血也，犀角地黄汤主之。（《温病条辨·下焦篇》第20条）

**【提要】**

论下焦温病合并出血及瘀血的诊断和治疗。

29 少腹坚满，小便自利，夜热昼凉，大便闭，脉沉实者，蓄血也，桃仁承气汤主之，甚则抵当汤。（《温病条辨·下焦篇》第21条）

**【提要】**

论蓄血证的表现和治法。

30 暑邪深入少阴消渴者，连梅汤主之，入厥阴麻痹者，连梅汤主之；心热，烦躁神迷甚者，先与紫雪丹，再与连梅汤。（《温病条辨·下焦篇》第36条）

**【提要】**

论暑温病后期，暑伤心肾的证治。

**【句解】**

暑温病后期，暑邪久羁，损伤肝肾之阴，暑热未解而成虚中夹实之证。暑邪入心，助长心火，消耗肾水而导致心肾不交之证。

# 三级条文(30条)

1 再前云舌或黄或浊,须要有地之黄。若光滑者,乃无形湿热中有虚象,大忌前法。(《温热论》第12条)

【提要】

论痞证用苦泄法的辨舌要点。

【词解】

① 有地:舌苔紧贴舌面,如有根底。

② 前法:此指苦泄法。

【句解】

本条进一步说明黄浊苔必须是指苔黄而腻浊,苔垢紧贴舌面刮之不去者,方为湿热痰浊结滞,可用苦泄法的指征。若舌苔黄而光滑,松浮无根,刮之即去者,则系湿热内蕴而中气已虚。

【拓展】

苦泄法是针对湿热痰浊结滞、湿热俱盛的主要治法,运用时常常苦辛温与苦寒并用,苦辛温以燥湿,苦寒以泄热,亦可称为燥湿泄热法,或辛开苦降法。患者常表现为舌苔黄腻或黄浊,治疗常用小陷胸汤,或泻心汤,或王氏连朴饮。苦泄法由于使用有黄连等苦寒之品,故中焦脾胃虚弱的患者不宜使用。

2 其脐以上为大腹,或满或胀或痛,此必邪已入里矣,表证必无,或十只存一。亦要验之于舌,或黄甚,或如沉香色,或如灰黄色,或老黄色,或中有断纹,皆当下之,如小承气汤,用槟榔、青皮、枳实、元明粉、生首乌等。若未见此等舌,不宜用此等法,恐其中有湿聚太阴为满,或寒湿错杂为痛,或气壅为胀,又当以别法治之。(《温热论》第12条)

【提要】

论腑实证用下法的辨舌要点。

【词解】

① 断纹:舌或舌苔上的裂纹。

② 元明粉:又名无水芒硝。

【句解】

脐以上大腹部正当肠胃之间,该处出现胀满疼痛,提示邪已入里,已结于肠

胃，此时多无表证，或仅微存表证。

【拓展】

本条主要说明阳明腑实出现腹部胀满疼痛，要采用攻下法时的舌诊指征。“当以别法治之”，又反映出叶氏强调辨证论治的思想。如见脾阳不足，湿邪停聚者，可用扶脾燥湿的平胃散；若因寒湿阻遏，阳气不通引起者，可用温阳化湿的附子理中汤；肝气郁滞，横伐脾土而见腹胀满者，可用疏肝理脾的柴胡疏肝散；若脾气虚弱而致虚满者，可予四君子汤健脾和中。总之，切忌妄用攻下，造成脾胃阳气大伤，反生其他变证。

3　湿热证，三四日即口噤，四肢牵引拘急，甚则角弓反张，此湿热侵入经络脉隧中，宜鲜地龙、秦艽、威灵仙、滑石、苍耳子、丝瓜藤、海风藤、酒炒黄连等味。（《湿热病篇》第4条）

【提要】

论湿热夹风，侵犯经络而致痉的证治。

【词解】

口噤：牙关紧闭，张口困难，口合不开。《医碥·卷一》：“口噤即牙关不开也”。

【拓展】

张仲景治痉，原有桂枝加栝蒌根及葛根汤两方，与本证有何区别？即伤寒痉与湿热痉有何区别？伤寒之痉自外来，证属太阳，治以散外邪为主，仲景以葛根汤治刚痉，以栝蒌加桂枝汤治柔痉；湿热之痉因中焦湿热不解，热盛于里，火动风生，外窜经脉为痉，而痉挛脉急，甚则风煽火炽，内侵心包为厥，而识乱神迷，痉厥并见。痉厥在湿热病中常并见，与伤寒不同，故治疗亦不同。

4　湿热证，壮热口渴，舌黄或焦红，发痉，神昏谵语或笑，邪灼心包，营血已耗。宜犀角、羚羊角、连翘、生地、玄参、钩藤、银花露、鲜菖蒲、至宝丹等味。（《湿热病篇》第5条）

【提要】

论湿热化燥，内陷心营的证治。

【句解】

壮热口渴，舌黄为湿已化燥，里热亢盛所致，表明气分之邪犹存；舌焦红为邪热由气入营，劫灼营阴之征，神昏谵语或笑系热灼心包，发痉系邪热引动肝风所致。纵观本证乃气营两燔之候。

【拓展】

本证为湿热化燥内陷心营，虽有气营两燔之候，但治疗重在凉营养阴，透热

转气，同时针对闭窍动风，加以开窍熄风。薛生白自注云："用药以清热救阴，泄邪平肝为务"。原文以犀角、生地、玄参清心凉营、滋阴养液；银花露、连翘清气泄热、透热转气；鲜菖蒲、至宝丹辟秽开窍；羚羊角、钩藤凉肝熄风。且所用至宝丹长于芳香辟秽，菖蒲可芳香宣窍，辟秽化浊，更可知本证由湿热化燥而来。银花露有清泄芳化作用，亦符合叶天士《温热论》中"若从温热陷入者，犀角、花露之品，参入凉血清热方中"的营分证治疗大法。

5 湿热证，初起即胸闷不知人，瞀乱大叫痛，湿热阻闭中上二焦。宜草果、槟榔、鲜菖蒲、芫荽、六一散各重用，或加皂角，地浆水煎。（《湿热病篇》第14条）

**【提要】**

论湿热秽浊，阻闭上中二焦的证治。

**【词解】**

① 瞀乱：视物不明，心中闷乱，甚至神识昏蒙。

② 地浆水：把新汲水倒入约三尺深的黄土坑，待其沉淀后，取清液用，有清暑解毒作用。

**【句解】**

湿热病早期即见胸闷，不知人事，神志昏乱而大叫痛，乃湿热秽浊之邪阻闭上中二焦所致。清阳闭阻不行则闷乱叫痛，机窍闭塞，浊邪害清则不省人事。此属湿热病的一种特殊类型，由于暑湿交蒸，秽浊气盛，素体虚弱不耐暑热，或素有湿热内盛，更易感其气而发病，每伴见头胀、头重、恶心、欲呕不得呕、腹胀、苔白腻垢浊等。

**【拓展】**

本证为湿热俱盛之候，但用药却是祛湿药多而清热药少。薛生白自注云："以病邪初起即闭，不得不以辛通开闭为急务，不欲以寒凉凝滞气机也"。以辛通开闭为主，以免凉遏之弊。以草果、槟榔辛开理气，菖蒲、芫荽（或按王孟英注易以薤白）芳香辟秽，六一散清利湿热，皂角辟秽解毒。另，本证颇似"发痧"，临床还可用玉枢丹、紫金锭、藿香正气水、十滴水、行军散等，或以刮痧法、针刺法急救之。

6 湿热证，呕吐清水或痰多，湿热内留，木火上逆。宜温胆汤加栝蒌、碧玉散等味。（《湿热病篇》第16条）

**【提要】**

论湿热证痰热内阻，胆火上逆的证治。

【拓展】

本证为湿热证阳明少阳同病的一种变证，即素有痰饮而阳明少阳同病，痰饮郁其肝胆之火证。患者素有痰饮内蕴，郁遏肝胆之火上逆，胆胃不和而呕吐清水，痰热内郁则胸闷痰多。此外，当有口苦、苔垢腻、脉弦滑等症。治宜温胆汤化痰涤饮、和胃降逆为主，薛氏加入栝蒌，意在增加清化痰热之力。碧玉散即六一散加青黛，有清利肝胆湿热之功。诸药合用，以达“一以涤饮，一以降逆”的治疗目的。

7　湿热证，胸痞发热，肌肉微疼，始终无汗者，腠理暑邪内闭，宜六一散一两，薄荷叶三、四分，泡汤调下即汗解。（《湿热病篇》第21条）

【提要】

论湿热病邪郁于肌表，不得外泄的证治。

【拓展】

湿病能否发汗？湿病发汗，昔贤有禁。但此证不微汗之，病必不除。临床既要知道不可汗之大戒，亦要知晓有得汗始解之治法。湿病，仲景有法当汗出解，用麻黄加术汤、麻黄赤豆汤、麻黄杏仁薏苡等汤，后世亦有羌活胜湿等汤，固非一概禁汗者。但寒湿在表，必当汗解，若湿热在里，必当清热利湿。本条强调汗解，是因为腠理被湿热所郁闭，必以轻宣透达之品使卫气通调，气机调畅，湿开热透，则邪随汗解，即吴子音所谓“辛凉解散”之理，与湿病的辛温发汗之禁不同。

8　至论大者为斑，小者为疹。赤者胃热极，五死一生。紫黑者胃烂，九死一生。余断生死，则又不在斑之大小紫黑，总以其形之松浮紧束为凭耳！（《余师愚疫病篇》）

【提要】

论斑疹的辨察要点。

【拓展】

斑疹是许多温病在病变过程中，肌肤上出现的红色皮疹。通过观察其色泽、形态、分布等情况，并结合全身的表现，有助于了解感邪的轻重、病变的浅深、气血津液的盛衰、病势的进退及预后的顺逆等情况，对于温病的辨证及临床治疗有重要的意义。一般而言，斑疹色泽红润者，为邪毒尚轻；若斑色紫、黑者，为邪毒深重之象，其中尤以黑斑最为险恶。但是，从斑的颜色以辨其预后吉凶，仅是临床诊断的一个方面，余氏进一步提出须详察斑疹形态，抓住“松浮紧束”四字，即斑疹透发，总以松浮为吉，紧束为凶。如斑疹一出，即松活浮洒于皮面，无论或红、或赤、或紫、或黑，均属于邪毒外泄，预后大多良好，即使紫黑成片，甚或有恶

证，均尚可救治。如果一出即小如粟粒，紧束有根，犹如从皮里钻出似的，则系热毒深重，正不胜邪而闭伏于里，预后不良。

9 邪从口鼻而入，则其所客，内不在脏腑，外不在经络，舍于伏脊之内，去表不远，附近于胃，乃表里之分界，是为半表半里，即《针经》所谓横连膜原是也。（《温疫论·原病》）

【提要】

论疫邪的传变和邪伏膜原。

【词解】

① 伏脊：又称“伏膂”、“夹脊”，指脊柱两旁的部位。

② 针经：一般认为指《灵枢》。

③ 横连膜原：语出《素问·疟论》：“邪气内薄于五脏，横连膜原”。膜原，又作“募原”。

【拓展】

膜原在《黄帝内经》中作为一个解剖位置，但确切的部位不够明白，吴氏引用膜原的概念，则将其作为一个假设的部位，所谓“内不在脏腑，外不在经络，舍于伏脊之内，去表不远，附近于胃”，与《黄帝内经》中膜原所在部位似同。但实质上，吴氏所说的膜原是一个病机概念，即“半表半里”，这是吴氏在临床实际观察中，注意到疫病初起时的症状与一般外感病的表证不同，既不是邪犯皮毛的太阳证，也不是一般感冒的寒热，咳嗽，但是又没有明显的脏腑病变表现，故属半表半里。

10 春温一证，由冬令收藏未固，昔人以冬寒内伏，藏于少阴，入春发于少阳，以春木内应肝胆也。寒邪深伏，已经化热，昔贤以黄芩汤为主方，苦寒直清里热，热伏于阴，苦味坚阴，乃正治也。（《叶香岩三时伏气外感篇》）

【提要】

论春温的病机与治法。

【拓展】

春温是伏气温病，外因冬伤于寒，内因阴精亏虚，于是冬寒内伏，藏于少阴，郁而化热，待春回阳生，触发其热，发为春温。春温初起常发于少阳胆，出现热郁胆腑证。治疗当苦寒清泄里热，以黄芩汤为主方，进行加减化裁。如柳宝诒《温热逢源》有黄芩汤加豆豉玄参方。此外，如果春温初起是因为新感引动伏邪，初起微有恶寒之表证，治疗当先辛凉以解新邪，继进苦寒以清里热。

11 风温者，春月受风，其气已温，《经》谓春气病在头，治在上焦。肺位最高，邪必先伤，此手太阴气分先病，失治则入手厥阴心包络，血分亦伤。（《叶香岩三时伏气外感篇》）

【提要】

论风温的病机与传变。

【拓展】

风温多发生于春季，因为春季温暖多风，故易形成风热病邪，引起风温。风温为病，邪从口鼻而入，首犯肺卫，此时当疏卫透表，疏风散热，如银翘散等；继而卫分证消失，出现邪热壅肺的气分证，患者出现肺热咳喘的征象，此时当清热宣肺平喘，如麻杏石甘汤等。若失治，则邪热内陷，传入手厥阴心包，出现热陷心包证，患者出现神昏谵语、舌謇肢厥、身热舌绛等症状，此时当清心开窍，如安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹等。

12 风温为病，春月与冬季居多，或恶风，或不恶风，必身热、咳嗽、烦渴，此风温证之提纲也。（《陈平伯外感温病篇》）

【提要】

论风温病的提纲。

【拓展】

风温多发生于冬春季，冬月天暖，所感亦是风温。冬月因风热病邪引起的温病又称为“冬温”。由于冬温的病因亦是风热病邪，因此，又统称为“风温”。风温一病的必然症状有身热、咳嗽、烦渴，说明风热病邪壅盛于肺，引起肺气失宣，甚或肺气闭郁出现咳喘。其中的身热烦渴说明热象，咳嗽说明热壅的部位在肺。若初起身热、咳嗽、烦渴症状轻，可用银翘散或桑菊饮，若病情发展身热、咳嗽、烦渴症状较重，可用麻杏石甘汤。

13 太阴温病，寸脉大，舌绛而干，法当渴，今反不渴者，热在营中也，清营汤去黄连主之。（《温病条辨·上焦篇》第 15 条）

【提要】

论温病邪入营分的证治。

【拓展】

温病营分证的临床表现为“寸脉大，舌绛而干，反不渴”。其中寸脉大，是邪在太阴之象；舌绛而干，是邪入营分而营阴耗伤的表现；“反不渴”是由于邪热深入营分后，蒸腾营气上升而滋润于口咽，所以患者没有明显的口渴症状。但医师不能因患者口不渴而怀疑所患的不是温病，也不能因此而认为病邪及阴伤程度

较气分证阶段有所减轻。实际上，此时虽表现不渴，但其阴液的耗伤较之气分更甚。如吴鞠通自注云："渴乃温之本病，今反不渴，滋人疑惑；而舌绛且干，两寸脉大，的系温病。盖邪热入营，蒸腾营气上升，故不渴，不可疑不渴非温病也"。

14 太阴温病，不可发汗，发汗而汗不出者，必发斑疹，汗出过多者，必神昏谵语。发斑者，化斑汤主之；发疹者，银翘散去豆豉，加细生地、丹皮、大青叶，倍元参主之，禁升麻、柴胡、当归、防风、羌活、白芷、葛根、三春柳。神昏谵语者，清宫汤主之，牛黄丸、紫雪丹、局方至宝丹亦主之。（《温病条辨·上焦篇》第16条）

【提要】

论温病忌汗之理，以及误汗而引起斑疹、邪闭心包等变证的治疗。

【拓展】

温病禁汗：吴氏强调，温病初起，邪在肺卫的手太阴温病，治当辛凉疏解，不能用辛温发汗的方法，如误用后就会发生一些变证。如误用辛温之品助热势，而阴液不足，又无作汗之源，汗不得出，邪热内逼血分，发于皮肤则为斑疹；如卫表疏松，在误用辛温发汗后，汗出不止，必然损伤心阳、心阴，邪热又可乘虚而入，造成邪闭心包，神明失主。所以，"温病禁汗"关键在于禁用麻黄汤、桂枝汤之类辛温发汗法。结合临床实际，温病禁汗并不能理解为温病的治疗绝对禁止使用发汗药物，特别是对感受温邪在表，表气郁闭而恶寒较著，或无汗者的治疗，可在辛凉清热的基础上，配伍辛散或少量辛温而不燥之品以助开表透汗之力，如辛凉平剂银翘散中即有淡豆豉、荆芥辛温发汗之品。说明温病的治疗并非绝对禁汗，而应把握禁用何类发汗药物。

误汗变证的治疗：对误汗后所造成的上述变证，吴氏提出：发斑者，可用化斑汤凉血解毒化斑；发疹者，银翘散去豆豉，加细生地、丹皮、大青叶，倍元参以清营凉血解毒透疹，但禁用升麻、柴胡、当归、防风、羌活、白芷、葛根、三春柳等辛温发散之品。对神昏谵语者，可用清宫汤，同时可配合牛黄丸、紫雪丹、局方至宝丹等。从吴氏列出的治疗神昏谵语的方药来看，主要是针对误汗后发生邪闭心包者，但如误汗后发生心阳、心阴外脱，或出现内闭外脱者，则不可拘于此法，当用固脱救逆之法，或固脱与开窍并用。

15 小儿暑温，身热，卒然痉厥，名曰暑痫，清营汤主之，亦可少与紫雪丹。（《温病条辨·上焦篇》第33条）

【提要】

论小儿暑痫的证治。

**【拓展】**

小儿脏腑娇嫩，患暑温后容易入侵心营，引动肝风，发生痉厥。这类病证，称为“暑痫”。如吴鞠通所云：“小儿之阴，更虚于大人，况暑月乎！一得暑温，不移时有过卫入营者，盖小儿之脏腑薄也。血络受火邪逼迫，火极而内风生，俗名急惊”。此时邪热已入心营，不可用发散消导之品，“混与发散消导，死不旋踵”，而应当以清营汤治疗，或加用紫雪丹开窍息风，即“惟以清营汤清营分之热而保津液，使液充阳和，自然汗出而解，断断不可发汗也。可少与紫雪者，清包络之热而开内窍也”。同时，针对患者的动风之象，临床还可酌加羚羊角、钩藤等凉肝息风之品。

此外，临床还需注意，小儿暑温发生痉厥并非都属营分证，如伴见壮热、渴饮、有汗、苔黄燥者，多为阳明热盛引动肝风，治疗当清泄阳明、凉肝息风，只要热势一减，痉厥即可自止。若伴见身灼热，以发斑疹或吐血、便血，则为血分热盛而引动肝风，治疗当凉血止血、凉肝止痉。

16　长夏受暑，过夏而发者，名曰伏暑。霜未降而发者少轻，霜既降而发者则重，冬日发者尤重，子、午、丑、未之年为多也。（《温病条辨·上焦篇》第 36 条）

**【提要】**

论伏暑的概念和发病。

**【词解】**

① 长夏：农历六月，一般指夏秋之交的季节。

② 子、午、丑、未：按十二地支纪年，子午为君火司天，气候炎热；丑未为湿土司天，气候潮湿。由于伏暑属暑热、暑湿为病，所以吴氏认为在这些年份易发生伏暑。

**【拓展】**

伏暑的概念：是在长夏时感受暑邪，到秋冬而发的一种温病。因此，伏暑的病证性质既具有暑邪致病的特点，而其发病则在秋冬，起病多为新感引动伏邪，即内有暑病的见症，外有时令之邪客在表的见症。

伏暑的发病：伏暑为伏气温病，热自里发，起病即有高热、心烦、口渴、脘痞、苔腻等暑湿郁蒸气分，或有高热、烦躁、口干不甚渴饮、舌赤等暑热内炽营分的里热见症。以发病急骤、病情深重、病势缠绵为特征。

17　太阴伏暑，舌白口渴，无汗者，银翘散去牛蒡、元参加杏仁、滑石主之。此邪在气分而表实之证也。（《温病条辨·上焦篇》第 38 条）

【提要】

论伏暑邪在气分兼表实证的证治。

【拓展】

邪在气分兼表实，是指在发病之初既有口渴、壮热等气分里热见症，脘痞、苔白腻等湿阻气机的表现，又有发热、恶风寒、头痛、无汗等时邪郁表见症，所以在治疗时用银翘散去牛蒡、元参加杏仁、滑石清暑化湿，疏宣表邪。方中银翘散疏透表邪且轻清泄热，因湿邪内阻，故加杏仁、滑石等宣开气机、分利暑湿，同时顾及与暑相合之湿邪，而去牛蒡、元参，因二药具阴腻之性，有碍于湿之故。

18 太阴伏暑，舌赤口渴，无汗者，银翘散加生地、丹皮、赤芍、麦冬主之。此邪在血分而表实之证也。（《温病条辨·上焦篇》第39条）

【提要】

论伏暑邪在血分兼表实证的证治。

【拓展】

邪在血分兼表实，是指在发病之初既有心烦不寐、口干不甚渴饮、舌赤少苔等热灼心营，营热阴伤之症，同时又有发热、恶风寒、头痛、无汗等风邪外袭，肺卫失宣的表实之症。此处所谓血分，主要是指营分，所以在治疗时用银翘散加用生地、丹皮、赤芍、麦冬方以清营泄热，辛凉透表。方用银翘散辛凉解表，疏散风热，加生地、麦冬凉营滋阴，赤芍、丹皮清营泄热。

19 伏暑、暑温、湿温，证本一源，前后互参，不可偏执。（《温病条辨·上焦篇》第42条）

【提要】

论伏暑、暑温、湿温的辨治规律可前后互参。

【拓展】

吴氏认为，伏暑、暑温、湿温在病变的初起虽然有湿重与热重的区别，但它们都属于湿热类温病的范畴，临床上各类证候可以在这三个不同的病种中交互出现，所以它们的辨证规律与治疗规律有共同之处，可以前后相互参照，不必拘执一端。提示将温病分为温热类温病与湿热类温病的重要性。

20 太阴湿温，气分痹郁而哕者（俗名呃），宣痹汤主之。（《温病条辨·上焦篇》第46条）

【提要】

论上焦宣痹汤的证治。

【拓展】

本条宣痹汤为上焦宣痹汤，与中焦宣痹汤不同。上焦宣痹汤主要用于湿热郁于上焦，阻滞气机，导致气机不降的病症。

21　面目俱赤，语声重浊，呼吸俱粗，大便闭，小便涩，舌苔老黄，甚则黑有芒刺，但恶热，不恶寒，日晡益甚者，传至中焦，阳明温病也。脉浮洪躁甚者，白虎汤主之；脉沉数有力，甚则脉体反小而实者，大承气汤主之。暑温、湿温、温疟，不在此例。（《温病条辨·中焦篇》第1条）

【提要】

本条为阳明温病的证治大纲，主要论述阳明温病的临床表现和阳明经腑二证的证治区别。

【拓展】

阳明温病的形成：上焦篇开始即强调感受外邪多从口鼻而入，首先侵犯上焦，病变从肺开始。如入侵手太阴肺的病邪能够及时清除外解，则病变即可终止发展而获得早期治愈。若在肺经没有外解，则势必向里传变而导致病变发展。

其发展趋向一般有两个途径：一为肺经之邪直接内陷手厥阴心包，即所谓“肺病逆传，则为心包”；一为肺经之邪由上焦而传至中焦阳明，即所谓“上焦病不治则中焦”。故中焦阳明病证的形成，多由上焦肺经之邪传变而来，其病位在胃和大肠。由于邪传阳明，邪正交争剧烈，所以临床呈现一派里热亢盛的征象。

阳明温病的临床表现：温热之邪传入中焦阳明，其主要临床表现以阳明里热亢盛的症状为主。

阳明温病的治疗：阳明经证属阳明无形邪热浮盛内外，临床以大热、大渴、大汗、脉浮洪躁为特征，治疗当用白虎汤清泄里热为主。阳明腑证属有形热结于内，临床则以痞满燥实，脉沉数有力，甚则脉体反小而实为特征，治疗当以大承气汤通腑泄热为要。由于攻下法易耗阴伤正，故吴氏强调：“承气非可轻尝之品，故云舌苔老黄，甚则黑有芒刺，脉体沉实，的系燥结痞满，方可用之”。实际上，临床上对热结肠腑者，并非一定要等到舌苔老黄，甚则黑有芒刺，痞满燥实俱全才用下法，以免错过了攻下时机。

22　下后数日，热不退，或退不尽，口燥咽干，舌苔干黑，或金黄色，脉沉而有力者，护胃承气汤微和之；脉沉而弱者，增液汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第15条）

【提要】

论阳明温病攻下后，邪实未尽或邪气复聚的证治。

【拓展】

阳明温病使用攻下后，若邪气已净，必然脉静身凉。今仍热不退，或退不尽，是因为邪气不净。“正气日虚一日，阴津日耗一日”，患者易出现口燥咽干，舌苔干黑等阴伤的表现。除阴伤外，未尽之邪热又兼有腑实内结。脉沉而有力者，护胃承气汤微和之。护胃承气汤由生大黄、玄参、细生地、丹皮、知母、麦冬组成，即增液汤加生大黄、知母、丹皮，养阴清热之中佐以通腑。而对于纯粹的液干便秘之证，脉沉而弱者，只需用增液汤即可。

本条涉及温病下后腑实未尽，再用下法时需注意要点，即要特别注意保护津液，再下之药不可过猛，同时配合滋阴之品。

23 阳明温病，干呕口苦而渴，尚未可下者，黄连黄芩汤主之。不渴而舌滑者，属湿温。（《温病条辨·中焦篇》第19条）

【提要】

论阳明温病干呕的证治。

【拓展】

吴鞠通自注阳明温病发生干呕是“由于邪热夹秽，扰乱中宫而然”。如热甚湿轻，干呕伴见口苦而渴，治疗可用黄连黄芩汤。如湿重热轻，干呕伴见不渴而苔滑，可按湿温病治疗。然而在临床上，由于邪热内盛而致胃气上逆干呕者，并非少见，似不能见干呕皆认定是夹秽，尚须结合全身症状综合分析。

24 阳明温病，舌黄燥，肉色绛，不渴者，邪在血分，清营汤主之。若滑者，不可与也，当于湿温中求之。（《温病条辨·中焦篇》第20条）

【提要】

论温病邪入营血的证治。

【拓展】

热邪传里，病在阳明气分，舌苔多黄而干燥，口必大渴引饮，是胃热灼津的表现。若热邪入里后舌呈红绛之色，口渴反而不甚或竟不渴的，则为邪气深入营血，“格阴于外，上潮于口”所致。

25 斑疹，用升提则衄，或厥，或呛咳，或昏痉，用壅补则瞀乱。（《温病条辨·中焦篇》第23条）

【提要】

论温病斑疹的治疗禁忌。

【词解】

瞀乱：心中闷乱，头目昏眩。

【拓展】

斑疹的病机与治则：温病过程中出现的斑疹是热入营血的征象，治疗应凉血解毒为主，如夹疹者，可配合轻宣透发之品，也即吴鞠通自注所说的“轻宣凉解”。具体而言，斑与疹的病机与治则又不同。陆子贤说：“斑为阳明热毒，疹为太阴风热”，因此，斑宜清胃泄热、凉血解毒；疹宜宣肺达邪、清营透疹。

为何忌升提？所谓升提，是指用辛温之剂发散透疹之法。这一治法主要是针对风疹、麻疹表气郁闭较甚者而设的，但通常对这类疾病的治疗仍以辛凉宣透为主，而非滥用辛温升提，更不要说是用于斑疹等营血有热之证。吴鞠通自注云：“若用柴胡、升麻辛温之品，直升少阳，使热血上循清道则衄；过升则下竭，下竭者必上厥；肺为华盖，受热毒之熏蒸则呛咳；心位正阳，受升提之摧迫则昏痉”。

为何忌壅补？斑疹是热入营血的征象，若在邪热炽盛之时，误用壅补，则会使邪无出路，反而加重病情。吴鞠通自注云：“至若壅补，使邪无出路，络道比经道最细，诸疮痛痒，皆属于心，既不得外出，其势必返而归之于心，不瞀乱得乎”。壅补，对一般斑疹治疗并无使用的必要，因斑疹本是邪热之证，治以清解为主。但在温病发斑疹时，如正气大虚而出现斑疹内陷之逆证，临床上可出现体温骤降，斑疹突然隐没等见症，当用补气以托斑疹之法，此则不属禁忌之法。

26　风温、温热、温疫、温毒、冬温之在中焦，阳明病居多；湿温之在中焦，太阴病居多；暑温则各半也。（《温病条辨·中焦篇》第37条）

【提要】

论不同温病之病在中焦病者。

【拓展】

凡属温热性质的温病（如风温、温热、温疫、温毒、冬温），其在中焦的病位侧重于阳明胃；凡属湿热性质的温病（如湿温），其在中焦的病位侧重于太阴；而湿热并重的温病（如暑温），病位则兼在阳明、太阴。

27　暑温蔓延三焦，舌滑微黄，邪在气分者，三石汤主之；邪气久留，舌绛苔少，热搏血分者，加味清宫汤主之；神识不清，热闭内窍者，先与紫雪丹，再与清宫汤。（《温病条辨·中焦篇》第41条）

【提要】

论暑湿弥漫三焦的证治。

【拓展】

“蔓延三焦”，是指暑热湿邪并不局限于某一脏腑，而是涉及上中下三焦，但病变仍属气分范围。上焦主要是指肺气不化，中焦主要为热盛阳明，下焦则表现

为膀胱不利。三焦密切相关，上下互相影响。

28 暑温、伏暑，三焦均受，舌灰白，胸痞闷，潮热，呕恶，烦渴，自利，汗出，溺短者，杏仁滑石汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第42条）

【提要】

论暑湿弥漫三焦的证治。

【拓展】

当暑湿散漫于全身，布于三焦时，主要表现为邪在上的汗出、烦渴，邪在中的痞满、呕恶，邪在下的自利、溺短等，所以治疗主以清热、宣气、化湿。

29 脉缓身痛，舌淡黄而滑，渴不多饮，或竟不渴，汗出热解，继而复热，内不能运水谷之湿，外复感时令之湿，发表攻里，两不可施，误认伤寒，必转坏证，徒清热则湿不退，徒祛湿则热愈炽，黄芩滑石汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第63条）

【提要】

论湿温的发病、治则，以及黄芩滑石汤的证治。

30 湿聚热蒸，蕴于经络，寒战热炽，骨骱烦疼，舌色灰滞，面目痿黄，病名湿痹，宣痹汤主之。（《温病条辨·中焦篇》第65条）

【提要】

论湿热痹的证治。

【词解】

骨骱：骨骼关节。

【拓展】

痹证多由风寒湿引起，但也有因风湿热邪所致者，或因风寒湿久郁而成湿热之证者。湿热蕴于经络则寒战热炽而骨骱疼痛，但与一般湿温之病在脾胃者有所不同。

# 成都中医药大学中医经典知识等级考试实施方案(试行)

《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》和温病学等经典是中医学的基本理论源泉。读经典、悟经典、用经典是中医人才成长的必由之路。中医院校将《内经选读》《伤寒论选读》《金匮要略选读》和《温病学》列为中医学人才培养的必修课程，对于认识中医、传承中医和发展中医具有重要意义。为进一步巩固大学生的中医基本理论和基础知识，提升学生的中医思辨能力，根据我校“再次腾飞”和“八大提升计划”精神，特制定成都中医药大学中医经典知识等级考试实施方案。

一、指导思想

中医经典，历史悠久，文辞古奥，非熟读无以领悟，非领悟难以应用，非应用难以融通。开设中医经典知识“三、四、六级”等级考试，通过以考促学的有效路径，激发学生学习中医经典的热情，养成诵习中医经典的习惯，培养中医临床思辨素养。

二、考试管理

1. 管理机构　　成立成都中医药大学中医经典知识等级考试领导小组，组长由学校主管教学副校长担任，教务处处长和基础医学院院长担任副组长。领导小组负责审定《成都中医药大学中医经典知识等级考试实施方案》，指导、协调中医经典知识等级考试各项工作。设立成都中医药大学中医经典知识等级考试办公室，负责中医经典知识等级考试方案的具体实施。

2. 考试管理　　中医经典知识等级考试办公室负责等级考试的日常管理工作，聘请各经典课程所属学科专家讨论并制定《成都中医药大学中医经典知识等级考试大纲》《成都中医药大学中医经典知识等级考试管理办法》《成都中医药大学中医经典知识等级考试命题要求》，组织相关专家编写《中医经典等级测试指南》，建立完善网络题库。相关学院负责组织学生报名工作，教务处负责组织协调考试工作，校团委负责组织协调课外学分的认定工作。

三、考试要求及内容

1. 报考资格　　成都中医药大学全日制在读学生，均具有参加中医经典知识等级测试资格。通过“中医经典三级”测试后方可申请参加“中医经典四级”测试，通过“中医经典四级”测试后方可申请参加“中医经典六级”测试。

2. 考试时间　　每年举行两次中医经典知识等级测试，分别在春、秋季学期

进行。根据报名情况确定开考的相应级别。

3. 考试范围及方式　　中医经典知识等级测试暂定为笔试，待题库建设完成后开展网络化考试。每个级别测试满分 300 分，测试时间为 120 分钟。

合格标准：测试成绩达到 180 分及以上者，则为通过相应级别测试。

经典条文难易程度设为一、二、三级，一级条文为掌握内容，二级条文为熟悉内容，三级条文为了解内容。各级别涉及条文和分值构成情况，见下表：

| 考试级别 | 考试范围 |
|---|---|
| 中医经典三级等级考试 | 《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《温病学》 |
| 中医经典四级等级考试 | 《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《温病学》 |
| 中医经典六级等级考试 | 《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》《温病学》 |

分值结构：

| 内容 | 《黄帝内经》 | | | 《伤寒论》 | | | 《金匮要略》 | | | 温病学 | | | 满分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级条文 | 二级条文 | 三级条文 | 一级条文 | 二级条文 | 三级条文 | 一级条文 | 二级条文 | 三级条文 | 一级条文 | 二级条文 | 三级条文 | |
| 三级 | 150 | 70 | 20 | 20 | — | — | 20 | — | — | 20 | — | — | 300 |
| 四级 | 100 | 60 | 20 | 40 | 20 | — | 20 | 10 | — | 20 | 10 | — | 300 |
| 六级 | 20 | 40 | 80 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 300 |

四、保障措施

1. 经费保障　　为保障中医经典知识等级测试正常进行，学校将每年投入专项资金，为考试大纲的制定、网络题库的建设、考试参考资料的整理与印制、考前辅导、命审题、试卷印制、考试阅卷、考务组织管理等各项工作提供资金保障。

2. 题库建设　　学校搭建考易网络题库平台，建设中医经典知识等级测试网络题库。

五、激励措施

（1）中医学专业学生要求参加中医经典知识等级考试，中西医临床、针灸推拿学专业学生自愿参加。考试通过者，学校颁发相对应级别的《成都中医药大学中医经典知识等级证书》，并分别记素质拓展教育学分 0.5 分。

（2）中医学专业长学制班级的学生在本科阶段必须通过中医经典四级考试，研究生阶段必须通过中医经典六级考试，将其作为长学制学生的分流淘汰标准之一。

（3）通过经典等级考试的学生，校团委同时授予《大学生素质教育证书》，经典三级考试证书获得者加综合素质教育分 4 分，经典四级考试证书获得者加综

合素质教育分7分,经典六级考试证书获得者加综合素质教育分10分。

(4)中医学专业学生,通过“经典四级考试”列为硕士研究生“推免”的基本条件之一,通过“经典六级考试”的在“推免”研究生时,综合积分排名总可享受3分的加分。

(5)中医经典知识等级考试成绩作为“国医之星”系列活动之“经典之星”比赛成绩组成部分。

六、本方案为试行办法,相关规定须符合《成都中医药大学学生手册》或学校教务管理之精神,实际执行过程中如有相悖处,应以《学生手册》或教务管理为准。

成都中医药大学

2015年6月

# 成都中医药大学中医经典知识等级测试试题范例

1.《素问·至真要大论》：治诸胜复，寒者热之，_____，温者清之，_____，散者收之，抑者散之。

2.《素问·至真要大论》：诸风掉眩，_____。诸寒收引，_____。

3.《素问·上古天真论》：女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，_____，_____，月事以时下，故有子。

4.《素问·阴阳应象大论》：天地者，万物之上下也；阴阳者，血气之男女也；左右者，_____；水火者，_____。

5.《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：太阳之为病，_____、_____。

6.《伤寒论·辨太阳病脉证并治》：太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，_____；外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜_____。

7.《伤寒论·辨阳明病脉证并治》：问曰：阳明病外证云何？答曰：_____，_____，不恶寒，反恶热也。

8.《伤寒论·辨少阴病脉证并治》少阴病，始得之，_____，_____，麻黄细辛附子汤主之。

9.《金匮要略·脏腑经络先后病脉证第一》：问曰：上工治未病，何也？师曰：夫治未病者，见肝之病，_____，当先实脾，四季脾王不受邪，_____；中工不晓相传，见肝之病，不解实脾，惟治肝也。

10.《金匮要略·脏腑经络先后病脉证第一》：夫肝之病，_____，助用焦苦，_____。

11.《金匮要略·痉湿暍病脉证治第二》：风湿，脉浮身重，_____者，防己黄芪汤主之。

12.《金匮要略·百合狐惑阴阳毒病脉证治第三》：论曰：百合病者，_____，_____。

13.《金匮要略·中风历节病脉证并治第五》：诸肢节疼痛，_____，脚肿如脱，头眩短气，_____，桂枝芍药知母汤主之。

14.《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治第六》：虚劳诸不足，风气百疾，

_____主之。

15.《温热论》：温邪上受，_____，逆传_____。

16.《温热论》：肺主气_____，心主血_____，辨卫气营血虽与伤寒同，_____。

17.《温热论》：在表初用_____。挟风则加入_____、牛蒡之属，挟湿加_____、滑石之流。

18.《温热论》：盖伤寒之邪留恋在表，然后_____，温邪则_____，未传心包，邪尚在肺，肺主气，其合皮毛，_____。

19.《温热论》：不尔，风挟温热而燥生，_____，为水主之气不能上荣，_____也。

20.《湿热病篇》：湿热证，始_____，后_____，汗出胸痞，舌白，_____。

21.《湿热病篇》：湿热证，舌根白，舌尖红，湿渐化热，_____。宜_____，如蔻仁、半夏、干菖蒲、大豆黄卷、连翘、绿豆衣、六一散等味。

22.《湿热病篇》：湿热证，恶寒发热，身重关节疼痛，湿在_____，不为_____。

23.《湿热病篇》：湿热证，恶寒无汗，身重头痛，湿在_____。宜藿香、_____、羌活、苍术皮、薄荷、牛蒡子等味。

24.《湿热病篇》：湿热证，数日后脘中微闷，_____。湿邪蒙绕三焦，宜_____、薄荷叶、鲜荷叶、_____、佩兰叶、芦尖、冬瓜仁等味。

(R-6298.01)

# 中医经典等级测试指南

ZHONGYI JINGDIAN DENGJI CESHI ZHINAN

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-050362-6

科学出版社互联网入口

部门：（021）64044170　销售：（010）64031535

部　门 E-mail: sciencep-shmed@vip.163.com

销售分类建议：医学／高等教育

定　价：40.00 元